

كتاب

سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة



المستوى الثانى - جميع الشعب والبرنامج الخاص

الفصل الدراسي الثانى

إعداد

أ.د/ أمانى عبد المقصود عبد الوهاب

F-12628

٢٠٢٥-٢٠٢٦م

[قائمة المحتويات](#)

الرؤية والرسالة

الرؤية

تتطلع كلية التربية النوعية جامعة المنوفية أن تكون مؤسسة رائدة في التعليم النوعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع تسهم في إعداد كوادر متميزة محليا وإقليميا وتدعم التنمية المستدامة.

الرسالة

تسعى كلية التربية النوعية جامعة المنوفية إلى إعداد خريجين متميزين في المجالات النوعية من خلال توظيف مواردها البشرية والمادية في تقديم تعليم عالي الجودة وتنمية مهارات البحث العلمي وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يواكب استراتيجيات التنمية المستدامة ويلبي احتياجات سوق العمل.

توصيف مقرر دراسي (نموذج استرشادي ٢٠٢٥)

نم

١. معلومات أساسية

اسم المقرر (تبعاً لما ورد باللائحة)				سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة	
كود/رمز المقرر (تبعاً لما ورد باللائحة)				F-12628	
القسم/الأقسام العلمية المشاركة في تدريس المقرر				قسم العلوم التربوية والنفسية	
عدد الساعات / النقاط المعتمدة للمقرر (تبعاً لما ورد باللائحة)				نظري	إجمالي
				٢	٢
نوع المقرر				اختياري	
الفرقة الدراسية / المستوى الدراسي الذي يقدم فيه المقرر				الفرقة/المستوي الثاني	
البرنامج الأكاديمي				جميع البرامج	
الكلية/المعهد				التربية النوعية	
الجامعة/الأكاديمية				المنوفية	
اسم منسق المقرر				أ.د/ سماح حلمي يس	
تاريخ اعتماد توصيف المقرر				9/7/2025	
جهة اعتماد توصيف المقرر (يرفق قرار/محضر مجلس القسم /الأقسام/ الجهة المختصة/....)				مجلس القسم العلمي	

٢. الوصف العام للمقرر Course overview (ملخص موجز للمحتوى العلمي)

يتناول هذا المقرر عرضاً لمفهوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والعوامل المكونة للإعاقات، وأنواع ذوى الاحتياجات الخاصة، وخصائصهم، والاحتياجات النفسية لهم، ولأسرهم، وطرق الاكتشاف المبكر لذوى الاحتياجات الخاصة، وبرامج تحسين ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتطلبات وإجراءات دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والأنشطة المتنوعة لتحسين توافق ذوى الاحتياجات الخاصة، والبرامج المستخدمة لمختلف ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة لبحوث ودراسات في ذوى الاحتياجات الخاصة.

٣. نواتج التعلم للمقرر

اتساق نواتج التعلم للمقرر مع مخرجات البرنامج (المعايير المتبناة)

قائمة المحتويات

مخرجات البرنامج / المعايير الأكاديمية المتبناة (التي يحققها المقرر تبعاً للمصفوفة في توصيف البرنامج)		نواتج التعلم للمقرر عند الانتهاء من المقرر سيكون الطالب قادراً على:	
الكود	النص	الكود	النص
A-3	نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين	٣-أ-١	يحدد خصائص الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
A-7	التربية الخاصة ومجالاتها واستراتيجياتها.	٣-أ-٢	يذكر طرق الاكتشاف المبكر للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
		٣-أ-٣	يعدد طرق رعاية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
		٣-أ-٤	يشرح برامج تنمية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
		٣-أ-٥	يعدد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وخصائص كل فئة.
B-2	يحلل نتائج تقييم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير.	٣-ج-٣	٤- يحلل إجراءات ومتطلبات الدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
C-5	يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم والأنشطة الصفية والملا صفية.	٣-ج-٣	يستخدم الأنشطة المناسبة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
C-7	يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	٣-ج-٢	يطبق البرامج التي تساعد على تنمية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
C-10	يوظف أسس الإرشاد: التربوي والنفسي وريادة الأعمال.	٣-ج-٤	يقيم طرق تشخيص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
		٣-ج-٥	يطبق الاختبارات النفسية على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
D-1	يعمل بكفاءة ضمن فريق.	٣-د-١	يعمل في فريق في برامج تنمية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
D-2	يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية؛ للتواصل والبحث عن المعلومات.	٣-د-٢	يتواصل بفاعلية مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء تطبيق الاختبارات النفسية عليهم.
		٣-د-٣	يستخدم الحاسب الآلي لتطبيق الأنشطة العملية التي تنمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
		٣-د-٥	يتعامل بفاعلية مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين.
D-5	يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحا حلولاً لها.	٣-د-٤	يشارك في التعرف على الاحتياجات النفسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

٤. طرق التعليم والتعلم

١. المحاضرة المطورة
٢. التعلم التعاوني
٣. المناقشة/ الحوار

قائمة المحتويات

الجدول الدراسي للمقرر

رقم الاسبوع الدراسي	المحتوى العلمي للمقرر (موضوعات المقرر)	إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	عدد ساعات التعلم المتوقعة			
			تدريس نظري (محاضرات/ مجموعات مناقشة/.....)	تدريب (عملي/إكلينيكي/)	تعلم ذاتي (مهام/ تكاليفات/ مشاريع/...)	أخرى (تحدد)
١	مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة.	٢	٢			
٢	-المفاهيم الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة	٢	٢			
٣	-العوامل المكونة للإعاقات	٢	٢			
٤	- فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.	٢	٢			
٥	-الإعاقة الحركية	٢	٢			
٦	-الإعاقة السمعية	٢	٢			
٧	-الإعاقة البصرية	٢	٢			
٨	-إعاقة صعوبات التعلم	٢	٢			
٩	-إعاقة بطيء التعلم	٢	٢			
١٠	-الإعاقات اللغوية	٢	٢			
١١	- خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة.	٢	٢			
١٢	-الاحتياجات النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسره.	٢	٢			
١٣	- طرق الاكتشاف المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة.	٢	٢			
١٤	-البرامج المستخدمة لمختلف ذوي الاحتياجات الخاصة.	٢	٢			

٥. طرق تقييم الطلاب

م	طرق التقييم *	توقيت التقييم المتوقع (رقم الأسبوع الدراسي)	درجات التقييم	النسبة المئوية من إجمالي درجة المقرر
١	امتحان ١ تحريري (أعمال سنة)	الأسبوع السابع	٥	٥٪
٢	امتحان ٢ (أعمال سنة)	-	-	-
٣	امتحان نهائي تحريري	وفق الجدول المعتمد للاختبارات	٨٠	٨٠٪
٤	امتحان نهائي عملي	الأسبوع الخامس عشر	-	-
٥	امتحان نهائي شفهي	-	-	-
٦	تكاليفات	مستمر	١٥	١٥٪
٧	تدريب ميداني	-	-	-
٨	أخرى (تذكر)	-	-	-

* الطرق المذكورة هي أمثلة استرشادية، ويجوز للمؤسسة الإضافة والحذف

قائمة المحتويات

٦. مصادر التعلم والتسهيلات الداعمة

- أمانى عبد المقصود عبد الوهاب (٢٠٢٤). سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: الأنجلو المصرية.	المرجع الأساسي للمقرر (لابد من كتابة البيانات كاملة وفقا لطريقة توثيق علمي)	مصادر التعلم (الكتب والمراجع العلمية وغيرها) *
- أمانى عبد المقصود عبد الوهاب (٢٠١٤). الكفاءة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: الأنجلو المصرية. -إيلي كرم الدين (٢٠٠٤). الأنشطة العملية لتعليم المفاهيم لطفل ما قبل المدرسة وذوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: دار الفكر العربي.	المراجع الأخرى	
http://www.apa.org/ http://www.bps.org.uk/ http://www.e paranm.org/ http://gulfkids.com/ar/	المصادر الالكترونية (لابد من إضافة الروابط)	
https://menofia.education/login/index.php	المنصة التعليمية (لابد من إضافة الرابط)	
-	أخرى (تذكر)	التجهيزات التعليمية المساندة للتعليم والتعلم *
أجهزة الحاسب الآلي + شاشات العرض	الأجهزة	
-	المستلزمات	
-	البرامج الالكترونية	
-	معامل المهارات/ المحاكيات	
-	المعامل الافتراضية	
-	أخرى (تذكر)	

* القائمة المذكورة هي أمثلة استرشادية ، ويجوز للمؤسسة الإضافة والحذف تبعا لطبيعة المقرر

اسم وتوقيع
منسق البرنامج
أ.د/ ياسر ميمون

اسم وتوقيع
منسق المقرر
أ.د/أمانى عبد المقصود
د/منى سعيد

مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر سيكولوجيه ذوى الاحتياجات الخاصة

المعارف والفهم		المهارات الذهنية		المهارات المهنية والعملية		المهارات العامة	
نواتج التعلم		نواتج التعلم		نواتج التعلم		نواتج التعلم	
المحاضرة	الحوار	التعلم					
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							
١٦/١٣							
١٥/١٣							
١٤/١٣							
١٣/١٣							
١٢/١٣							
١١/١٣							
١٠/١٣							
٩/١٣							
٨/١٣							
٧/١٣							
٦/١٣							
٥/١٣							
٤/١٣							
٣/١٣							
٢/١٣							
١/١٣							
٣٨/١٣							
٣٧/١٣							
٣٦/١٣							
٣٥/١٣							
٣٤/١٣							
٣٣/١٣							
٣٢/١٣							
٣١/١٣							
٣٠/١٣							
٢٩/١٣							
٢٨/١٣							
٢٧/١٣							
٢٦/١٣							
٢٥/١٣							
٢٤/١٣							
٢٣/١٣							
٢٢/١٣							
٢١/١٣							
٢٠/١٣							
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							
١٦/١٣							
١٥/١٣							
١٤/١٣							
١٣/١٣							
١٢/١٣							
١١/١٣							
١٠/١٣							
٩/١٣							
٨/١٣							
٧/١٣							
٦/١٣							
٥/١٣							
٤/١٣							
٣/١٣							
٢/١٣							
١/١٣							
٣٨/١٣							
٣٧/١٣							
٣٦/١٣							
٣٥/١٣							
٣٤/١٣							
٣٣/١٣							
٣٢/١٣							
٣١/١٣							
٣٠/١٣							
٢٩/١٣							
٢٨/١٣							
٢٧/١٣							
٢٦/١٣							
٢٥/١٣							
٢٤/١٣							
٢٣/١٣							
٢٢/١٣							
٢١/١٣							
٢٠/١٣							
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							
١٦/١٣							
١٥/١٣							
١٤/١٣							
١٣/١٣							
١٢/١٣							
١١/١٣							
١٠/١٣							
٩/١٣							
٨/١٣							
٧/١٣							
٦/١٣							
٥/١٣							
٤/١٣							
٣/١٣							
٢/١٣							
١/١٣							
٣٨/١٣							
٣٧/١٣							
٣٦/١٣							
٣٥/١٣							
٣٤/١٣							
٣٣/١٣							
٣٢/١٣							
٣١/١٣							
٣٠/١٣							
٢٩/١٣							
٢٨/١٣							
٢٧/١٣							
٢٦/١٣							
٢٥/١٣							
٢٤/١٣							
٢٣/١٣							
٢٢/١٣							
٢١/١٣							
٢٠/١٣							
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							
١٦/١٣							
١٥/١٣							
١٤/١٣							
١٣/١٣							
١٢/١٣							
١١/١٣							
١٠/١٣							
٩/١٣							
٨/١٣							
٧/١٣							
٦/١٣							
٥/١٣							
٤/١٣							
٣/١٣							
٢/١٣							
١/١٣							
٣٨/١٣							
٣٧/١٣							
٣٦/١٣							
٣٥/١٣							
٣٤/١٣							
٣٣/١٣							
٣٢/١٣							
٣١/١٣							
٣٠/١٣							
٢٩/١٣							
٢٨/١٣							
٢٧/١٣							
٢٦/١٣							
٢٥/١٣							
٢٤/١٣							
٢٣/١٣							
٢٢/١٣							
٢١/١٣							
٢٠/١٣							
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							
١٦/١٣							
١٥/١٣							
١٤/١٣							
١٣/١٣							
١٢/١٣							
١١/١٣							
١٠/١٣							
٩/١٣							
٨/١٣							
٧/١٣							
٦/١٣							
٥/١٣							
٤/١٣							
٣/١٣							
٢/١٣							
١/١٣							
٣٨/١٣							
٣٧/١٣							
٣٦/١٣							
٣٥/١٣							
٣٤/١٣							
٣٣/١٣							
٣٢/١٣							
٣١/١٣							
٣٠/١٣							
٢٩/١٣							
٢٨/١٣							
٢٧/١٣							
٢٦/١٣							
٢٥/١٣							
٢٤/١٣							
٢٣/١٣							
٢٢/١٣							
٢١/١٣							
٢٠/١٣							
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							
١٦/١٣							
١٥/١٣							
١٤/١٣							
١٣/١٣							
١٢/١٣							
١١/١٣							
١٠/١٣							
٩/١٣							
٨/١٣							
٧/١٣							
٦/١٣							
٥/١٣							
٤/١٣							
٣/١٣							
٢/١٣							
١/١٣							
٣٨/١٣							
٣٧/١٣							
٣٦/١٣							
٣٥/١٣							
٣٤/١٣							
٣٣/١٣							
٣٢/١٣							
٣١/١٣							
٣٠/١٣							
٢٩/١٣							
٢٨/١٣							
٢٧/١٣							
٢٦/١٣							
٢٥/١٣							
٢٤/١٣							
٢٣/١٣							
٢٢/١٣							
٢١/١٣							
٢٠/١٣							
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							
١٦/١٣							
١٥/١٣							
١٤/١٣							
١٣/١٣							
١٢/١٣							
١١/١٣							
١٠/١٣							
٩/١٣							
٨/١٣							
٧/١٣							
٦/١٣							
٥/١٣							
٤/١٣							
٣/١٣							
٢/١٣							
١/١٣							
٣٨/١٣							
٣٧/١٣							
٣٦/١٣							
٣٥/١٣							
٣٤/١٣							
٣٣/١٣							
٣٢/١٣							
٣١/١٣							
٣٠/١٣							
٢٩/١٣							
٢٨/١٣							
٢٧/١٣							
٢٦/١٣							
٢٥/١٣							
٢٤/١٣							
٢٣/١٣							
٢٢/١٣							
٢١/١٣							
٢٠/١٣							
١٩/١٣							
١٨/١٣							
١٧/١٣							

أستاذ المقرر : ا.د/ أمانى عبد المقصود

رئيس مجلس القسم : أ.د/ ياسر ميمون

قائمة المحتويات

مصفوفة أساليب التقييم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة

أساليب التقييم	نواتج التعلم المستهدفة للمقرر																																			أعمال السنة	الامتحان																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	المعرفة والفهم										المهارات الذهنية										المهارات المهنية والعملية							المهارات العامة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	نواتج التعلم										نواتج التعلم										نواتج التعلم							نواتج التعلم																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
١٩/١٢/٢٠٢٣	١٨/١٢/٢٠٢٣	١٧/١٢/٢٠٢٣	١٦/١٢/٢٠٢٣	١٥/١٢/٢٠٢٣	١٤/١٢/٢٠٢٣	١٣/١٢/٢٠٢٣	١٢/١٢/٢٠٢٣	١١/١٢/٢٠٢٣	١٠/١٢/٢٠٢٣	٩/١٢/٢٠٢٣	٨/١٢/٢٠٢٣	٧/١٢/٢٠٢٣	٦/١٢/٢٠٢٣	٥/١٢/٢٠٢٣	٤/١٢/٢٠٢٣	٣/١٢/٢٠٢٣	٢/١٢/٢٠٢٣	١/١٢/٢٠٢٣	٣٠/١١/٢٠٢٣	٢٩/١١/٢٠٢٣	٢٨/١١/٢٠٢٣	٢٧/١١/٢٠٢٣	٢٦/١١/٢٠٢٣	٢٥/١١/٢٠٢٣	٢٤/١١/٢٠٢٣	٢٣/١١/٢٠٢٣	٢٢/١١/٢٠٢٣	٢١/١١/٢٠٢٣	٢٠/١١/٢٠٢٣	١٩/١١/٢٠٢٣	١٨/١١/٢٠٢٣	١٧/١١/٢٠٢٣	١٦/١١/٢٠٢٣	١٥/١١/٢٠٢٣	١٤/١١/٢٠٢٣	١٣/١١/٢٠٢٣	١٢/١١/٢٠٢٣	١١/١١/٢٠٢٣	١٠/١١/٢٠٢٣	٩/١١/٢٠٢٣	٨/١١/٢٠٢٣	٧/١١/٢٠٢٣	٦/١١/٢٠٢٣	٥/١١/٢٠٢٣	٤/١١/٢٠٢٣	٣/١١/٢٠٢٣	٢/١١/٢٠٢٣	١/١١/٢٠٢٣	٣٠/١٠/٢٠٢٣	٢٩/١٠/٢٠٢٣	٢٨/١٠/٢٠٢٣	٢٧/١٠/٢٠٢٣	٢٦/١٠/٢٠٢٣	٢٥/١٠/٢٠٢٣	٢٤/١٠/٢٠٢٣	٢٣/١٠/٢٠٢٣	٢٢/١٠/٢٠٢٣	٢١/١٠/٢٠٢٣	٢٠/١٠/٢٠٢٣	١٩/١٠/٢٠٢٣	١٨/١٠/٢٠٢٣	١٧/١٠/٢٠٢٣	١٦/١٠/٢٠٢٣	١٥/١٠/٢٠٢٣	١٤/١٠/٢٠٢٣	١٣/١٠/٢٠٢٣	١٢/١٠/٢٠٢٣	١١/١٠/٢٠٢٣	١٠/١٠/٢٠٢٣	٩/١٠/٢٠٢٣	٨/١٠/٢٠٢٣	٧/١٠/٢٠٢٣	٦/١٠/٢٠٢٣	٥/١٠/٢٠٢٣	٤/١٠/٢٠٢٣	٣/١٠/٢٠٢٣	٢/١٠/٢٠٢٣	١/١٠/٢٠٢٣	٣٠/٩/٢٠٢٣	٢٩/٩/٢٠٢٣	٢٨/٩/٢٠٢٣	٢٧/٩/٢٠٢٣	٢٦/٩/٢٠٢٣	٢٥/٩/٢٠٢٣	٢٤/٩/٢٠٢٣	٢٣/٩/٢٠٢٣	٢٢/٩/٢٠٢٣	٢١/٩/٢٠٢٣	٢٠/٩/٢٠٢٣	١٩/٩/٢٠٢٣	١٨/٩/٢٠٢٣	١٧/٩/٢٠٢٣	١٦/٩/٢٠٢٣	١٥/٩/٢٠٢٣	١٤/٩/٢٠٢٣	١٣/٩/٢٠٢٣	١٢/٩/٢٠٢٣	١١/٩/٢٠٢٣	١٠/٩/٢٠٢٣	٩/٩/٢٠٢٣	٨/٩/٢٠٢٣	٧/٩/٢٠٢٣	٦/٩/٢٠٢٣	٥/٩/٢٠٢٣	٤/٩/٢٠٢٣	٣/٩/٢٠٢٣	٢/٩/٢٠٢٣	١/٩/٢٠٢٣	٣٠/٨/٢٠٢٣	٢٩/٨/٢٠٢٣	٢٨/٨/٢٠٢٣	٢٧/٨/٢٠٢٣	٢٦/٨/٢٠٢٣	٢٥/٨/٢٠٢٣	٢٤/٨/٢٠٢٣	٢٣/٨/٢٠٢٣	٢٢/٨/٢٠٢٣	٢١/٨/٢٠٢٣	٢٠/٨/٢٠٢٣	١٩/٨/٢٠٢٣	١٨/٨/٢٠٢٣	١٧/٨/٢٠٢٣	١٦/٨/٢٠٢٣	١٥/٨/٢٠٢٣	١٤/٨/٢٠٢٣	١٣/٨/٢٠٢٣	١٢/٨/٢٠٢٣	١١/٨/٢٠٢٣	١٠/٨/٢٠٢٣	٩/٨/٢٠٢٣	٨/٨/٢٠٢٣	٧/٨/٢٠٢٣	٦/٨/٢٠٢٣	٥/٨/٢٠٢٣	٤/٨/٢٠٢٣	٣/٨/٢٠٢٣	٢/٨/٢٠٢٣	١/٨/٢٠٢٣	٣٠/٧/٢٠٢٣	٢٩/٧/٢٠٢٣	٢٨/٧/٢٠٢٣	٢٧/٧/٢٠٢٣	٢٦/٧/٢٠٢٣	٢٥/٧/٢٠٢٣	٢٤/٧/٢٠٢٣	٢٣/٧/٢٠٢٣	٢٢/٧/٢٠٢٣	٢١/٧/٢٠٢٣	٢٠/٧/٢٠٢٣	١٩/٧/٢٠٢٣	١٨/٧/٢٠٢٣	١٧/٧/٢٠٢٣	١٦/٧/٢٠٢٣	١٥/٧/٢٠٢٣	١٤/٧/٢٠٢٣	١٣/٧/٢٠٢٣	١٢/٧/٢٠٢٣	١١/٧/٢٠٢٣	١٠/٧/٢٠٢٣	٩/٧/٢٠٢٣	٨/٧/٢٠٢٣	٧/٧/٢٠٢٣	٦/٧/٢٠٢٣	٥/٧/٢٠٢٣	٤/٧/٢٠٢٣	٣/٧/٢٠٢٣	٢/٧/٢٠٢٣	١/٧/٢٠٢٣	٣٠/٦/٢٠٢٣	٢٩/٦/٢٠٢٣	٢٨/٦/٢٠٢٣	٢٧/٦/٢٠٢٣	٢٦/٦/٢٠٢٣	٢٥/٦/٢٠٢٣	٢٤/٦/٢٠٢٣	٢٣/٦/٢٠٢٣	٢٢/٦/٢٠٢٣	٢١/٦/٢٠٢٣	٢٠/٦/٢٠٢٣	١٩/٦/٢٠٢٣	١٨/٦/٢٠٢٣	١٧/٦/٢٠٢٣	١٦/٦/٢٠٢٣	١٥/٦/٢٠٢٣	١٤/٦/٢٠٢٣	١٣/٦/٢٠٢٣	١٢/٦/٢٠٢٣	١١/٦/٢٠٢٣	١٠/٦/٢٠٢٣	٩/٦/٢٠٢٣	٨/٦/٢٠٢٣	٧/٦/٢٠٢٣	٦/٦/٢٠٢٣	٥/٦/٢٠٢٣	٤/٦/٢٠٢٣	٣/٦/٢٠٢٣	٢/٦/٢٠٢٣	١/٦/٢٠٢٣	٣٠/٥/٢٠٢٣	٢٩/٥/٢٠٢٣	٢٨/٥/٢٠٢٣	٢٧/٥/٢٠٢٣	٢٦/٥/٢٠٢٣	٢٥/٥/٢٠٢٣	٢٤/٥/٢٠٢٣	٢٣/٥/٢٠٢٣	٢٢/٥/٢٠٢٣	٢١/٥/٢٠٢٣	٢٠/٥/٢٠٢٣	١٩/٥/٢٠٢٣	١٨/٥/٢٠٢٣	١٧/٥/٢٠٢٣	١٦/٥/٢٠٢٣	١٥/٥/٢٠٢٣	١٤/٥/٢٠٢٣	١٣/٥/٢٠٢٣	١٢/٥/٢٠٢٣	١١/٥/٢٠٢٣	١٠/٥/٢٠٢٣	٩/٥/٢٠٢٣	٨/٥/٢٠٢٣	٧/٥/٢٠٢٣	٦/٥/٢٠٢٣	٥/٥/٢٠٢٣	٤/٥/٢٠٢٣	٣/٥/٢٠٢٣	٢/٥/٢٠٢٣	١/٥/٢٠٢٣	٣٠/٤/٢٠٢٣	٢٩/٤/٢٠٢٣	٢٨/٤/٢٠٢٣	٢٧/٤/٢٠٢٣	٢٦/٤/٢٠٢٣	٢٥/٤/٢٠٢٣	٢٤/٤/٢٠٢٣	٢٣/٤/٢٠٢٣	٢٢/٤/٢٠٢٣	٢١/٤/٢٠٢٣	٢٠/٤/٢٠٢٣	١٩/٤/٢٠٢٣	١٨/٤/٢٠٢٣	١٧/٤/٢٠٢٣	١٦/٤/٢٠٢٣	١٥/٤/٢٠٢٣	١٤/٤/٢٠٢٣	١٣/٤/٢٠٢٣	١٢/٤/٢٠٢٣	١١/٤/٢٠٢٣	١٠/٤/٢٠٢٣	٩/٤/٢٠٢٣	٨/٤/٢٠٢٣	٧/٤/٢٠٢٣	٦/٤/٢٠٢٣	٥/٤/٢٠٢٣	٤/٤/٢٠٢٣	٣/٤/٢٠٢٣	٢/٤/٢٠٢٣	١/٤/٢٠٢٣	٣٠/٣/٢٠٢٣	٢٩/٣/٢٠٢٣	٢٨/٣/٢٠٢٣	٢٧/٣/٢٠٢٣	٢٦/٣/٢٠٢٣	٢٥/٣/٢٠٢٣	٢٤/٣/٢٠٢٣	٢٣/٣/٢٠٢٣	٢٢/٣/٢٠٢٣	٢١/٣/٢٠٢٣	٢٠/٣/٢٠٢٣	١٩/٣/٢٠٢٣	١٨/٣/٢٠٢٣	١٧/٣/٢٠٢٣	١٦/٣/٢٠٢٣	١٥/٣/٢٠٢٣	١٤/٣/٢٠٢٣	١٣/٣/٢٠٢٣	١٢/٣/٢٠٢٣	١١/٣/٢٠٢٣	١٠/٣/٢٠٢٣	٩/٣/٢٠٢٣	٨/٣/٢٠٢٣	٧/٣/٢٠٢٣	٦/٣/٢٠٢٣	٥/٣/٢٠٢٣	٤/٣/٢٠٢٣	٣/٣/٢٠٢٣	٢/٣/٢٠٢٣	١/٣/٢٠٢٣	٣٠/٢/٢٠٢٣	٢٩/٢/٢٠٢٣	٢٨/٢/٢٠٢٣	٢٧/٢/٢٠٢٣	٢٦/٢/٢٠٢٣	٢٥/٢/٢٠٢٣	٢٤/٢/٢٠٢٣	٢٣/٢/٢٠٢٣	٢٢/٢/٢٠٢٣	٢١/٢/٢٠٢٣	٢٠/٢/٢٠٢٣	١٩/٢/٢٠٢٣	١٨/٢/٢٠٢٣	١٧/٢/٢٠٢٣	١٦/٢/٢٠٢٣	١٥/٢/٢٠٢٣	١٤/٢/٢٠٢٣	١٣/٢/٢٠٢٣	١٢/٢/٢٠٢٣	١١/٢/٢٠٢٣	١٠/٢/٢٠٢٣	٩/٢/٢٠٢٣	٨/٢/٢٠٢٣	٧/٢/٢٠٢٣	٦/٢/٢٠٢٣	٥/٢/٢٠٢٣	٤/٢/٢٠٢٣	٣/٢/٢٠٢٣	٢/٢/٢٠٢٣	١/٢/٢٠٢٣	٣٠/١/٢٠٢٣	٢٩/١/٢٠٢٣	٢٨/١/٢٠٢٣	٢٧/١/٢٠٢٣	٢٦/١/٢٠٢٣	٢٥/١/٢٠٢٣	٢٤/١/٢٠٢٣	٢٣/١/٢٠٢٣	٢٢/١/٢٠٢٣	٢١/١/٢٠٢٣	٢٠/١/٢٠٢٣	١٩/١/٢٠٢٣	١٨/١/٢٠٢٣	١٧/١/٢٠٢٣	١٦/١/٢٠٢٣	١٥/١/٢٠٢٣	١٤/١/٢٠٢٣	١٣/١/٢٠٢٣	١٢/١/٢٠٢٣	١١/١/٢٠٢٣	١٠/١/٢٠٢٣	٩/١/٢٠٢٣	٨/١/٢٠٢٣	٧/١/٢٠٢٣	٦/١/٢٠٢٣	٥/١/٢٠٢٣	٤/١/٢٠٢٣	٣/١/٢٠٢٣	٢/١/٢٠٢٣	١/١/٢٠٢٣	٣٠/١٢/٢٠٢٣	٢٩/١٢/٢٠٢٣	٢٨/١٢/٢٠٢٣	٢٧/١٢/٢٠٢٣	٢٦/١٢/٢٠٢٣	٢٥/١٢/٢٠٢٣	٢٤/١٢/٢٠٢٣	٢٣/١٢/٢٠٢٣	٢٢/١٢/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	٢٠/١٢/٢٠٢٣	١٩/١٢/٢٠٢٣	١٨/١٢/٢٠٢٣	١٧/١٢/٢٠٢٣	١٦/١٢/٢٠٢٣	١٥/١٢/٢٠٢٣	١٤/١٢/٢٠٢٣	١٣/١٢/٢٠٢٣	١٢/١٢/٢٠٢٣	١١/١٢/٢٠٢٣	١٠/١٢/٢٠٢٣	٩/١٢/٢٠٢٣	٨/١٢/٢٠٢٣	٧/١٢/٢٠٢٣	٦/١٢/٢٠٢٣	٥/١٢/٢٠٢٣	٤/١٢/٢٠٢٣	٣/١٢/٢٠٢٣	٢/١٢/٢٠٢٣	١/١٢/٢٠٢٣	٣٠/١١/٢٠٢٣	٢٩/١١/٢٠٢٣	٢٨/١١/٢٠٢٣	٢٧/١١/٢٠٢٣	٢٦/١١/٢٠٢٣	٢٥/١١/٢٠٢٣	٢٤/١١/٢٠٢٣	٢٣/١١/٢٠٢٣	٢٢/١١/٢٠٢٣	٢١/١١/٢٠٢٣	٢٠/١١/٢٠٢٣	١٩/١١/٢٠٢٣	١٨/١١/٢٠٢٣	١٧/١١/٢٠٢٣	١٦/١١/٢٠٢٣	١٥/١١/٢٠٢٣	١٤/١١/٢٠٢٣	١٣/١١/٢٠٢٣	١٢/١١/٢٠٢٣	١١/١١/٢٠٢٣	١٠/١١/٢٠٢٣	٩/١١/٢٠٢٣	٨/١١/٢٠٢٣	٧/١١/٢٠٢٣	٦/١١/٢٠٢٣	٥/١١/٢٠٢٣	٤/١١/٢٠٢٣	٣/١١/٢٠٢٣	٢/١١/٢٠٢٣	١/١١/٢٠٢٣	٣٠/١٠/٢٠٢٣	٢٩/١٠/٢٠٢٣	٢٨/١٠/٢٠٢٣	٢٧/١٠/٢٠٢٣	٢٦/١٠/٢٠٢٣	٢٥/١٠/٢٠٢٣	٢٤/١٠/٢٠٢٣	٢٣/١٠/٢٠٢٣	٢٢/١٠/٢٠٢٣	٢١/١٠/٢٠٢٣	٢٠/١٠/٢٠٢٣	١٩/١٠/٢٠٢٣	١٨/١٠/٢٠٢٣	١٧/١٠/٢٠٢٣	١٦/١٠/٢٠٢٣	١٥/١٠/٢٠٢٣	١٤/١٠/٢٠٢٣	١٣/١٠/٢٠٢٣	١٢/١٠/٢٠٢٣	١١/١٠/٢٠٢٣	١٠/١٠/٢٠٢٣	٩/١٠/٢٠٢٣	٨/١٠/٢٠٢٣	٧/١٠/٢٠٢٣	٦/١٠/٢٠٢٣	٥/١٠/٢٠٢٣	٤/١٠/٢٠٢٣	٣/١٠/٢٠٢٣	٢/١٠/٢٠٢٣	١/١٠/٢٠٢٣	٣٠/٩/٢٠٢٣	٢٩/٩/٢٠٢٣	٢٨/٩/٢٠٢٣	٢٧/٩/٢٠٢٣	٢٦/٩/٢٠٢٣	٢٥/٩/٢٠٢٣	٢٤/٩/٢٠٢٣	٢٣/٩/٢٠٢٣	٢٢/٩/٢٠٢٣	٢١/٩/٢٠٢٣	٢٠/٩/٢٠٢٣	١٩/٩/٢٠٢٣	١٨/٩/٢٠٢٣	١٧/٩/٢٠٢٣	١٦/٩/٢٠٢٣	١٥/٩/٢٠٢٣	١٤/٩/٢٠٢٣	١٣/٩/٢٠٢٣	١٢/٩/٢٠٢٣	١١/٩/٢٠٢٣	١٠/٩/٢٠٢٣	٩/٩/٢٠٢٣	٨/٩/٢٠٢٣	٧/٩/٢٠٢٣	٦/٩/٢٠٢٣	٥/٩/٢٠٢٣	٤/٩/٢٠٢٣	٣/٩/٢٠٢٣	٢/٩/٢٠٢٣	١/٩/٢٠٢٣	٣٠/٨/٢٠٢٣	٢٩/٨/٢٠٢٣	٢٨/٨/٢٠٢٣	٢٧/٨/٢٠٢٣	٢٦/٨/٢٠٢٣	٢٥/٨/٢٠٢٣	٢٤/٨/٢٠٢٣	٢٣/٨/٢٠٢٣	٢٢/٨/٢٠٢٣	٢١/٨/٢٠٢٣	٢٠/٨/٢٠٢٣	١٩/٨/٢٠٢٣	١٨/٨/٢٠٢٣	١٧/٨/٢٠٢٣	١٦/٨/٢٠٢٣	١٥/٨/٢٠٢٣	١٤/٨/٢٠٢٣	١٣/٨/٢٠٢٣	١٢/٨/٢٠٢٣	١١/٨/٢٠٢٣	١٠/٨/٢٠٢٣	٩/٨/٢٠٢٣	٨/٨/٢٠٢٣	٧/٨/٢٠٢٣	٦/٨/٢٠٢٣	٥/٨/٢٠٢٣	٤/٨/٢٠٢٣	٣/٨/٢٠٢٣	٢/٨/٢٠٢٣	١/٨/٢٠٢٣	٣٠/٧/٢٠٢٣	٢٩/٧/٢٠٢٣	٢٨/٧/٢٠٢٣	٢٧/٧/٢٠٢٣	٢٦/٧/٢٠٢٣	٢٥/٧/٢٠٢٣	٢٤/٧/٢٠٢٣	٢٣/٧/٢٠٢٣	٢٢/٧/٢٠٢٣	٢١/٧/٢٠٢٣	٢٠/٧/٢٠٢٣	١٩/٧/٢٠٢٣	١٨/٧/٢٠٢٣	١٧/٧/٢٠٢٣	١٦/٧/٢٠٢٣	١٥/٧/٢٠٢٣	١٤/٧/٢٠٢٣	١٣/٧/٢٠٢٣	١٢/٧/٢٠٢٣	١١/٧/٢٠٢٣	١٠/٧/٢٠٢٣	٩/٧/٢٠٢٣	٨/٧/٢٠٢٣	٧/٧/٢٠٢٣	٦/٧/٢٠٢٣	٥/٧/٢٠٢٣	٤/٧/٢٠٢٣	٣/٧/٢٠٢٣	٢/٧/٢٠٢٣	١/٧/٢٠٢٣	٣٠/٦/٢٠٢٣	٢٩/٦/٢٠٢٣	٢٨/٦/٢٠٢٣	٢٧/٦/٢٠٢٣	٢٦/٦/٢٠٢٣	٢٥/٦/٢٠٢٣	٢٤/٦/٢٠٢٣	٢٣/٦/٢٠٢٣	٢٢/٦/٢٠٢٣	٢١/٦/٢٠٢٣	٢٠/٦/٢٠٢٣	١٩/٦/٢٠٢٣	١٨/٦/٢٠٢٣	١٧/٦/٢٠٢٣	١٦/٦/٢٠٢٣	١٥/٦/٢٠٢٣	١٤/٦/٢٠٢٣	١٣/٦/٢٠٢٣	١٢/٦/٢٠٢٣	١١/٦/٢٠٢٣	١٠/٦/٢٠٢٣	٩/٦/٢٠٢٣	٨/٦/٢٠٢٣	٧/٦/٢٠٢٣	٦/٦/٢٠٢٣	٥/٦/٢٠٢٣	٤/٦/٢٠٢٣	٣/٦/٢٠٢٣	٢/٦/٢٠٢٣	١/٦/٢٠٢٣	٣٠/٥/٢٠٢٣	٢٩/٥/٢٠٢٣	٢٨/٥/٢٠٢٣	٢٧/٥/٢٠٢٣	٢٦/٥/٢٠٢٣	٢٥/٥/٢٠٢٣	٢٤/٥/٢٠٢٣	٢٣/٥/٢٠٢٣	٢٢/٥/٢٠٢٣	٢١/٥/٢٠٢٣	٢٠/٥/٢٠٢٣	١٩/٥/٢٠٢٣	١٨/٥/٢٠٢٣	١٧/٥/٢٠٢٣	١٦/٥/٢٠٢٣	١٥/٥/٢٠٢٣	١٤/٥/٢٠٢٣	١٣/٥/٢٠٢٣	١٢/٥/٢٠٢٣	١١/٥/٢٠٢٣	١٠/٥/٢٠٢٣	٩/٥/٢٠٢٣	٨/٥/٢٠٢٣	٧

رئيس مجلس القسم : أ.د/ ياسر ميمون

أستاذ المقرر : د.أ. / امانى عبد المقصود

قائمة المحتويات

مصنوفة مخرجات التعلم المستهدفة لمقرر سيكولوجيه ذوى الاحتياجات الخاصة

[illegible]

قائمة المحتويات

Contents

٢	الرؤية والرسالة.....
Error! Bookmark not defined.	الرؤية.....
Error! Bookmark not defined.	الرسالة.....
١١	قائمة المحتويات.....
١٧	سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة.....
١٧	مقدمة:.....
٢٠	الفصل الأول.....
٢٠	مفهوم ذوى الاحتياجات الخاصة.....
٢١	مخرجات التعلم المستهدفة.....
٢٢	تمهيد:.....
٢٣	تصنيفات ذوى الفئات الخاصة:.....
٢٣	
٢٦	الإعاقة Handicap.....
٢٦	مفهوم الإعاقة:.....
٢٦	
٢٨	أسباب الإعاقة:.....
٣٢	الآثار السلبية لمشكلة الإعاقة:.....
٣٢	
٣٥	أنشطة تدريبية.....
٣٦	روابط الكترونية.....
٣٧	الفصل الثانى.....
٣٧	تصنيف ذوى الاحتياجات الخاصة.....
٣٨	مخرجات التعلم المستهدفة.....
٣٩	أولاً: الإعاقة الحركية Orthopedic Handicap.....
٤٠	ثانياً: الإعاقة السمعية (الأصم-ضعف السمع): Hearing Impariment.....
٤٢	مفهوم الإعاقة السمعية: Hearing Impariment.....
٤٣	الصمم:.....
٤٤	ضعاف السمع:.....

قائمة المحتويات

٤٤	أسباب الإعاقة السمعية:
٤٥	أسباب وراثية:
٤٥	أسباب بيئية (مكتسبة):
٤٦	خصائص المعاقين سمعياً:
٤٧	أثر الإعاقة السمعية على مظاهر النمو:
٥٠	مشكلات المعاقين سمعياً:
٥١	أساليب التواصل لدى ذوي الإعاقة السمعية:
٥٣	ثالثاً: الإعاقة البصرية (الكفيف - ضعاف البصر):
٥٤	تعريف الإعاقة البصرية:
٥٦	أنواع كف البصر:
٥٧	-أسباب الإعاقة البصرية وطرق الوقاية:
٥٧	-خصائص المعاقين بصرياً:
٦٠	-الخصائص المميزة للطفل الكفيف في مرحلة ما قبل المدرسة:
٦٣	المشكلات النفسية والاجتماعية لدى المكفوفين:
٦٤	رابعاً: الإعاقة العقلية: Mental Retardation (M.R) / Intellectual Disability
٦٥	مفهوم الإعاقة العقلية:
٦٨	تصنيف الإعاقة العقلية:
٦٩	أولاً: التصنيف الإكلينيكي:
٧٢	ثانياً: التصنيفات السلوكية الوظيفية:-
٧٢	أسباب الإعاقة العقلية:-
٧٥	خصائص المعاقين عقلية القابلين للتعلم:
٧٧	د- الخصائص اللغوية Languages Skills
٧٨	النظريات المفسرة لأسباب الإعاقة العقلية:
٧٨	أ- نظرية التحليل النفسي:
٧٨	ب- نظرية العقل:
٧٨	ج- نظرية الاضطراب الأيضي:
٧٩	د- نظرية التسمم بالمعادن واللحاحات:
٧٩	-تشخيص الإعاقة العقلية:
٨٠	متلازمة أعراض داون:-
٨٢	مشكلات المعاق عقلياً:
٨٤	خامساً: اضطرابات التواصل (اضطراب التوحد):
٨٤	تمهيد:
٨٧	مفهوم التوحد: Autism
٨٩	النظريات المفسرة لاضطراب الذاتوية (التوحد):-
٨٩	- النظرية النفسية: Psychological Theory
٨٩	-نظرية حجم المخ:

٩٠	 نظرية الذات: Self Theory
٩٠	 أعراض اضطراب التوحد:
٩٠	-خصائص الأطفال التوحدين:
٩١	 خصائص السلوك الاجتماعي لدى الأطفال ذوي طيف التوحد:
٩٢	 ١- قصور في نموهم الاجتماعي :
٩٢	 ٢- قصور في التواصل مع الآخرين :
٩٢	 ٣- اهتمامات وميول وسلوكيات مقيدة وتكرارية :
٩٤	 أسباب التوحد:
٩٤	
٩٥	 نسبة انتشار اضطراب التوحد:
٩٦	 المشاكل الرئيسية للأطفال المصابين بالتوحد:-
٩٦	 المهارات الاجتماعية لدى أطفال طيف التوحد:
٩٧	 سادساً: صعوبات التعلم:
٩٨	 تعريف صعوبات التعلم Learning Disability:
٩٩	 محكات تشخيص صعوبات التعلم:
٩٩	 أنواع صعوبات التعلم:
١٠٠	 خصائص ذوي صعوبات التعلم:
١٠٠	 - الخصائص المعرفية:-
١٠٠	-الخصائص الوجدانية لصعوبات التعلم:
١٠٠	 - الخصائص العقلية للاضطرابات اللفظية:-
١٠١	-الخصائص الانفعالية للاضطرابات اللفظية:
١٠١	 سابعاً: فرط الحركة المصحوب بنقص الانتباه ADHD
١٠٢	 مفهوم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:
١٠٦	-الآثار السلبية لتشتت الانتباه المصحوب بفرط الحركة:
١٠٧	 اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عند الكبار:
١٠٨	 ثامناً: اضطرابات اللغة والتواصل:
١٠٩	 مفهوم اللغة والتواصل:
١١٠	 تعريف اضطرابات اللغة والتواصل:
١١٠	-تصنيف اضطرابات اللغة والتواصل:
١١١	 مشكلات اللغة والتواصل لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية:
١١٣	 أنشطة تدريبية
١١٤	 روابط إلكترونية
١١٥	
١١٥	 الفصل الثالث.....
١١٥	 الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال.....
١١٥	 ذوي الاحتياجات الخاصة.....
١١٦	 مخرجات التعلم المستهدفة

١١٧	تمهيد:
١١٩	-حقوق المرأة المعاقة ذهنياً:
١١٩	-الحاجات الأساسية لأسر الأطفال المعاقين عقلياً:-
١٢٢	-دور الأسرة في إشباع حاجات الأبناء المعاقين ذهنياً:-
١٢٤	*الضغوط النفسية التي يتعرض لها آباء وأسر الأطفال المعاقين ذهنياً وافتقارهم لكيفية إدارتها: -
١٢٥	-دور الوالدين في ارتقاء وتحسين مستوى التوافق النفسي لأبنائهم المعاقين عقلياً:
١٢٥	
١٢٧	*الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع والدي المعاق:-
١٢٧	-جودة الحياة الأسرية واضطرابات اللغة والتواصل:
١٢٩	أنشطة تدريبية
١٢٩	روابط إلكترونية
١٣٠	الفصل الرابع:
١٣٠	ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية المستدامة (برامج التدخل).
١٣٠	الأهداف التربوية والتأهيلية لبرامج الأطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعلم:
١٣١	مخرجات التعلم المستهدفة
١٣٢	المبادئ الأساسية في إرشاد المعاقين بشكل عام :
١٣٢	المبادئ الأساسية في إرشاد أسرة المعاق:
١٣٢	الخدمات الإرشادية:
١٣٣	*الأهداف التربوية والتأهيلية لبرامج الأطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعلم:
١٣٤	-التدريب على المهارات الاجتماعية كطريقة علاجية:
١٣٨	استراتيجية اللعب وأهميته:
١٣٨	مفهوم اللعب:
١٤٠	-اللعب والطفل التوحدي:
١٤١	ملاح البرامج الإرشادية والتأهيلية لأسر الأطفال المعاقين عقلياً:-
١٤٢	كيفية التعامل مع الطفولة المعاقة ذهنياً:
١٤٢	التأهيل النفسي للمعاقين: Psychological Rehabilitation
١٤٣	أهداف برامج التأهيل النفسي:
١٤٣	طرق تعليم الأطفال:
١٤٤	المحافظة على نفسية الطفل ذوي الإعاقة
١٤٥	دور الأسرة في تعديل الاتجاه نحو الابن وأساليب معاملته:
١٤٥	-تعامل الأسرة مع أخوة الطفل المعاق:
١٤٦	تفاعل الأسرة مع المجتمع المحيط وأسر الأطفال المعاقين:
١٤٧	دور أسرة الطفل المعاق في التفاعل مع المجتمع:
١٤٧	تعاون الأسرة مع الفنيين المعنيين بحالة الابن المعاق:
١٤٨	التدخل المبكر
١٤٨	طرق التدخل المبكر:-
١٥٠	١ - البرامج الوقائية في الطفولة المبكرة:

١٥٠	٢- البرامج الإنمائية في الطفولة المبكرة:
١٥١	المهارات الاجتماعية: Social Skills
١٥٣	طرق اكتساب المهارة:
١٥٣	أهمية التقييم وتنمية المهارات:
١٥٣	الألعاب التي تنمي المهارات الاجتماعية للطفل:
١٥٧	قياس المهارات الاجتماعية للأطفال التوحدين:
١٥٧	معايير فاعلية البرامج الموجهة للطفل المصاب بالتوحد:
١٥٩	علاج التوحد:
١٥٩	علاج التوحد في مصر والعالم العربي:
١٦٠	التدخل المبكر في علاج اضطراب التوحد:
١٦١	برامج التدخل:
١٦١	برنامج لوفاس LOVAAS:
١٦١	برنامج تيتش TEACCH:
١٦٢	برنامج بيكس PECS:
١٦٢	برنامج صن رايز Son- Rise:
١٦٣	-السيكودراما Psychodrama:
١٦٤	-العلاج بالموسيقى " Music therapy "
١٦٤	العلاج بالرقص الإيقاعي:
١٦٥	-القصة الموسيقية الحركية:
١٦٥	دور الموسيقى في علاج الإعاقات:
١٦٥	التذوق الموسيقي:-
١٦٦	الموسيقى وعلاقتها بالتوافق النفسي:-
١٦٦	-العلاج بالموسيقى لبعض الأمراض النفسية:-
١٦٧	-العلاج بالموسيقى لبعض الاضطرابات الانفعالية:-
١٦٧	-العلاج بالموسيقى لبعض الاضطرابات السلوكية:-
١٦٧	-استخدام الموسيقى في إحداث بعض التغيرات السلوكية لدى المعاقين ذهنياً:-
١٦٨	دور الأنشطة التعبيرية الفنية في علاج الإعاقات:
١٧٠	-استخدام الفن والرسم مع الأطفال المعاقين:-
١٧٠	
١٧٠	أساليب تعليمية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة:
١٧٣	روابط إلكترونية يمكن الاستفادة منها:
١٧٤	أنشطة تدريبية
١٧٥	الفصل الخامس
١٧٥	التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

١٧٥.....	دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية.....
١٧٦.....	مخرجات التعلم المستهدفة.....
١٧٨.....	الدمج/التمكين Empowerment.....
١٧٨.....	مفهوم التمكين الاجتماعي:.....
١٧٩.....	تعريف الدمج Mainstreaming.....
١٨٠.....	مبشرات الدمج:.....
١٨٠.....	أساليب الدمج:.....
١٨١.....	مزايا الدمج وسلبياته:.....
١٨٢.....	دور جمعيات المجتمع المدني:.....
١٨٤.....	العلاج الأسري لذوي الاحتياجات الخاصة:.....
١٨٥.....	العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء الوالدين والأسرة:.....
١٨٥.....	١- القدرات الشخصية Personal strengths.....
١٨٦.....	٢- أنظمة الدعم Support systems.....
١٨٦.....	٣- المصادر الأسرية Family resources.....
١٨٧.....	٤- مصادر المجتمع Community resources.....
١٨٧.....	٥- الضغوط Stress.....
١٨٧.....	٦- ردود الأفعال / الحزن Reactions / Grieving.....
١٨٨.....	ج- تأثير الضغوط Impact of stress.....
١٨٩.....	مسلمات النموذج متعدد الأبعاد :.....
١٨٩.....	الإجراءات المتبعة لعلاج اضطرابات النطق والكلام:.....
١٩٠.....	**نصائح للأسرة التي لديها طفل يعاني من مشكلات في النطق:.....
١٩١.....	التربية الجنسية والتعامل الاجتماعي للمعاقين ذهنياً.....
١٩١.....	ما هي آثار التحرش الجنسي على نفسية الطفل؟.....
١٩١.....	نصائح للأهل أو القائمين بالرعاية:-.....
١٩٢.....	العناية بالأبناء جنسيا حسب السن:-.....
١٩٢.....	-إذا بلغت البنت ١٠ سنوات:.....
١٩٣.....	-إذا بلغ الولد ١٠ سنوات:.....
١٩٣.....	دراسات وبحوث في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.....
١٩٧.....	أنشطة تدريبية.....
١٩٨.....	المراجع.....

سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة

مقدمة:

تحتل رعاية الطفولة أهمية خاصة فى الفكر الاجتماعى المعاصر، ذلك لأن أطفال اليوم هم رجال الغد وأمل المستقبل والجيل الذى يمكن أن يرتقى بالحياة ووسائلها إلى أعلى مستوى طموح البشر. تلك الطفولة التى كلما قوى عودها وأشدت أزرها ونالت ما تستحق من رعاية واهتمام كلما كان ذلك أدعى إلى تكوين المجتمع السليم الذى ننشده، حيث أن جميع المجتمعات على اختلاف أنواعها خاصة النامية منها هى فى أمس الحاجة إلى خدمات وجهود جميع أبنائها وفئاتها مهما كانت درجة العجز لديهم •

وواقع أن أى جهد يوجه إلى رعاية الطفولة وحمايتها هو فى نفس الوقت تأمين لمستقبل الأمة وتدعيماً لسلامتها وحفاظاً على ثروة البشرية، ومن ثم تعتبر رعاية الطفولة بمثابة العملية البناء الأساسية فى أى مجتمع يسعى إلى تحقيق آماله فى تكوين مجتمع سوى متوازن بعيداً عن العلل الاجتماعية والنفسية (عبد المنعم السنهورى، ١٩٨٦).

وتعتبر مرحلة الطفولة من أخطر فترات الحياة الإنسانية لأن ما يحدث فيها من اضطراب أو إعاقات فى مسار النمو يصعب علاجها فيما بعد مما يؤثر على الإطار العام للشخصية، ونتيجة لذلك فقد لقيت الطفولة اهتماماً عظيماً على مر العصور حتى أصبح الاهتمام بالطفولة ورعايتها هو موضوع الساعة فى مجتمعنا المصرى •

كما تعتبر رعاية وتربية الطفولة غير العادية واجب قومى أبدته روح الديمقراطية التى أكدت حقوق الإنسان، وعلى تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع. وقد تضمنت توصيات بعض المؤتمرات التى تهتم بالطفولة على ضرورة الاهتمام بتربية الأطفال المعاقين واعتبار رعايتهم حقاً إنسانياً تقننه التشريعات والقوانين والعمل على استثمار إمكانيات الطفل المعاق بما يضمن له التوافق مع البيئة المحيطة، وتأهيله للاندماج فى المجتمع الذى يعيش فيه بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج الإثراء والتنمية والرعاية للأطفال المعاقين واعتبار هذه البرامج مطلباً اجتماعياً، وتوجيهها أساسياً فى تربية الأطفال ورعايتهم (المؤتمر السنوى الثانى، ١٩٨٩، ٤؛ المؤتمر السنوى الثالث، ١٩٩٠، ٢) •

وقد أكد ابن القيم الجوزية على أهمية الاهتمام بالطفولة المبكرة وتوفير الرعاية المتكاملة لها، وحث الأسرة على ملاحظة نمو أطفالها مما يسهم فى الاكتشاف المبكر للإعاقة، وأشار إلى أهمية راحة الجسم من الاضطرابات الانفعالية السلوكية.

ومما لا شك فيه أن إثارة موضوع الطفولة المعوقة والمشكلات المتعلقة برعاية الأطفال المعاقين يعتبر من الموضوعات الهامة، خاصة عندما يهتم المجتمع بتحقيق التكيف الاجتماعى لأفراده. والبداية الأولية لرعاية المعوقين هي طفولتهم، فالطفولة هي اللبنة الأولى لتنمية الشخصية والمحور الأساسى والسليم لتقديم الرعاية فى المهد حتى يتم توجيه هذه الطفولة إلى التكيف مع إعاقتها، وإلى استغلال هذه الإعاقة للإبداع والمشاركة فى التنمية والإنتاج.

إن المعاقين يجب أن يجدوا فى غير المعاقين حاجاتهم وسداد ما ينقصهم والدعم اللازم لهم سواء الدعم المادى أو المعنوى أو الاجتماعى أو النفسى، فإذا كان المعاق كفيفاً فيجب أن نجعله يحس أنه يبصر بعيون المبصرين، وإذا كان ضعيفاً فينبغى أن يقوى باستعدادات الأقوياء •• وهكذا.

قائمة المحتويات

لذا تعد إحدى مؤشرات تقدم وارتقاء الأمم مدى العناية التي توليها لرعاية أبنائها منذ بداية نشأتهم في أرحام أمهاتهم وحتى بلوغهم المقدرة على تحمل أعباء الحياة. ويتمثل الاهتمام بالتربية أحد مظاهر تلك الرعاية التي تقدمها الدول لأبنائها، لا سيما رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والمظاهر التربوية التي تقدم لهم سواء كان ذلك من خلال البرامج التي توليها الدولة أو الجهود الأهلية القائمة بها المختصين والمتعاملين مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة (على سبيل المثال لا الحصر: الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة العقلية، الشلل الدماغي أو التوفاقي، والتوحد)، وهذا الاهتمام الذي توليه الدول لأبنائها حكومة وشعباً هو ما يساهم في ألا تكون هذه الفئة من المجتمع مصدراً لإعاقة مسيرة التنمية والتقدم لهذه الدول، بل قد يكون لبعضهم دوراً منتجاً في مجتمعهم، ويصبحون ترساً في ماكينة التنمية وذلك بما تسمح به قدراتهم الفردية وما يتوفر لهم من برامج إعداد وتأهيل وتوظيف لهذه القدرات مع ما يتوافق مع احتياجات المجتمع لهم.

إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المجتمع، فإما أن يعطى الفرصة لتنمية طاقات الأطفال المعوقين وأما يقضى عليها، والدولة عندما ترعى المعاقين من أبنائها بإعاقات حسية أو بدنية أو عقلية وتعمل على تربيتهم وتأهيلهم، فإنما تحولهم من جموع عاطلة تشكل عبئاً على المجتمع إلى قوة عاملة نشطة وسعيدة، كما أنها تكفل لأسرهم الاطمئنان والتخفيف من الأعباء المادية والقلق والتوتر، وتتيح لهم الفرصة للتوافق مع المجتمع والاندماج في صفوفه والمشاركة في مسيرته مشاركة منتجة واعية، انطلاقاً من أن أي جهد أو أي مال أو وقت يبذل لرعايتهم إنما يمثل استثماراً له عائده الجزى بالنسبة لهذا المعوق وبالنسبة للمجتمع أيضاً.

ولأن الإنسان هو عماد التنمية وهدفها سواء كان هذا الإنسان معاق أو غير معاق، وهو أحد العناصر البشرية الهامة التي أخذت الدولة توليه عنايتها واهتمامها وتخطط له للنهوض به بما يتيح مستقبلاً أفضل له ولأسرته ولمجتمعه المحلي، كما أن النهوض بالمعاق باعتباره جزءاً هاماً لا يتجزأ من محاور التنمية الشاملة، حيث لا يمكن أن تقوم الجهود التنموية الناجحة مع إهدار طاقات وإغفال مشاركة المعاقين التي تمثل نسبة غير قليلة للطاقة البشرية في المجتمع.

والإعاقة حالة اجتماعية يخلقها المجتمع، إذ أن إعاقة الفرد جسمياً أو نفسياً أو سلوكياً تصبح كذلك حينما يراها المجتمع أو الفرد ذاته على أنها واقع يشكل اختلافاً غير مرغوب من الآخرين.

إن فئة المعاقين هي فئة من فئات المجتمع أصابها القدر بإعاقة قللت من قدرتهم على القيام بأدوارهم الاجتماعية على الوجه الأكمل مثل الأشخاص العاديين. هذه الفئة هي أحوج إلى أن نتفهم بعض مظاهر الشخصية لديهم نتيجة لما تفرضه الإعاقة من ظروف جسمية ومواقف اجتماعية وصراعات نفسية وإلى أن نتفهم أساليبهم السلوكية التي تعبر عن كثير من التعقيد والتشابك، رغم كل ذلك فإن هذه الفئة لم تلق حتى الآن الاهتمام المناسب سواء من الباحثين أو من المهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن الطبيعي أن لفئة المعاقين متطلبات تربوية ونفسية وجسمية واجتماعية تختلف عن المتطلبات الأخرى للأشخاص العاديين وتختلف أيضاً تبعاً لنوع الإعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات.

كما أنه لو تركت هذه الفئة من الأطفال دون اهتمام بمشاكلهم وتذليل الصعاب التي تواجههم ومساعدتهم على التكيف مع أنفسهم ومع الآخرين ومساعدتهم على تقبل أنفسهم وتقبل إعاقاتهم، فإنه قد يتحول البعض منهم إلى وجهات انحرافية أو يتباطأ نموهم في مختلف جوانب الشخصية، مما قد يعوق تقدم وازدهار المجتمع، لذلك فإن الاستفادة من جهود هذه الفئة واستثمار طاقاتها وتوجيه هذه الطاقات في الإنتاج يعتبر أمراً هاماً وضرورياً.

ويمثل الطفل ذو الاحتياجات الخاصة عائقاً في حياة إخوته وأسرته. ويبدو هذا واضحاً أكثر في الأوساط الشعبية التي ينتشر فيها الفقر والأمية، وتقسو الظروف على الجميع، وخاصة على الأطفال الذين يجدون أنفسهم

محرومين من أبسط أشكال الرعاية. فالزواج يتم بصورة لا تراعى فيها الشروط الصحية التى تضمن إنجاب أطفال أسوياء. وظروف الأسرة وإمكانياتها المادية لا تمكنها أيضا من ضمان هذه الشروط لأبنائها أو تحسين الظروف التى يعيشون فى ظلها. والآباء والأمهات يجهلون أبسط المبادئ والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الأطفال بشكل عام وخاصة مع ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون عبئاً مادياً ونفسياً ثقيلاً على آبائهم وإخوتهم، سواء فى الأسر الفقيرة، أو حتى فى الأسر الغنية، مما يستدعى التفكير فى الطرق التى نستطيع بها مساعدة هذه الأسر فى تحمل أعبائها والتعامل مع أطفالها المعاقين بما يساعد على التخفيف عنهم وقبول الآخرين لهم.

وقد تزايد الاهتمام بدراسة الإعاقات المختلفة وتوفير الرعاية الشاملة لهم حتى يصبحوا طاقة منتجة فعالة بل متفوقة مثلاً:

قاد "روزفلت" الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانتصار فى الحرب العالمية الثانية من فوق كرسيه المتحرك، ووضع "بيتهوفن" أجمل ألحانه وهو أصم ، وصاغ "أبو العلاء المعرى" أجمل الصور الشعرية ببصيرته لا ببصره.

ونقدم إحساس وشعور المعاق وقدراته على التحدي حيث يقول:

ما احتجت منك العطف والاشفاقا	يامن تراني عاجزا ومعاقا
انظر إلي. تري التحدي. ساطعا	في جبهتي. متلألئا. براقا
الله شاء لي الحياة. فكيف. لا	أحيا . أعانق. مثلك. الأفاقا
إن لم أكن. مثل البقية. منتجا	فالعطف لا أحتاجه. إطلاقا
دعني أحاول. أو دربني. علي	عمل. يزيد. مواهبي. إشراقا
ستري . بآني . قادرا. بإرادتي	وعزيمتي أن أقهر. الإملاقا
ثق بي . لتفتح. باب آمالي الذي	إشفاق مثلك. زاده. إغلاقا
كم واحد منا. تحدي عجزه	ومع. الأصحاء. البناة تلاقى
أنا لا أريد . بان. أعيش. كعالة	ما طاب عيش العاجزين. مذاقا

الفصل الأول



مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة

- مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

- فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الإعاقة

- أسباب الإعاقة

- الآثار السلبية لمشكلة الإعاقة

مخرجات التعلم المستهدفة

في نهاية الفصل يصبح الطالب قادرًا على أن:

-يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة.

- يحدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم.

-يوضح أسباب الإعاقة.

-يتفهم الآثار السلبية لمشكلة الإعاقة.

الفصل الأول

مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة

تمهيد:

إن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم بنائي يتسع ليشمل فئات اجتماعية كثيرة غير ذوي الحاجات الخاصة (الجسمية أو الذهنية)، فهناك الإعاقة (العقلية/الذهنية-الحسية/العضوية-السياسية-القانونية – الاقتصادية...). وذوي الاحتياجات الخاصة هم معاقين لأسباب بعضها وراثي وبعضها بيئي (حادث سيارة – إصابة عمل – سوء تقديم الرعاية قبل الحمل وأثناء الولادة، كذلك يضم إليهم المعاق ثقافياً وسياسياً والموهوبون لأنهم ذو احتياج خاص في التعامل) مما يعكس ذلك مدي اتساع فئات الإعاقة.

وتعرف الإعاقة Handicap بكونها فقدان أو تهميش أو محدودية المشاركة في فعاليات وأنشطة وخبرات الحياة الاجتماعية عند مستوي مماثل للعاديين وذلك نتيجة العقبات والموانع Barriers الاجتماعية والبيئية.

وقد تباينت آراء العلماء والباحثين عند التصدي لتحديد المصطلحات والمسميات التي تشير إلي الأفراد الذين يختلفون سلباً عن غيرهم في جانب أو أكثر من جوانب الشخصية أو مظهر من مظاهر النمو، ومن هذه المصطلحات والمسميات العجز disability، الضعف impairment، الإعاقة handicap، الاضطراب disorder. ولعل أهم ما يؤخذ علي هذه المسميات تداولها بين الناس علي أساس أنها وصمة اجتماعية، مما ترتب عليه انخفاض مستوي إدراك هؤلاء الأفراد لأنفسهم وتدني تقديرهم لذواتهم، ومن ثم تزايد لديهم الإحساس بالعجز والألم النفسي، فضلاً عن أن هذه المسميات لا تفيد كثيراً في تحديد نواحي القصور التربوية التي يمكن من خلالها تحديد احتياجاتهم والخدمات اللازمة لهم، كذلك لم تتضمن هذه التسميات مظاهر الاختلافات الإيجابية كالتفوق العقلي والموهبة والإبداع، لذا لجأ بعض الباحثين والعلماء إلي استخدام مصطلحات بديلة تعبر عن التوجه الإيجابي منها مصطلح غير العاديين upnormality أو exceptional، أو ذوي الحاجات أو الاحتياجات الخاصة Persons with special needs، للإشارة إلي من ينحرف أدأؤه في جانب أو أكثر من الشخصية عن متوسط أقرانه من العاديين إلي الحد الذي يلزم معه ضرورة تقديم خدمات أو مظاهر عناية ورعاية خاصة لهم كالخدمات التربوية أو الطبية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو النفسية (عبد المطلب القريطي، ١٩٩٦، ٢٠٠).

وقد اهتمت بعض الدول التي تسعى إلي التقدم والنماء بجهود جميع الأفراد، لذلك أصبحت رعاية ذوي الحاجات الخاصة من العوامل التي من خلالها نستطيع الحكم علي مدي تقدم المجتمعات، ومن أجل هذا الهدف تحاول الدول أن تقدم كافة الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، وتوفير كافة احتياجاتهم، من أجل أن يحيا كل فرد منهم حياة كريمة شريفة دون الشعور بالعجز أو القصور.

ويشهد مجال سيكولوجية الفئات الخاصة تطوراً سريعاً ومطرداً، مما كان له أبلغ الأثر في تحسين ظروف تلك الفئات بما أسهم به علم النفس من تقدم في أساليب التشخيص والعلاج النفسي وما ترتب عليهما من رعاية صحية ونفسية، فضلاً عن ذلك تكوين اتجاهات إيجابية نحو أصحاب هذه الحاجات، حيث ازداد الوعي بتقبلهم وتلبية احتياجاتهم.

وقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة الاهتمام بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة ومشكلاته خاصة مع التزايد المطرد في نسبتهم في مصر، حيث بلغت هذه النسبة ٦٪ من مجموع السكان، وهي نسبة عالية تبعث كثيراً من

قائمة المحتويات

القلق في ظل غيبة الوعي وضعف الإمكانيات المتمثلة في قلة الجمعيات والمراكز المتخصصة في رعاية المعاقين الذين تم الاتفاق على تسميتهم بالفئات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة (محمد عباس، ٢٠٠٣، ١٣).

وقد حدد المؤتمر القومي الأول للتربية الخاصة سنة ١٩٩٥ مصطلح "الفرد ذو الحاجات الخاصة" علي أنه كل فرد يحتاج إلي خدمات خاصة لكي ينمو أو يتعلم أو يتدرب أو يتوافق مع متطلبات حياته اليومية الأسرية أو الوظيفية أو المهنية، ويمكن أن يشارك في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقدر ما يستطيع وبأقصى طاقاته كمواطن.

ويعرف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم الأطفال الذين لديهم تأخر أو إعاقة في إحدى المجالات التالية: النمو الجسمي، النمو العقلي المعرفي، النمو الانفعالي، النمو الاجتماعي، النمو اللغوي، وممن تتراوح أعمارهم الزمنية بين ٣-٩ سنوات، ولكي يطلق على طفل ذوي احتياجات خاصة، لابد أن يتوافر محكين أساسيين هما:

١- أن يكون لدى الطفل واحد أو أكثر من التأخر أو العجز أو الإعاقة في المجالات السابقة.

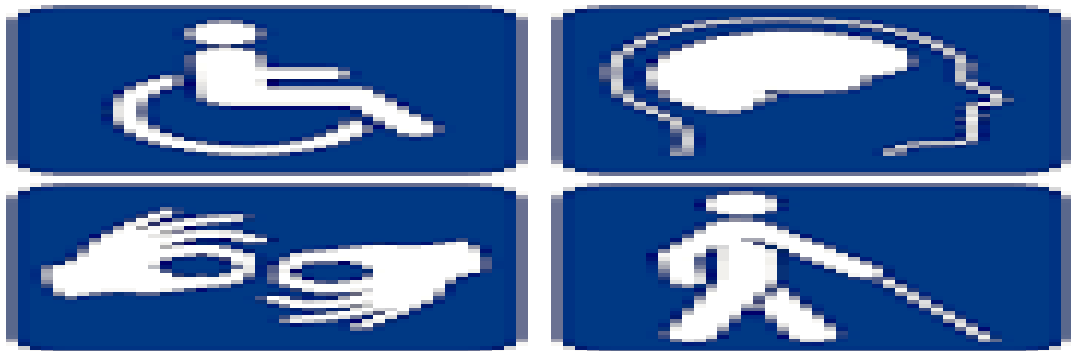
٢- أن يتطلب الطفل برامج تربوية أو خدمات خاصة (إسماعيل إبراهيم بدر، ٢٠٠٧).

ويتعرض ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجتمعات إلي مختلف صور التمييز السلبي وخاصة الاستبعاد من كافة فعاليات وخبرات الحياة الاجتماعية، وتعد الإناث أكثر فئات المعاقين تعرضاً للإهمال والتجاهل بصورة خاصة في المجتمعات النامية، حيث يظهر ذلك في قلة الدعم المادي المخصص للإنفاق في مجال تعليم الأطفال والمراهقين من الإناث المعاقات، إضافة إلي عدم تأهيلهم بالصورة الكافية لدمجهم في المجتمع وبناء عليه تترك المرأة المعاقة علي هامش المجتمع تعاني من العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة النفسية وتعرض للنزب والإهمال الاجتماعي وينظر إليها بوصفها عبئاً علي المجتمع ويدلل علي ذلك الكثير من الإحصائيات التي تظهر بوضوح الظلم الاجتماعي البين الواقع علي النساء المعاقات في العديد من الدول.

ويرجع ذلك إلي القصور في التشريعات القانونية المتعلقة بتعليم ورعاية هذه الفئة وهي تعد من ضمن أهم الأسباب التي ترتبط بهذا الظلم الاجتماعي.

وقد نبهت نتائج العديد من البحوث والدراسات التربوية والاجتماعية إلي أهمية المشاركة الكاملة للأسرة لما لها من آثار إيجابية وفعالة في تحقيق التوافق الاجتماعي والإنجاز والتحصيل التعليمي لهؤلاء الأطفال.

تصنيفات ذوي الفئات الخاصة:



تعددت تصنيفات ذوي الفئات الخاصة سواء من قبل هيئات عالمية أو علمية أو من قبل العلماء والباحثين، ومن أهم هذه التصنيفات:

قائمة المحتويات

(أ) ما ورد في قانون التربية للأفراد المعوقين بالولايات المتحدة (١٩٩٤) Individual with Disabilities Education Act (IDEA) بأن هناك ثلاث عشرة فئة من فئات الإعاقة تقدم لها الخدمات وتشمل:

- ١- التوحد (أضيف عام ١٩٩٠).
- ٢- الإعاقة الحسية المزدوجة.
- ٣- الصمم.
- ٤- ضعف السمع.
- ٥- التخلف العقلي.
- ٦- الإعاقات المتعددة.
- ٧- الإعاقات البدنية.
- ٨- الإعاقات الصحية.
- ٩- الاضطرابات الانفعالية الشديدة.
- ١٠- صعوبات التعلم.
- ١١- اضطرابات النطق واللغة.
- ١٢- الإصابات الدماغية.
- ١٣- الإعاقة البصرية (ديان برادلي وآخرون، د.ت؛ عبد العزيز الشخص، ٢٠٠٠، ٦١).

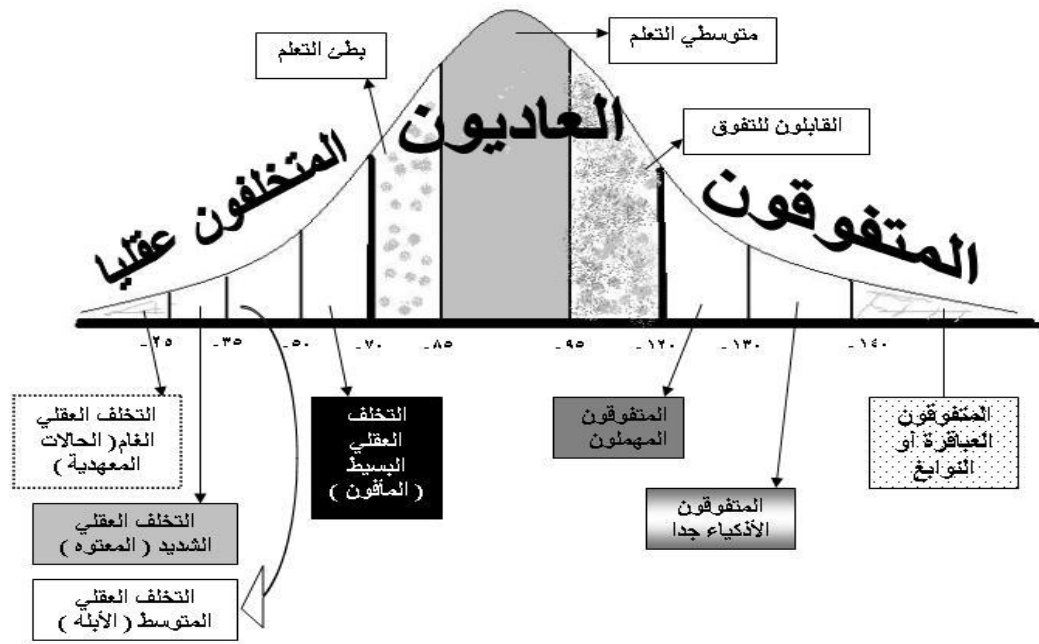
(ب) ما أقره المؤتمر القومي الأول للتربية الخاصة في مصر (١٩٩٥، ٦٥) والذي أكد أن الفرد من ذوي الحاجات الخاصة ينتمي إلى فئة أو أكثر من الفئات التالية:

- ١- التفوق العقلي – والموهبة الإبداعية.
- ٢- الإعاقة البصرية بمستوياتها المختلفة.
- ٣- الإعاقة السمعية – الكلامية – اللغوية بمستوياتها المختلفة.
- ٤- الإعاقة الذهنية بمستوياتها المختلفة.
- ٥- الإعاقة البدنية والصحية الخاصة.
- ٦- التأخر الدراسي وبطء التعلم.
- ٧- صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية.
- ٨- الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
- ٩- الإعاقة الاجتماعية.
- ١٠- الاجترارية أو التوحدية.

ويمكن تقسيم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأنواع التالية:

- ١- الموهبة والتفوق Giftedness & Talents
- ٢- الإعاقة العقلية Mental Retardation
- ٣- الإعاقة السمعية Hearing Impairment
- ٤- الإعاقة البصرية Impairment Visual
- ٥- الإعاقات الجسمية والصحية Physical & Health Impairment
- ٦- صعوبات التعلم Learning Disabilities
- ٧- اضطرابات السلوك Behavior Disorders
- ٨- اضطرابات التواصل Disorders Communication (زينب محمود شقير، ٢٠٠٧).

قائمة المحتويات



وعندما نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، فإننا نتجه إلى التركيز على الإعاقة، بدلاً من الاهتمام بالفرد ذاته وما لديه من إمكانيات وقدرات خاصة لذا جاءت النظرة سلبية إليه، فقديمًا كان ينظر للإعاقة على أنها عاهة، مما ساهم في عزلة الأفراد المعاقين وتهميش دورهم وإصاق المسميات السلبية بهم، وفي ظل المبدأ التوجيهي الذي ينادي بجعل المعاق إنساناً طبيعياً وهو اتجاه اجتماعي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للحياة مثل الأفراد العاديين وهذا يتطلب التعامل مع هؤلاء الأفراد على نحو طبيعي وإعطائهم الفرص ومساواتهم في الحقوق، وجعل الظروف المحيطة بهم عادية.

ومن المتفق عليه بين عامة الناس والمتخصصين أن ذوي الإعاقة لا تتاح أمامهم مختلف فرص التفاعل مع مختلف مواقف وخبرات الحياة الاجتماعية، ويعيشون في نوعية حياة أقل كثيراً مقارنة بأقرانهم العاديين، وتعتمد أي محاولة للتعامل مع أو للتخلص من الصعوبات التي يعاني منها المعاقين على ما يعتقد أنه السبب في الإعاقة والصعوبات المرتبطة بها.



تعد الإعاقة من أهم المشكلات التي تشغل اهتمام الحكومات والدول والمنظمات، وذلك لما يترتب علي حدوثها من آثار نفسية، واقتصادية واجتماعية يصعب مواجهتها والتغلب عليها.

وقد تعددت التعريفات الخاصة بالإعاقة، وقد اختلف الباحثون في تعريفهم للإعاقة حسب تخصصاتهم ومنحاهم الفكري، فمنهم من تناولها من زوايا جسمية وحسية، ومنهم من اهتم بالجوانب الطبية، ومنهم من اهتم بها من زوايا نفسية واجتماعية وتربوية، ومنهم من نظر إليها نظرة شاملة. وتعرف الإعاقة لغويا بأنها مشتقة من الفعل عاق، وعاق عن الشئ يعوقه عوقاً، أى صرفه وحبسه وعطله (ابن منظور، دت، ٣١٧٣).

ويقصد بالإعاقة كل ضرر يمس فردا معينا، وينتج عن اعتلال أو عجز يحد من تأدية دورها لطبيعي بحسب عامل السن والجنس والعوامل الاجتماعية والثقافية، أو يحول دون تأدية هذا الدور بالنسبة لذلك الفرد.

وبالتالي فالشخص المعاق يعاني من عجز في قدرته على التوافق مع البيئة المحيطة به، وبالتالي يحدث أزمة في محيط الأسرة التابع له، وهذا ما استخلصه "على شعيب" (١٩٩١، ٣٩) حيث أشار إلى أن الطفل المعوق يحتاج إلى قدر من الرعاية والاهتمام يتوازى مع مقدار ما لديه من إعاقة وإن كان في كل حالاته يختلف عن ما يتطلبه هذا القدر من الاهتمام والرعاية للطفل العادي.

ويعرف "جمال محمد الخطيب" (١٩٩٣، ٨) الأطفال المعاقين Handicapped Children "بأنهم أطفال لديهم الحاجات الأساسية الموجودة لدي جميع الأطفال، إلا أنه نتيجة الاضطرابات الجسدية أو العقلية أو السلوكية أو الحسية التي يعانون منها يصبح لديهم حاجات خاصة إضافية لاتوجد لدي الأطفال الآخرين"، وبذلك يجب تقديم خدمات تربوية خاصة لهم لا يحتاج إليها العاديين وتسمى بالتربية الخاصة Special education، والتي تتضمن تقييم المناهج الدراسية والمواد التعليمية بهدف تلبية الحاجات التربوية الخاصة للأطفال المعاقين، كما أن مصطلح الإعاقة يشير إلى جميع الانحرافات عن النمو الطبيعي.

ويعرف "فاروق الروسان" (١٩٩٨، ٤٠) الإعاقة بأنها انحراف عن أداء الفرد عن متوسط أداء الجماعة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك الانحراف في مجال القدرة العقلية أو السمعية أو الحركية أو التعليمية".

ويفرق "عبد الرحمن سليمان" (١٩٩٨، ١٢) بين الإصابة Impairment والعجز Disability، والإعاقة Handicap، حيث أن الإصابة ينصرف معناها إلى الجانب الخلقي الولادي أو ما يتعرض له الفرد بعد ولادته نتيجة الإصابة بخلل فسيولوجي، سيكولوجي، جيني، أما العجز "فهو الحالة المترتبة على الإصابة بقصور نتيجة قصور في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكلوجية"، والإعاقة هي "عدم قدرة الفرد على تلبية متطلبات أداء دوره الطبيعي المرتبط بعجزه وجنسه وخصائصه الاجتماعية والثقافية نتيجة الإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكلوجية".

كما يعرف "أحمد السعيد، ومصري عبد الحميد" (١٩٩٩، ٦١) الإعاقة بأنها هي: "من تكون قدراته على أداء المهام العادية في الحياة اليومية أقل من الشخص العادي"، ويشار عادة إلى من لديهم عجز من الناحية الفسيولوجية أو التشريحية.

ومن هنا تصبح الإعاقة هي تلك العلاقة الوظيفية بين المعاق وبيئته، وتحدث عندما يواجه حواجز ثقافية أو اجتماعية أو طبيعية تمنع وصوله إلى أهدافه أو إشباع احتياجاته أو نظم المجتمع المتاحة للمواطن العادي. وعليه فإن الإعاقة تعدو فقدان أو محدودية الفرص التي يجدها المعاق لتأدية دور فعال في الحياة والمجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وقد عرف قانون التأهيل المعوق بأنه "كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي به" (قانون تأهيل المعاقين رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ م). ووفقاً للموسوعة الطبية الأمريكية فقد عرفت المعاق على أنه كل شخص به عيب صحي أو عقلي يمنعه من أن يشارك بحرية في النشاط الملائم لعمره، كما يولد لديه إحساس بصعوبة الاندماج بالمجتمع. أما منظمة العمل الدولية فقد عرفت المعاق بأنه هو كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية. وعرفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة من خلال مرور الإعاقة بعدة مراحل، حيث يمر حدوث الإعاقة بمراحل ثلاث هي:-

١-الإصابة أو حدوث العامل المسبب: Impairment

تتمثل في فقد طرف من الأطراف نتيجة حادث، أو شلل أو إصابة الرأس في حادث تؤدي إلى تلف في أنسجة المخ وتلف عقلي، أو الإصابة بالصرع، أو الإصابة بالحصبة أو التراكوما أو الالتهاب السحائي، أو إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية، أو تعرضها لأشعة أكس x-ray. مما ينتج عنه فقدان أو شذوذ عن الطبيعي لأحد الجوانب النفسية أو العقلية أو الجسمية للفرد.

٢-القصور الوظيفي: Functional limitation

يترتب على الإصابة وحدث العامل المسبب (أ) وبالتالي يحدث القصور الوظيفي في أداء بعض الوظائف الجسمية أو العقلية التي يؤديها الإنسان الطبيعي المماثل للفرد المصاب في العمر والجنس (كالمشي والرؤية والسمع والقراءة والكتابة والحساب والتفكير والتعليم والاتصال بالبيئة وحماية النفس)، هذا القصور الوظيفي يحتاج إلى إجراءات علاجية وقائية تحد من الوصول إلى المرحلة الثالثة من مراحل الإعاقة.

٣- الإعاقة والعجز : Disability

هي حالة يصل إليها الفرد المصاب الذي لم تتخذ بعد إصابته مباشرة الإجراءات الكفيلة بعلاج العجز الوظيفي، تلك هي حالة يعاني فيها الفرد من العجز وتعثر الأداء للأعمال العادية الأساسية لمتطلبات الحياة، وبالتالي تعوق الفرد عن القيام بدوره الذي يفرضه سنه وجنسه والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعه. وقد وضع الاتحاد النوعي لرعاية المكفوفين تعريفاً للمعوق بأنه فرد لديه قصور حسي أو عقلي يترتب عليه آثار بدنية، ونفسية، وتعليمية جعلته غير قادر على الوفاء باحتياجاته الأساسية في الحياة، أو بتعبير آخر الذي فقد قدرته على مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر نتيجة نقص أو قصور بدني أو حسي سواء كان هذا القصور بسبب مرض أو إصابة أو كان خلقياً منذ الولادة (فوقية محمد زيدان، ١٩٨٤).

وعرفها عبد الفتاح عثمان بأنها "قصور أو تعطل عضو أو الأعضاء الداخلية للجسم عند القيام بوظائفها نتيجة لأسباب وراثية أو مكتسبة ميكروبية أو فيروسية أو أمراض أو حوادث معينة" (في: أمانى عبد المقصود، ١٩٩٣). وعرفها زهير السباعي بأنها "كل ما يحد من قدرات الإنسان العقلية أو النفسية أو الجسدية ويجعله غير قادر على أن يمارس حياته الطبيعية المتوقعة منه في حدود عمره وجنسه وظروفه البيئية" (في: رسمى بر الملك رستم، ١٩٩٨).

ويطلق لفظ المعاق علي الشخص الذي فقد أحد أجزاء جسمه أو أصيب بعاهة أو بمرض قبل الميلاد أو بعده مما يجعله غير قادر علي الاستجابة بشكل مناسب لما يرد إليه من منبهات سواء كانت هذه المنبهات داخلية أو خارجية (English&English, 1998, P.236).

ويشمل مصطلح "الأطفال المعوقين" المتخلفين عقلياً ومن لديهم صعوبة في السمع والصمم ومن لديه إعاقة في الكلام أو أي إعاقة صحية أخرى، ويشمل كذلك كف البصر ومتعددي الإعاقات ومن لديهم صعوبات معينة في التعليم وهم الذين يحتاجون إلى تربية خاصة وخدمات أخرى مرتبطة بها.

وفي ضوء ما سبق يتضح أن الشخص المعاق يعاني من نقص أو عجز في إحدى الحواس التي يتمتع بها الشخص العادي، وبالتالي فإنه يواجه المجتمع فاقد إحدى الحواس أو أكثر من حاسة "متعددي الإعاقة" الأمر الذي يستلزم من المحيطين به تقبله وعدم إشعاره بإعاقته، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على شعوره بالإنجاز رغم إعاقته.

أسباب الإعاقة:

تختلف أسباب الإعاقة نتيجة تفاوت الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومدى ما يوفره كل مجتمع لتحقيق الرفاهية لأفراده. ولم يستطع العلم الجزم بأسباب الإعاقة، ولكن هناك العديد من الاجتهادات، حيث توجد طريقتين مختلفتين لتفسير ما يعتقد أنه السبب في الإعاقة وتداعياتها النفسية وقد أمكن بلورة هاتين الطريقتين فيما يطلق عليه نموذجاً لتفسير الإعاقة وهما :

١ - النموذج الطبي للإعاقة Medical Model of Disability

٢ - النموذج الاجتماعي للإعاقة Social Model of Disability

ويركز أنصار النموذج الطبي بشكل كبير علي الملامح والخصائص الأساسية للفرد من حيث البنية التكوينية العضوية، في حين يتبنى مؤيدو النموذج الاجتماعي التفسيرات التي تعتمد علي الخصائص الأساسية للمؤسسات

قائمة المحتويات

الاجتماعية وما يسود المجتمع بشكل عام من أنساق قيم ومعتقدات تجاه الإعاقة والمعاقين وفيما يلي تناول موجز لكلا النموذجين:

أولاً: النموذج الطبي للإعاقة:

ينظر هذا النموذج للإعاقة علي أنه عجز أو عدم قدرة المعاقين علي الارتباط والمشاركة في أنشطة وخبرات الحياة ترجع بالأساس إلي معاناة الفرد من إصابة Impairment تتلف أو تحدث تدميراً لعضو ما من جسده يترتب عليه قصور أو عجز وظيفي شديد لا يمكنه من الاستفادة والمشاركة في فعاليات وخبرات الحياة الاجتماعية ولا يرجع هذا العجز من قريب أو بعيد لملامح وخصائص وأنساق القيم والمعتقدات في المجتمع.

وعندما يفكر صناع السياسة في الإعاقة وفق النموذج الطبي فإنهم يميلون إلي تركيز مجهوداتهم في تعويض ذوي الإصابات أو التلف العضوي وما يرتبط به من قصور وظيفي وذلك من خلال صياغة نظم تربوية وتزويدهم بالخدمات العلاجية والتأهيلية في مؤسسات قائمة علي العزل والاستبعاد من فعاليات وخبرات الحياة الاجتماعية العادية.

ويؤثر النموذج الطبي للإعاقة أيضاً علي الطريقة التي ينظر ويفكر المعاقون بها حول أنفسهم إذ عادة ما يتبنى الكثيرون منهم رسالة سلبية مفادها أن كل المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة تنشأ عن امتلاكهم أجساد غير عادية أو بها عيب تكويني، وعادة ما يميل المعاقين إلي الاعتقاد بأن إصابتهم تحول بالضرورة دون مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية، ويؤدي إستدخال هذه الأفكار والمعتقدات في البنية الفكرية لذوي الإعاقة إلي عدم مقاومتهم محاولات استبعادهم من الاندماج Mainstreaming في فعاليات وخبرات الحياة الإنسانية في المجتمع.

ثانياً: النموذج الاجتماعي للإعاقة:

تبدأ الرؤى التفسيرية للإعاقة وفق النموذج الاجتماعي من التحديد للاختلاف بين مفهومي الإصابة أو التلف أو العطب Impairment والعجز أو الإعاقة Disability وقد بدأت صياغة النموذج الاجتماعي من قبل بعض العلماء إثر إظهار العديد من المعاقين استيائهم وامتعاضهم من النموذج الفردي أو الطبي لكونه لا يقدم تفسيرات مقنعة لاستبعادهم من الاندماج في مسار الحياة الاجتماعية، ولأن هناك العديد من الخبرات لمعاقين أظهرت أن مشكلاتهم الحياتية والتوافقية لا ترجع إلي الإصابة أو الإعاقة في حد ذاتها، ولكن تعود بالأساس إلي الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم ويتجاوز هذا النموذج المسلمات التي ينطلق منها النموذج الطبي والتي تتمثل في عدم التفرقة بين الإصابة والتلف والعطب، والعجز لأن جميعهم يؤدي إلي قصور وظيفي وأن هذا القصور الوظيفي كامن داخل الفرد نفسه ومنعزل عن المتغيرات الخارجية، مسلماً بأن العجز وليس العقبات أو العناصر الأساسية للمؤسسات الاجتماعية التي لا تلقي بالا بحاجات وخصائص المعاقين بأي شكل من الأشكال، وهنا يبدو أن المجتمع هو سبب الإعاقة بمعنى أن المجتمع هو المعوق لأنه يمنع ذوي الإعاقة من الاشتراك في فعاليات وأنشطة وخبرات الحياة اليومية، وإذا ما أريد اشتراك واندماج ذوي الإعاقة في مسار الحياة الاجتماعية لابد أن يعاد تنظيم المجتمع من حيث بنائه ووظائفه، وأيضاً لا بد من القضاء علي كل الحواجز والموانع والعقبات التي تحول دون هذا الاندماج. ومن هذه العقبات أو الحواجز:

- التحيز ضد الإعاقة والمعاقين والميل إلي الوصم والتنميط.

- عدم مرونة الإجراءات والممارسات المؤسسية

- تعذر الحصول علي المعلومات الصحيحة

- تعذر وجود البيانات والمؤسسات المناسبة

- تعذر وجود وسائل المواصلات والنقل المناسبة

قائمة المحتويات

ويشير تحليل "هنت" Hunt إلى أنه يعتقد أن المعاقين يواجهون اضطهاد وإساءة معاملة من قبل الآخرين وتتضح تجليات ذلك في ظاهرة التمييز discrimination والاستبعاد من فعاليات الحياة الاجتماعية الطبيعية وخلص "هنت" من تحليله لهذه الأوضاع إلى التأكيد على وجود علاقة مباشرة بين الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية نحو الإعاقة والمعاقين، وقد استخدم المعاقون في بداية السبعينيات من القرن العشرين خبراتهم الشخصية مع الإعاقة وعن حياتهم في المؤسسات (مؤسسات الرعاية والإيواء والتربية القائمة على العزل) ليظهروا أن إصابتهم أو نواحي العجز لديهم ليست السبب في المشكلات العديدة التي يواجهونها في حياتهم أو في التفاعلات النفسية والسلوكية المصاحبة للإعاقة، وأن السبب الأساسي في هذا العجز وهذه المشكلات إنما يعزى إلى فشل المجتمع في التسامح مع/ والتقبل للاختلافات والفروق بين المعاقين من المشاركة العادية في فعاليات وأنشطة خبرات الحياة الاجتماعية اليومية، والنموذج الاجتماعي لا يغفل أو ينكر تأثير الإصابات والفروق الفسيولوجية ولكنه يعالج هذا التأثير دون التقيد أو الالتزام بالأحكام ذات الطابع التقويمي، لذا فمن المتصور أن استخدام النموذج الاجتماعي يؤدي إلى التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وباختصار يؤكد النموذج الاجتماعي أن العجز والإعاقة ناتجة عن عدم إدراك وعدم رغبة المجتمع في التعامل والتسليم بالاختلافات والفروق في الخصائص والإمكانات البدنية والعقلية بين ذوي الإعاقة وأقرانهم العاديين.

لقد أدت الالتفات إلى الأهمية البالغة لمفهوم رأس المال البشري ودوره في نهضة المجتمع وتقدمه إلى إيجاد أولوية متقدمة للتنمية البشرية في مجالات مثل رعاية الفقراء المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم كي نستفيد بما لديهم من طاقات وتركيزنا هنا على ذوي الاحتياجات الخاصة فلكي نمكن لهم داخل المجتمع لا بد من تأهيلهم وتعليمهم وإدماجهم في مجتمعهم كقوي منتجة وفاعلة، فذوي الاحتياجات الخاصة مصطلح يشمل كل الفئات التي تحتاج إلى نوع خاص من الرعاية سواء كانت جسمانية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية وتختلف قضايا ومشكلات وطرق رعاية كل فئة من هذه الفئات باختلاف احتياجاتهم، واختلاف نوع الإعاقة ودرجتها.

كما توجد العديد من الاجتهادات لحصر أسباب الإعاقة حيث تنقسم إلى:

* أسباب وراثية وخلقية: انتقال الصفات الوراثية (الجينات)، خلل في الانقسام الجيني أو اضطراب كروموسومي.
* أسباب تتعلق بالحمل والولادة، وتنقسم إلى:

١- أسباب ما قبل الولادة مثل: التعرض للأشعة وتناول الأدوية أثناء الحمل، أو الإصابة بالأمراض الضارة والمعدية مثل: الحصبة الألمانية.

٢- أسباب أثناء الولادة مثل: نقص الأكسجين أو الولادة المتعثرة أو المبتسرة، والنزيف أثناء الولادة.

٣- أسباب ما بعد الولادة مثل: الاختناق أو التعرض للإصابات كالسقوط.

* أسباب التهابية مثل: تعرض الطفل لإصابات الرأس أو حوادث السير والسقوط أو الالتهابات مثل: التهاب السحايا والتهاب الدماغ.

* أسباب متنوعة تتعلق بالبيئة مثل: التلوث والإشعاع والتسمم بالرصاص وأكسيد الكربون والعقاقير المخدرة، الحروب، الكوارث الطبيعية، الظروف الأسرية والحرمان البيئي الشديد، والإهمال، أو الحماية الزائدة.

ويرى الأفراد المعاقين الراشدين المدافعين عن تطبيق وتنفيذ تشريعات ما يعرف بقانون "الحق في التربية لكل المعاقين" أن العجز في حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى الإعاقة والاتجاهات الاجتماعية والتصورات النمطية الجامدة وظروف الإسكان والنقل وغيرها من المعوقات الاجتماعية التي تسهم في تحويل القصور أو العجز إلى إعاقة حقيقية تحد من المشاركة في فعاليات وخبرات الحياة الاجتماعية.

قائمة المحتويات

شعار المؤسسة

أيها المعاق كن كشجرة الصندل كلما تطرقها
الفؤوس تزداد عطراً.

Look at the Sandalwood Tree:

The more it is damaged,

The finer its perfume will be

ولما كانت الإعاقة تلعب دوراً في عزل الطفل وأسرته عن المجتمع، فإن العزلة تعنى المرض، والمرض يعنى الإعاقة، والمعاق يعنى عدم القدرة على أداء دوره في المجتمع مما يتطلب ذلك تنمية القدرات التي لديه بما يمكنه من أداء دوره في المجتمع في حدود هذه القدرات، وإعادة الاندماج والانتماء إلى المجتمع للقضاء على العزلة التي يعاني منها.

ويعتبر الشخص المعاق مجالاً هاماً من مجالات اهتمام أنثربولوجيا الطفل – التي تركز الاهتمام على دراسة الطفل من كل الجوانب الاجتماعية، الثقافية، النفسية، والبيولوجية للتعرف على حاجاته ومشكلاته. كما يعتبر موضوع اهتمام أنثربولوجيا التنمية هو اعتبار الطفل المعاق طاقة بشرية معطلة يجب تنميتها لزيادة الموارد البشرية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك برعاية المعاق.

وقد اهتمت الأنثربولوجيا بدراسة مشكلة الإعاقة لتحديد طبيعتها عن طريق الدراسات المتعمقة التي تقوم على الواقع لمعرفة أسبابها وتقدير حجمها، والتعرف على المشاكل الناجمة عنها للتوصل إلى حلول لها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإعاقة ومعالجة أسبابها ووضع البرامج اللازمة لذلك. والاهتمام بدراسة الإعاقة ليس فقط اهتمام بدراسة المشكلة فحسب وإنما التدخل لتحسين ظروف المجتمع والفئات التي تعاني من المشكلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحيطين بالمعاق.

وقد استخدم المدخل الأنثربولوجي في دراسة الإعاقة في مصر في عدد من المجتمعات للتعرف على طبيعة الشخص المعاق منذ بداية تكوينه وتاريخ تطوره قبل وبعد الميلاد ودراسة المعاق من حيث كونه مركزاً لشبكة علاقات تبدأ من البيئة الاجتماعية التي تشمل الأسرة والعلاقات الاجتماعية داخلها وخارجها، والجماعات التي ينتمي إليها، وعلاقاته وأدواره، ومكانته، وعزله واندماجه والتعرف على أسباب الإعاقة من رؤية أفراد المجتمع، ورؤيتهم للطفل المعاق والمفاهيم المستخدمة محلياً عن الطفل المعاق.

الآثار السلبية لمشكلة الإعاقة:



إن مشكلة الإعاقة من المشكلات متعددة الأبعاد، إذ لا يقتصر آثارها على الطفل المعاق بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع، باعتباره طاقة حيوية مفقودة، بل تختلف هذه الآثار بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث أن الإعاقة الذهنية أشد وطأة من الإعاقة الجسمية، فكلما اشتدت درجة الإعاقة، زادت معوقات الاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية العديدة المترتبة على الإعاقة.

وتظهر هذه المشكلات نتيجة للتغير الذي يطرأ على الفرد حيث تعد التغيرات الجسمية المفاجئية شغله الشاغل ومصدر قلق بالنسبة له، فهو يرى نفسه محط أنظار أقرانه مما يجعل الانفعالات والاضطرابات والعقد النفسية تسيطر على شخصيته.

وتعد المشكلات النفسية أمراً راجعاً إلى سوء توافق المعوق مع نفسه ومع بيئته بسبب فشله في تحقيق أهدافه وإرضاء حاجاته النفسية والاجتماعية، فالإعاقة بصورة عامة تؤدي إلى تذبذب الثبات الانفعالي، ويصعب على المعوق إعادة توافقه النفسي والاجتماعي بمفرده، لأن الإعاقة تعتبر بمثابة حاجز نفسي بين المعوق وبيئته الاجتماعية، فينكمش على نفسه نتيجة شعوره بالاختلاف عن الآخرين.

وتزداد حدة المشكلات النفسية عند زيادة حدة الإعاقة الظاهرة فالإعاقة الشديدة تفرض على صاحبها نمطاً معيناً في الحياة، خاصة لمن يتطلب عمله استغلال أطرافه، فيصبح في هذه الحالة غير راض عن نفسه وتنتابه الهواجس ويساوره القلق المستمر عن حاضره ومستقبله، مما يجعله يعاني ألماً نفسية شديدة تؤدي إلى ظهور عدد من الخصائص الانفعالية السالبة مثل الغضب وسرعة الاستثارة وتقلب المزاج وقد أشارت البحوث والدراسات الاجتماعية في هذا المجال إلى أن أكثر ما ينجم عن الإعاقة من مشكلات نفسية يمكن أن نوجزها في الآتي:

١- الشعور الزائد بالنقص: إن الظروف المحيطة بالمعوقين تجعلهم عادة يشعرون بالنقص فالمعوق نظراً لإعاقته وضعفه، ونظراً لاعتماده على الآخرين، ونظراً لحساسيته الزائدة في تعامله مع من حوله، تجعله يشعر بقلته وعجزه، مقللاً تقديره لذاته والمعوق الذي يعاني من الشعور الزائد بالنقص تجده ضعيف الثقة في النفس وفي الآخرين، نتيجة لمواقف الآخرين نحوه، ونتيجة لفشله في مواقف متكررة تزيد من شعوره بالنقص، مما يجعله مبتعداً عن الناس، خجولاً شديد الحساسية إلى غير ذلك من مظاهر الشعور بالنقص فالمعوق الذي تسبب له الإعاقة

قائمة المحتويات

الكثير من المشكلات المختلفة، تجعله عاجزاً عن الاستقلال، والاعتماد على النفس، وأصبح حالة على غيره، حتى فقد الأمن المادي والنفسي، والاجتماعي، وأصبح قلقاً خائفاً من المجهول وضعيف الثقة بالنفس، سريع الانفعال شديد الحساسية. وكثيراً ما يلجأ المعوق إلى التعويض الزائد عن طريق التفوق على الآخرين بصورة فائقة، حتى يعوض تفوقهم عليه في الجوانب التي تنقصه وهذا التعويض الزائد، والتفوق المبهر، يساعد المعوق ويمكنه من الظهور والسيطرة على الآخرين، ليغطي مشاعر الألم والحسرة، والضيق والقلق، التي تسببها له مشاعر النقص.

٢- عدم الاتزان الانفعالي: تسبب الإعاقة عدم الثبات الانفعالي، وعدم الثبات الوجداني، وعدم نضج انفعالات المعاق.

وعدم الثبات الانفعالي يتميز بالتغير المفاجئ في الحالة المزاجية والسلوك وهو من الأمور التي كثيراً ما يلاحظها الآخرون قبل أن يلاحظها الشخص نفسه، مثل إظهار الحزن مكان السرور والابتهاج، والفور مكان التقبل والرضا، والتحول إلى الإسراف فجأة مكان الحرص والتعقل، وإبداء التجاهل وعدم الاكتراث في المواقف التي تتطلب الحزم والاهتمام وعدم اتزان المعوق الانفعالي يؤدي إلى عدم القدرة على التفاعل مع المواقف المختلفة، وعدم القدرة على الاستفادة من الخبرات المتاحة له عند تفاعله مع مواقف الحياة المختلفة، مما يؤدي إلى عدم قدرته على تنمية مهارته وقدراته المتبقية، كما يؤدي إلى كثير من الاتجاهات الاجتماعية السالبة، وما لها من تأثير سلبي على تكيف المعوق مع مجتمعه، ويقلل من فرص تفاعله مع الآخرين، وبالتالي يؤثر سلباً على علاقته بأسرته وبالمحيطين به من أفراد المجتمع.

٣- الاضطرابات النفسية: ليس المقصود بالاضطرابات النفسية تلك الأعراض المرضية من نقص عقلي، واضطرابات عقلية، أو عصابية، أو اضطرابات نفس جسمية. ولكن المقصود بالاضطرابات النفسية التي يعاني منها كثير من المعوقين تلك الحالة النفسية التي تتضمن عدم شعور المعوق بالطمأنينة والارتياح والرضا وعدم قدرته على تكيفه مع نفسه، وعدم رضاه عنها، وكذلك عدم قدرته على التكيف مع الآخرين، وعدم قدرته على تكوين علاقات إيجابية مع أسرته، ومع الآخرين، وعدم مواجهة الأزمات والشدائد والصعوبات، وما يترتب عليها من عدم الاتزان والثبات العاطفي وما يتبعه من انطواء وعزله، وشعور بالاكتئاب بالإضافة إلى شعوره بعدم راحة البال، وعدم الشعور بالأمن والطمأنينة، وعدم رضاه عن نفسه، وتقبله لها، وما يصاحب ذلك من توتر، وصراع، وآلم، وما يؤدي إليه من عدم تحقيق التوازن النفسي مع المجتمع وبين مطالبه الجسمية والنفسية، وغالباً ما يسمى عدم تحقيق التوازن هنا بعدم تحقيق التوافق مع نفسه ومع مجتمعه.

٤- فقدان الشعور بالأمن : فقدان المعوق لمشاعر الأمن يقصد به هنا تلك الحالة النفسية التي يشعر فيها بأنه خائف دائماً، وغير آمن على نفسه، أو على أسرته، ويخيفه المجهول ويرعبه، ويشعر بأنه مهدد في حياته، مهدد في كل شيء يحيط به، أو يتعامل معه، ويخاف من كلام الناس ونقدهم وملاحظاتهم والتعامل معهم فعجزه، وما يصاحبه من مشاعر النقص يدفعه إلى الخوف من الناس والنفور منهم وانطوائه، وانزوائه بعيداً عنهم، حتى لا يمسون ذاته، أو يجرحون كرامته بسخريتهم، أو بشفتتهم، أو بنقدهم له؛ لأنه عاجز عن منافستهم أو التعايش معهم، بعد أن أفقدته العاهة ثقته بنفسه، وشعور المعوق بالنقص وفقدان الثقة بالنفس يزيدان من مخاوفه، وبفقدانه الشعور بالأمن.

٥- سيادة السلوك الدفاعي: السلوك الدفاعي هو ما يسمى بـ ميكانيزمات الدفاع (Mechanisms Defence) وهي حيل دفاعية وأساليب تهدف إلى الدفاع عن الشخصية ضد أي تهديد داخل الفرد وخارجه، والحيل الدفاعية عبارة عن عمليات نفسية هدفها خفض التوتر والقلق، وهي تعمل بطريقة لا شعورية، لإنكار الواقع أو تزييفه. واستخدام الحيل الدفاعية أمر سوي وعادي إذا استخدم بصورة سليمة أما إذا استخدمت الحيل الدفاعية بشكل مسرف، فإنها يمكن أن تؤثر في النمو النفسي لأنها تمنع الفرد من التعامل مع العالم الواقعي بطريقة واقعية والمعوق قد تدفعه الإعاقة إلى اللجوء للحيل الدفاعية، بعضها، أو واحدة منها، دون أن يشعر، وذلك عند إخفاقه وفشله في الوصول

قائمة المحتويات

إلى التوافق بينه وبين نفسه، أو بينه وبين بيئته الاجتماعية، ويترتب على هذا الفشل والإخفاق الصراع والقلق، الذي يحتاج المعوق إلى تخفيفه بطرق شتى من الحيل الدفاعية، فقد يستخدم المعوق حيلة خداعية مثل (الكبت التبرير - الإسقاط - والتكوين العكسي) أو يستخدم حيلة هروبية، مثل أحلام اليقظة والنكوص الارتداد لمراحل النمو الطفولية أو يستخدم حيلة استبدالية مثل التعويض التحويل) وكل ذلك يمنعه من التعامل مع العالم الواقعي بطريقة واقعية.

٦- مشكلة الاضطرابات النفسجسمية: مشكلة الاضطرابات النفسجسمية من المشكلات التي يعاني منها بعض المعوقين، وخاصة الذين يعانون من بعض الصراعات النفسية، أو يعرضون أنفسهم للانفعالات الشديدة. والاضطرابات النفسجسمية هي مجموعة من الاضطرابات ذات الأصل النفسي، التي تلعب فيها الأسباب النفسية دوراً بارزاً، وهي اضطرابات ليس لها سبب عضوي واضح، وتحدث يومياً، وبشكل ملاحظ مثل الشعور بالصداع والدوخة، والشكوى من أوجاع جسمية متعددة، على الرغم من عدم وجود سبب عضوي لهذه الأعراض، إلا أنها تسبب لصاحبها آلاماً حقيقية بسبب أصلها النفسجسمي وهذه الاضطرابات هي وسائل هروبية توفر لصاحبها الحصول على الاهتمام أو تستخدم للتعبير عن عدم الرضا، وهي تؤدي بدورها إلى انخفاض حدة الشعور بالقلق التي يعيشها المعوق. وهذه الاضطرابات الجسمية ذات الأصل النفسي قد تتطور وتصل إلى أعراض أكثر شدة وقد تصل إلى إصابة المعوق بأمراض جسمية حقيقية ولكنها ذات أصول نفسية مثل قرحة المعدة، وقرحة الاثنى عشر، وضغط الدم العالي والإمساك المزمن، وغيرها من الأمراض، لذلك لابد من التنفيس عن الانفعالات وتصريفها، والتعبير عن المشاعر السلبية وتخفيفها، والتعبير عن الضغوط البيئية وإزالتها، حتى لا تكون سبباً لمثل هذه الاضطرابات النفسجسمية.

وهناك بعض المشاكل النفسية الأخرى التي يعاني منها المعاقون والتي تسبب لهم الكثير من الضيق والألم، والخوف والحزن، والقلق (أو يستخدم حيلة هروبية، مثل أحلام اليقظة والنكوص الارتداد لمراحل النمو الطفولية أو يستخدم حيلة استبدالية مثل التعويض التحويل) وكل ذلك يمنعه من التعامل مع العالم الواقعي بطريقة واقعية.

أنشطة تدريبية

س ١- عرف كل من: الإعاقة- ذوي الاحتياجات الخاصة؟

س ٢- ما هي أسباب الإعاقة؟

س ٣- وضح الآثار السلبية لمشكلة الإعاقة؟

س ٤- للإعاقة تعريفات متعددة. ناقش هذه العبارة؟

روابط إلكترونية

روابط إلكترونية يمكن الرجوع لها للاستفادة:

<https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>

<https://www.moh.gov.sa/awarenessplatform/VariousTopics/Pages/Disability.aspx>

<https://www.un.org/ar/observances/day-of-persons-with-disabilities/background>

<https://www.ohchr.org/ar/stories/2014/02/right-education-all-including-persons-disabilities>

<https://www.youtube.com/watch?v=TpnI1Q9IuxY>

<https://www.youtube.com/watch?v=hBkCdyyiEpA>

<https://www.youtube.com/watch?v=oQTv4H2O5aQ>

https://www.youtube.com/watch?v=WRkUpcm_yiw

<https://www.youtube.com/watch?v=teL4nv3qkQ>

رابط الاختبار التفاعلي:

https://docs.google.com/forms/d/1jUSqs0witKSMRhe9VEXNLJIT3iwEhMGq_77Y9PdaJfw/edit?hl=ar

قائمة المحتويات

الفصل الثانى

تصنيف ذوى الاحتياجات الخاصة

- -أولاً: الإعاقة الحركية.
- -ثانياً: الإعاقة السمعية.
- -ثالثاً: الإعاقة البصرية.
- -رابعاً: الإعاقة العقلية.
- -خامساً: اضطرابات التواصل "التوحد".
- -سادساً: صعوبات التعلم.
- -سابعاً: فرط الحركة ونقص الانتباه.
- -ثامناً: اضطرابات اللغة والتواصل.

مخرجات التعلم المستهدفة

في نهاية الفصل يصبح الطالب قادرًا على أن:

- يصنف ذوى الاحتياجات الخاصة.
- يحدد خصائص الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يشخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم.
- يشارك في التعرف على الاحتياجات النفسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يحدد خصائص كل فئة من فئات ذوى الاحتياجات الخاصة.
- يشرح المشكلات التي تعاني منها كل فئة من فئات ذوى الاحتياجات الخاصة.
- يعدد الأسباب المؤدية لكل نوع من الإعاقة.
- يقارن بين الصم وضعاف السمع.
- يقارن بين أنواع الإعاقة العقلية.
- يقارن بين أنواع كف البصر.
- يشرح أثر الإعاقة على جوانب النمو.

الفصل الثانى

تصنيف ذوى الاحتياجات الخاصة



أولاً: الإعاقة الحركية Orthopedic Handicap

عند دراسة الإعاقة الحركية، فإننا نلتقى بأفراد أنقذتهم الجراح، جراح جسمية بقدر ما تعد جراح نفسية، حيث يلتقى بفئة ضائعة قد تقف على أطلال الماضى، تجرفهم إعاقتهم فى منحى يعزلهم عن العالم بأسره، يتشوقون أن يروا أنفسهم خارج عالم الإعاقة الذى ينصهرون فيه ولكن كيف؟ إنهم يعيشون فى بوتقة نظرات الآخر التى تتأرجح بين الشفقة والاشمئزاز أو السخرية (إيمان حسين، ٢٠٠٨، ٧٤٩). وتشير ثريا إبراهيم (٢٠٠٧، ٦٨٦) إلى أن المعوق يبدأ بالإصابة وينتهى بسخرية متواصلة، فالإعاقة الحركية ليست بإعاقة فى وظيفة عضو الحركة فحسب، بل هى إعاقة فى المحيط النفسى، والاجتماعى للمعاق، وكلما زادت شدة الإعاقة الحركية فإن هؤلاء المعاقين قد يلجأون إلى السلوكيات الدفاعية والانسحاب من الحياة واللجوء إلى العزلة وأحلام اليقظة.

ويرى أدث.م.ستيرن والذاكاستنديك (١٩٩٧، ٢٤) أن الآثار التى تنشأ عن الإعاقة الحركية لن تكون آثارها هو ما يحدث للمرء فقط وقت حدوثها، ولكن تمتد هذه الآثار مع امتداد العمر، فالجسد يستهلك أسرع وتضعف القوى وتخور النفس بمرور الوقت.

ويعرف كل من هنت ومارشال (Hunt&Marshall,1994,21) الإعاقة الحركية بأنها "حالة من نقص الكفاءة فى مستوى الوظائف الحركية سواء الخاصة بالأطراف أو العظام أو العضلات".

ويعرف فتحى عبد الرحمن (٢٠٠٠، ٢٨) المعاق حركياً بأنه "الفرد الذى يعاني من عجز حركى أو جسمى يحد من نشاطه وحيويته ويعوق حركته نتيجة عيب خلقى أو حادث".



أما عن أنواع الإعاقة الحركية فيمكن أن تصنف إما لمكانها (سفلى-علوى) أو لشدتها (شديدة- بسيطة). ويذكر شاكر قنديل (٢٠٠٠، ٤٠٦) أن هناك عامل مشترك بين جميع أشكال الإعاقة والمعوقين، وهو أن وجودهم يمثل إزعاجاً للآخرين، ويفسر "هوفمان" هذا الإزعاج بأنه نتيجة للتناقض الذي يحدث بين المعوق وبين هويته الواقعية.

ويشير عبد الرحمن سليمان (٢٠٠١، ١٣١) إلى الإعاقة الجسمية بأنها "تلك الإصابة الجسمية التي لها صفة دائمة وتؤثر تأثيراً حيوياً على ممارسة الفرد لحياته الطبيعية في المجتمع".

ويشير عادل عبد الله (٢٠٠٤، ٢٨٤) إلى الإعاقة الجسمية بأنها "حالة تعوق الفرد عن أن يقوم باستخدام جسمه أو أجزاء منه استخداماً كاملاً ذا فاعلية مما يؤثر على كم وكيف أدائه". والإعاقة الحركية قد ترجع في الأساس إلى عدد من الظروف والأسباب المختلفة منها ما هو وراثي ومنها ما هو بيئي.

ثانياً: الإعاقة السمعية (الأصم- ضعف السمع): Hearing Impairment

اللغة هي وسيلة الاتصال بين البشر في الحياة اليومية، في نقل المعلومات ونقل الثقافة والحضارة عبر المكان والزمان ووسيلة للتخاطب والتعبير عن الانفعالات واستقبال المعلومات، ومن ثم فالإعاقة السمعية تقف حائلاً في وجه اللغة، وتعطيل دورها الأساسي في الاتصال (Marcel Broester, 2005, 411).

وتعد حاسة السمع من أهم الحواس التي يستند إليها الأطفال لتفاعلهم وتواصلهم مع المحيطين بهم، ومع المجتمع ككل، فالسمع يؤدي دوراً هائلاً في النمو الاجتماعي والانفعالي والفكري للأطفال، وضعف السمع يؤدي لإعاقة تقدمهم، مما ينتج عنه مشكلات في التعليم والسلوك في وقت مبكر من عمر الطفل، كما يؤثر على تواصله مع المجتمع، وقد يحرم الطفل ضعيف السمع من وسيلة الإدراك لما يجري من حوله كأى طفل عادي في مظهره الخارجي، ونقص قدرته على السمع أو فقدانها قد لا يلتفت نظر الآخرين له (Golos, 2006).

ومما لا شك فيه أن لحاسة السمع أهمية عظيمة، وقد لا يعرف البعض أن أهميتها تفوق أهمية البصر، بالرغم أن البعض يعطي الكثير من عطفه وحنانه للكفيف دون الأصم، ولكن قوله تعالى هو الفاصل، فقد ذكر الله السمع والبصر وقدم السمع على البصر في الكثير من الآيات القرآنية: "ثم سواء ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون" سورة السجدة: آية (٩)، وقوله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" سورة الإسراء: آية (٣٦) مما يؤكد على أهمية حاسة السمع في حياتنا اليومية. كما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فهو السميع البصير (عبد المطلب القرطبي، ١٩٩٦، ١٣٦).

وتمثل الإعاقة السمعية شكلاً من أشكال العجز أو القصور يستشعر معها صاحبها فقدان عضو ما من أعضائه أو إمكانية من إمكانياته لها أهميتها الاجتماعية ويتمتع بها غيره من أقرانه العاديين، كما يستشعر أن هذا فقدان له دلالة بالنسبة للدور الذي يمكن أن يلعبه في مجالات الحياة داخل الإطار الثقافي الذي يعيش فيه (فتحي الطاهر، ٢٠٠٢، ٨).

ويظهر تأثير ضعف السمع عند الطفل على نموه اللغوي والمعرفي وتحصيله الدراسي، وخصائصه الصوتية وقدرته على الكلام (إيمن فوزى، ٢٠٠٦)، كما يؤدي إلى شعوره بالقلق والشعور بالعزلة والاكنتاب، وبذلك فالتدخل المبكر لمعالجة هذه المشكلات يمكن من خلال استخدام طرق حديثة لتفادي المشكلة بالاستعانة بالمعينات السمعية للتقليل من المشكلة (أماني عبد السلام، ٢٠٠٥)، وفي هذه الحالة يحتاج الأطفال ضعاف السمع إلى تنمية القدرات الإدراكية والانتباه والتركيز عن قصد دون إصدار أحكام تقييمية وتقبل كل الخبرات الايجابية والسلبية (Brown & Ryan, 2007, P: 2).

وتتفق الآراء في أن الطفل ضعيف السمع في أمس الحاجة للفهم والأخذ بيده عن طريق أساليب التواصل والمساعدة على التكيف مع المحيطين به والتعايش معهم (ماجدة عبيد، ٢٠٠٩)، وفي ظل ذلك التقدم المعرفي والتطور التكنولوجي الهائل في المجالات التربوية والعلاجية، وزيادة انتشار مشتتات الانتباه وكثرة الضغوط، وعدم قدرة الطفل ضعيف السمع في وصف وفهم وتفسير سلوكياتهم للآخرين، وعدم قدرتهم على إحداث توازن بين مهاراتهم الإدراكية وبين تحدياتهم، مما دفع الباحثين في مجال علم النفس بالبحث عن عوامل تساعد الطفل في تزويد مهاراته وقدراته وحسن تواصله مع الآخرين، والاهتمام بصفة عامة بالمفاهيم الايجابية للسلوك (النشيمي الرويلي، ٢٠١٩).

ففي مصر قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التربية والتعليم بتطوير حزمة من البرامج التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع المجتمع، وذلك لكسر حاجز التواصل بين الطفل المعاق سمعياً وبين المجتمع، حيث تم توزيع مشروع نظام "التواصل" على (٢٠٠) مدرسة للمعاقين سمعياً والتعاون مع قطاع التدريب المهني على وضع قاموس إلكتروني موحد كبرنامج رئيسي في تدريب المعلمين بعدد (٥٠٠٠) معلماً كمبادرة لكيفية التعامل والتواصل مع المعاقين سمعياً وضعاف السمع (وزارة التربية والتعليم، ٢٠١٧).

وتشير الإحصاءات في مصر طبقاً لعام ٢٠٠٩، أن نسبة الصم وضعاف السمع من الأطفال تصل إلى (٠,٠٠٧٪) (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٠٩، ١)، كما تشير إحصائيات عام ٢٠١٩، أن عدد ضعاف السمع في مصر وصل إلى (٤٥٢٢٠٠٠) بنسبة (٤,٧ ٪) من سكان مصر، والمحتاجون إلى زراعة القوقعة (٢٤٠٠٠٠) بنسبة (٠,٢٥ ٪) وعدد من يتم إجراء زراعة قوقعة سنوياً (١٥٠٠٠) سنوياً بنسبة (٠,٠١٦ ٪) (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ٢٠١٩).

ففقدان حاسة السمع تجعل الطفل لا يستطيع أن يسمع صوت أمه والأشخاص المحيطين به لكي يتعلم الكلام، فالإنسان يتعلم الكلام من تقليد كلام الآخرين، ونجد أن الطفل الأصم لا يستطيع تعلم الكلام رغم وجود جهاز الكلام كالطفل العادي من حلق ولسان وأسنان وشفاه ولكن عدم مقدرته على السمع هي التي تمنعه من تعلم الكلام... فالطفل الأصم يبدأ مرحلة المناغاة Babbling في نفس الوقت مع الطفل العادي ويكررها الطفل الأصم ولكنها ليست نتيجة لتقليد أصوات الآخرين، وبوصول الطفل الأصم إلى سن ٦ شهور تتحول مناغاته إلى صراخ ذي أنماط متكررة وربما يحوي أو لا يحوي بعضاً من الحروف الساكنة مثل ماما أو بابا (لطفى بركات، ١٩٧٨، ٢٣-٢٤).

قائمة المحتويات

وتتفق الآراء في أن الطفل ضعيف السمع في أمس الحاجة للفهم والأخذ بيده عن طريق أساليب التواصل والمساعدة علي التكيف مع المحيطين به، والتعايش معهم (ماجدة عبيد، ٢٠٠٩). فالمعاق سمعياً يتعذر عليه بسبب إعاقته الاندماج في المجتمع نظراً لفقدانه حاسة السمع التي تؤثر بدورها على تعلمه الكلام، والتواصل مع الآخرين.

ويتضح مما سبق أن الإعاقة السمعية أحد الإعاقات الحسية، وأن إصابة أي جزء في الجهاز السمعي قد يؤثر بدوره على الفرد، وقد يترتب عليه فقدان القدرة على الكلام واكتساب اللغة مما يؤثر على أدائه التعليمي أو المهني وتفاعله مع المثيرات البيئية والاجتماعية، وتشمل الإعاقة السمعية الصم وضعاف السمع.

وبالرغم من أن فقدان حاسة السمع تأثيرات سلبية على شخصية المعاق سمعياً، إلا أننا ينبغي ألا نفقد الأمل في تعليمه، فالمجتمع يوفر له فرص التعليم وممارسة المهن التي تتلائم مع إعاقته، الأمر الذي يقلل من الآثار السلبية للإعاقة، فضلاً عن أن هناك نماذج كثيرة تحدثت الإعاقة ونالت مكانة مرموقة في المجتمع، وبالتالي فإن فقدان حاسة السمع لا يعني نهاية حياة الفرد، فهناك حواس أخرى تلعب دوراً هاماً كحاسة الإبصار التي يستخدمها الأصم لترجمة ردود أفعال الآخرين، مما يؤكد على أهمية دور الآخرين أو المحيطين بالأصم في تقبله لإعاقته ولذاته.

مفهوم الإعاقة السمعية: Hearing Impairment

يرى عبد العزيز الشخص (١٩٨٥، ٣٦٣) أن المعاق سمعياً هو "من حرم حاسة السمع منذ ولادته أو قبل تعلم الكلام، إلى درجة تجعله حتى مع استعمال المعينات السمعية غير قادر على سماع الكلام المنطوق، ومضطراً إلى استخدام الإشارة أو لغة الشفافة أو غيرها من أساليب التواصل مع الآخرين".

والإعاقة السمعية مصطلح عام يغطي مدى واسع من درجات فقدان السمع Hearing Loss، يتراوح بين الصم أو الفقدان الشديد Profound الذي يعوق عملية تعلم الكلام واللغة، والفقدان الخفيف Mild الذي لا يعوق استخدام الأذن في فهم الحديث وتعلم الكلام واللغة (عبد المطلب القريطي، ١٩٩٦).

ويذكر جمال الخطيب ومنى الحديدي (١٩٩٦، ٦٥) أن الإعاقة السمعية مصطلح يشير إلى فقدان سمعي يبلغ من الشدة درجة يصبح من التعلم بالطرائق العادية غير ممكن أو غير مفيد، وبالتالي فلا بد من تقديم البرامج التربوية.

وتشير زينب شقير (١٩٩٩، ١٨٤-١٨٥) إلى تصنيف تelford & Swrey للمعاقين سمعياً وفي ضوء درجة فقدان السمع على النحو التالي:-

١- فقدان سمع بسيط (٢٠-٣٠ ديسبل): وفي هذه الحالة يعاني الفرد من صعوبة في سماع الكلام الخافت أو الكلام عن بعد، كما يعاني من صعوبة تمييز بعض الأصوات.

٢- فقدان سمع هامشي وتكون درجة فقد السمع (٣٠-٤٠ ديسبل): حيث يعاني الفرد من بعض الصعوبات في سماع الكلام ومتابعة ما يدور حوله من أحاديث عادية، إلا أنه يمكنه الاعتماد على أذنيه في فهم الكلام وتعلم اللغة.

٣- فقدان سمع متوسط (٤٠-٦٠ ديسبل): حيث يعاني الفرد من صعوبة أكبر في الاعتماد على أذنيه في تعلم اللغة ما لم يستخدم بعض المعينات السمعية المكبرة للصوت كالسماعات.

قائمة المحتويات

٤- فقدان سمعي شديد (٦٠-٧٥): حيث يعاني الفرد من صعوبات كبيرة في سماع الأصوات وتمييزها ولو من مسافات قريبة. إضافة إلى عيوب النطق ويحتاج الفرد في هذه الحالة إلى خدمات خاصة لتدريبه على الكلام وتعلم اللغة وهذه الفئة تمثل الحد الفاصل بين الصم وضعاف السمع.

٥- فقدان سمعي عميق (٧٥ديسبل فأكثر) حيث لا يمكن الفرد من فهم الكلام، وتعلم اللغة سواء بالاعتماد على أذنيه، أو حتى مع استخدام المعينات السمعية.

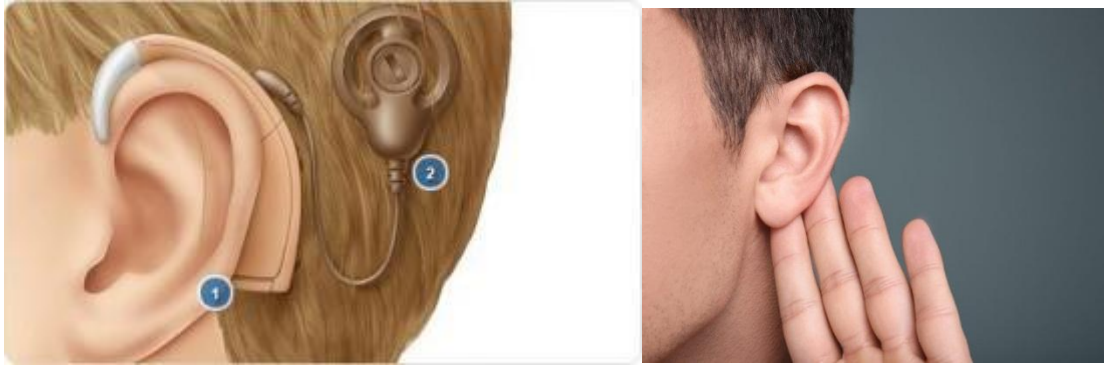
وتمثل الفئات الثلاثة الأولى فئة ضعاف السمع، أما الفئتان الأخيرتان فتمثلان فئة الصم.

ويلاحظ أن برامج التربية للمعاقين سمعياً بمدارس الأمل تتعامل مع الصم وضعاف السمع دون أن تخصص برامج محددة لكل من الفئتين لذلك فإن هذا الكتاب سوف يتعامل معهما كفئة واحدة تحت مسمى المعاقين سمعياً لفئة عدد ضعاف السمع.

ويعرف نظمي أبو مصطفى (٢٠٠٠، ١١٢) الأطفال المعاقين سمعياً بأنهم "الأطفال الذين يعانون قصوراً أو عجزاً في قدرتهم السمعية، مما يعيق الأداء التعليمي أو المهني أو فرص تفاعلهم مع المثيرات البيئية والاجتماعية".

مما سبق يتضح أن المعاق سمعياً هو الذي ينحرف عن مستوى العاديين خاصة فيما يتعلق بالجانب الحسي أو الحاسة السمعية لديه بالمقارنة بأقرانه الأسوياء، فالحاسة السمعية لدى المعاق سمعياً معطلة بشكل يعوقه عن التواصل بفاعلية في بيئته.

الصمم:



الأطفال الصم هم أولئك الذين لا يمكنهم الانتفاع بحاسة السمع في أغراض الحياة العادية، سواء منهم من ولدوا فاقدين السمع تماماً، أو بدرجة أعجزتهم عن الاعتماد على أذانهم في فهم الكلام وتعلم اللغة، أم من أصيبوا بالصمم في طفولتهم المبكرة قبل أن يكتسبوا الكلام واللغة، أو من أصيبوا بفقدان السمع بعد تعلمهم الكلام واللغة مباشرة لدرجة أن آثار هذا التعلم قد تلاشت تماماً مما يترتب عليه في جميع الأحوال افتقاد القدرة على الكلام وتعلم اللغة، وهكذا قد يكون الصمم سابقاً على اكتساب الكلام واللغة Pre language أو بعد تعلم اللغة والكلام Post language (عبد الرحمن سليمان، ٢٠٠١، ٨٢).

ويعرف عبد المطلب القريطي (٢٠٠٥، ٢٩٩) الصم بأنهم "أولئك الذين لا يمكنهم الانتفاع بحاسة السمع في أغراض الحياة العادية سواء من ولدوا منهم فاقدى السمع تماماً، أو بدرجة أعجزتهم عن الاعتماد على أذانهم في

قائمة المحتويات

فهم الكلام وتعلم اللغة، أم من أصيبوا بالصمم في طفولتهم المبكرة قبل أن يكتسبوا الكلام واللغة مباشرة لدرجة أن آثار هذا التعلم تلاشت تماماً، مما يترتب عليه في جميع الأحوال افتقاد المقدرة على الكلام وتعلم اللغة".

والطفل الأصم هو الطفل الذي "لديه فقدان سمعي من ٧٠ ديسيبل وأكثر ويعيق فهم الكلام من خلال الأذن وحدها باستعمال أو بدون استعمال السماع الطبية" (Moore, 1996).

فالصمم في الأصل مشكلة في الاتصال، ولا يوجد هناك اختلاف فطري بين المعاقين سمعياً والعاديين باستثناء الاتصال الاستقبالي التعبيري، وأن الصم لديهم حاجات اجتماعية مثل غيرهم، وخلال اليوم المدرسي يحتاجون للتفاعل مع أقرانهم في البرامج الأكاديمية والثانوية، بحيث ينجح في المشاركة بالنشاطات المدرسية، وهم يستمتعون بالخبرات العادية ولهم الحق في أن يقفوا في الساحات ويناقشوا أفكارهم والاختبارات المقدمة لهم، وهذا يعتبر بعداً لكافة الطلاب سواء معاقين أم غير معاقين (ماجدة سيد عبيد، ١٩٩٢، ١٣).

ويتضح من العرض السابق أن الآراء التي تناولت تعريف الأصم قد اتفقت على أن الصمم عبارة عن "فقدان حاسة السمع بدرجة كبيرة لدى الفرد تؤدي بدورها إلى إعاقته لفهم الكلام من خلال الأذن مع أو بدون استخدام معينات سمعية، مما تتطلب أسلوباً مناسباً للتلميذ لمساعدته على فهم الكلام وتعلم اللغة".

ضعاف السمع:

يعرف عبد المطلب القريطي (١٩٩٦، ١٣٨) ضعف السمع بأنهم "أولئك الأفراد الذين يكون لديهم قصور سمعي أو بقايا سمع، ومع ذلك فإن حاسة السمع لديهم تؤدي وظيفتها بدرجة ما تمكنهم من تعلم الكلام واللغة سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونها".

ويعرف أحمد يونس ومصري حنورة (١٩٩٩، ٧٢) التلميذ ضعيف السمع بأنه "التلميذ الذي لديه تلف في السمع، والذي يحتاج من أجل تربيته ترتيبات خاصة أو تسهيلات معينة، على الرغم من عدم الحاجة إلى كل الطرق التي تستخدم مع الأطفال من ذوي الصمم الكامل".

ويعرف وحيد مصطفى (٢٠٠٣) الأطفال ضعاف السمع بأنهم "الأطفال الذين لديهم عجز جزئي في حاسة السمع بدرجة لا تسمح لهم بالاستجابة الطبيعية لأغراض الحياة اليومية إلا في ظروف خاصة باستخدام معينات سمعية".

وتعرف أماني عبد السلام (٢٠٠٥) الطفل ضعيف السمع بأنه "الطفل الذي يعاني من فقدان القدرة السمعية وقد يمكن تعويضها باستخدام المعينات السمعية ويمكنه التعلم بذات الطريقة التي يتعلم به الأطفال السمعيين أي العاديين".

وتعرف ماجدة عبيد (٢٠١٠) الأطفال ضعاف السمع أنهم "الذين فقدوا جزءاً من قدرتهم على السمع بعد أن تكونت لديهم مهارة الكلام والقدرة على فهم اللغة وحافظ على قدرته على الكلام وقد يحتاج هؤلاء الأطفال إلى وسائل سمعية معينة".

يتضح مما سبق أن ضعيف السمع لديه القدرة على الكلام، وفهم اللغة، ولكنه يحتاج وسيلة سمعية تعينه على ممارسة حياته بطريقة طبيعية.

أسباب الإعاقة السمعية:

تنقسم أسباب الإعاقة السمعية إلى نوعين من الأسباب هما:

قائمة المحتويات

أسباب وراثية:

كثيرا ما تحدث حالات الإعاقة السمعية الكلية، أو الجزئية نتيجة انتقال بعض الصفات الحيوية، أو الحالات المرضية من الوالدين إلى أبنائهما عن طريق الوراثة، من خلال الكروموزومات الحاملة لهذه الصفات كضعف الخلايا السمعية أو العصب السمعي، ويقوى احتمال ظهور هذه الحالات مع زواج الأقارب ممن يحملون تلك الصفات. وتضيف زينب شقير (١٩٩٩، ١٩٦) أن معظم العوامل المسؤولة عن الصمم هي من النوع المتنحي، أي أن فرصة تلاقي عوامل متشابهة للصمم من زوجين لديهما صمم أو يسمعان فرصة ضئيلة، لكن هذه الفرصة تزداد إذا كان الزوجان بينهما قرابة".

بينما تشير برنستين (Bernstein, 1999, 34) إلى أن فقدان السمع المتعلق بالجينات يعني أن صفة فقدان السمع هي صفة سائدة ولهذا فإنها تمر خلال الأجيال لتنتقل إلى الطفل مع مجموعة أخرى من الصفات، أو أنها كانت صفة متنحية اشتركت مع غيرها من الموروثات.

أسباب بيئية (مكتسبة):

- أسباب تحدث قبل الولادة وتشمل (عبد المطلب القريطي، ١٩٩٦، ١٤٨):
 - إصابة الأم في الشهور الأولى من الحمل بالحصبة الألمانية.
 - إصابة الأم ببعض الأمراض المعدية كالزهري.
 - تعارض عامل (RH) في دم الأم والجنين ، يمكن أن يسبب الصمم خاصة عندما يكون الـ RH للجنين إيجابيا والـ RH للأم سلبيا.
 - تناول الأم بعض العقاقير أو التعرض لأشعة إكس أثناء الشهور الأولى من الحمل.
- ب-أسباب تحدث أثناء الولادة وتشمل (زينب محمود الشقير، ١٩٩٩، ١٩٥):
 - ولادة الطفل قبل اكتمال نموه.
 - تعرض الطفل للاختناق أو نقص الأكسجين بسبب تعسر الولادة أو مشاكل الحبل السري، أو إصابة المخ بنزيف، مما يؤدي إلى تلف بعض خلايا المخ.
 - استخدام الطبيب الآلات مثل (الجفت) بطريقة غير سليمة أثناء عملية الولادة.
- ج-أسباب تحدث بعد عملية الولادة وتشمل (نجوى السيد، ١٩٩٠، ٣٦) :
 - إصابة الطفل بالالتهاب السحائي.
 - إصابة الطفل بالتهاب الغدة النكافية، والحمى القرمزية، أو الحصبة ومضاعفاتها.
 - إصابة الطفل بالحمى الشوكية التي تصيب العصب السمعي بالالتهاب والضمور.
 - إصابة الطفل بنزلة برد شديد، وحدوث التهاب في اللوزتين والحمية، مما يؤثر على الأذن الوسطى التي قد يحدث بها التهاب صديدي قد يؤدي إلى حدوث ثقب في طبلة الأذن.
 - تعرض الطفل لضربة شديدة أو حادثة تؤدي إلى إصابة مركز السمع في المخ.
 - تعرض الطفل لسماع أصوات شديدة الارتفاع لفترة طويلة.

قائمة المحتويات

خصائص المعاقين سمعياً:

تؤثر الإعاقة السمعية تأثيراً كبيراً على جميع جوانب شخصية المعاق سمعياً وفيما يلي عرض تفصيلي لخصائص المعاقين سمعياً:

١- الخصائص اللغوية:

يعد النمو اللغوي من أكثر مظاهر النمو تأثراً بالإعاقة السمعية حيث أنها تؤثر سلباً على جميع جوانب النمو وبدون تدريب منظم ومكثف لن تتطور لدى الشخص المعاق سمعياً مظاهر النمو اللغوي الطبيعية، لذلك فهم يحتاجون إلى تعلم هادف ومتكرر.

"والإعاقة السمعية تؤخر النمو اللغوي، وتؤثر على إدراك التلميذ للعلاقة بين الصوت والرموز المكتوبة، وعليه تؤثر الإعاقة على طريقة اكتساب مهارات اللغة ومنها القراءة" (Bill Gearheart, 1984, 54).

ويلاحظ على لغة المعاقين سمعياً أنها تتصف بكونها غير غنية كلغة الآخرين فهي محدودة وألفاظهم تتصف بالتمركز حول الملموس، وجملهم أقصر وأقل تعقيداً، أما كلامهم فيبدو بطيئاً ونبرته غير عادية.

وقد كشفت دراسة صفاء سلطان (١٩٩٥، ٤٤) عن ضعف مستوى أداء التلاميذ الصم لعناصر الفهم اللغوي، وضعف مستويات الفهم القرائي لديهم وقد أرجعت هذه النتائج إلى عدم مناسبة محتوى مناهج المعاقين سمعياً.

ويعد ضعف قدرة المعاق سمعياً، وعجزهم عن فهم اللغة السائدة في بيئتهم أو التحدث بها من أخطر المشكلات التي يواجهونها، ولا يقلل من خطورة هذه المشكلة براعة الصم وخبرتهم في فهم واستخدام لغة الإشارة اليدوية المتداولة بينهم كمجموعة ذات خصائص واحدة، إذ أن خبرتهم هذه لا تعينهم على فهم اللغة السائدة في مجتمعهم أو التحدث بها وهذا هو الفارق الأساسي بين الصم، ومجتمع العاديين في سمعهم.

ويذكر فاروق الروسان (١٩٩٦، ١٤٦) أن هناك علاقة طردية بين درجة الإعاقة السمعية من جهة ومشكلات النمو اللغوي من جهة أخرى، فكلما زادت درجة الإعاقة السمعية كلما زادت المشكلات اللغوية.

٢- الخصائص المعرفية:

لا تؤثر الإعاقة السمعية على الذكاء، فمستوى ذكاء الأشخاص المعاقين سمعياً لا يختلف عن مستوى ذكاء الأشخاص العاديين، بينما تؤثر الإعاقة السمعية على لغة المعاقين سمعياً مما يجعلها أضعف من لغة العاديين، ويعد الضعف اللغوي من المؤثرات على التحصيل العام، مما يجعله أضعف لدى المعاقين سمعياً وهذا ما أوضحته ماجدة عبيد (٢٠٠٠، ٣١٥) بأن تأخر المعاقين سمعياً من الناحية التحصيلية التعليمية بالمقارنة مع تحصيل أقرانهم العاديين.

وتؤكد دراسة فاتن فاروق عبد الفتاح (١٩٩٤) على أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة بين درجات نسب الذكاء ودرجات التحصيل الدراسي لدى من يتعلمون في معاهد الأمل وتوصي بعدم استخدام معايير تقويم التحصيل الدراسي للأسوياء عند تقويم التحصيل الدراسي للصم.

ويشير جمال الخطيب (١٩٩٨، ٩٠-٩١) إلى أن تحصيل المعاقين سمعياً يضعف كلما زادت المتطلبات اللغوية ومستوى تعقدها.

قائمة المحتويات

ويتأثر التحصيل الأكاديمي بمتغيرات أخرى غير شدة الإعاقة السمعية مثل القدرات العقلية والشخصية، والدعم الذي يقدمه الوالدان حسب القدرات السمعية المتبقية وكيفية استثمارها، وعمر الطفل لحظة حدوث الإعاقة السمعية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة (Edward, 1982, P.319).

٣- الخصائص الجسمية والحركية:

تشير ماجدة عبيد (٢٠٠٠، ٣١٢-٣١٣) إلى أن مشكلات التواصل التي يعاني منها المعاقون سمعياً تضع حواجز وعوائق كبيرة أمامهم لاكتشاف البيئة والتفاعل معها، وإذا لم يزود المعاق سمعياً باستراتيجيات بديلة للتواصل فإن الإعاقة السمعية قد تفرض قيوداً على النمو الحركي، بالإضافة إلى أن اللياقة البدنية لدى المعاقين سمعياً أقل منها لدى نظرائهم العاديين، وذلك نظراً للقيود التي تفرضها الإعاقة على تفاعل هؤلاء المعاقين مع مؤثرات البيئة، وذلك نتيجة للمشكلات التي تواجههم في التواصل مع العاديين.

٤- الخصائص الاجتماعية والانفعالية:

تعد اللغة وسيلة أساسية من وسائل الاتصال الاجتماعي، ولذلك يعاني المعاقون سمعياً من مشكلات تكيفية في نموهم الاجتماعي، حيث يقل النضج الاجتماعي للمعاقين سمعياً عن الأشخاص العاديين بسبب النقص الواضح في قدراتهم اللغوية وصعوبة التعبير عن أنفسهم وصعوبة فهمهم للآخرين، فهم يميلون إلى الخجل والانطواء، ويفتقرون إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين وكذلك أنماط التنشئة الأسرية قد تقود إلى عدم النضج الاجتماعي والاعتمادية.

وتوضح دراسة عطية محمد (١٩٩٠، ٥٩) وجود علاقة دالة بين فقدان السمع وكل من توافق وتقبل المعاق سمعياً لهذا الفقدان، ويرجع ذلك إلى أن فقدان السمع الكلي يضعف من مستوى النمو الاجتماعي والشخصي للفرد المعاق، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات سلوكية في حياة الفرد تعوق تكيفه العام. كما أوضحت الدراسة أنه كلما زاد عمر المعاق سمعياً قل تقبل المعاق سمعياً لإعاقته وخاصة الإناث حيث تزداد مخاوفهن من المستقبل بصورة واضحة بزيادة العمر، مما يقلل من تقبلهن لإعاقتهن. وتشير الدراسات إلى أن المعاقين سمعياً يعانون من عدم الثبات أو الاتزان الانفعالي بالإضافة إلى سوء التوافق الاجتماعي، وذلك بدرجة أعلى من العاديين.

ويميل المعاقون سمعياً إلى تكوين التجمعات الخاصة بهم، إذ تعد هذه التجمعات ذات أهمية خاصة بالنسبة لهم. بسبب تعرض الكثير منهم لمواقف الإحباط التي تترتب على نتائج التفاعل الاجتماعي بين الأفراد العاديين والمعاقين سمعياً إلى الأعمال التي لا تتطلب الكثير من الاتصالات الاجتماعية كالرسم والخياطة والنجارة والحدادة ويشير محمد حلاوة (١٩٩٠، ٧٠)، إلى أن الأطفال الذين يعانون من الصمم منذ ولادتهم يظهرون انحرافاً أكبر في النمو الانفعالي عن أولئك الذين يصابون بالصمم بعد فترة من النمو.

أثر الإعاقة السمعية على مظاهر النمو:

أ- أثر الإعاقة السمعية على النمو اللغوي:

تعتبر اللغة وسيلة تفاعل الإنسان مع بيئته ومن خلالها يعبر عن أفكاره ورغباته وميوله، ولذا فإن فقد السمع ليس مجرد حرمان الفرد من السمع ولكنه يعني الحرمان من اللغة المنطوقة فذو الإعاقة السمعية يفقدون القدرة على الانتفاع بحاسة السمع في مناحي الحياة المختلفة بسبب ما يعانونه من عجز أو قصور يحول بينهم وبين الاستفادة من حاسة السمع، وبناء على ذلك لا يستطيعون اكتساب اللغة بالطريقة العادية (مختار حمزة، ١٩٧٥، ٦٢). وعند مقارنة نمو الطفل العادي ونمو الطفل المعاق سمعياً يلاحظ أن المعاق سمعياً ينفصل انفصالاً كلياً عن العالم الخارجي وعن عالم الأصوات ويمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة في بداية الشهر السابع من عمره حيث لا يستجيب للأصوات (ماجدة عبيد، ١٩٩٢، ٢٩).

قائمة المحتويات

فالأطفال الذين يعانون من الإعاقة السمعية لا يمكنهم اكتساب اللغة من خلال عملية التقليد بسبب وجود هذه الإعاقة ولذلك يحاول الأطفال ذوو الإعاقة السمعية اكتساب اللغة المكتوبة لأنها الوسيلة التي يتعاملون من خلالها مع المجتمع (ماجدة عبيد، ١٩٩٢، ٢٩).

ويعاني الطفل الذي أصابه الصمم قبل اكتساب اللغة، والطفل ذو الصمم العارض والطفل ضعيف السمع درجات متباينة من الانحراف في اللغة الحسية والسمعية والشفهية تظهر خلال محاولتهم الاتصال (Edmunds, 1992: 102).

ومما سبق يتضح أن النمو اللغوي، أكثر مظاهر النمو تأثراً بالإعاقة السمعية، فالإعاقة تؤثر سلباً على جميع جوانب النمو اللغوي، وبدون تدريب منظم ومكثف لن تتطور لدى الشخص المعاق سمعياً مظاهر النمو اللغوي الطبيعية، ومع أن الأطفال ذوي السمع العادي يتعلمون اللغة والكلام دون تعلم مبرمج فالمعوقون سمعياً بحاجة إلى تعليم هادف ومتكرر فالشخص المعوق سمعياً سيصبح أبكماً إذا لم تتوفر له فرص التدريب الخاص الفاعل، ويعزي ذلك لغياب التغذية الراجعة السمعية عند صدور الأصوات وعدم الحصول على تعزيز لغوي كافي من الآخرين وفي حالة اكتسابهم المهارات اللغوية فإن لغتهم تتصف بكونها غير غنية كلغة الآخرين، وذخيرتهم محدودة وألفاظهم تتصف بالتمركز حول الملموس، وجعلهم أقصر وأقل تعقيداً، أما كلامهم فيبدو بطيئاً ونبرته غير عادية (جمال الخطيب، ١٩٩٦، ٣٢).

ب- أثر الإعاقة السمعية على النمو العقلي:

يشير أيوجين مندل ومكاني فيرنون (١٩٧٦، ١٥٧-١٥٨) أن ثنائية فقدان السمع والغباء أطلقت ظلماً على أيدي المضللين وبعض الأخصائيين في مجال نفسية الطفل ذي الإعاقات السمعية وهذا المنطلق يركز إما على التفكير الخاطئ بأن الإعاقة في الكلام تعني إعاقة في القدرات المعرفية، أو على افتراض زائف آخر بأن الأخطاء في كتابة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية ينعكس على ذكائهم، وأن الطفل ذا الإعاقة السمعية أقل قدرة على التفكير المجرد. إلا أن البحوث التي اهتمت بالعلاقة بين اللغة والعمليات الفكرية أظهرت أن القدرة على التفكير المجرد لا تختلف بين الأطفال ذوو الإعاقة السمعية وعادي السمع.

في حين أوضح بنتر Pintner وزملائه وتلاميذه أن مستوى القدرات العقلية للطفل الذي أصيب بالصمم في الصغر تكون أقل منها لدى الطفل العادي، وأن الأمراض المسببة للصمم أثرت على المخ وبالتالي سببت التخلف العقلي (في: فتحي عبد الرحيم وحليم بشاي، ١٩٩٢، ٥٣٢). ويؤكد كارفر Carver (١٩٨٨، ٧١) إلى أن الإصابة بالصمم ليس لها تأثير على الجانب العقلي لدى الطفل، إذ لا توجد هناك اختلافات جوهرية بين الطفل العادي والأصم من حيث القدرات العقلية، فقد أكدت ذلك اختبارات نسبة الذكاء التي أثبتت أن غالبية هؤلاء الصم كانت لديهم قدرات عقلية تفوق العاديين.

جـ أثر الإعاقة السمعية على النمو الانفعالي:

يشير مورثان وريتشارد (Morethan&Richard، ١٩٨٠، ١١٥-١١٩) إلى أن الأصم إبان الطفولة لا يشعر بحنان الأمومة وعطفها الدافئ ويرجع ذلك إلى عدم سماعه صوت أمه وترانيمها خلال فترة عنايتها به وهو في حضانتها ويضيف الباحثان أن الأطفال الصم يعانون من الإحباط نتيجة لعدم فهم الآخرين لهم، بسبب افتقارهم وسيلة الاتصال (اللغة)، حيث إننا نشرح للطفل العادي مثلاً سبب رفض شيء ما في حين أننا لا نفعل شيئاً للأصم سوى أن نجيب بالرفض، فيشعر بالإحباط لأنه لم يفهم سبب الرفض أو سبب معاقبته.

ويذكر محمد فهمي وغريب أحمد (١٩٨٣، ٨٦) أن من أهم المشاكل التي تترتب على فقدان السمع: الاهتزاز النفسي والانفعالي، الذي من نتائجه الانطوائية لدى غالبية الصم وتكتلهم في مجتمعات شبه معزولة اجتماعياً ومن الناحية النفسية يؤدي هذا الاهتزاز أو عدم الثبات الانفعالي إلى أمراض نفسية مختلفة تصاحب أحياناً حالات الصمم الشديدة.

وقد وجد ليفين Levine أن الأشخاص الصم متهورون وينقادون للآخرين بسهولة ومن السهل استثارتهم (في: جمال الخطيب ومنى الحديدي: ١٩٩٦، ٤٠٦).

وقد أسفرت أبحاث كل من ليون Lyon وبنتر Pintner وفسفلد Fوسفلد عن النواحي المزاجية للصم، أن معظم الصم يتصفون بعدم الاتزان العاطفي ويتصفون بالانطواء على أنفسهم، كما أن لديهم رغبة في الإشباع المباشر لحاجاتهم ويكونون أقل حبا للسيطرة (في: مختار حمزة، ١٩٧٩، ٧٩).

وفي دراسة قام بها فاريفجيا وأوستين (Farrivgia&Austin, 1980) بهدف المقارنة بين أربع مجموعات من الأطفال ضعاف السمع والصم في المدارس العامة، والعاديين في المدارس العامة، والصم في المدارس الداخلية باستخدام استبيان التوافق الاجتماعي والانفعالي لميدو وكاندال (Meadow & Kendall, 1980) وتوصلاً في نتائجهما إلى أن الأطفال الصم في المدارس العادية يعانون من سوء التوافق الانفعالي وتقدير الذات من أي مجموعة أخرى (in Lemonek& Gresham, 1984: 385).

ومن ثم يتضح أن أهم آثار الإعاقة السمعية على النمو الانفعالي هي عدم الاتزان الانفعالي، الإحباط، الاضطرابات العاطفية، وغير ذلك من الآثار التي تعوق الأصم عن بلوغ التوافق النفسي، وعن إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين، ولذلك يجب على الأسرة توفير الجو الأسري الملائم، ومحاولة اشتراك الأصم في أمورهم ومناقشتهم لزيادة خبراته المعرفية التي تساهم في تفاعله وتوافقه مع ذاته ومع الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة استخدام أكثر من طريقة للتواصل مع الأصم لأنها تشبع حاجاتهم بشكل ملائم، الأمر الذي يحد من أثر الإعاقة على النمو الانفعالي لديهم.

د- أثر الإعاقة السمعية على النمو الاجتماعي:

يرتبط هذا النوع ارتباطاً وثيقاً بالنمو اللغوي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، إذ أن الإعاقة السمعية تحجب الطفل عن المشاركة الإيجابية الفعالة مع من حوله في الجماعة الإنسانية، ذلك أن عملية اكتساب الكلام تعتمد في بداية نموها على قدرة الطفل على التقليد سواء كان ذاتياً في مرحلة المناغاة أو في مرحلة متقدمة عن ذلك (لطي بركات، ١٩٧٨، ٧٠).

وحينما يكبر الطفل الأصم ينظر فيما حوله متسائلاً عن هذه المخاطر الساكنة التي تبدو أمامه، وفيما عدا ما تعود عليه أشياء ألفها سبيل كل شيء أمامه غامضاً حيث إنه حرم من القدرة على السؤال، وأحياناً ما يعتريه شعور بالخوف والتذمر ولكن بدون جدوى، لأن حائط السكون مازال مطبقاً حوله، وبناء عليه فإن الطفل الذي

قائمة المحتويات

يسمع ويستطيع أن يميز صوت أمه يختلف عنه في حالة الطفل السليم، وغالبا ما تكون البيئة العادية مصدر حيرة أكبر لهذا الطفل بسبب مختلف نواحي النشاط التي يقوم بها أفرادها من ذوي السمع السليم، فهذا الطفل يجد نفسه في حيرة وفي حالة من الغضب نتيجة لعدم قدرة من حوله على فهمه وذلك نتيجة عجزه عن التفاهم والاتصال معه (مختار حمزة، ١٩٧٥، ٦٧).

ويشير جرينلري وكوش (Greenlery&Kusshe,1989) إلى أن الأطفال المعاقين سمعيا يعانون من صعوبة إقامة علاقات اجتماعية مع أقرانهم العاديين، ولذا فهم يشعرون بالنبذ الاجتماعي Social rejection . وتذهب لادموسون Laddmuson إلى أنه يجب تضافر الجهود لإيجاد مناخ اجتماعي يدعم التفاعل الإيجابي بين المعاقين سمعيا وأقرانهم العاديين (Leight & Stinson, 1991 :9).

ويؤكد عبد المطلب القريطي (١٩٩٦، ١٣٦-١٣٧) على أن الإعاقة السمعية تؤدي بدورها إلى إعاقة النمو الاجتماعي للطفل حيث تحد من مشاركته وتفاعلاته مع الآخرين واندماجه في المجتمع، مما يؤثر سلبيا على توافقه الاجتماعي وعلى مدى اكتسابه المهارات الاجتماعية الضرورية واللازمة لحياته في المجتمع، كما تعوق عدم القدرة على السمع النمو الانفعالي والعاطفي للطفل.

وقد توصل إديك (Eldik,1994,396) في دراسته عن المشكلات السلوكية لدى ذوي الإعاقة السمعية إلى أنهم يعانون من مشكلات سلوكية تتمثل في الانسحاب من المجتمع، والعدوانية، وعدم تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى الخوف من المستقبل، وأشاد إديك Eldik بدور الأسرة في فهم شخصية الأصم وكيفية التعامل معه لتحقيق مستوى أفضل من الصحة النفسية.

والفرد المعاق سمعيا قد يعاني من سوء التوافق إذا لم يكن بمقدوره الرضا عن واقعه الحالي، وأيضا إذا لم يستطع أن يغير من حاله، حيث أن الإعاقة السمعية قد تفرض على الأصم الانسحاب من المجتمع، وبالتالي تؤدي إما إلى تقبل اجتماعي منخفض، وإما إلى التحدي الذي إذا صادفه النجاح حاز على الشهرة والنجومية التي تتيح لصاحبها تقبلا اجتماعيا مرتفعا (علي عبد النبي، ١٩٩٦، ٨٩).

وبهذا تتضخم المشكلة في نظر نفسه، ونظر المجتمع، وقد ينشأ عن ذلك اختلال علاقته بالآخرين بسبب عجزه عن أن يحيا حياة طبيعية مثلهم، فإما الانطواء والخوف من الناس ومن الحياة وإما الاستسلام أو التحدي والعدوان (رمزية الغريب، ١٩٨٢، ٧).

مشكلات المعاقين سمعياً:

ينمو الأصم في عالم بلا أصوات عالم خال من حرارة العطف والحنان ومن أصوات الأم والأب والأصدقاء، ومن أي صوت يدفعه للشعور والإحساس بما يراه ويلمسه فكل شئ بالنسبة له ساكن بارد ولذا يبدو وكأنه غريب أو أنه يعيش في عالم غريب عنه لا صلة له به، كما أنه غير قادر على السؤال عما حوله فيشعر بالخوف والتذمر والعزلة والحيرة والغضب والوحدة لعدم قدرته على فهم من حوله وعدم قدرة من حوله على فهمه.

ودلت الدراسات الحديثة على أن الأصم يصاب بعدم الاتزان العاطفي وأكثر انطواء وعزلة، ويعاني من أعراض سوء التكيف الاجتماعي وكذلك الإحساس بالنقص وعدم الثقة وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الاختبارات الخاصة بالتكيف على عينة من المعاقين سمعياً (<http://almraah.net/t334802.html>). ويميل الأصم بسبب عاهته الحسية إلى أن ينسحب من المجتمع ولذلك فهو غير ناجح اجتماعيا بدرجة كافية. كما يعاني من سوء التكيف الاجتماعي بسبب عجزه عن التفاعل مع المجتمع، ومن ثم يفرض عليه عزلة اجتماعية.

قائمة المحتويات

ويتأثر كل طفل أصم باختلاف ظروف البيئة والتنشئة الاجتماعية كما يتأثر بدرجة إصابته، فنتيجة لعدم قدرة الأصم مشاركة الآخرين وسائل اتصالهم المختلفة والتي تعتمد في الأساس على القدرة على السمع وتمييز الأصوات والكلام، فهو غالباً ينعزل عن الجماعة وهو ما يبعده عن اكتساب الخبرات الاجتماعية بصورة سليمة وهو ما يؤدي إلى تكوين شخصية منطوية غير ناجحة انفعاليا واجتماعيا، ويزيد من ذلك إحساس الطفل الأصم بالنقص والقصور والدونية والعجز وعدم الثقة، الأمر الذي يؤثر على توافقه الشخصي والاجتماعي. والتلميذ الأصم في حالة توتر مستمر عندما يكون مع الناس، لذا يفضل الانزواء النفسي والعيش في عزلة، فهو يتسم بالعجز عن إقامة علاقات اجتماعية سليمة مع أقرانه.

والمعاقين سمعيا يشعرون خلال طفولتهم بالدونية والشك ونقص الثقة وسوء التوافق الإنفعالي وضعف الضبط الذاتي والشعور بنقص الكفاءة، ويتوقع مواجهة مواقف إحباط جديدة لم يسبق مواجهتها نتيجة لفقد السمع مما يثير لديه القلق والاضطراب الانفعالي والذي يؤدي إلى العزلة والعجز والاغتراب وشعوره بالوحدة.

أساليب التواصل لدى ذوي الإعاقة السمعية:

يقصد بها تلك الطرق التي يستخدمها الصم للتواصل فيما بينهم وبين الآخرين، ومن هذه الطرق ما يلي:

أ- هجاء الأصابع Fingers Spelling:

وسيلة من الوسائل التي يستعان بها للتواصل مع المعاقين سمعيا أثناء تواجده في مجتمع العاديين، وتعني التماثل بين الكلام وهجاء الأصابع، وقد استخدمت هذه الطريقة في الخمسينات والستينات على نطاق واسع فقد استخدمها ستيفن Stephen في دراسته عن تأثير هذا المدخل في تعليم اللغة والقراءة للصم، وقد اتضح من استخدام هذه الطريقة فعاليتها ودلالاتها أكثر من الطرق الأخرى في تعليم اللغة والقراءة (سعيد جابر المنوفي، ١٩٩٠، ٣٢).

وترى ماجدة عبيد (١٩٩٥، ٧١) أن الهجاء الإصبعي عبارة عن إشارات حسية يدوية للحروف الهجائية تستخدم بطريقة متفق عليها، ومن الممكن تعلم الهجاء الإصبعي، حيث يمكن التعبير عن الأسماء والأفعال التي يصعب التعبير عنها بلغة الإشارة بلغة الأصابع، ومع ذلك يمكن الجمع بين لغة الإشارة والأصابع معا لتكوين جمل مفيدة ذات معنى.

وفي العادة يستخدم الهجاء الإصبعي كطريقة مساندة للغة الإشارة إذا كان الشخص الأصم لا يعرف الإشارة المستخدمة لكلمة ما أو إذا لم يكن هناك إشارة للكلمة، بعبارة أخرى نادرا ما يستخدم الهجاء الإصبعي بمفرده للتواصل مع الشخص الأصم (جمال الخطيب، ١٩٩٦، ٦٠-٦١).

ب- لغة الإشارة Sign Language:

هي عبارة عن رموز مرئية إيمائية في نظام حسي بصري يدوي يقوم على أساس الربط بين الإشارة والدلالة وهي لغة مستقلة لها نظامها واستراتيجيتها وفوائدها وتعد هذه اللغة الأم الأصلية بالنسبة للصم مثل اللغة العربية لنا، إذ ليس هناك لغة إشارية عالمية لجميع اللغات، وإنما لغة إشارية خاصة تتعلق بمتطلبات الفهم والتعامل والتواصل في الحياة (حمدي شاكر محمود، ب.ت: ١٢١).

ويرى جمال الخطيب (١٩٩٦، ٦١) أن لغة الإشارة بصري - يدوي لاستقبال المعلومات والتعبير عنها، والإشارات هي خليط من الأوضاع والأشكال والحركات باليد تمثل كلمات أو أفكار محددة، وهذه اللغة تسمح

قائمة المحتويات

بالتواصل بين الناس الصم، ولكن هذه الطريقة ليست مفيدة للتواصل مع الغالبية العظمى من الناس الذين يسمعون لأنهم لا يعرفون لغة الإشارة.

وتنقسم الإشارات إلى قسمين:

أ- إشارات وصفية: وهي الإشارات اليدوية التلقائية التي تصف فكرة معينة مثل: رفع اليد للتعبير عن الطول أو فتح الذراعين للتعبير عن الكثرة.

ب- إشارات غير وصفية: وهي لغة خاصة متداولة بين الصم وهي مثل: الإشارة بإبهام اليد إلى أعلى للدلالة على شيء حسن، والإشارة بالإبهام إلى أسفل للدلالة على شيء رديء (عبد المجيد عبد الرحيم، لطفي بركات، ١٩٧٩، ٢٢٨).

وتعتبر لغة الإشارة هي الطريقة الأكثر استخداماً بين الصم والآخرين، بل أن معظم الأسر لديها خلفية عن الإشارات المتداولة في مجتمع الصم لاحتياجاتهم اليومية، وهذا يتفق مع ما أشارت إليه كلومين وكوستاد (Klumin & Coustad, 1944, 330) إلى أن هناك دراسات عديدة أثبتت أن الأمهات اللاتي يستخدمن لغة الإشارة مع أطفالهن الصم تمكن أبناءهن من إحراز درجات عالية من التفاهم والتواصل، الأمر الذي ينعكس على تقبلهم لذواتهم.

ج- الطريقة الشفاهية Oral Method:

يقصد بالطريقة الشفاهية قراءة الشفاه Lip Reading أي أن يفهم ذو الإعاقة السمعية الرموز البصرية لحركة الفم والشفاه أثناء الكلام من قبل الآخرين (فاروق الروسان ١٩٨٩، ١٤٧).

وتسمى أيضاً الطريقة الشفوية السمعية Oral-odue method وفيها يستقبل الأطفال الرسالة Input من خلال القراءة الكلامية، كما أنهم يعبرون عن أنفسهم من خلال الكلام، وتعتمد على قدرة الأصم على ملاحظة حركات الفم والشفاه والحلق واللسان وترجمة هذه الحركات إلى أشكال صوتية أو حروف، الأمر الذي يتطلب التمرين أو الممارسة لإتقان هذه الطريقة، فهي التي تسلح الأصم بطريقة تمكنه من أن يشق بها سبيله في الحياة العامة والعلمية والاجتماعية (سعيد جابر المنوفي، ١٩٩٠، ٣١).

ويؤكد أنصار الطريقة الشفوية في التواصل أن التواصل اللفظي أو الشفوي الذي يمثل فيه الكلام قناة التواصل الرئيسية يجعل الأشخاص الصم أكثر قدرة على فهم الكلمات المنطوقة وذلك من خلال الاستفادة من التعليمات والإيماءات الناجمة عن حركة شفاه المتكلم ولكن تكمن الصعوبة في هذه الطريقة في أن بعض الأصوات عندما تلفظ تبدو متشابهة على الشفاه والوجه، وبالتالي فإن قراءة الشفاه ليست عملية سهلة ولذلك فهي لا تستخدم بمفردها ولكن تستخدم مع أساليب التواصل الأخرى (جمال الخطيب، ١٩٩٦، ٦٠).

د- التواصل الكلي:

تتضمن هذه الطريقة استخدام أنواع مختلفة من طرق التواصل لمساعدة الأصم على التعبير واكتساب اللغة. ويشتمل أسلوب التواصل الكلي على الصورة الكاملة للأنماط اللغوية، الحركات التعبيرية التي يقوم بها الطفل من نفسه، ولغة الإشارة، والكلام وقراءة الشفاه، وهجاء الأصابع والقراءة والكتابة.

ويرجع عبد المطلب القريطي (١٩٩٦، ١٦٨) أفضلية طريقة التواصل الكلي مع المرونة الكافية في إمكانية مزجها بحسب الأحوال بطرق أخرى ربما يستجيب لها الطفل أكثر من غيرها، وذلك بالنسبة لذوي فقدان السمع الحاد أو العميق (٩١ ديسبل فأكثر) والذي لا يمكنهم الاعتماد على سمعهم في تعلم اللغة والكلام. وأهمية استخدام معلمي المعاقين سمعياً لأسلوب التواصل الكلي في تعليم المعاقين سمعياً حيث تستخدم طريقة التواصل الكلي لتحقيق هدفين أساسيين هما: تسهيل عملية التواصل وتوفير بديل عملي للكلام (ص ١٣٨).

قائمة المحتويات

ويشتمل التواصل الكلي على الإدراك البصري لبعض عناصر الموقف التعليمي وتشير مارجريت وآخرون (١٩٩٠، ١٥٦) إلى اعتماد المعاقين سمعياً بشكل كبير على الفهم البصري واستراتيجيات التنظيم وإظهار القوة في مجال الإدراك البصري.

كما يشير لوكنير وآخرون (Luckner, et al., 2001, 619) إلى أهمية استخدام استراتيجيات التعليم البصري للتلاميذ المعاقين سمعياً والتي تعرض أمثلة لبعض المواد البصرية التي تستعمل مع هؤلاء للتلاميذ.

ثالثاً: الإعاقة البصرية (الكفيف - ضعاف البصر):



يعد البصر من أهم روافد المعرفة لدى الإنسان وبه يدرك العلاقات المكانية والأحجام والأطوال والأشياء، وحاسة البصر هي الحاسة التي يرى بها الإنسان العالم من حوله وبدونها يكون العالم من حوله معتماً ولا يشعر به إلا عن طريق المعلومات التي تدخل إليه عن طريق الحواس الأخرى، وإذا ما حدث خلل في هذه الحاسة يتعرض الإنسان لكثير من المشاكل والاضطرابات النفسية والاجتماعية، فالمعاقين بصرياً هم الذين يعيشون في ظلمة تامة أو يرون الأشياء دون تمييز كامل لها، كما أن هذه الأشياء تؤثر في المعاقين بصرياً تأثيراً سلبياً، ومن هذه التأثيرات السلبية الوحدة النفسية، حيث اتفق معظم الباحثين والعلماء على أن الوحدة النفسية هي إحساس أليم وبغيض يشعر فيه الفرد بانخفاض تقدير الذات وعدم احترام الآخرين له، ومن ثم نقص في شبكة العلاقات الاجتماعية مما يترتب على ذلك رغبة الفرد للعزلة والانطواء والانسحاب من المجتمع (محمد على عرابي، ٢٠١٩).

ويعتبر دراسة كف البصر من الدراسات ذات الأهمية الكبيرة وذلك لما قد يوجد بين تلك الفئة من مكفوفي البصر ممن هم لديهم قدرات خاصة، ومواهب طبيعية، وسمات نادرة لا بد أن نهتم بها ونرعاها، حتى تنمو تلك القدرات والمواهب بطريقة طبيعية، كما أن هذه الفئة لها تأثير كبير على تطور وتقدم المجتمع، فالرعاية لا بد أن تشمل الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي والتربوي للكفيف (حنان شرشر، ١٩٩٥، ٣).

وتمثل حاسة البصر أهمية كبرى في حياة الإنسان فهي تساعد على التفاعل الواقعي مع بيئته سواء كانت طبيعية أو اجتماعية، إذ أن حوالي ثلثي معلومات الفرد عن العالم المحيط به تأتي عن طريق حاسة البصر، أي أن البصر يضيف على حياة الإنسان معنى خاصاً (عبد العزيز الشخص، ١٩٩٤، ١٨٥).

ويعتبر غياب حاسة الإبصار من الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة نسبية في الاتصال بالآخرين، فالكفيف لا يستطيع الاتجاه بنظره إلى محدثه، وهو لا يستطيع استخدام الإشارات أو الإيماءات التي تنوب عن اللغة في

قائمة المحتويات

بعض الأحيان، وهو لا يستطيع قراءة تعبيرات الوجه لمعرفة أثر كلماته على من يستمع إليه، ولا يستطيع استخدام تلك التعبيرات لتصوير انفعالاته لما يقوله الآخرين مما يوحى لمحدثه أنه لا ينصت إليه، أو بأنه لا يهتم بما يقوله، ولأن الكفيف يعتمد على حاسة السمع وحدها في الاتصال بالآخرين، ولأنه لا يستطيع إدراك أفعال الآخرين بما يقوله أو يفعله، فإنه يحتاج دائماً إلى قدر كبير من الانتباه والتركيز لكي يحتفظ بتواصله مع الآخرين، ولهذا السبب فإن علاقات المكفوفين بالآخرين تبدو في كثير من الأحيان أحادية الجانب (Burlingham, 1992, P. 259).

وهكذا يجد الكفيف نفسه عاجزاً عن الاندماج الصحيح في المجتمع، ومن ثم يفضل الكثير من المكفوفين قصر علاقاتهم الاجتماعية على زملائهم من المكفوفين. وقد وجد باترا (Patra, 1981) أن نسبة كبيرة من المكفوفين يشعرون بوجود فجوة (عائق) تعوق التواصل بينهم وبين المبصرين وأن المكفوفين في الغالب يتخيرون أصدقائهم من بين المكفوفين وليس من المبصرين.

وعلى الرغم من أن المكفوفين في جمهورية مصر العربية يحظون بكثير من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية التي تقوم على تنفيذها الوزارات والجمعيات الأهلية المختلفة، إلا أن هناك فئة منهم لا تحظى بأي نوع من الرعاية وهي فئة الأطفال المكفوفين في مرحلة ما قبل المدرسة، ويرجع ذلك إلى وجود قصور في المعلومات والإحصاءات الخاصة بأعداد هذه الفئة ممن تتراوح أعمارهم الزمنية بين ٤-٦ سنوات، وقلة عدد الدور أو الأماكن التي تقوم برعايتهم، إضافة إلى ذلك أن معظم هذه الدور والمؤسسات لا تقبل الأطفال قبل سن التعليم الأساسي أي قبل سن السادسة، مما ترتب عليه وجود قصور نسبي في الإحساس بمشكلات تلك الفئة وندرة الخطط والبرامج الخاصة بهم بالرغم من أهمية وجود هذه الخطط والبرامج لمثل هؤلاء الأطفال وفي هذه المرحلة العمرية لتأهيلهم ومساعدتهم على التوافق النفسي والاجتماعي ونمو جميع جوانب شخصيتهم (سميرة أبو زيد، ١٩٩٨، أحمد عبد الرحيم، ١٩٩٤، وزارة التربية والتعليم، ١٩٩٥، فاتن النمر، ١٩٩٨)، ونتيجة لذلك فإن معظم هؤلاء الأطفال يظلون في رعاية أسرهم التي غالباً ما تحتاج إلى التوجيه والإرشاد للقيام بدورها في أهم فترة عمرية من فترات التنشئة الاجتماعية، كما أن غالباً ما تكون اتجاهات الأسرة نحو طفلهم الكفيف في هذه المرحلة اتجاهات سلبية تؤثر في تأخر نموه وتسلك سلوكاً لا يؤدي إلى التربية السليمة (أسماء السرسى، وأمني عبد المقصود، ٢٠٠٢).

ويرى العديد من الباحثين أن الطفل الكفيف في مرحلة رياض الأطفال لديه قصور في النمو الحركي، خاصة في مهارات الوقوف والجلوس والاتصال والتحكم والسيطرة الحركية (Ferguson & Builjens, 1990; Troster & Bombring, 1994).

كما يواجه الطفل المعاق بصرياً بالتعليم النظامي داخل المدرسة دون المرور بمرحلة رياض الأطفال، وعلى الرغم من أن تعليم المكفوفين ليس بالأمر الهين حيث يعتمد تعليمهم على المهارات المكتسبة قبل سن المدرسة سواء كانت حركية أو سمعية أو لمسية، وكذلك يحتاج المدرس للوقت والجهد في العملية التعليمية، هذا في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بتربية الطفل قبل المدرسة وإعداده نفسياً واجتماعياً وعقلياً ودينياً وتهيئته للتعليم النظامي (سميرة أبو زيد، ١٩٩٢، ٤٩).

تعريف الإعاقة البصرية:

الإعاقة البصرية من المنظور اللغوي: هناك ألفاظ كثيرة في اللغة العربية تستخدم للتعريف بالشخص الذي فقد بصره، كالأعمى، والأكمه، والكفيف، المكفوف، والضرير، والعاجز. ويعرف الكفيف لغوياً بأنه "من كف بصره أي عمى (جبران مسعود، ١٩٢٧)، والعمى هو ذهاب البصر (محمد بن أبو بكر الرازي، ١٩٥٤)، وكلمة العاجز يطلقها العامة على الأعمى لملاحظتهم أنه قد عجز عن الأشياء التي يستطيعونها، أما كلمة الأكمه فمأخوذة من الكمه

قائمة المحتويات

وهي "العمى قبل الميلاد"، وقد وردت في القرآن الكريم "وتبرئ الأكمه والأبرص بأذني" (سورة المائدة، آية ١٠)، وكلمة "الأعمى" وردت في القرآن الكريم بمعنيين أولهما الضلالة كما جاء في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا) [إسراء: ٧٢]، ثم جاءت بمعنى ذهاب البصر بقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) [النور: ٦١]، وقوله تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)) [عبس، ١-٢] (أحمد أبو هشيمة، ٢٠١٢: ٢٦-٢١). وكلمة الأعمى أصل مادتها العماء، والعماء هو الضلالة ويقال العمى في فقدان البصر، ويشار بها إلى من يولد أعمى (إيهاب الببلاوى، ٢٠٠١: ٧).

أما من الناحية الطبية فقد عرف القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ لجمهورية مصر العربية المكفوفين علي أنهم "الأطفال الذين فقدوا حاسة البصر أو كان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون فيها إلى أساليب تعليمية لا تعتمد علي استخدام البصر، ولا يستطيعون التعامل البصري مع مستلزمات الحياة اليومية في يسر وكفاءة" (اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين، ١٩٩٨، ٦٩). وكف البصر هي "الحالة التي يفقد فيها الشخص المقدرة على الرؤية بالجهاز المخصص لهذا الغرض وهو العين، نتيجة إصابة هذا الجهاز عبر حادثة أو خلل خلقي يولد به اشخص، ودرجة إبصاره لا تزيد عن ٦/٦٠". وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه حالة يجد فيها الإنسان صعوبة بالغة في تأدية الوظائف الأساسية، بسبب فقدان القدرات البصرية (رأفت خطاب، ٢٠١٤: ٤٧). وتعرف الجمعية الطبية الأمريكية "كل فرد تصل حدة إبصار أقوى عينيه إلى ٢٠/٢٠ أو أقل بعد استخدام أقوى العدسات الطبية بالنسبة له" (James, E. & Bob, A., 1995, 377). وبذلك يعرف كف البصر بأنه "الحالة التي يفقد الفرد الرؤية بالجهاز المخصص لذلك وهو العين، وهو الحالة التي تتراوح ما بين الكف الكلي أي فقد قوة الأبصار كلية والحالات القريبة من ذلك والتي تبلغ حدة البصر فيها ٢٠/٢٠ أو أقل في العين الأقوى ويليها استخدام العدسات الطبية (مصطفى فهمي، ١٩٦٥؛ ميتلر، ١٩٧٣، ٣٧٥). والكفيف من الوجهة التربوية: حسب تعريف هيئة اليونسكو هو "الشخص الذي يعجز عن استخدام بصره في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من متابعة الدراسة في المدارس العادية (مصطفى فهمي، ١٩٦٥، ١٣). ومن الوجهة الاجتماعية: تحدد درجة كف البصر علي أساس قدرة الطفل البصرية الضعيفة أو المنعدمة بحيث يحتاج إلى المساعدة الأدبية والاجتماعية (لطفى بركات، ١٩٨١، ١٣٩). ومن المنظور الفسيولوجي هي الحالة التي يفقد فيها الشخص كلياً أو جزئياً القدرة علي الرؤية بالجهاز المخصص لهذا الغرض وهو العين، والأسباب الفسيولوجية يمكن تقسيمها إلى قسمين:

١- أسباب خارجية: تتعلق بالعين نفسها وتشتمل علي العيوب التي تصاب بها الطبقات والأجزاء المكونة للعين كالقرنية أو الشبكية أو العدسة.

٢- أسباب داخلية: تتعلق بالعصب البصري الموصل أو المراكز العصبية في الدماغ وتشمل عيوب العصب البصري كأن ينقطع مثلاً نتيجة الإصابة بحادث فيتعذر بذلك وصول الإحساس البصري المنطبع علي الشبكية إلى المراكز الحسية في الدماغ وقد يحدث أن يكون العصب البصري سليم وكذلك العين إلا أن المراكز العصبية في الدماغ المخصصة لتلقي الإحساسات البصرية تكون معطلة فتكون النتيجة توقف الإحساس البصري في نهاية العصب الموصل دون أن تتلقفه المراكز البصرية لأنها عاطلة عن العمل (مني حسين الدهان، ١٩٩٤: ١٥). ومن الوجهة القانونية يعرف كف البصر بأنه "عدم القدرة علي الرؤية" وأن درجة الإبصار ٢٠/٢٠ في العين الأقوى مع التصحيح، وأن معظم أسباب كف البصر عضوية ولكن يوجد كف بصر وظيفي أو نفسي ويكون عادة كف بصر هستيري، وقد أشارت دراسات الشخصية إلى أن الأشخاص الذين يولدون مكفوفين لديهم مشكلات في الشخصية عن هؤلاء الذين فقدوا بصرهم في مرحلة متأخرة من الحياة" (جولدن صن، ١٩٨٤، ١٠٤). أما من وجهة نظر التربية الخاصة، فالطفل الكفيف هو ذلك "الشخص الذي لا يستطيع أن يعتمد علي حاسة الإبصار لعجزه فيها وعجزه في أداء الأعمال التي يؤديها غيره باستخدام هذه الحاسة". والكفيف من وجهة

قائمة المحتويات

نظر الصحة العامة وطب المجتمع هو الطفل المصاب بالعمى الكلي أو الجزئي، والأطفال المكفوفين هم الأطفال الذين لا يبصرون أو أن نظرهم به خلل وقصور يجعلهم يتعلمون أشياء لا تحتاج لاستعمال النظر وهو غالباً ما يكون بسبب عيب خلقي في كرة العين نفسها أو لوجود الماء الأبيض في عدساتها نتيجة لإصابة الأم بحصبة المانية أو زهري أثناء الحمل أو كنتيجة للأمراض التي تصيب الأطفال حديثي الولادة) (سيد خير الله، ١٩٦٧، ١١).

ويعرف دافيد هيل وآخرون (David, M.B. Hall, et al., 1996, 224) الطفل الكفيف بأنه الطفل الذي يتطلب تعليمه استخدام وسائل غير بصرية، ويحتاج إلى التعلم بطريقة برايل إذا كان لديه قدر معقول من الذكاء.

ويعرف الكفيف بأنه ذلك "الفرد الذي تبلغ حدة إبصار أقوى عينيه (٢٠/٢٠) قدم أو أقل بعد استخدام أقوى العدسات الممكنة، أو من يضيق مجال الرؤية لديه بحيث لا يستطيع رؤية سوى الأشعة الضوئية التي تقع في مخروط ضوئي زاوية راسه (٢٠) درجة" (عبد العزيز الشخص، ٢٠٠٦: ٦٦).

ويعرف خالد عبد الرازق النجار (٢٠١١: ٣٣) الكفيف هو الذي يحتاج إلى المساعدة الاجتماعية، أي أن الفرد يُعد مكفوف من الناحية الاجتماعية عندما تمنعه هذه الإعاقة من التفاعل بصورة ناجحة مع العالم المحيط به وتحد من قيامه بالوظائف السلوكية المختلفة.

كما عرفه محمد على عرابي (٢٠١٩) بأنهم الأشخاص الذين فقدوا بصرهم كلية ولم تعد لديهم القدرة على الإبصار وليس لديهم القدرة على اكتساب المعرفة ببصرهم ولا يستطيعون أن يتعلموا إلا بطريقة برايل أو المعينات السمعية أو المجسمات أو الحواسب الناطقة، وهم الأشخاص الذين لا يمكنهم بصرهم من العمل وكسب قوتهم. وتتفق خولة أحمد يحيى (٢٠٢٠: ٢٠٣) مع سابقها في أن الكفيف هو شخص ليس لديه القدرة على كسب عيشه بسبب كف بصره.

كما عرفته حنان السيد حسنين (٢٠٢١) بأنهم الأفراد الذين خُرموا من نعمة البصر، سواء قبل الولادة أو بعد الولادة، وليس لديهم القدرة على استقبال المؤثرات البصرية، ولا يستطيعون قراءة الكتابة المطبوعة، ويعتمدون على أساليب تعليمية لا تعتمد على البصر مثل القراءة والكتابة بطريقة برايل، والشرائط المسموعة.

أنواع كف البصر:

عند تعريف العمى ينبغي التمييز بين:

- ١- الذين لا يرون شيئاً أبداً ولم يبصروا أبداً مثل: الأكمه أو المكفوفين منذ الولادة أو المكفوفين تماماً.
- ٢- الذين استعادوا قليلاً من الرؤية بعد أن كانوا مكفوفين علي الإطلاق وهم الذين كانوا مكفوفين منذ الولادة وأجريت لهم عمليات جراحية.
- ٣- الأطفال الذين كانت لهم دائماً إدراكات ضوئية ضعيفة رغم أنهم عملياً مكفوفين وهم يستطيعون التمييز بين الليل والنهار والظل والألوان.
- ٤- الأطفال الذين صاروا مكفوفين تماماً بعد أن كانت لهم بعض الإدراكات الضعيفة.
- ٦- الأطفال الذين يكونون أنصاف مبصرين ثم يفقدون أبصارهم تدريجياً.

ولقد تم الإجماع بين المتخصصين في الإعاقة البصرية علي تصنيف كف البصر إلي أربعة أصناف:
-فاقدوا البصر تماماً: أو فاقده من الناحية العملية ودليل ذلك هو غياب الرؤية تماماً أو وجود مجرد لبعض الإدراكات الضوئية.

قائمة المحتويات

فأفقدوا البصر جزئياً: هم من يتمتعون بنسبة من الإبصار تمكنهم من التوجه في الضوء وإدراك الأجسام وهي تعمل علي تسهيل التنقل والتعامل مع العالم الخارجي وتصل درجة الرؤية لهذه الفئة عند ممارستها الحياة المدرسية درجة إبصار (٥٠/١ أو ٥٠/٢).

-المصابون بالعمش العميق: يكون رصيد الرؤية المتبقي لهم أفضل وتنبين لديهم الأحجام بشكل أحسن مع تمييز الألوان كما يستطيع قراءة الكتابة بالعناوين الكبيرة وتبلغ درجة الإبصار له (٥٠/٣ أو ٥٠/٤).

-المصابون بالعمش المتوسط أو الخفيف: فيها يتمكن الطفل من الرؤية عن قرب وتكون له فرصة أكبر في التعليم والكتابة العادية والقراءة وتبلغ شأن الطفل المبصر الذي يستطيع استخدام بصره من أجل التعلم فقط، ولكن طرق التعلم الخاطئة في المدارس لا يمكن أن تفيدته وقد تعود بالضرر علي بصره الضعيف (محمد عبد المؤمن، ١٩٨٦، ٢٣، ٢٤).

-أسباب الإعاقة البصرية وطرق الوقاية:

يمكن تلخيص مجمل أسباب الإعاقة البصرية فيما يلي:

١- الأسباب الخلقية: هي إما نتيجة عوامل وراثية أو عوامل تتعرض لها الأم الحامل فتؤثر على الجهاز البصري للجنين.

٢- الأمراض: التي تصيب العين وأهمها التراكوما والرمد الحبيبي والماء الأبيض والماء الأزرق والسكري.

٣- الإصابات: التي تتعرض لها العين كالصدمات الشديدة للرأس التي قد تؤدي إلى انفصال الشبكية أو تلف في العصب البصري أو إصابة العين بأجسام حادة، أو تعرض الأطفال غير مكتملي النمو إلى كميات عالية من الأوكسجين في الحاضانات مما يؤدي إلى تلف الشبكية.

٤- الإهمال: في معالجة بعض الصعوبات البصرية البسيطة مما يؤدي إلى آثار جانبية وتطور هذه الصعوبات إلى درجة أشد كما هو الحال في حالات طول البصر وقصر البصر والحوول والماء الزرقاء والبيضاء.

٥- انفصال الشبكية: ينتج عن ثقب في الشبكية مما يؤدي إلى تجمع السائل وانفصال الشبكية عن مقلة العين، ومن أهم أعراض انفصال الشبكية الأم شديدة وضعف في مجال الرؤية.

٦- اعتلال الشبكية: الناتج عن السكري: ويحدث عندما تصاب الأوعية الدموية في الشبكية ويحدث نزيف دموي يؤدي إلى حالة العمى.

٧- ضمور العصب البصري: ويحدث نتيجة الحوادث أو الالتهابات والأورام ونقص الأوكسجين مما يؤدي إلى فقدان البصر (السيد شريف، ٢٠١٤ : ٥٣).

-خصائص المعاقين بصرياً:

١- الخصائص الجسمية:

يترتب على الإعاقة البصرية المختلفة آثار غير مباشرة على بعض الخصائص الجسمية والحركية، ففي حين نجد النمو الجسمي في الطول والوزن يسير على نحو لا يختلف على نمو الأطفال المبصرين، فإن بعض القصور يمكن أن يلاحظ في المهارات الحركية، فالمعوقين بصرياً يواجهون قصوراً في مهارات التناسق الحركي والتآزر العضلي نتيجة لمحدودية فرص النشاط الحركي المتاح من جهة ونتيجة للحرمان من فرص التقليد للكثير من المهارات الحركية كالقفز والجري التمارين الحركية، فإنهم يتعرضون إلى خلل في توازن استهلاك الطاقة، وقد يكون فيما سبق تفسير لظاهرة السمنة في أوساط ذوي الإعاقة البصرية وهذا القصور في المهارات الحركية لدى المعاقين بصرياً يرجع إلى الأسباب التالية:

-نقص الخبرات البيئية والذي ينتج عنه عدم القدرة على المحاكاة والتقليد.

-قلة الفرص المتاحة لتدريب المهارات الحركية.

قائمة المحتويات

-الحماية الزائدة من جانب أولياء الأمور والتي تعيق الطفل عن اكتساب خبرات حركية مبكرة.

٢- الخصائص العقلية:

في البداية لابد من الإشارة إلى صعوبة قياس ذكاء ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر بدقة الاعتبار عدة، أهمها أن معظم اختبارات الذكاء المتوافرة تشتمل على أجزاء أدائية (كبناء المكعبات أو تجميع الأشكال وخلافه) وبالطبع فهي غير ملائمة للاستخدام مع المعوقين بصرياً، إضافة إلى ذلك فإن الاختبارات المطورة لذوي الإعاقة البصرية على قلتها تعوزها الدقة في معايير التقنين، وفي معظم الأحيان يلجأ الفاحصون إلى استخدام الجزء اللفظي من مقياس وكسلر لذكاء الأطفال المنقح لتقدير ذكاء الأطفال المعوقين بصرياً، ويشير "كوفمان" إلى أن نتائج الذكاء أظهرت أنه لا يوجد فرق كبير بين ذكاء المعوقين بصرياً مقارنة بالمبصرين، ومن الملاحظ أن المعوقين بصرياً يواجهون مشكلات في مجال إدراك المفاهيم ومهارات التصنيف للموضوعات المجردة خاصة مفاهيم الحيز والمكان والمسافة، ومن جانب آخر فإن الانتباه والذاكرة السمعية من العمليات العقلية التي يتفوق فيها المعوقين بصرياً على المبصرين، وليست هذه خاصية وراثية للمعوقين بصرياً، بل أنها نتيجة للتدريب المستمر الذي يمارسه المعوق بصرياً لهذه العمليات يحكم اعتماده بدرجة كبيرة على حاسة السمع.

٣- الخصائص اللغوية:

لا يعتبر ضعف حاسة البصر أو فقدانها من العوامل المعيقة لتعلم الطفل اللغة وفهم الكلام إلا أن لها أثراً على بعض مهارات الاتصال اللفظي الثانوي، وعلى سبيل المثال فإن الحرمان من حاسة البصر لا يسمح للمعوقين بصرياً تعلم الإيماءات والتعبيرات، كما أن نسبة شيوع المشكلات في اللفظ بين المعوقين بصرياً أعلى منها عند المبصرين، نتيجة لحرمانهم ملاحظة الشفاه لتعلم النطق السليم.

إن الكثير من المعاقين بصرياً يعانون من بعض الاضطرابات في الكلام واللغة، وقد أشارت بعض المعلومات عن ظاهرة اضطرابات اللغة والكلام لدى الأطفال المعاقين بصرياً، أنها مستقاة من عينات من الطلاب المعاقين بصرياً، المقيمين في المدارس الداخلية وأن هؤلاء الطلاب لا يمكن أن يمثلوا فئات المعاقين بصرياً، ولهذا فإنه يجب أن نأخذ هذه الخصائص بحذر تام وأن لا نطلقها على جميع المعاقين بصرياً بكامل فئاتهم ودرجاتهم، ومن أهم أنواع اضطرابات اللغة والكلام التي يعانيتها بعض المعاقين بصرياً ما يلي:

- ١- العلو: يتمثل في ارتفاع الصوت الذي قد لا يتوافق مع طبيعة الحدث الذي يتكلم عنه.
- ٢- عدم التغير في طبقة الصوت: بحيث يسير الكلام على نبرة ووتيرة واحدة.
- ٣- قصور في الاتصال بالعين مع المتحدث: عدم حركة الرأس عند الاستماع لشخص ما.
- ٤- القصور في استخدام الإيماءات والتعبيرات الوجهية والجسمية المصاحبة للكلام.
- ٥- الإفراط في الألفاظ على حساب المعنى: ينتج هذا عن القصور في الاستخدام الدقيق للكلمات أو الألفاظ الخاصة بموضوع ما أو فكرة معينة، فيعتمد إلى سرد مجموعة من الكلمات أو الألفاظ علة يستطيع أن يوصل أو يوضح ما يريد قوله.
- ٦- قصور في التعبير: ينتج من القصور في الإدراك البصري لبعض المفاهيم أو العلاقات أو الأحداث وما يرتبط بها من قصور في استدعاء الدلالات اللفظية التي يعبر عنها (طارق عامر، ٢٠١٥: ١٥-١٧).

٤- الخصائص الاجتماعية:

يتأثر التوافق الاجتماعي للمعوق بصرياً بفرص التفاعل الاجتماعي المتاحة من جهة ودرجة تقبل أو تكيف الفرد مع إعاقته من جهة أخرى، وتعتبر الاتجاهات الاجتماعية حيال المعوقين بصرياً وطبيعة التدريب الذي تلقاه المعوق بصرياً من العوامل الأساسية في أغناء فرص التفاعل الاجتماعي المتاحة، وفيما يتعلق بالاتجاهات

الاجتماعية السائدة حيال المعوقين بصرياً في المجتمعات الغربية فهي متناقضة في نتائجها، ويصعب على المبصرين التعرف على المعوقين بصرياً عن كثب حتى يتوصلوا إلى درجة أكثر موضوعية عن قدراتهم وإمكاناتهم، أما فيما يتعلق بطبيعة التدريب الذي يتلقاه المعوق بصرياً وعلاقته بتوافقه الاجتماعي، فلقد أظهرت العديد من الدراسات أن المعوقين بصرياً الذين يتلقون خدمات تربوية في المدارس العادية أكثر توافقاً ممن يوضعوا في مدارس التربية الخاصة أو المدارس الداخلية.

ومن العوامل التي ترفع من درجة التوافق الاجتماعي للمعوق بصرياً هو التدريب على النشاطات الحياتية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالعناية بالذات والمظهر والتنقل في البيئة، إن إتقان المهمات السابقة يعمل بشكل مباشر على تعزيز ثقة المعوق بصرياً بنفسه وتقليل درجة اعتماده على الآخرين، كما أنه يساهم بشكل غير مباشر على تحسين الاتجاهات الاجتماعية السائدة نحوه.

٥- الخصائص النفسية:

إن النمو النفسي للطفل المعوق بصرياً لا يختلف عنه عند المبصرين، ويمكن القول أن الطفل المعاق بصرياً لا يواجه صعوبات انفعالية متميزة عن الآخرين، والاضطرابات الانفعالية التي قد تظهر لدى الطفل المعوق بصرياً هي ذاتها التي يمكن أن يتعرض لها الطفل المبصر مع فرق في الدرجة بحكم ما يتعرض له المعوق بصرياً من مواقف يكون لها دوراً كبيراً في تحديد مفهوم الطفل لذاته من جهة ودرجة توافقه النفسي من جهة أخرى.

إن المعوق بصرياً أكثر من أقرانه المبصرين عرضة للقلق، خاصة في مرحلة المراهقة نظراً لعدم وضوح مستقبله المهني والاجتماعي وما يواجهه من صعوبات في تحقيق درجة عالية من الاستقلالية والتي يسعى لها جميع المراهقين في العادة. وإن إدراك أهمية ردود الأهل حيالة أبنائهم المعوقين بصرياً ودورهم الكبير في إتاحة الفرص لنمو نفسي سليم أمر في غاية الأهمية وذلك نظراً لدرجة الاعتمادية الكبيرة لدى المعوق بصرياً في مراحل الطفولة المبكرة على أسرته، ويؤكد المهتمين بشئون ذوي الإعاقة البصرية التأكيد على ضرورة تقديم الخدمات الإرشادية للأسر، وتدريبهم على كيفية العمل مع طفلهم المعوق بصرياً.

٦- الخصائص الأكاديمية:

لا يختلف المعوقون بصرياً بوجه عام عن أقرانهم من المبصرين فيما يتعلق بالقدرة على التعلم، والاستفادة من المنهاج التعليمي بشكل مناسب، ولكن يمكن القول أن تعليم الطالب المعوق بصرياً يتطلب تعديلاً في أسلوب التدريس والوسائل التعليمية المستخدمة، لتتلاءم مع الاحتياجات التربوية المميزة للمعوقين بصرياً، إذ ما من شك في أن ضعف البصر أو كفه يحد من قدرة الطالب على التعليم بذات الوسائل والأساليب المستخدمة مع المبصرين. وتعتبر درجة الإعاقة البصرية والسن الذي حدثت فيه، من العوامل الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للبرنامج التعليمي للمعوقين بصرياً، فعلى سبيل المثال، تختلف احتياجات التلميذ الذي يعاني من ضعف بصري بسيط عن احتياجات زميله الذي يعاني من كف كلي للبصر، كما أن من أصيب بكف البصر عن عمر ٦ سنوات أو أقل قليلاً، يتوفر لديه صورة ذهنية عن العالم الخارجي، بعكس الطفل الذي يولد كفيف أو يصاب بكف البصر في السنة الأولى والثانية من العمر (محمد عبد التواب، ٢٠١٥، ٩٣).

ويحتاج الطفل الكفيف إلى رعاية خاصة تساعد على التكيف مع البيئة من حوله، وتساعد على الاعتماد على نفسه وعلى التوافق النفسي والاجتماعي، كما تساعد على تنمية حواسه وقدراته بما يسمح له بالاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة.

قائمة المحتويات

كما تتمثل أهمية التفاعل الاجتماعي للطفل الكفيف في كونه أساس بناء الشخصية الاجتماعية له وتشكيلها ونموها، والوسيلة الأساسية للتعلم والتوافق، وأداة تنظيم المجتمعات والتجمعات الإنسانية وانتقال حضارتها من جيل إلى جيل.

- الخصائص المميزة للطفل الكفيف في مرحلة ما قبل المدرسة:

تصبح المشكلة كبيرة لدى الكفيف الذي فقد حاسة الإبصار خلال الخمس سنوات الأولى من حياته فهو يعتمد علي اللمس، والشم، والتذوق، كما أن الصور الذهنية Mental pictures، تستمد من حواسه المختلفة، وتتطلب حاسة البصر علي سبيل المثال لدي الكفيف اتصال مباشر بالشيء الذي هو موضوع الإحساس، مما قد يتعذر معه في بعض الأحيان الاتصال المباشر، كما أن مدى اللمس محدود وقد لا يتعدى طول الزارعين، كما أن الألوان وتمييزها لا تستطيع حاسة اللمس أن تتعرف عليها، ولاشك أن اتجاهات أفراد الأسرة والمحيطين بالطفل الكفيف تؤثر علي مدى تقبلهم له (الإلهامي عبد العزيز وآخرون، ٢٠٠١، ١٤٠).

وقد أسفرت هذه النتائج علي وجود أوجه تشابه واختلاف بين كل من الطفل الكفيف والمبصر في جوانب النمو المختلفة وهي كالتالي:

النمو الجسمي:

يتفاوت الأطفال من حيث الطول والوزن باختلاف العديد من العوامل مثل: الجينات والمستوي الاقتصادي للأسرة، وأنماط التغذية. وليس هناك دليل واضح علي وجود أى اختلافات بين الطفل الكفيف والطفل المبصر في الطول والوزن، حيث أشارت الدراسات التي تمت في هذا المجال إلي عدم وجود اختلاف بين الطفل الكفيف والطفل المبصر في جوانب النمو الجسمي (Samuel, 1990, 221).

النمو الحركي:

تنمو لدي الطفل عموماً في هذه المرحلة مهارات حركية عديدة حيث يمكنه أن يقفز ويتسلق وأن يقذف الكرة ويمسكها بسهولة، كما يمكنه الاحتفاظ بتوازن جسمه عند السير علي خط مستقيم، مع ملاحظة أنه يستخدم في حركاته العضلات الكبيرة في الجسم مثل عضلات الكتفين والفخذين أما الحركات التي تستخدم العضلات الدقيقة كأصابع اليد فلا يميل إليها كثيراً (سهير كامل، ١٩٩٤، ٦٧).

أما الطفل الكفيف فقد أشار ريان Rhyne إلي أنه لا يوجد اختلاف في النمو الحركي للطفل المعاق بصرياً ولأدياً في الأشهر الأولى من حياته بشكل واضح عن النمو الحركي للطفل المبصر، حيث أن معدل نمو القدرة علي الجلوس والتدحرج من وضع الانبطاح إلي وضع الاستلقاء لا يختلف بين المعاق بصرياً وبين الطفل المبصر (في: كمال سالم، ١٩٩٧، ٦٦). ومع ذلك وجد أن الطفل الكفيف يتأخر عن الطفل المبصر في بعض المهارات الحركية التي تتعلق بالحركة الذاتية للطفل مثل رفع الجسم والمشي باستقلالية وذلك لارتباط تلك المهارات بقدرة الطفل علي الثبات ودقة الحركة، وينتقل الطفل المكفوف من الجلوس إلي الوقوف مباشرة دون المرور بالمرحلة الوسطي التي من خصائصها الزحف علي الأرض (سميرة أبو زيد، ١٩٩٢، ٥١). والطفل الكفيف لا يتمكن من المشي باستقلالية إلا في حوالي الشهر التاسع عشر وهو بذلك يعتبر متأخراً عن الطفل المبصر الذي يقوم بنفس العملية في حوالي الشهر الثاني عشر، كما نجد أن الطفل الكفيف يواجه بعض المشكلات فيما يتعلق بإتقان بعض المهارات الحركية مثل الجري والتوازن والتقاط الأشياء.

وقد وجد نورس Norris أن هناك علاقة بين فرص التعلم التي تتاح للطفل الكفيف وبين قدرته علي الحركة، فالأطفال الذين أتاحت لهم فرص لتسلق الأشجار وممارسة التزلج ومصارعة أقرانهم المبصرين لا يعانون من

قائمة المحتويات

قصور التناسق الحركي، وفي الوقت نفسه يكون من المتوقع أن نجد أن مجموعة الأطفال المبصرين الذين لم تتح لهم فرص الحركة والذين يجلسون طول الوقت دون القيام بأي أنشطة حركية سوف يعانون من بعض القصور في التناسق الحركي (Samual,A.,1990,P.221).

والأطفال المكفوفين أكثر تعرضاً لنمو العادات الحركية من الأطفال المبصرين، وتبدو هذه العادات الحركية في صورة هرش الطفل في رأسه أو عبثه بأنفه أو دعه لعينييه وما شابه ذلك، ولعل أفضل طريقة لعلاج ذلك هي جعل الطفل مشغولاً باستمرار أو بإمداده بأشياء تشغل حواسه وتحرك أصابعه (سميرة أبو زيد، ١٩٩٢، ٥٢). وقد فسرت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع نمو تلك العادات الحركية أنه ناتج عن خلو أوقات فراغ الطفل الكفيف من الأنشطة الترويحية التي تعمل علي تسليته والترفيه عنه وتدريبه علي التفاعل الاجتماعي.

النمو العقلي المعرفي:

الذكاء:

أوضحت العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة ذكاء المكفوفين ومقارنته بذكاء أقرانهم من المبصرين أن ذكاء الكفيف لا يختلف كثيراً عن ذكاء المبصر (Daniel,et al., 1992,P.291).

وقد أوضح "أرنولد ميزميل" من خلال نتائج دراسات واختبارات علي الأطفال المكفوفين أنهم قادرين علي إتمام الاختبارات بفهم جيد، كما أن تفهم الطفل الكفيف لمواد الاختبار يدل علي تساوي العمر العقلي وتشابه العادات والطباع مع غيره من المبصرين في مثل سنه (في: سيد صبحي، ١٩٩٧، ٤٣).

نمو المفاهيم:

أكدت العديد من الدراسات علي أن النمو المعرفي ونمو المفاهيم لدي الكفيف يتأخر عنه لدي المبصر، فالطفل الكفيف يواجه صعوبات في المهام مما تتطلب تفكيراً مجرداً، كما أن لديه قدرة أكبر علي التعامل مع المفردات المحسوسة في بيئته، وترجع نقاط الضعف تلك لنقص في الخبرات التعليمية الملائمة وليست نقصاً في الشخص الكفيف (Daniel,et al.,1992,P.291).

وبالنسبة للمفاهيم المكانية: يعتبر المفهوم الخاص بالمكان من أكثر المفاهيم صعوبة بالنسبة للأطفال المكفوفين ولكن علي الرغم من ذلك هناك العديد من الدراسات التي قامت بدراسة مدي تأخر المكفوفين بالنسبة للمفاهيم المكانية منها دراسة "هارلي" (١٩٧٣) حيث وجد أن تكوين المفاهيم المكانية ليس مستحيلاً بالنسبة للأشخاص المكفوفين ويمكن أن ينمي تقدير المكان من خلال حساب الوقت الذي يستغرقه لمشي مسافة معينة (Daniel,et al.,1992,P.291).

لذلك يجب علي أفراد الأسرة أن يسهلوا للطفل الكفيف أن يوجد العلاقة بين الأشياء فيدربوه علي مقارنة الأشياء وصفاتها مع بعضها البعض، وبهذا يمكن للطفل الكفيف إدراك العلاقات ومعرفة الحقائق (سيد صبحي، ٢٠٠٠، ٦٣).

ومما سبق يتضح أن قدرة الطفل الكفيف علي تكوين المفاهيم ليست قاصرة وإنما تتأثر بدرجة كبيرة بالمناخ المحيط بالطفل، فإذا كانت بيئة الطفل بها من المثيرات الحسية ما يساعد الطفل علي اكتساب المفاهيم المختلفة فإنه سوف يتغلب علي الصعوبات التي يواجهها في مجال تكوين المفاهيم.

-النمو اللغوي:

اختلف العديد من الباحثين فيما يتعلق بتأثير كف البصر علي القدرة علي استخدام اللغة، حيث وجد أن كف البصر لا يؤثر في القدرة علي فهم واستخدام اللغة، وأنه لا توجد فروق بين الأطفال المبصرين والمكفوفين في المهارات اللغوية (Daniel,et al.,1992,289)، وقد يرجع ذلك إلى أن الطفل الكفيف قادراً علي سماع اللغة وقد يكون أكثر حماساً من الطفل المبصر لاستخدامها لأنها القناة الرئيسية التي تمكنه من التواصل مع الآخرين.

وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها "كاتسفورث" (١٩٥١) في دراسة له علي عينة من الأطفال المكفوفين ولادياً، حيث وجد أن لغة هؤلاء الأطفال تتسم باللفظية، حيث يستخدم الطفل الكفيف كلمات وعبارات لا تتسجم مع خبراته الحسية، ووجد "كاتسفورث" أن الأطفال المكفوفين يميلون لاستخدام اللغة التي تعكس خبرات بصرية، ويفسر "كاتسفورث" ذلك بأنه رغبة من الطفل الكفيف في الحصول علي الاستحسان الاجتماعي (Samuel,1990, P.224).

-نمو الحواس:

تعتبر حاسة السمع من أهم الحواس بالنسبة للطفل الكفيف فعن طريقها يكتشف العالم المحيط به ويتعرف علي العديد من المعلومات المتعلقة ببيئته من خلال التمييز بين المثيرات السمعية المختلفة وكذلك تقدم حاسة اللمس العديد من المعلومات للكفيف حول خصائص الأشياء مثل الوزن والطول كذلك تساعد حاسة الشم علي إدراك الملاحظات حول عناصر البيئة المختلفة من بعيد وهي في ذلك تماثل حاسة السمع بينما تستخدم حاسة التذوق في الاحتكاك المباشر بمصادر الخبرة.

وتعتبر تربية الحواس الباقية من أهم واجبات الأفراد المحيطين بالطفل الكفيف وأساس من أسس التكيف الاجتماعي للكفيف فالحواس هي الوسائل التي تحمل الخبرة للإنسان فعن طريقها يتصل الكفيف بما في بيئته المحيطة به من أشياء وبذلك يكتسب عن طريقها الخبرة والمعرفة وتقوم كل حاسة بوظيفتها في تلقي المثيرات المختلفة فتساعده علي التفكير وتكوين المفاهيم والمعاني (سيد صبحي، ٢٠٠٠، ٢٣).

-النمو الاجتماعي:

تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة حرجة في السلوك الاجتماعي حيث توضع أسس هذا السلوك في هذه المرحلة فيبدأ الطفل في تقليد اتجاهات وسلوك الأشخاص الذين يحبهم رغبة منه في التشبه بهم والتوحد مع الجماعة ومن ثم يتم تشكيل شخصيته وتحديد معالم سلوكه الاجتماعي.

وقد أوضحت نتائج العديد من الدراسات أن بعض المعاقين بصرياً يعانون من المشاكل الاجتماعية والانفعالية، وأن مرجع هذه المشاكل هو القصور البصري من ناحية وردود فعل الآخرين نحو هذا القصور من ناحية أخرى، لهذا فمن الطبيعي أن تختلف درجة ونوع هذه المشاكل باختلاف طبيعة ودرجة القصور البصري من ناحية واتجاهات الآخرين نحو المعاق بصرياً من ناحية أخرى (كمال سالم، ١٩٩٧، ٧٠).

وتلعب زيارات الأقارب والأصدقاء دور هام في التنشئة الاجتماعية للطفل المعاق وإحساسه بالثقة بالنفس وتوسيع مجال إدراكه، حيث تساهم الأسرة باقي أفرادها في إمداد الكفيف بالصور السمعية إلي جانب اللعب مع الأطفال الذين في مثل عمره العقلي، لكي يشعر بأنه فرد في المجتمع وله دور فعال (سميرة أبو زيد، ١٩٩٢، ٣٣).

أما عن النضج الاجتماعي للطفل الكفيف فقد أوضحت العديد من الدراسات أن الأطفال المكفوفين يحصلون علي درجات أقل عن أقرانهم المبصرين علي مقياس النضج الاجتماعي، وأرجعت الدراسات ذلك إلي بيئة الطفل الكفيف وإلي ميل الوالدين إلي حماية الطفل بصورة زائدة (Samuel,Kirk, 1990, P.223).

المشكلات النفسية والاجتماعية لدى المكفوفين:

يتأثر المراهق الكفيف بمشكلة إعاقته مما يصعب عليه الوصول لمستوى مناسب من التوافق الشخصي والاجتماعي، كما أنه خلال مرحلة المراهقة يزداد لديه الشعور بالمعاناه وإدراكه للصعوبات التي يواجهها نظير قصوره الحسي، الذي يؤدي به إلى ضعف الاندماج مع الآخرين، وتجنب المشاركة في الأنشطة، ويتسم الكفيف بالانتمية في سلوكياته، والمحدودية، ويكون غير قادر على إدراك البيئة من حوله، مما يجعله عرضة للرفض وأقل شعوراً بالأمان (Silva,et al.,2014; Majerova,2017; Bennett,2019; Heppe,etal., 2020; Munoz,2020).

وقد اتضح أن المكفوفين يعانون من مشكلات سلوكية وانفعالية واجتماعية عديدة تتمثل في: انخفاض الثبات الانفعالي ومفهوم الذات وضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على ضبط الذات وقصور أو ضعف المهارات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي وزيادة احتمال ظهور السلوك التجنبي لديهم، وتؤدي مواقف الرفض إلى الانعزالية والشعور بالوحدة النفسية، كما أن مواقف عدم التقبل تؤدي إلى أنماط سلوكية فيها مظاهر سوء التوافق كالقلق وعدم الاطمئنان، والتشتت والإحباط، هذا كله يترك أثراً عميقاً في نفس الكفيف وفي تكوين فكرته عن ذاته وقدراته وإمكاناته وفي تطور شخصيته (Rosenblum, P., 2000: 436).

ومن ثم فالإعاقة البصرية تؤثر على النضج الانفعالي للمراهق الكفيف حيث يصبح من الصعب عليه تفهم انفعالات ومشاعر الآخرين في سياق احترام وتقدير وجهات نظرهم الشخصية، والتعامل مع الآخرين في المواقف العصبية، وتبدأ مخاوفه من المجتمع وتتشكل لديه مشكلات نفسية وينعزل حتى أنه يتخيل أن جميع أفراد المجتمع يتخلون عنه فتتشأ مشكلة التوافق الاجتماعي لديه نتيجة معاملة المجتمع له بطريقة مختلفة (Khurshid&Najeeb,2012).

كما أن للإعاقة البصرية وانفصال الطفل الكفيف عن البيئة الخارجية المحيطة به تأثيرات سلبية على السلوك الاجتماعي، حيث يترتب عليها الكثير من المشاكل في عمليات النمو والتفاعل الاجتماعي، وفي اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة لتحقيق الاستقلالية والشعور بالاكفاء الذاتي، وذلك لعجز المعاقين بصرياً أو لمحدودية الحركة لديهم، وعدم استطاعتهم ملاحظة سلوك الآخرين ونشاطاتهم اليومية وتعبيراتهم الوجهية كالشاشة، والرضا والغضب، وغيرها مما يعرف بلغة الجسم وتقليد هذه السلوكيات أو محاكاتها بصرياً والتعلم منها، ونقص خبراتهم والفرص الاجتماعية المتاحة أمامهم للاحتكاك بالآخرين والاتصال بالعالم الخارجي المحيط بهم فهم لا يتحركون بالسهولة والمهارة والطلاقة التي يتحرك بها المبصرون (نعمات عبد الخالق، ١٩٩٣؛ عبد المطلب القريظي، ٢٠٠١، ١٩٧؛ صلاح السرسى، ١٩٩٨، ١٦٣؛ إلهامي عبد العزيز، وإيمان حبرس، ٢٠٠٠، ١٤).

وأوضحت العديد من الدراسات أن المراهقين المكفوفين قد لا يدركون المعنى لحياتهم، وتعرضهم للعديد من المواقف الضاغطة التي تترك خبرات مؤلمة وغير سارة، والإحساس بالألم النفسي والوحدة، وتزداد لديهم مشاعر الغضب لفقدان سيطرتهم على حياتهم، وفقد الأمل في تحقيق الأهداف والدافعية في الحياة، وفشل الآخرين في التواصل معهم يقيدهم، ويصعب عليهم التنبؤ بسلوكياتهم مما يحبطهم ويشعرهم بالحزن (Joann,2001؛ فتحى عبد الرحمن الضبع، ٢٠٠٦؛ مصطفى عبد المحسن الحديبي، ٢٠١٢؛ محمد مصطفى غنيم، ٢٠١٦؛ أحمد أبو الفتوح مجاهد، ٢٠١٧).

قائمة المحتويات

ومن أهم المشكلات النفسية التي قد تواجه بعض المكفوفين الشعور بفقدان المعنى في الحياة، وتتفاقم هذه المشكلة وفقدان الهدف في الحياة لدى المكفوفين في مرحلة المراهقة، وقد يرجع ذلك إلى الشعور بالعجز عن منافسة أقرانهم المبصرين، مما قد يؤدي إلى قلقهم تجاه مستقبلهم الأسري والمهني وشعورهم بالتشاؤم، وقد يترتب على ذلك الانسحاب من أى مشاركات اجتماعية نظراً لما تفرضه إعاقته عليه (إبراهيم أبو الهدى، ٢٠١١؛ أمل عمر عبد الحفيظ، ٢٠٢١).

ومن أبرز المشكلات السلوكية التي ظهرت عند الطلبة المكفوفين كانت الحساسية الزائدة، والاعتمادية، والشروود والتشتت، والشعور بالقلق، والسلوك المتخاذل، والانسحاب من المشاركة الاجتماعية، ووجد أنه كلما زادت درجات القلق والاكتئاب لديهم تناقصت درجات ضبط الذات والثبات الانفعالي والشعور بالسعادة (إيمان طاهر، ٢٠١٧، ٩٠).

وتُعد السلوكيات النمطية التي يظهرها بعض المكفوفين مشكلة شديدة لأنها سلوكيات متكررة وغير هادفة، يترتب عليها انفصال الفرد عن بيئته، وازدياد فرص حرمانه من التفاعل معها، فالسلوك النمطي يسلب الفرد الكيف عن الواقع ويجعله يعيش في عالم محدود، وإذا استمر ذلك يفقده اتصاله مع العالم، وهذه الأنماط بدءاً من الضغط على العين ونقرها وانتهاءً بهز الجسم هي أنماط إثارة ذاتية تحدث أكثر في مرحلة الطفولة والمراهقة، وتقل مع الوقت نتيجة التعلم والتفاعل مع البيئة حيث يقوم الفرد بفاعليات مفيدة، لكن عند بعضهم الآخر قد يستمر لديه وبالتالي يزداد رفض المجتمع له ويدفعه للانطواء، وتقف وراء هذه الحركات النمطية عدة أسباب أهمها: التركيز حول الذات، وقلة التحفيز، والملل، وعدم وجود أنشطة يقوم أو يشارك بها، والتوتر والضغط النفسي، وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر والانفعالات، وعدم القدرة على إشباع حاجاته الأساسية (سيد محمد صبحي، ٢٠٠٧). أما السلوك العدوانى اللفظي الذي يتمثل في السب والتوبيخ والشتم وإلحاق الإهانات بالآخرين يظهر أكثر من غيره لدى الأفراد المكفوفين. وهناك العديد من الأسباب التي تقف وراء السلوك العدوانى فقد ينشأ نتيجة تعرض الفرد لإحباطات الحياة اليومية، فيتصرف بعنصرية عندما يمنع عائق ما من الوصول إلى حاجته أو رغباته أو يمنعه من الوصول لأهدافه، وتساهم أساليب تربية الوالدين والجو الأسري العام السائد في المنزل في إيجاد العدوان لدى الفرد، كذلك الحرمان من عطف الوالدين وحبهم، وفي النهاية قد يكون العدوان وسيلة لجذب الانتباه عند الآخرين، أو وسيلة للوصول إلى ما يبتغيه ويريد الفرد، وأشارت العديد من الدراسات إلى ندرة أداء الأطفال المكفوفين لسلوك العدوان الجسمي، أما العدوان اللفظي فينتشر بين المكفوفين وخاصة الذكور منهم، في حين أشارت دراسات أخرى إلى أن المكفوفين أقل عدوانية من المبصرين، وأن لديهم نزعة نحو السلبية أكثر، لكون الفرص المتاحة للكيف للتعبير عن العدوان محدودة بسبب الافتقار إلى البصر الأمر الذي يؤدي غالباً إلى أن يعبر عن غضب عام وغير موجه أو بالعزلة والانسحاب (إيهاب عبد العزيز الببلاوى ومحمد أحمد خضير، ٢٠١٠).

رابعاً: الإعاقة العقلية: Mental Retardation (M.R) / Intellectual Disability

تعد الإعاقة العقلية مشكلة متعددة الأبعاد بالنسبة للأباء والأسر والمعلمين والمدرسين والمشرفين... الخ. حيث يعاني أهالي الأطفال من مشكلات اجتماعية وسلوكية ووجدانية قد تؤثر في تفهمهم الاجتماعي وتفاعلهم مع الآخرين، وتعمل تلك المشكلات على التقليل من استفادتهم من البرامج المقدمة لهم؛ حيث يعاني الأطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعلم من ضعف القدرة على الانتباه، والقابلية العالية للتشتت وهذا يفسر عدم مقدرتهم أو مواصلتهم الأداء في المواقف الاجتماعية (رأفت سعيد خطاب، ٢٠١١، ١٣٩).

قائمة المحتويات

كما تزداد أهمية مشكلة الإعاقة العقلية حيث تدل الإحصائيات أن هناك ما يقرب من ٢,٥ - ٣٪ من الأطفال يعانون من حالة الإعاقة العقلية بمستوياتها الثلاث، معنى ذلك أنه يوجد في مجتمع ما حوالي ثلاثة أرباع مليون معاق عقلياً في مجتمع يبلغ عدد سكانه ٢٥ مليون نسمة، وهذا العدد الكبير من المعاقين عقلياً مشكلة تتطلب العناية والرعاية (محمد أشرف، ٢٠٠٩، ٤٦).

مفهوم الإعاقة العقلية:

لم تحظ أى إعاقة اهتمام الباحثين مثلما حظيت الإعاقة العقلية، حيث تعددت تعريفات الإعاقة العقلية بتعدد وجهات النظر والمجالات والتخصصات المختلفة لهؤلاء الباحثين. وتعد الإعاقة العقلية مشكلة متعددة الأبعاد جسمياً ونفسياً ومعرفياً وسلوكياً سواء للطفل المتخلف عقلياً نفسه أو لمن يتعامل معه من آباء وأمهات ومعلمين.... الخ. حيث يعاني أهالي الأطفال من مشكلات قد تؤثر في تكيفهم الاجتماعي وتفاعلهم مع الآخرين (رأفت سعيد خطاب، ٢٠١١، ١٣٩).

والإعاقة العقلية (اضطراب النمو العقلي) عبارة عن اضطراب يبدأ خلال مراحل النمو يشمل كلا من عجز الوظائف العقلية والتكيفية في المجالات المفاهيمية، والاجتماعية، والعملية (American Psychiatric Association, 2013, 33).

وقد استخدمت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي American Association of Mental Retardation (A.A.M.R.) مفهوم التأخر العقلي بمعنى التخلف العقلي Mental Retardation وأطلقت على كل من يقل مستوى قدراته العقلية العامة عن المتوسط (كمال إبراهيم مرسى، ١٩٩٦، ١٧)، وأشار عبد المطلب القريطى (٢٠٠١، ٢٠٩) إلى أن مصطلح التخلف العقلي يدل على انخفاض الأداء الوظيفي العقلي بكافة درجاته.

إلا أن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية قد قام بتغيير المسمى إلى الإعاقة العقلية في الإصدار الخامس لعام ٢٠١٣، وقد كانت معايير التشخيص للإعاقة العقلية تتطلب أن تكون نتيجة الفرد أدنى أو أعلى (٥) في الانحرافات المعيارية لمعدل ذكائه المتوقع بالمقارنة مع من نفس السن على اختبار الذكاء المعياري ٧٠ أي من ٦٥ إلى ٧٥، وبالإضافة لما سبق فقد أكد الإصدار الخامس من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية على أن درجة الذكاء ليست هي المحدد الأساسي للإعاقة العقلية، فلم يعد هناك درجة قاطعة تحدد الوضع التشخيصي، بدلا من ذلك يتم تقييم درجات مقاييس معدل الذكاء في سياق كامل للصورة السريرية للفرد. وقد يكون الأساس المنطقي لهذا التغيير مبني على أن درجات اختبارات الذكاء تمثل الإشارة للمفاهيم الوظيفية، وبالتالي فإنها قد لا تكون كافية لتقييم الاستنتاج في مواقف الحياة الواقعية والتمكن من المهام العملية ضمن الميادين المفاهيمية والاجتماعية والعملية (American Psychiatric Association, 2013, 34).

والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية قادرون على التعلم والنمو، ولكن نموهم وإن كان يوازي نمو الأشخاص غير المعاقين فكرياً يتصف بكونه بطيئاً، واستناداً إلى هذه الحقيقة، فإن فلسفة رعاية هؤلاء الأشخاص قد تغيرت في العقود الماضية من الإيواء إلى تطوير البرامج التربوية والتأهيلية الفعالة (جمال محمد الخطيب ومنى صبحي الحديدي، ٢٠٠٩، ٢٣).

وتعرف "الجمعية الأمريكية للإعاقة العقلية" American Association of Mental Retardation (٢٠٠٢) بأنها "نقص أساسي في جوانب معينة من الكفاءة الشخصية التي تظهر من خلال أداء دون المتوسط للقدرات العقلية، مصحوباً بنقص في المهارات التوافقية، في واحد أو أكثر من مجالات: الاتصال- العناية بالنفس- المهارات الاجتماعية- الأداء الأكاديمي- الاستفادة من المجتمع- المهارات العملية- قضاء وقت الفراغ- العمل-

قائمة المحتويات

المعيشة الاستقلالية- وغالباً ما يكون بعض النقص مصحوباً بمهارات توافقية أخرى في سياق بيئة اجتماعية كذلك التي يعيش فيها أقران المعاق ممن هم في مثل عمره بحيث يكون مؤشراً لاحتياجات الشخص الضرورية للعون، ومن خلال توافر الخدمات المناسبة يتحسين الأداء الشامل للشخص ذي الإعاقة العقلية بصفة عامة".

ويعرف "عبد العزيز الشخص وعبد الغفار الدمياطي" (١٩٩٢: ٢٨٨) الإعاقة العقلية بأنها "أداء ذهني عام أقل من المتوسط بدرجة دالة، بحيث يظهر خلال الفترة النهائية، كما يصاحب في نفس الوقت بقصور في السلوك التوافقي".

وتعرف "جمعية علم النفس الأمريكية" American psychiatric Association (١٩٩٤) الإعاقة العقلية بأنها "مصطلح عام يغطي مدي واسعاً من درجات الإعاقة العقلية، ويتراوح بين إعاقة عقلية تامة تعوق عملية الكلام والحركة، ومعدل ذكاء أفرادها بين (٢٥- ٤٠)، وإعاقة عقلية بسيطة لا تعوق الكلام والحركة ومعدل ذكاء أفرادها بين (٥٥- ٧٠)، ولكنهم يحتاجون إلى المساعدة والتوجيه عندما يتعرضون لصعوبة ما تواجههم في حياتهم.

ويعرف حامد زهران (١٩٩٧: ٤٠٥) الإعاقة العقلية بأنها "حالة نقص أو تأخر أو تخلف أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي المعرفي، ويولد بها الفرد أو تحدث في سن مبكرة، نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية وتؤثر علي الجهاز العصبي للفرد، مما يؤدي إلي نقص الذكاء، وتتضح آثارها في ضعف مستوي أداء الفرد في المجالات التي ترتبط بالنضج والتعليم والتوافق النفسي في حدود انحرافين معيارين".

ويذكر "بات شو ومارك (Bat shaw & Mark,1997,2) أن الشخص المعاق عقلياً يعاني من نقص أو تخلف أو بطء في نموه العقلي الأمر الذي يؤدي إلي تدني في مستوي ذكاءه وتوافقه الاجتماعي، بحيث لا تتناسب قدراته مع عمره الزمني.

كما عرف "رشاد عبد العزيز" (٢٠٠٢: ٣٢) الإعاقة العقلية بأنها "أداء عقلي دون المتوسط بفرق جوهري، مصحوب بإعاقات في السلوك التكيفي، ويظهر خلال المرحلة الارتقائية من العمر".

في حين يعرف "وليد السيد أحمد" (٢٠٠٦: ٥٨) الإعاقة العقلية بأنها "اضطراب في أداء الوظائف العقلية، يولد بها الطفل نتيجة أسباب وراثية أو يتعرض لها نتيجة أسباب بيئية أو نفسية أو اجتماعية، وتحدث قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ويتضح هذا الاضطراب في انخفاض نسبة الذكاء عن (٧٥) درجة، مع قصور في النضج العقلي والسلوك التوافقي، ويظهر خلال الفترة النمائية تحت (١٨) سنة.

كما تعرف الإعاقة العقلية بأنها "قصور في النمو المعرفي والسلوك التوافقي يحدث نتيجة خلل في بناء المخ أو وظائفه، ويرجع أيضاً إلى خلل عصبي ويؤثر على العديد من نواحي الحياة لدى الطفل المعاق عقلياً وأسره ومجتمعاتهم" (Shea,2006:133).

كما تعرف الإعاقة العقلية بأنها انخفاض في القدرة العقلية ذو الدلالة (نسبة الذكاء أقل من ٧٠) مع وجود قصور في السلوك التوافقي، ونسبة الانتشار بين أفراد المجتمع ٢-٣ % وترجع إلى أسباب وعوامل وراثية وبيئية، إلا أن حوالي ٣٠-٥٠ % من الحالات لا يمكن تحديد الأسباب حتى بعد تشخيص الحالة بأنها تعاني من إعاقة عقلية (Kampert&Goreczny,2007).

ويعرف "أحمد رجب محمد" (٢٠٠٨: ٥٨) الإعاقة العقلية بأنها "أداء عقلي وظيفي دون المتوسط ناتج عن عوامل وراثية أو مرضية أو بيئية، يصاحبه قصور في واحدة أو أكثر من مظاهر السلوك التكيفي، ويحدث قبل سن ١٨".

قائمة المحتويات

كما تعرف "نانسي نبيل" (٢٠٠٩: ٧) الإعاقة العقلية بأنها "وجود قصور في الوظائف العقلية والتوافقية لدى الطفل مما يؤثر على أدائه التعليمي".

وفي ضوء هذه التعريفات يمكن تعريف الإعاقة العقلية بأنها "أداء عقلي وظيفي دون المتوسط يصاحبه قصور في النضج العقلي وفي واحد أو أكثر من مهاراته التوافقية وهو ناتج عن عوامل وراثية أو بيئية أو مرضية، خلال الفترة النمائية تحت (١٨) سنة.

ونظراً لتعدد وتنوع تعريفات الإعاقة العقلية تبعاً لتعدد اتجاهات الباحثين وتخصصاتهم فظهر التعريفات الطبية والعضوية والنفسية والاجتماعية والتربوية وغيرها. حيث ركزت **التعريفات الطبية: Medical definitions** على أن "الإعاقة العقلية هي حالة من عدم التوازن الكيميائي في الجسم" وهو "حالة توقف أو عدم اكتمال نمو الدماغ نتيجة لمرض أو إصابة قبل سن المراهقة أو بسبب عوامل جينية" (محمد محروس الشناوى، ١٩٩٧، ٢٥)، ومن **الناحية النفسية** هو "حالة عجز أو قصور أو تأخر أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي المعرفي يولد بها الفرد وتحدث في سن مبكرة نتيجة لعوامل وراثية أو بيئية أو مرضية تؤثر على الجهاز العصبي للفرد مما يؤدي إلى نقص الذكاء ويتضح آثارها في ضعف أداء الفرد في المجالات التي ترتبط بالنضج والتعلم والتوافق في حدود انحرافين معياريين سالبين (حامد زهران، ١٩٩٨، ٤٣٢)، ومن **الناحية القانونية** يعرف الشخص المعاق ذهنياً بأنه "غير القادر على الاستقلالية وتدبر شئونه بسبب حالة الإعاقة الدائمة أو توقف النمو العقلي في سن مبكر". ومن **الناحية الاجتماعية Social Definitions** التي تحدد الصلاحية الاجتماعية للفرد، فيعرفه كل من مايزرال وآخرون. Maieseral, et al. بأن الفرد المعاق عقلياً تتحدد حالته العقلية سواء منذ الولادة أو في سن مبكرة وبظل معاقاً حتى بلوغ سن الرشد وبعده، بحيث يظل الفرد المعاق أقل من الأفراد الأسوياء من حيث القدرة العقلية والكفاءة الاجتماعية والمهنية فلا يستطيع أن يسير أموره بمفرده وترجع تخلفه في الأصل إلى عوامل تكوينية وراثية أو نتيجة للإصابة بمرض وهي حالة مستعصية ولا تقبل الشفاء (في: رشا محمد أحمد، ١٩٩٩، ٢٤)، وتعرفه الجمعية الأمريكية للضعف العقلي Association of Mental Retardation بأنها "حالة عامة تشير إلى الأداء الوظيفي المنخفض عن المتوسط بدرجة جوهرية في العمليات العقلية، وتكون متلازمة مع قصور في السلوك التكيفي للفرد، وتحدث هذه الحالة أثناء فترة النمو (عبد المطلب القريطي، ٢٠٠٥). وتشير الجمعية الأمريكية للإعاقات العقلية والنمائية للإعاقة العقلية على أنها "إعاقة تتسم بقيود كبيرة في كلا من الأداء العقلي الذي يشير إلى القدرة العقلية العامة، مثل التعلم والتفكير، وحل المشكلات، وهكذا"، والسلوك التكيفي الذي يشير إلى مجموعة من المهارات المفاهيمية والاجتماعية والعملية التي يمتثلها والتي يقوم بها الأفراد في حياتهم اليومية. وتنشأ هذه الإعاقة قبل سن ١٨ عاماً (The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016). ومن **الناحية التربوية Educational Definitions** هو الطفل الذي يكون لديه قصور في القدرة على التعلم والتكيف لمطالب المجتمع (محمد محروس الشناوى، ١٩٩٧، ٣٧)، وتعرف زينب شقير (٢٠٠٢: ٢٥٠) الطفل المعاق تربوياً بأنه "ذلك الطفل الذي لا يستطيع التحصيل الدراسي في نفس مستوى زملائه في الفصل الدراسي، وفي نفس العمر الزمني، وتقع نسبة ذكائه بين (٥٠-٥٥) إلى (٧٠-٧٥). ويرى "عبد المطلب القريطي" (٢٠٠٥: ٨٧) أن التعريفات التربوية تقوم على أساس مدى القصور في الاستعدادات التحصيلية، والقدرة على التعليم والتدريب خلال سنوات الدراسة في ضوء معاملات الذكاء المختلفة. في حين عرفت "نانسي نبيل" (٢٠٠٩: ١٤) الإعاقة العقلية على أساس تبني التعريف المتقدم من الجمعية الأمريكية للإعاقة العقلية، والجمعية الأمريكية للطب النفسي، والذي يشير إلى وجود قصور في الوظائف العقلية والتكيفية لدى الطفل، مما يؤثر على أدائه التعليمي.

تصنيف الإعاقة العقلية:

نظراً لتعدد ظاهرة الإعاقة العقلية من حيث مظاهرها وأسبابها، فقد تعددت تصنيفاتها والأسس التي قامت عليها، فمنها التصنيف الطبي، والتصنيفات السلوكية الوظيفية، التصنيف السيكولوجي، التصنيف التربوي، والتصنيف الاجتماعي (عبدالمطلب القريطي، ٢٠٠٥، ٢٢٢). فمن حيث التصنيف التربوي Educational Classification قام كل من عادل عبدالله محمد (٢٠٠٤، ١٠٩) وعبدالمطلب القريطي (٢٠٠٥، ٢٣١) بوضع ثلاث مستويات للإعاقة العقلية تشمل: أ- المعاقون عقلياً القابلون للتعلم Educable : يقابلون فئة الإعاقة العقلية البسيطة الذين تتراوح نسب ذكائهم بين ٥٥-٧٠، والذين يصل عمرهم العقلي عند النضج إلى ما يوازي طفل الحادية عشرة من عمره. ب- المعاقون عقلياً القابلون للتدريب Trainable : يقابلون فئة التخلف العقلي المتوسط الذين تتراوح نسب ذكائهم بين ٤٠-٥٥ والذين يصل عمرهم العقلي عند النضج إلى ما يوازي طفل التاسعة من عمره. ج- المعاقون عقلياً غير القابلين للتعلم أو التدريب "المعتوهين" Custodial : وهم يقابلون الإعاقة العقلية الشديدة والعميقة، والذين تقل نسب ذكائهم عن ٤٠ في الفئة الأولى، وعن ٢٠ في الفئة الثانية.

وتستفيد فئة القابلين للتعلم Educable من البرامج التعليمية العادية ولكن بصورة بطيئة حيث يحتاجون إلى برامج خاصة موجهة لإحداث تغير في السلوك الاجتماعي ليصبح مقبولاً في تفاعلهم مع الآخرين، وأيضاً في تحسين العمليات المعرفية والمهنية لديهم، وتستطيع تلك الفئة الاعتماد على نفسها في مرحلة عمليات البيع والشراء والعمل اليدوي على مبادئ بسيطة من الناحية الأكاديمية، أي المهارات الأولية للتعلم، وتتراوح نسب ذكائهم ما بين (٥٠-٧٠)، وهم يمتلكون القدرة على التعلم إذا توافرت لهم خدمات تربوية خاصة، إلا إنهم لا يستطيعون مواصلة الدراسة وفقاً للمناهج العادية، كما أنهم لا يستطيعون البدء في اكتساب مهارات القراءة والكتابة أو الهجاء قبل سن الثامنة ويتعلمون ببطء شديد وبعضهم يبدي استعداداً للتعلم في المجالات المهنية ليصل إلى التفوق أحياناً ولا يستطيع هؤلاء الأطفال التقدم في الدراسة لأكثر من الصف الثاني أو الخامس الابتدائي (عبدالمطلب القريطي، ٢٠٠٥: ٢٣١).

كما يصنف الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية (١٩٩٤) التابع للجمعية الأمريكية للإعاقة العقلية المعاقين عقلياً على النحو التالي:-

- ١- إعاقة عقلية بسيطة/خفيفة Mild Mental Retardation: حيث يتراوح معامل الذكاء بين (٥١-٧٠)، ويوازي في التصنيف التربوي فئة القابلين للتعلم وتمثل ٨٣,٦ % من المعاقين عقلياً.
- ٢- إعاقة عقلية متوسطة Moderate Mental Retardation: حيث يتراوح معامل الذكاء بين ٣٦-٥٠.
- ٣- إعاقة عقلية شديدة Severe Mental Retardation: حيث يتراوح معامل الذكاء بين ٢٠-٣٥.
- ٤- إعاقة عقلية حادة أو عميقة Profound Mental Retardation: حيث يكون معامل الذكاء أقل من ٢٠ (Dade- ٢٠٠٥, 54, Bildteta, et al.).

وقد حدد الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الإصدار الرابع المعدل مستويات الإعاقة العقلية بالمستوي الخفيف (نسبة الذكاء من ٥٠-٥٥ إلى ٧٠ تقريباً)، والمتوسط (نسبة الذكاء من ٣٥-٤٠ إلى ٥٠-٥٥) والشديد (نسبة الذكاء من ٢٠-٢٥ إلى ٣٥-٤٠) والعميق (نسبة الذكاء أقل من ٢٠ أو ٢٠) (American Psychiatric Association, 2000, 42)، ولم يرقم الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الإصدار الخامس بوضع درجة محددة للذكاء تعبر عن كل مستوى واستعاض عنها بالسلوك التكيفي، حيث يتميز مستوى الإعاقة العقلية الخفيف وهي فئة القابلين للتعلم في المجال الاجتماعي بالمقارنة مع من هم في نفس السن بأنهم غير ناضجين في التفاعل الاجتماعي، حيث يعانون من صعوبة في فهم الإشارات الاجتماعية، التواصل،

قائمة المحتويات

المحادثة، ولغتهم تكون غير ناضجة أو منسجمة بالمقارنة مع من في نفس السن. ويمكن أن يكون لديهم صعوبة في التنظيم الانفعالي والسلوكي تلاحظ من قبل الأقران في التفاعل الاجتماعي، ولديه قصور في فهم المخاطر في المواقف الاجتماعية، وغير ناضج في الحكم الاجتماعي بالنسبة لعمره، ويكون الفرد في خطر من تلاعب الآخرين به (السذاجة)، في حين يتميز في المجال العملي بكون الفرد في حاجة للدعم في المهام الحياتية المعقدة بالمقارنة مع أقرانه (American Psychiatric Association, 2013, 36).

-التصنيف الاجتماعي Social Classification: (وفقاً لمهارات التكيف adaptive skills اللازمة للحياة اليومية):

يعتمد هذا التصنيف على محك التوافق الاجتماعي للفرد، ومدى اعتماده على نفسه ووفاءه بالواجبات والمطالب الاجتماعية، ويستخدم العلماء في تحديد ذلك مقاييس النضج الاجتماعي والسلوك التكيفي (عبد المطلب القريطي، ٢٠٠٥: ١٠٤) وتصنف الإعاقة العقلية وفقاً لهذا التصنيف إلى أربع فئات هي:-

- ١- القصور الخفيف Mild : وهي فئة قابلة للتعليم وقادرة على الاستفادة من البرامج التعليمية وبرامج التربية الخاصة.
- ٢- القصور المعتدل Moderate: وهم يطلق عليهم قابلون للتدريب ويمكن تعليمهم أساليب العناية بأنفسهم ويحتاجون إلى المساعدة والرعاية والإشراف.
- ٣- القصور الشديد Sever: وهذه الفئة من الإعاقة العقلية تكون مهاراتهم المعرفية والحركية والكلامية محدودة، ويمكن تعليمهم بعض مهارات العناية بالنفس.
- ٤- القصور الحاد Profound : وهم يحتاجون إلى العناية التامة والإشراف الكامل من جانب الآخرين طوال حياتهم (أمل محمد لطفي، ٢٠٠٤: ٧٣).

وتعرف مهارات التكيف بأنها "مهارات الحياة اليومية التي يحتاجها الفرد، كي يعمل، ويلعب ويتفاعل في المواقف الحياتية المختلفة". وهي تشمل مهارات التواصل، العناية بالنفس/ الذات (مثل: النظافة)، المعيشة المنزلية، أوقات الفراغ، الصحة والأمان، توجيه النفس، والمهارات الأكاديمية الوظيفية (القراءة، الكتابة، أساسيات الحساب)، وكذلك مهارات العمل والعيش مع المجتمع.

ويتم تقييم مهارات التكيف عبر تقييم الشخص في بيئته المعتادة وعبر جميع أوجه الحياة. وقد لا يتم تشخيص الفرد ذي القدرة الذكائية المحدودة على أنه معاق ذهنياً حينما لا يظهر صعوبة في مهارات التكيف.

إن هذا التقسيم وفقاً للسلوك التكيفي يعتمد على مدى قدرة الفرد في اعتماده على نفسه في حياته اليومية ويعتمد أيضاً على المهارات الاجتماعية للفرد بصفة عامة وعلى مدى نضجه الاجتماعي أو قدرته على تحقيق التكيف الاجتماعي مع المحيطين به وتحمل المسؤولية، وبشكل خاص يتم على أساس درجة الانحراف التي تظهر في سلوك الفرد عن معايير السلوك التكيفي للأشخاص العاديين في مثل عمره ولا يتم الحصول على المعلومات اللازمة لهذا المقياس في موقف اختبار وإنما عن طريق مقابلة مع شخص يعرف المفحوص حق المعرفة كوالدين أو مشرفين ويعتمد المقياس على الأشياء التي عملها الفرد في حياته اليومية (عبد العزيز الشخص، ١٩٩٤، ٢٥).

أولاً: التصنيف الإكلينيكي:

يستخدم هذا التصنيف محكات متعددة منها مصدر الإصابة ودرجتها وتوقيتها والمظهر الإكلينيكي المصاحب للإعاقة العقلية. ويعتمد هذا التصنيف على الملامح والمظاهر البدنية التي تصاحب حالات الإعاقة العقلية، كما يصنف الإعاقة العقلية حسب المصدر، وتوقيت ودرجة الإعاقة:

قائمة المحتويات

١- التصنيف حسب مصدر الإصابة:-

ميز كل من "ستراوس Strauss"، و"الينتين Lehtinen"، بين الإعاقة العقلية الناشئة عن عوامل داخلية ناتجة عن انتقال صفات نفسية عضوية خاطئة أو غير تامة النمو، والإعاقة العقلية الناشئة عن عوامل خارجية وتكون ناتجة عن التغيرات المرضية التي تحدث للفرد مثل الإصابة التي تحدث تلقاً في المخ (Howard, 1994: 375).

ويعتبر "تريود جولد Trud Gold" أول من قسم الإعاقة العقلية إلى:

- إعاقة عقلية أولية Primary Amentia : هي التي تحدث نتيجة الوراثة .
- إعاقة عقلية ثانوية Secondary Amentia: هي التي تحدث نتيجة عوامل خارجية أو مكتسبة، وبعض الحالات يظهر فيها العاملان معاً (في:رشاد عبد العزيز، ٢٠٠٢: ١١٦).

٢- التصنيف حسب درجة الإعاقة:-

يذكر "لويس وآخرون" (Louis,C.,at el.,2002,322) أن هذا التصنيف يعتمد على درجة الإعاقة (بسيطة-متوسطة-شديدة) بصرف النظر عن مصدرها. واقترح "كانر Kanner"، تصنيف الإعاقة العقلية إلى إعاقة مطلقة: هي التي تتميز بقصور في القدرات المعرفية والعاطفية، والإعاقة العقلية النسبية: حيث تختلف وتتباين الأحكام على جوانب سلوكهم، كما يوجد الإعاقة العقلية الظاهرية: التي تنشأ عن عوامل ثقافية وبيئية.

وقدمت الجمعية الأمريكية للإعاقة العقلية تصنيفاً لشرائح ومستويات الإعاقة العقلية، حيث تقع فئات المعاقين عقلياً بمستوياتهم المختلفة ابتداءً من معامل ذكاء أقل من (٢٠-٢٥) (كحد أدنى) إلى (٦٨-٧٠) (كحد أقصى)، وذلك على مقاييس الذكاء المقننة، وحددت أربعة فئات طبقاً لشدة الإعاقة تراوحت ما بين الإعاقة البسيطة Mild، والإعاقة الحادة Profound، وذلك على النحو التالي:-

أ- الإعاقة البسيطة Mild: هم الأفراد الذين يتعلمون ببطء في المدارس ويستطيعون إنجاز المهارات الأكاديمية حتى المستوى السادس تقريباً وقدراتهم المهنية والاجتماعية تسمح لهم بالعمل والحياة باستقلالية، مع قدر بسيط من المساندة والمتابعة.

ب- الإعاقة المتوسطة Moderate: تشير إلى الأفراد الذين ينخفض مستوى مهاراتهم الأكاديمية إلى الصف الثاني على الأكثر، وهم قابلون للتدريب على المهارات الحياتية والتكيف الاجتماعي ويحتاجون لإشراف كامل في أعمالهم.

ج- الإعاقة الشديدة Severe: تشير إلى الأفراد الذين لديهم قدرات تواصلية محدودة ويفهمون المعلومة الأساسية فقط فيما يتعلق بالحروف الأبجدية والعد، ولديهم درجات من العجز البدني مثل صعوبة الحركة أو اضطرابات النطق والكلام، وتعتمد البرامج التربوية لديهم على إكسابهم المهارات الحياتية والتواصل، ويحتاجون إلى الإشراف والمتابعة الكاملة في أعمالهم.

د- الإعاقة الحادة Profound: تشير إلى الأفراد الذين يتسمون بدرجة ملحوظة من العجز وفي حاجة مستمرة للتدريب والمساندة والمتابعة، مثل صعوبة الرؤية أو السمع، أو الحركة، ومن ثم يلزمهم مجموعة من المؤهلين لرعايتهم.

٣- التصنيف حسب توقيت الإصابة:-

تصنف الإعاقة العقلية حسب وقت حدوثها، ومن أشهر هذه التصنيفات التصنيف الذي قدمه "دافنبورت Davenport" حسب توقيت الإصابة، وحدود التوقيات كالاتي:-

أ- في مرحلة تكوين الخلايا الذكرية .

ب- في مرحلة تكوين البويضة وأثناء التلقيح .

ج- أثناء فترة الحمل الأولي (الثلاث أشهر الأولي) .

قائمة المحتويات

د- أثناء فترة الحمل الباقية.
و- الإصابة التي تحدث أثناء الولادة أو في الطفولة الأولى أو المتأخرة (في: حمدي أمين، ٢٠٠٦: ٧٦).

واقترح "يانيت yannet"، تصنيف آخر للإعاقة العقلية تبعاً لتوقيت حدوث الإعاقة وهو:

أ- إعاقة تحدث في مرحلة ما قبل الولادة Pre-Natal :

تحدث لأسباب فسيولوجية ومرضية واضطرابات كيميائية تنتقل إلى الجنين من الوالدين أو إحداها مثل عامل ريزيس RH، وعدم ضبط السكر في الدم، والضغط المرتفع الذي يمكن أن يؤثر على نمو الجهاز العصبي المركزي للجنين، وتعاطي الأم الكحوليات والعقاقير أثناء الحمل، أو الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية كالحصبة.

ب- إعاقة تحدث أثناء الولادة Intra-Natal :

يتعرض فيها الجنين للإصابة أثناء الولادة كالاختناق، أو إصابة جراح استخدام أجهزة سحب الجنين بالجفت من رحم الأم فيصيب دماغ الجنين والمعروفة باسم الولادة الميكانيكية.

ج- إعاقة تحدث بعد الولادة Post-Natal :

تحدث الإصابة فيها خلال الفترة النمائية- كتعرض الفرد لبعض الأمراض كالالتهابات السحائية وإصابة المخ نتيجة التسمم بأملاح الرصاص، أو أول أكسيد الكربون، أو الإصابات المباشرة للدماغ والناجمة عن الحوادث. ويقترح "يانيت" نسب الإصابة نتيجة العوامل التي تقف وراء الإعاقة العقلية كما في جدول ١ (في: محمد سلامة آدم، ٢٠٠١: ١٧٧).

جدول (١)

م	العوامل	النسبة المئوية
١	عوامل عائلية	٤٠٪
٢	عوامل قبل الولادة غير معروفة	٣٥٪
٣	عوامل قبل الولادة معروفة	١٠٪
٤	عوامل تلف المخ	١٠٪
٥	عوامل جينية	٥٪

٤-التصنيف حسب

المظهر الإكلينيكي:-

تشير "فيوليت فؤاد إبراهيم" (٢٠٠٥) إلى أهم الأنماط الأكلينيكية في التصنيف للمعاقين عقلياً مايلي:-

- ١- المنغولية Mongolism وتسمى أيضاً أعراض "داون".
- ٢- استسقاء الدماغ Hydrocephalus .
- ٣- كبر الجمجمة Monocephalic .
- ٤- صغر الجمجمة Microcephalic .
- ٥- القماءة أو القصاع Cretinism . وهو حالة نقص النمو الجسدي والعقلي نتيجة نقص هرمون الغدة الدرقية الخلقي نتيجة لقصور الغدة الدرقية للأم.
- ٦- حالات الشلل السحائي Cerebral palsy .
- ٧- حالات العامل الريزيسي في الدم Rh- factor .
- ٨- حالات اضطراب التمثيل الغذائي (Pku) .
- ٩- حالات الصرع Epilepsy .

ثانياً: التصنيفات السلوكية الوظيفية:-

أ- التصنيف السيكولوجي Psychological classification

تصنيف يعتمد على أساس نسبة الذكاء، ومن التصنيفات السيكولوجية التي ظلت شائعة لفترة طويلة بين علماء النفس التصنيف الثلاثي لفئات المعاقين عقلياً وهو:-

- ١- فئة المورون Moron: تتراوح نسبة ذكائها ما بين (٥١-٧٠).
- ٢- فئة البلهاء Imbecile: تتراوح نسبة ذكائها ما بين (٥٠-٢٥).
- ٣- فئة المعتوهين Idiot: تتراوح نسبة ذكائها ما بين (أقل من ٢٥).

وقد اقترح جروسمان Grossman تصنيف للمعاقين عقلياً تبنته الجمعية الأمريكية للإعاقة العقلية حيث اعتبر أن حالات الإعاقة العقلية هي الحالات التي ينخفض أدائها الذهني العام عن المتوسط بانحرافين معياريين على الأقل، وهو الأمر الذي ضيق حدود الإعاقة فأصبحت تحت ٧٠ على مقياس وكسلر، وتحت ٦٨ على مقياس ستانفورد- بينيه. ويوضح الجدول التالي فئات الإعاقة العقلية تبعاً لمتوسطات الدرجات والانحرافات المعيارية على كل من مقياس ستانفورد- بينيه، وكسلر.

جدول (٢)

نسبة الذكاء		الفئات
مقياس وكسلر	ستانفورد بينيه	
م = ١٠٠، ع = ١٥	م = ١٠٠٠، ع = ١٦	
٥٥ - ٦٩	٥٢ - ٦٨	- إعاقة عقلية بسيطة
٤٠ - ٥٤	٣٦ - ٥١	- إعاقة عقلية متوسطة
٢٥ - ٣٩	٢٠ - ٣٥	- إعاقة عقلية شديدة
أقل من ٢٥	أقل من ٢٠	- إعاقة عقلية حادة

(في: عبد المطلب القريطي، ٢٠٠٥: ١٠١ - ١٠٢)

أسباب الإعاقة العقلية:-

قام الأطباء والعلماء المهتمون بدراسة الإعاقة العقلية بجهود كبيرة لاكتشاف أسباب الإعاقة العقلية، وقد تم تحديد كثير من العوامل التي تؤدي إلى الإعاقة العقلية، رغم أن هناك عوامل وأسباب كثيرة لم يتوصل اليها الباحثون والأطباء إلى التعرف عليها (تيسير كوافحة وعمر عبد العزيز، ٢٠٠٣، ٦٦). ومن العوامل المسببة للإعاقة العقلية: العوامل الوراثية والعوامل البيئية، وفيما يلي شرح تفصيلي لهما:

١- أسباب وراثية:-

تلعب العوامل الوراثية التي تحددها أساساً الجينات، دوراً مهماً في حدوث الإعاقة العقلية، حيث يكون أثر الوراثة منذ اللحظة الأولى لتكوين الجنين، أي منذ إخصاب البويضة بواسطة الحيوان المنوي (محمد محروس الشناوي، ١٩٩٧، ٧٩). والأسباب الوراثية (حوالي ٥٪). شذوذ الكروموسومات، داء تاي ساكس Tay Sachs، والتصلب الحدبي Tuberous Sclerosis.

والعوامل الوراثية هي المسؤولة عن (٨٠٪)، من حالات الإعاقة العقلية وذلك لوجود تلف أو قصور أو خلل في خلايا المخ أو الجهاز العصبي المركزي، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث إعاقة في وسائل الإدراك والوظائف العقلية المختلفة بالإضافة إلى صعوبات في عملية التعلم (إبراهيم الزهيري، ١٩٩٨، ٢٣٧).

قائمة المحتويات

كما يشير "نادر فهمي الزبيدي" (٢٠٠٠، ٥٤) إلى أن الوراثة تلعب دوراً بارزاً في حدوث الإعاقة العقلية، فبعض الأطباء كانوا يرجعون كل الأسباب التي لا يعرفونها عن الإعاقة العقلية إلى عامل الوراثة، مما أدى إلى التأكيد على أهمية العامل الوراثي، فالطفل يرث الإعاقة العقلية عن طريق والديه وأجداده، وذلك عن طريق الجينات، وقد تظهر في زواج الأقارب أكثر من زواج غير الأقارب.

ومما لا شك فيه أن الوراثة تعنى في أساسها "انتقال سمات مختلفة من الآباء والأجداد إلى الأبناء والأجيال التالية"، وأن بعض هذه السمات تكون في أساسها سمات مرضية، إلى جانب أن هناك بعض الأمراض قد تنتقل أيضاً عن طريق الوراثة أو عن طريق الجينات. ومن هذا المنطلق قد يولد الطفل معوقاً لوالدين عاديين حيث تنتقل السمات المرضية إليه في تلك الحالة عن طريق جين منتج قد ينتقل إليه من الأب أو الأم، وقد يولد الطفل من جانب آخر معوقاً لأبوين معاقين أو أحدهما فتنتقل السمات المرضية إليه آنذاك عن طريق جين سائد (عادل عبد الله، ٢٠٠٤، ٧٢). كما أن هناك نمط آخر من أنماط الإعاقة العقلية الناجم من اختلال الكروموزومات وتظهر أعراضه في شكل يطلق عليه زملة أعراض كيلفنتر ولا تظهر هذه الأعراض إلا في سن البلوغ ولدى الذكور، ويظل المعاق صغير الجسم وتظهر عليه الصفات الجنسية الثانوية، وقد تحدث الإعاقة العقلية بسبب عوامل مباشرة أو عوامل غير مباشرة:-

- أ- العوامل المباشرة: تكون عن طريق الجينات التي يرثها الطفل من والديه، والتي تحمل الصفات الموروثة للفرد.
- ب- العوامل غير المباشرة: لا تورث الإعاقة العقلية ولكنها تورث نوع من المرض أو الخلل أو الاضطراب في تكوين المخ يترتب عليه تلف أنسجة المخ أو إعاقة نموه ووظيفته، وتشمل هذه الفئة مجموعة من العوامل الآتية:
 - العيوب المخية: مثل صغر الدماغ أو كبره .
 - الاضطرابات في تكوين الخلايا .
 - اضطراب التمثيل الغذائي أو عملية البناء أو الهدم (الأبيض): وهو وجود عدد المركبات أو العناصر التي تحدث بعض الاضطرابات الجينية (عبد الرحمن العيسوي، ٢٠٠٢، ١٠٣).

٢- أسباب بيئية:-

تتدخل العوامل البيئية بنسبة (٢٠٪) من حالات الإعاقة العقلية، وتتدخل بعد عملية الإخصاب مباشرة، أي أثناء تكوين البويضة في رحم الأم أثناء فترة الحمل ثم الولادة ثم بعد الولادة، حيث ينتهي أثر العوامل الوراثية بعد الإخصاب ثم يظهر أثر العوامل البيئية (إبراهيم الزهيري، ١٩٩٨: ٢٣٨). ولهذا فإن الأطفال يتعرضون داخل رحم الأم لعوامل بيئية عديدة مثل: الحرارة والضغط والتغذية وغيرها من العوامل الفسيولوجية والكيميائية، هذا بالإضافة إلى انفصالات الأم السارة والحزينة، وعادات الأم الخاطئة مثل التدخين والإدمان، والمرض أثناء الحمل كالعدوى ببعض الأمراض مثل: الحصبة الألمانية أو التهاب السحايا والأورام العصبية واضطراب الغدد الصماء واضطراب عملية التمثيل الغذائي وتأثير الأشعة السينية وغيرها، هذا بالإضافة إلى تناول المواد والعقاقير أثناء الحمل أو بعد الولادة.

وتتعدد الأسباب البيئية للإعاقة الذهنية، فمنها ما هو مرتبط بالأم قبل وأثناء فترتي الحمل والولادة، ومنها ما هو مرتبط بالبيئة النفسية والاجتماعية التي يعيش فيها الطفل (طارق عامر وربيع عامر، ٢٠٠٦: ١٣١). ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى ما يلي:-

- عوامل الحمل المبكر (حوالي ٣٠٪). متلازمة التثالث الصبغي (متلازمة داون) وتناول الأمهات المواد والعقاقير.
- الحمل في وقت متأخر والعوامل المحيطة بالولادة (حوالي ١٠٪). الولادة المبكرة Prematurity، نقص الأكسجين، صدمات الولادة، وسوء التغذية للجنين.

قائمة المحتويات

-عوامل ما قبل الولادة (أثناء الحمل) وتشمل:-

- أ- حالات مصاحبة لأمراض قبل الولادة غير معروفة المصدر مثل: حالات فقدان الكلي أو الجزئي لجزء من المخ، أو سوء تكوين التجاعيد على سطح المخ، وكذلك حالات الاستسقاء الدماغي وعيوب التحام عظام الراس وكبر حجم الجمجمة أو صغرها وكلها تتميز بوجود الإعاقة العقلية (Hopkins,M.,1996:1053-1060)
- ب- قد تحدث إصابات قبل الولادة فيتعرض الجنين للاختناق Asphyxia خاصة إذا أصيبت الأم بالأنيميا أو التوتر العصبي أو ارتفاع ضغط الدم hypertensive (Hopss,W.,1998 :441).
- ج- إصابة الأم بالزهري أو الإيدز أو الحصبة الألمانية أو غيرها من الأمراض الفيروسية أو بالبول السكري أثناء الحمل.
- د- إدمان الأم المخدرات أو المسكرات أثناء الحمل أو تناول أدوية دون استشارة الطبيب .
- هـ- اختلاف أو عدم تشابه دم الأم ودم الطفل ($RH^- RH^+$) .
- و- اضطرابات الغدد الصماء قبل الولادة ومنها ظهور الغدة التيموسية أو تضخم الغدة الدرقية (عثمان لبيب، ٢٠٠٢: ٣٣).
- ي- كما أن إصابة الأم خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل بالحصبة الألمانية قد يؤدي إلى تلف الأنسجة العصبية لدى الجنين، وإصابته بالإعاقة العقلية والصرع وربما أفضت إلى موته، وقد تكون بسبب أيضاً عدوى أو تسمم الأم أثناء فترة الحمل كما في حالات تسمم الدم وزيادة نسبة الصفراء في الدم، أو نتيجة تعاطي الأم لعقاقير بدون إشراف الطبيب المعالج لها أثناء الحمل، وأيضاً عوادم السيارات والكحوليات وغيرها من العديد من الأشياء التي تؤدي لتشوهات خلقية للجنين (عبد المطلب القريطي، ٢٠٠٥: ٩١).
- ف- تعرض الأم الحامل للأشعة يعرضها لمضاعفات وأكثرها حدوثاً هو سرطان الدم وغيره من أنواع السرطان، وصغر حجم الدماغ (خولة يحيى وماجدة عبيد، ٢٠٠٥: ٣٩).

٢- عوامل أثناء الولادة ومنها:-

- نقص الأكسجين عن الجنين في المرحلة الأخيرة من الحمل أو التفاف الحبل السرى حول رقبته.
- الولادة العسرة أو القيصرية، أو الولادة المبكرة.
- عوامل ما بعد الولادة : هي عوامل تتعلق بالطفل نفسه، وعوامل تتعلق ببيئة الطفل.
- أ- عوامل تتعلق بالطفل نفسه وتتمثل في:
 - إصابة الطفل بعد الولادة- قبل سن البلوغ (بالحمى الشوكية) والتي تؤثر على خلايا المخ، أو بأحد أنواع الشلل المخي أو الحصبة.
 - السقوط أو اصطدام الجمجمة بشدة في مرحلة الطفولة - قبل المراهقة- بصورة يترتب عليها تلف بعض أنسجة المخ أو الإصابة ببعض الأورام (عثمان لبيب، ٢٠٠٢: ٣٤) .
 - التهاب السحائي Meningitis الذي يؤثر في القشرة الدماغية والجهاز العصبي المركزي، والالتهاب الدماغي Encephalitis الذي يؤدي إلى الإعاقة العقلية (محمد إبراهيم، ١٩٩٩: ٢٣).
 - إصابة الجمجمة أو المخ أثناء الولادة نتيجة استعمال الجفت أو الشفط في الولادة (عثمان لبيب، ٢٠٠٢: ٣٣؛ قحطان الظاهر، ٢٠٠٥: ٨٢).

ب- عوامل تتعلق ببيئة الطفل:-

هي عوامل بيئية تحدث ردود فعل وظيفية فقط مثل: الاضطرابات النفسية الانفعالية في الطفولة المبكرة وضعف المستوى الاجتماعي الاقتصادي والثقافي والحرمان من المثيرات الكافية التي تساعد الطفل على النمو

قائمة المحتويات

السليم، أو التي تؤدي إلى النضج العقلي النفسي والاجتماعي والانفعالي. فالتنشئة غير السليمة أو غير الملائمة لا تتيح الفرصة لنمو الطفل وتعوق قدراته العقلية وإمكاناته الوراثية من الوصول إلى النضج، وهو الهدف الأساسي من عملية النمو المتكامل في جميع جوانب شخصية الطفل، فالحرمان الاجتماعي له آثار سيئة على النمو العقلي في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث أن النمو العقلي للطفل في هذه السن المبكرة يتعطل بسبب الحرمان الاجتماعي أو نتيجة لاضطرابات نفسية أو انفعالية (إبراهيم الزهيري، ١٩٩٨: ٢٣٩).

وتعتبر البيئة الفقيرة ثقافياً التي تفتقد الأنشطة الذهنية الحافزة لذكاء الطفل في مراحل نموه الأولى، تعتبر مسئولة عن نسبة عالية جداً من حالات الإعاقة العقلية البسيطة (٨٠٪)، وخاصة إذا لم يتوفر الغذاء الكامل والخدمات الصحية (عثمان لبيب، ٢٠٠٢: ٣٤). وتمثل التأثيرات البيئية والاضطرابات النفسية (حوالي ٢٠٪). والحرمان الثقافي والبدنية المبكرة للفصام.

د- الحالة البدنية في مرحلة الطفولة (حوالي ٥٪). تسم الرصاص، والالتهابات، والصدمات النفسية.

و- لا يوجد سبب محدد (حوالي ٣٠٪) (Morrison, 2014, 21).

خصائص المعاقين عقلية القابلين للتعلم:

يتسم الأطفال المعاقين عقلياً بأنهم فئة القابلين للتعليم بعدد من الخصائص والسمات العامة التي تميزهم عن غيرهم من الأطفال الأسوياء من جانب وعن أقرانهم من الأطفال المعاقين عقلياً من باقي الفئات من جانب آخر، منها: نقص القدرة على الانتباه، الحاجة إلى التكرار، نقص القدرة على التركيز، انخفاض البصيرة أو الفطنة، نقص القدرة على الاتصال اللفظي، نقص القدرة على التخيل، نقص القدرة على المشاركة في الأنشطة، بطء الاستجابة وتأخر رد الفعل، الانفعال الزائد في المواقف المحيرة، نقص القدرة على حل المشكلات حتى بعد تقديم إيضاحات وإرشادات، نقص القدرة على اكتشاف التشابهات والاختلافات بين الأشياء، نقص القدرة على تعميم الخبرة واستخدامها في مواقف جديدة (رشا محمد أحمد، ١٩٩٩: ٣٧). وفيما يلي عرض لهذه الخصائص:

أ- الخصائص العقلية المعرفية:

تعرف الخصائص العقلية والمعرفية بأنها "مجموعة الخصائص والسمات المرتبطة بالعمليات ذات العلاقة بالقدرة على التعلم والانتباه والذاكرة والتمييز والتفكير والقدرة على التخيل" (عبدالمطلب القريطي، ٢٠٠١، ٢١٩). ويذكر "عبدالمطلب القريطي" (٢٠٠٥: ٨٩) أن المعاقين عقلياً يتصفون ببعض الصفات العقلية المعرفية التالية:-

- ١- أداء منخفض عن المتوسط في اختبارات الذكاء.
- ٢- ضعف القدرة على التركيز والانتباه لفترة طويلة.
- ٣- قصور الفهم والاستيعاب وتدني القدرة على التحصيل الدراسي.
- ٤- بطء التعلم.
- ٥- ضعف الذاكرة وقصور القدرة على الملاحظة وإدراك العلاقات.
- ٦- الجمود والتصلب العقلي (نقص المرونة العقلية).
- ٧- تأخر النمو اللغوي وقصور اللغة اللفظية.
- ٨- القصور في تكوين المفاهيم والتفكير المجرد والتخيل والإبداع.

قائمة المحتويات

ب- الخصائص الاجتماعية والانفعالية:

الطفل المعاق عقلياً يتصف ببعض الصفات الاجتماعية والانفعالية التي تعكسها قدراته العقلية وهي الانسحاب والتردد والسلوك التكراري والحركة الزائدة وعدم قدرته على ضبط انفعالاته، وعدم القدرة على إنشاء علاقات اجتماعية فعالة مع الغير ويميل إلى مشاركة الأصغر منه سناً ويميل إلى العدوان وعدم تقدير الذات، ويبدو أيضاً هادئاً لا يتأثر بسرعة، راضياً بحياته كما هي ويستجيب إذا علمناه كالطفل الصغير ويغضب إذا أهمل ولكن لا يستمر في غضبه فترة طويلة وسرعان ما يمرح ومن السهل التأثير عليه لأنه سهل الاستهواء (آمال عبدالسميع باظة، ٢٠١٢، ٢١).

- يتصف الطفل المعاق عقلياً بتقديره المنخفض للذات والذي يعكس إحساساً بالدونية وضعف الثقة بالنفس.

- الميل إلى الانسحاب والانعزال والوحدة .

- التقلب في المزاج وسوء التوافق وعدم الاستقرار الانفعالي .

- الشعور بالخجل، والخوف، والأناية، والعدوانية الزائدة والعصبية وسهولة الاستثارة، والقابلية للاستهواء بالاضافة إلى الإحباط السريع واضطراب الحالة المزاجية.

- النقص في الدافعية فهو ليس لديه دوافع تجعله يتأثر لإنجاز عمل معين.

- المخاوف المرضية من بعض الحيوانات ومن الظلام (طارق عامر وربيع عامر، ٢٠٠٦: ١٢٤).

وتشير "سهير كامل" (٢٠٠٢: ٩٨) إلى أن الأطفال المعاقين عقلياً يتصفون بالغضب وانفعالاتهم متقلبة، ويخافون من بعض الحيوانات ومن الأماكن المغلقة والمفتوحة والمرتفعة والمظلمة بشكل أكبر من أقرانهم العاديين. ويعاني المعاقين عقلياً من عدم القدرة على التوافق الاجتماعي، ويظهر لديهم اضطرابات في التعرف على المواقف الاجتماعية وأساليب التفاعل الاجتماعي، ولديهم لا مبالاة وأحياناً عدم اهتمام لما يدور حولهم في البيئة المحيطة، وعدم تقدير المسؤولية والمشاركة الاجتماعية، بالاضافة إلى عدم وجود رغبة لديهم لعمل علاقات اجتماعية مع الأطفال في مثل عمرهم الزمني، ويميلون أحياناً إلى اللعب والإشتراك وإنشاء علاقات مع الأطفال الأصغر منهم عمراً" (جمعة سيد يوسف، ٢٠٠٠: ٨٢).

ج- الخصائص الأكاديمية والتربوية:

تقوم على أساس القصور في الاستعدادات التحصيلية لدى المعاقين والقدرة على التعلم والتدريب خلال سنوات الدراسة وفي ضوء نسب الذكاء المختلفة، فهم يتصفون بالأداء المنخفض في الاختبارات والأنشطة والمهارات المدرسية والتحصيلية، وفي سن السادسة يكونون غير مستعدين للقراءة والكتابة والحساب، إلا إذا توفرت لديهم قدرات خاصة، ولا يتمكنون من اكتساب المهارات إلا عند بلوغهم سن الثامنة أو أكثر، ومن ثم فالطفل المعاق عقلياً غير قادر على أن ينهي المقرر لسنة دراسية في الوقت المحدد دائماً، وإنما يحتاج إلى سنتين أو أكثر، وهم بحاجة إلى مناهج دراسية تتفق مع قدراتهم المحدودة بالإضافة إلى طرق تدريس مناسبة والتي لا بد أن تختلف بالضرورة مع مثيلاتها من طرق تدريس الطفل العادي خاصة أن الطفل المعاق عقلياً القابل للتعلم غالباً ما يعاني من تأخر واضح في نمو القدرات اللغوية والكلام (خولة يحيى وماجدة عبيد، ٢٠٠٥، ١٣٨).

وعلى الرغم من انخفاض المهارات الأكاديمية لدى الأطفال المعاقين عقلياً إلا أن ذلك لا يعني أنهم غير قادرين على التعلم أو التحصيل ولكن يجب إعداد البرامج التربوية الخاصة التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم.

د- الخصائص اللغوية Languages Skills

إن "اللغة ظاهرة إنسانية غريزية لتوصيل العواطف والأفكار والرغبات عن طريق نظام من الرموز الصوتية الاصطناعية. إلا أن اللغة بنوعها اللفظية وغير اللفظية هي الوسيلة الجوهرية للاتصال الاجتماعي والعقلي والثقافي، وهي بصورتها الكتابية السجل الحافل لثقافة النوع الإنساني وتتطوي عليها هذه الثقافة في آثار عقلية معرفية معنوية مادية فهي لهذا كله إحدى الدعائم القوية لكسب المعرفة، وارتداد آفاق هذا العالم المجهول وهي بصورتها اللفظية مظهر قوي من مظاهر النمو العقلي والحسي - الحركي ووسيلة من وسائل التفكير والتخيل والتذكر.. ثم أوضح أن اللغة تعني كل الوسائل الممكنة، لفظية كانت أو غير لفظية للتفاهم بين الكائنات الحية وبذلك تكون حركة اليد لغة وإيماءة الوجه لغة وغمز الحاجب لغة، ورمز الشفة للإشارة التي تؤدي إلى فهم معنى ما تخدم الغرض نفسه الذي تسعى إلى تحقيقه (زينب محمود شقير، ٢٠٠٦، ١٦٣).

وتحتل اللغة والمهارات اللغوية مكانة مهمة بين المهارات التي يجب أن نسعى إلى تنميتها لدى الأطفال عامة والأطفال المعاقين عقلية خاصة، وترجع أهمية اكتساب اللغة والمهارات اللغوية إلى كون اللغة تؤدي وظائف عدة:

- ١- الوظيفة النفعية أو الوظيفية: تتمثل في استخدام اللغة لإشباع الحاجات والتعبير عن الرغبات وتحقيق أهداف معينة.

- ٢- الوظيفة التنظيمية: تتمثل في استخدام اللغة للسيطرة والتحكم في سلوك الآخرين من خلال الطلبات والأوامر أو إصدار التعليمات والتوجيهات.

- ٣- الوظيفة التفاعلية: تتمثل في استخدام اللغة كأداة للتفاعل والتواصل مع الآخرين، فهي تشير إلى وظيفة التعبير عن الأنا وأنت ونحن.

- ٤- الوظيفة الشخصية: تتمثل في استخدام اللغة كأداة للتعبير عن المشاعر والاتجاهات والآراء والأفكار نحو الموضوعات المختلفة، حيث تمثل أداة إثبات الهوية والثبات الشخصي لدى الأفراد.

- ٥- الوظيفة الاستكشافية: تتمثل في استخدام اللغة كأداة لاكتساب المعرفة والخبرات المختلفة أو لفهم طبيعة الأشياء والحوادث، وهذا ما يسمى بالوظيفة الاستفهامية التي تتمثل في طرح الأسئلة والاستفهام حول المواضيع المختلفة.

- ٦- الوظيفة التخيلية: تتمثل في استخدام اللغة كأداة للهروب من الواقع من خلال كتابة الشعر والقصص للتنفيس عن الانفعالات الشخصية، كما تستخدم للترويح عن النفس وللتغلب على صعوبات الحياة أو العمل من خلال الغناء والنكت.

- ٧- الوظيفة الإعلامية: تتمثل في استخدام اللغة كأداة لنقل المعارف والخبرات والمعلومات إلى الآخرين، كما هو الحال في استخدامها في المجالات السياسية والإعلامية والمهنية من أجل شحذ الهمة والتأثير في سلوك الأفراد وتوجيهه.

- ٨- الوظيفة الرمزية: تتمثل في استخدام اللغة للدلالة على الأشياء والموجودات المادية المفاهيم المادية أو الخبرات والمعاني المجردة.

وهكذا نجد أن اللغة والمهارة اللغوية إنجاز إنساني مهم متميز كونها وسيلة للتفاعل والاتصال الاجتماعي وكذلك لها أثرها في علاقات الطفل الاجتماعية وإيجاد شعور من الرضا والقبول، وتلعب دوراً مهماً في عملية التفكير والنمو المعرفي لدى الفرد وهي وسيلة من وسائل التواصل اللفظي الإنساني وأسلوب من أساليب التنشئة الاجتماعية (عماد عبد الرحيم الزغول، ٢٠٠٥، ٢٠١-٢٠٢).

ويتأخر الأطفال المعاقين عقلياً (القابلين للتعلم)، عن أقرانهم من الأطفال العاديين في النطق ولكنهم يصلون إلى مستوى معقول من الأداء اللغوي، ولكن لا يستطيع الطفل في هذه الفئة استيعاب المفاهيم المجردة، إلا أنه قد

قائمة المحتويات

يكون قادراً على فهم الكلام الموجه من الآخرين والتعبير عن نفسه بصورة معقولة (عبد المطلب القريطي، ٢٠٠٥).

ومن صفات المعاقين عقلياً المشكلات المرتبطة بالخصائص اللغوية، حيث نجد قصوراً واضحاً في استخدام اللغة والكلام، فهو لا يستطيع استخدام اللغة الصحيحة أو الكلام المتناسق المعنى، ومن أهم ما يتسم به الكلام واللغة عند المعاقين عقلياً تأخر النمو اللغوي بصورة واضحة، فنجد لديهم مشكلة في مخارج الأصوات ونطق الكلمات واستخدام الجمل والتعبير اللفظي والتعبير عن مشاعرهم (رشاد عبد العزيز، ٢٠٠٢، ١١٣) ومن لديه صعوبة أو مشكلة أو اضطراب في اللغة لديه مشكلة في التفاعل المعرفي والاجتماعي والوجداني (أحمد رجب، ٢٠٠٨، ٦٧).

هـ الصفات الجسمية والحركية:

تشير نتائج الأبحاث التي أجريت علي المعاقين عقلياً في هذا الميدان إلى وجود فروق بين القابلين للتعلم والعاديين من حيث مستوى نموهم الجسدي والحركي، فهم بصفة عامة أقل طولاً ووزناً، ومتأخرين عن العاديين في نموهم الحركي، كالقدرة على السير مثلاً، وقد أكدت دراسات "سولون" Solon، على وجود فروق بين القابلين للتعلم وبين العاديين في المهارات الحركية المختلفة غير أن هذه الفروق سواء في الصفات البدنية أو الحركية ليست كبيرة بحيث نستطيع القول بأن هؤلاء الأطفال يصلون في نموهم الجسدي والحركي إلى مستوى قريب من مستوى العاديين، وذلك فيما عدا الحالات التي ترجع فيها الإعاقة العقلية إلى إصابات في الجهاز العصبي المركزي، ففي هذه الحالات غالباً ما يصاحب الإعاقة العقلية اضطراب في المهارات الحركية (في: عبد الرحمن سليمان، ٢٠٠١، ١٣٢).

النظريات المفسرة لأسباب الإعاقة العقلية:

أ- نظرية التحليل النفسي:

فسر بعض الأطباء النفسيين المتأثرين بنظرية التحليل النفسي "لفرويد" الإعاقة العقلية على أنها تنتج من التربية الخاطئة خلال مراحل النمو الأولى من عمر الطفل، وهذا يؤدي إلى اضطرابات ذهنية، كثيرة عنده. وفسر العالم النفسي "برونو بيتلهايم" Bruno Bettelheim أن سبب الإعاقة العقلية ناتج عن خلل تربوي من الوالدين، وتوجيه اللوم بشكل أساسي إلى الأم حيث كان يطلق عليها سابقاً لقب الأم الثالجة (مجدي فتحي غزال، ٢٠٠٧، ٤٥).

ب- نظرية العقل:

تشير نظرية العقل إلى الكيفية التي يتعامل بها الفرد مع أفكار ومعتقدات ومشاعر الآخرين من فهم وإدراك وتنبؤ من خلال الإشارة إلى صعوبة قدرة الأطفال المعاقين عقلياً على الاستنتاج، ومثال ذلك إنهم يجدون صعوبة في تصور أو تخيل الإحساس والشعور لدى الآخرين أو ما قد يدور في ذهن الآخرين من تفكير، وهذا بدوره يقود إلى ضعف مهارات التقمص العاطفي وصعوبة التكهن مما قد يفعله الآخرون (سعدي فتيحة، ٢٠١٧، ٢٨٦).

ج- نظرية الاضطراب الأيضي:

تفترض هذه النظرية أن تكون الإعاقة العقلية نتيجة وجود عامل مؤثر خارجي المنشأ (من الغذاء) يؤثر على النقل العصبي داخل الجهاز العصبي المركزي، وهذا التأثير قد يكون بشكل مباشر أو من خلال التأثير على تلك البيبتايدات الموجودة والفاعلة في الجهاز العصبي؛ مما قد يؤدي إلى أن تكون العمليات داخله مضطربة، هذه

قائمة المحتويات

الببتايدات تتكون عند حدوث التحلل غير الكامل لبعض الأغذية المحتوية على الجلوتين مثل الشوفان، والشعير، والقمح والكازين الموجود في الحليب ومنتجات الألبان (عادل محمد العدل، ٢٠١٠، ٦٧).

د- نظرية التسمم بالمعادن واللقاحات:

تستند هذه النظرية بالأساس إلى الملاحظة الثابتة والحقيقة أن التسمم بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك يسبب ضررا بالدمغ في مرحلة النمو كما عند الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. أما عن اللقاحات فتعد إحدى النظريات التي وجدت قبولا كبيرا في بداية الأمر، وسنتناول هنا نظرية علاقة الإصابة بالإعاقة العقلية باللقاحات، التي تعطى للأطفال وبخاصة اللقاح الثلاثي الفيروسي. والسبب الرئيس في هذا الربط مع هذا اللقاح بالذات هو توقيت إعطاء اللقاح الذي يكون مع بلوغ العام الأول من العمر وهو يوافق بداية التقدم في القدرات الكلامية (يفقد بعض الأطفال ذوي الإعاقة العقلية قدراتهم الكلامية ما بين ١٨ شهر و ٢٠ شهرا (محمد الدوسري، ٢٠٠٩، ٥٥).

وعلى الرغم من هذه التفسيرات الاجتماعية والنفسية والإدراكية العقلية والبيو- كيميائية، فإنه لا يوجد سبب رئيس يتفق عليه الجميع ليكون المسبب للإصابة بالإعاقة العقلية، ومن ثم مازال سبب الإصابة به رهن البحث والدراسة ولم يحدد تحديدا دقيقا. ومع ازدياد نسبة الأطفال المصابين بالإعاقة العقلية، ازداد تسليط الضوء مؤخرا على هؤلاء الأطفال من خلال البحوث والدراسات من أجل التمهيد لعودتهم مرة أخرى مع أقرانهم العاديين والانصهار في بوتقة المجتمع وهو ما يظهر في تفسير نظرية العقل التي يمكن عن طريقها معرفة مدى قدرة الأطفال المعاقين عقليا على إدراك واستنتاج ما يدور في عقول الآخرين من أفكار ومشاعر ومعتقدات وانفعالات، من خلال القيام بعملية التصور العقلي لما يدور في عقولهم، لمعرفة الحالات العقلية التي تقف وراءها من خلال الربط بين السلوك وخلفيته العقلية.

-تشخيص الإعاقة العقلية:

أقرت الجمعية الأمريكية للطب النفسي (A.P.A) American Psychiatric Association (١٩٩٤، ٤٠٠) في الإصدار الرابع للدليل التشخيصي الإحصائي للأمراض النفسية والعقلية DSM, IV ضرورة استيفاء المحكات الآتية لتشخيص الحالة على أنها تخلف عقلي وهي:

- ١- أداء ذهني وظيفي دون المتوسط، ونسبة ذكاء حوالي ٧٠ أو أقل على اختبار ذكاء يطبق فردياً.
- ٢- عيوب أو قصور في السلوك التكيفي الراهن، أي مدى كفاءة الفرد في الوفاء بالمستويات المتوقعة ممن هم في عمره أو جماعته الثقافية في اثنين على الأقل من المجالات الآتية: التواصل واستخدام إمكانات المجتمع، التوجيه الذاتي والمهارات الأكاديمية الوظيفية، العمل، الفراغ، الصحة والسلامة.
- ٣- يحدث ذلك قبل سن ١٨ سنة.

يدخل الشخص ضمن فئة الإعاقة الذهنية عند توافر المعايير الثلاثة التالية:

- ١- عندما ينخفض مستوى الأداء العقلي (معدل الذكاء) عن ٧٥
- ٢- عند وجود صعوبات واضحة في مهارات التكيف.
- ٣- حدوث الإعاقة في الطفولة (دون سن الثامنة عشر).

وقد حدد الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي أنه يجب أن تتحقق المعايير الثلاثة التالية للفرد لكي يتم تشخيصه معاقا عقليا:

أ-العجز في الوظائف العقلية، مثل التفكير، وحل المشكلات، والتخطيط، والتفكير المجرد، والحكم والتعلم الأكاديمي، والاستفادة من التجارب السابقة، والتي أكد عليها كل من التقييم السريري والفردية، واختبار الذكاء المعياري.

قائمة المحتويات

ب-العجز في الوظائف التكيفية التي تؤدي إلى الفشل في تلبية المعايير التنموية والاجتماعية والثقافية من أجل الاستقلال الشخصي والمسؤولية الاجتماعية، وبدون الدعم المستمر، فإن العجز في التكيف يحد من الوظائف في نشاط واحد أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية، مثل التواصل، والمشاركة الاجتماعية، والعيش المستقل، عبر بيئات متعددة، مثل البيت والمدرسة والعمل والمجتمع.

ج- بداية العجز العقلي والتكيفي خلال فترات النمو في الطفولة والمراهقة (American Psychiatric Association,2013, 33).

متلازمة أعراض داون:-

تعد متلازمة أعراض داون نمطاً أساسياً من أنماط الإعاقة العقلية يشهد درجة معينة من القصور العقلي أو القصور في القدرة العقلية حيث يتراوح مستوى ذكاء الأطفال من هذه المتلازمة بين التخلف العقلي البسيط والمتوسط، ونادراً ما نجد أطفالاً منهم يقل مستوى ذكائهم عن هذا المستوى . وكغيرها من فئات الاضطرابات الجينية المختلفة هناك العديد من السمات التي تميز هؤلاء الأطفال وتجعل منهم فئة فريدة بين فئات الإعاقة الأخرى يمكن تمييزها عنهم كما ترى سارة روتر (Rutter, S.,2002) وتتضمن هذه السمات ما يلي:

- ١ - جفاف الجلد .
- ٢ - البطء في ابتلاع الطعام أو حتى السوائل .
- ٣ - ضعف السيطرة على اللسان .
- ٤ - شكل مميز للوجه حيث يشبه الجنس المنغولي، وتكون الأذنان صغيرتين ومنخفضتين عن وضعهما الطبيعي، ويوجد تقوس غير طبيعي في الفم من أعلى، وتكون الأسنان عفاء خطافية، والأنف مسطح.
- ٥ - التعرض المستمر لعدوى الصدر أو حتى الأمراض الصدرية .
- ٦ - الالتهاب المستمر للجيوب وخاصة الجيوب الأنفية .
- ٧ - أن حوالي ٤٠ ٪ منهم تقريباً يتعرضون لأمراض القلب والتي تتراوح بين اللغط الخفيف Slightmurmur إلى الشذوذ الشديد الذي يتطلب الجراحة .
- ٨ - التعرض لمشكلات في السمع .
- ٩ - مشكلات في الإبصار .
- ١٠ - مشكلات في الغدة الدرقية أو القصور الدرقي .
- ١١ - توجد مجموعة من الخصائص العامة المميزة لهم من أهمها قصر القامة، وقصر الرقبة وعرضها، وقصر الذراعين والرجلين، وضعف العضلات وارتخاؤها، وقصص صدري غير عادي في شكله، وبروز البطن، وزيادة الوزن.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المتلازمة ترجع في الأساس إلى شذوذ أو خطأ كروموزومي معين لا يعتمد بدرجة كبيرة على الوراثة، وإن كان رغم ذلك يعتمد على وجود تاريخ مرضي لدى أسرة أي من الزوجين، وإلى زيادة عمر الأم الحامل عن خمس وثلاثين عاماً. وترى كيسلنج وسوتيل (Kessling&Sawtell,2002) أن مثل هذا الخطأ أو الشذوذ الكروموزومي يتحدد في الكروموزوم رقم ٢١ الذي يصبح ثلاثياً أي يتضمن كروموزوماً زائداً أو إضافياً نتيجة لأن عدد الكروموزومات في الحيوان المنوي أو البويضة يكون ٢٤ بدلاً من ٢٣ مما يؤدي بالتالي إلى زيادة عدد الكروموزومات في الخلية ليصبح ٤٧ بدلاً من ٤٦ كما يحدث في الظروف العادية.

قائمة المحتويات

وهناك ثلاثة أنماط من هذه المتلازمة يسمى أولها بالشذوذ الكروموزومي في الكروموزوم رقم ٢١ (Trisomy 21) الذي يتضمن ثلاثاً من الكروموزومات. أما النمط الثاني فلا يتضمن مثل هذه الزيادة الكروموزومية، بل يكون عدد الكروموزومات في كل خلية طبيعياً أي ٤٦ كروموزوماً فقط، ولكن الخطأ في تلك الحالة يكمن في انتقال جزء من الكروموزوم رقم ٢١ أو انتقاله بأكمله إلى كروموزوم آخر قد يكون الكروموزوم ١٣ أو ١٤ أو ١٥ أو ٢٢ ولكنه في الغالب يكون رقم ١٤ وقد يحدث ذلك قبل الحمل، وقد يحدث كذلك بعد الحمل وذلك عندما يتوقف هذا الكروموزوم عن الانقسام وينتقل جزء منه أو ينتقل بأكمله إلى الكروموزوم رقم ١٤. ويمكن أن يكون الوالد أباً أو أمّاً حاملاً لذلك كسمة متنحية فينقلها إلى أطفاله لتكون سائدة لديهم، وأن حوالي ١ % تقريباً من أولئك الأطفال هم الذين يرثون تلك الحالة أي تنتقل إليهم وراثياً وذلك من والدهم الذي يعد حاملاً لمثل هذه السمّة. هذا وتبلغ احتمالات ولادة طفل آخر من ذلك النمط ١ : ٦ إذا كانت الأم هي الحاملة لتلك الحالة أو الناقلة لها، بينما تبلغ ١ : ٢٠ إذا كان الأب هو الناقل لها أو هو الذي يحملها. أما في النمط الثالث والمعروف بالفسيفسائي Mosaic فيجمع الفرد في خلاياه بين الخلايا الطبيعية والخلايا الشاذة حيث يكون عدد الكروموزومات في بعض خلاياه طبيعياً أي ٤٦ كروموزوماً، بينما يكون في بعضها الآخر شاذاً أي ٤٧ كروموزوماً، وعادة ما تتكون هذه الحالة بعد الحمل حيث تنقسم الخلايا بشكل عادي، بينما يحدث خطأ يتعلق بذلك في انقسامات تالية مما يجعل بعض خلايا الجسم عادية وبعضها الآخر شاذاً، وتحدد درجة الإعاقة لدى الفرد بمقدار ما لديه من خلايا شاذة في مقابل خلاياه الطبيعية، وتعد ولادة طفل آخر في الأسرة من نفس هذا النمط نادرة للغاية. ورغم وجود ثلاثة أنماط من متلازمة أعراض داون فإنه لا توجد فروق بين الأطفال من هذه الأنماط جميعاً، ولكن بإمكاننا أن نتعرف على نمط هذه المتلازمة على وجه التحديد من خلال فحص الدم، ورسم بروفيل للكروموزومات karyotype حتى نتجنب النمط الثاني الذي تعد الوراثة مسؤولة عن ١ % منه.

ومن الجدير بالذكر أن الإعاقة العقلية في أي صورة من صورها تمثل محوراً هاماً وأساسياً من تلك المحاور التي تدور التربية الخاصة حولها، وتوليها اهتمامها. وتعرف الإعاقة العقلية بأنها اضطراب في واحدة أو أكثر من تلك العمليات السيكلوجية الأساسية التي يتضمنها الفهم واستخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة والتي يمكن أن تعبر عن نفسها على هيئة قصور في واحدة أو أكثر من قدرات الطفل على الاستماع، أو التفكير، أو التحدث، أو الكتابة، أو التهجي، أو إجراء العمليات الحسابية. ومن ثم فإن مثل هذه الإعاقة تعد بمثابة حالة تتعارض مع تحقيق إنجاز أكاديمي يتناسب مع عمر الطفل، كما تتعارض مع قيامه بأنشطة الحياة اليومية بذلك الشكل وتلك الكيفية التي نتوقعها ممن هم في مثل سنه. وعلى ذلك فإن أول عقبة يمكن أن يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة العقلية تتمثل في حدوث قصور في تجهيز المعلومات من جانبهم حيث تعاق قدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات، أو القيام بالعمليات المختلفة عليها، أو إنتاج مثل هذه المعلومات. كما أن تلك الإعاقة تستتبعها بالضرورة عدة أمور لها مغزاها ودلالاتها في هذا الإطار حيث تترتب عليها وتمثل انعكاساً لها، وهذه الأمور هي:

- ١- عدم قدرة الطفل على أن يحيا بشكل مستقل.
- ٢- عدم قدرته على إتباع التوجيهات والتعليمات المختلفة.
- ٣- عدم قدرته على القيام بترتيب المعلومات أو البيانات المختلفة.
- ٤- عدم قدرته على تصنيف تلك المعلومات أو البيانات.
- ٥- تدني مهاراته الاجتماعية.
- ٦- قصور مهاراته التنظيمية.
- ٧- عدم قدرته على الاختيار أو ما يعرف بالقدرة على اتخاذ القرارات المختلفة.

ومن هذا المنطلق فإن الإعاقة العقلية تعد بمثابة أي حالة يتدنى فيها مستوى الأداء الوظيفي العقلي للطفل إلى الدرجة التي تصل به إلى القصور في هذا الجانب إضافة إلى القصور في سلوكه التكيفي، وهو ما يمكن التأكد منه عن طريق استخدام المقاييس الخاصة بذلك. ومن المعروف أن هناك حالات عديدة يبدو أداء الطفل الوظيفي العقلي عاملاً أساسياً فيها، إلا أن الواقع وما تظهره الإحصاءات العديدة كتلك التي صدرت عن الاتحاد القومي لدراسات وبحوث التوحد بالولايات المتحدة الأمريكية NAAR (٢٠٠٣) تؤكد أن هناك ثلاثة أنماط أساسية من هذه الإعاقات أي تعتبر هي الأكثر انتشاراً مع وجود أنماط أخرى أقل انتشاراً، ويمكن ترتيب تلك الأنماط الأكثر انتشاراً بحسب نسبة انتشارها فيأتي التخلف العقلي في البداية، يليه اضطراب التوحد، ثم متلازمة أعراس داون. وجدير بالذكر أن كل أنماط الإعاقة العقلية تتميز بضرورة توفر شروط التخلف العقلي فيها دون الحاجة إلى وجود التخلف العقلي معها ككيان مستقل لدى نفس الفرد في نفس الوقت وهو الأمر الذي يعني وجود تداخل بين تلك الإعاقات. وبالتالي يمكن تشخيصها باستخدام اختبارات ذكاء للأطفال، واختبارات للسلوك التكيفي مع الملاحظة في بعض الحالات. وعلى هذا الأساس نجد أن كل إعاقة من تلك الإعاقات تتطلب توفر ثلاثة شروط أساسية وفق ما ورد في الطبعة الرابعة من دليل التصنيف التشخيصي والإحصائي للأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية DSM-IV الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي (١٩٩٤) APA هي:

- ١- أن يقل الأداء الوظيفي العقلي للطفل بشكل يدل على وجود قصور فيه، وهو ما يجعله ينعكس سلباً على مستوى ذكائه فيصل ٧٠ أو أقل على أحد مقاييس الذكاء الفردية للأطفال.
- ٢- أن يعاني الفرد كذلك من قصور في تلك المهارات التي تتعلق بسلوكه التكيفي وترتبط به مما يؤدي بالضرورة إلى قصور في سلوكه التكيفي.
- ٣- أن تحدث مثل هذه الإعاقة خلال سنوات النمو، وبالتحديد خلال طفولة الفرد أي قبل انتهاء مرحلة الطفولة المتأخرة.

مشكلات المعاق عقلياً:

أ-مشكلات اجتماعية:

اتجاهات المجتمع الخاطئة نحو المعاقين عقلياً تعتبر أخطر من الإعاقة نفسها ومن أمثلتها:

- ١- إطلاق بعض الألقاب -الاستهزاء- السخرية.
- ٢- الحماية الزائدة.
- ٣- القسوة الزائدة.

ب-مشكلات أسرية:

- ١- نظرة الوالدين للطفل المعاق على أنه عقاب من الله لهم على أخطاء سابقة.
- ٢- إنكار / رفض بعض الوالدين إعاقة أبنائهم.
- ٣- خلل الوالدين من وجود طفل معاق لديهم.

ج-مشكلات تربوية :

- ١-نقص الإمكانيات والأجهزة اللازمة لتعليم هذه الفئة.
- ٢-نقص المعلمين المؤهلين لرعاية هذه الفئة.

د-مشكلات مهنية:

- ١-نقص فرص العمل أمام المعاق عقلياً.
- ٢-نظرة أصحاب العمل للمعاق بأنه أقل إنتاج.

قائمة المحتويات

مشكلات انفعالية:

- ١- الشعور بعدم الرضا والخوف والإحباط والنقص.
- ٣- ضعف الخدمات الإرشادية للمعوقين ذهنياً.

ويجعل الضعف العقلي الإنسان المعاق عقلياً عرضة لمشكلات إجتماعية وانفعالية مختلفة، ولا يعود ذلك إلى الضعف العقلي فحسب ولكنه أيضاً إلى اتجاهات الآخرين نحو المعاقين عقلياً وطرق تعاملهم لهم وتوقعاتهم منهم، وهذه الاتجاهات والتوقعات تؤدي إلى تدني مفهوم الذات لديهم لما مروا به من إخفاق وفشل (جمال الخطيب ومنى الحديدى، ٢٠٠٩، ٢٥٣).

وتعد المشكلات الانفعالية لدى الأطفال المعاقين عقلياً من أكثر المشكلات لديهم، وتظهر في عدم قدرتهم علي ضبط دوافعهم وغرائزهم وعدم استقرارهم الانفعالي (سهير كامل أحمد، ٢٠٠٥، ٩٥)، كذلك يميلون إلى العزلة والانسحاب من المواقف الاجتماعية، والشعور بالدونية والإحباط، وضعف الثقة بالنفس، وانخفاض تقدير الذات، والمفهوم السلبي عن النفس (عبدالمطلب القريطي، ٢٠٠٥، ٢١٩).

خامساً: اضطرابات التواصل (اضطراب التوحد):

تمهيد:

شهدت الساحة العلمية منذ النصف الأول من القرن الماضي اكتشاف أحد أهم الاضطرابات النمائية التي أثارت جدلاً على كافة المستويات منذ اليوم الأول لاكتشافه، وهو اضطراب التوحد، حيث اعتبره البعض فصاماً، واعتبره البعض الآخر اضطراباً سلوكياً، وأخيراً تمت النظرة إليه على أنه اضطراب نمائي عام منتشر يؤثر سلباً على العديد من جوانب نمو الطفل (عادل عبد الله محمد، ٢٠١٤: ٤٥).

ويعد التوحد إعاقة نمائية ذات تأثير شامل على كافة جوانب النمو تظهر على الأطفال خلال الثلاث سنوات الأولى من العمر، ويحدث نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومات ومعالجتها بواسطة المخ، ويتأثر التفاعل الاجتماعي بالسلب وقد يصل الأمر للغياب التام للغة بسبب اضطرابات في مهارات التواصل، وتكمن في عدم القدرة على التعبير عن الذات تلقائياً وبطريقة ملائمة، وعدم القدرة على فهم ما يقوله الآخرين. كما يعاني الأطفال ذوي اضطراب التوحد في المقام الأول من قصور في التواصل الاجتماعي وغالباً ما يظهرون نطقاً محدوداً من تعبيرات الوجه. وعادة لا يتم توظيف ذلك بشكل جيد مع محتوى الحوار ويفشلون في مشاركة الآخرين المتعة أو الاهتمامات أو التجارب العاطفية، وبالتالي فإن المحادثات لديهم غالباً ما تكون محدودة فيظهر لديهم شعور بالاغتراب النفسي، كما أنهم يعانون من نقص في واحدة أو أكثر من المتطلبات الأساسية للتواصل حيث يواجهون صعوبات تشير إلى عدم اكتسابهم العديد من المفاهيم الضرورية، لذا فإنهم لا يستطيعون الحديث عنها، بالإضافة إلى عدم وعيهم بالحاجات الخاصة بهم (حسام الدين جابر السيد، ٢٠١٨).

وتعد اضطرابات التواصل الاجتماعي من الملامح الأساسية لأطفال التوحد ومن أهم الأعراض المميزة لهم، ومعيار مهم في عملية التشخيص (تيسير كوافحة وعمر عبد العزيز، ١٦٧، ٢٠٠٣). والذاتوية هي حالة طويلة المدى يمكن أن تتحسن مع الوقت من خلال التعليم المناسب ومن خلال تنمية مهاراتهم الاجتماعية لخفض الشعور بالاغتراب الاجتماعي، كما يحتاج هؤلاء الأطفال إلى مجهود حتى يصلوا إلى مرحلة التكيف (عادل عبد الله محمد، ٢٠٠٨، ١٢٤)، وتشير "زينب محمود شقير" (٢٠١٤، ٤٩) إلى أن هناك مجموعة من ردود الفعل الانفعالية لدى الأطفال الذاتويين، مثل نقص المخاوف من الأخطار الحقيقية، وقد يشعر بالذعر من الأشياء غير الضارة أو مواقف معينة، وليس قدرة عالية على فهم الأشخاص من حوله فقد يضحك لوقوع شخص أمامه، وقد يتعرض لنوبات بكاء وصراخ دون سبب واضح، أي أن هناك تقلب مزاجي مرتفع لديه. ويرى "مورين اورتر Maureen Orter" (٢٠٠٥، ٩٩) أنه لا يمكن للطفل التوحدي إدراك مشاعره أو مشاعر المحيطين به ولن يمكنه اكتساب قدر من الفهم والاستيعاب ويظهر ذلك خلال العمليات المعرفية السلوكية التي يقوم بها الطفل التوحدي، والتي لا تتيح لهم الاستمتاع بحياتهم بشكل أكبر.

وقد تعددت المصطلحات ما بين الذاتوية والتوحد- ذكرها عبد العزيز السيد الشخص (٢٠١٢) في عدة كتب ورسائل أشرف عليها على أنها "توحد"- كما أن العديد من البحوث تناولت اللفظين كمترادفين (في: إيمان عبد الوهاب محمود، ٢٠١٥)، إلا أن البعض يفضل استخدام مصطلح "توحد" لذيوعه وانتشاره وألفة الناس بالاسم حتى أن مراكز عديدة استخدمت لفظ الطفل التوحدي عن لفظ الطفل الذاتوي، وقد استخدمت عدة الكتاب مصطلح "التوحد" الأكثر شيوعاً وانتشاراً.

ويرى كل من (Begeer, Koot, Rieffe, Terwogt & Stegge, 2001) أن التعبير عن الحالة العاطفية يؤثر على التفاعل الاجتماعي فهو إشارة للحالة الداخلية التي تحدث التفاعلات من البيئة الاجتماعية، على سبيل المثال البكاء

قائمة المحتويات

في الأطفال يتبعه سلوك الحمل والاحتضان من قبل الآباء، وبالمثل الضحك والابتسام يدفع الآباء لإعادة السلوك الذي دفع الطفل للابتسام، ويعتبر البكاء هو أول تعبير يقوم به الإنسان بعد الميلاد ثم يبدأ الطفل في إنتاج انفعالات أخرى للتواصل ولفت ومشاركة الآخرين باستجابات مناسبة.

ويعتبر تعريف الجمعية الأمريكية للذاتوية (٢٠٠٠) من أهم التعريفات التي نظرت له كنوع من الاضطرابات في تطور نمو الطفل تظهر خلال السنوات الثلاثة الأولى من العمر، نتيجة لاضطرابات عصبية فسيولوجية تؤثر على وظائف المخ، وتؤثر على مختلف نواحي النمو سواء الاجتماعية التواصلية، العقلية الانفعالية والسلوكية، وتستمر هذه الاضطرابات التطورية مدى الحياة، ولكنها تتحسن نتيجة البرامج العلاجية، والتدريبات التربوية المقدمة للطفل. كما أن لإعاقتهم تأثير شامل على كافة جوانب نمو الطفل إلا أن أكثر جوانب القصور وضوحاً في هذه الإعاقة هو الجانب الاجتماعي، حيث أن الطفل التوحدي غير قادر على التفاعل الاجتماعي وتكوين علاقات مع الأقران، مما يترتب عليه العديد من المشكلات كأن يصبح الطفل في حالة من العزلة والوحدة الدائمة. وبمراجعة التراث النفسي في هذا المجال ومراجعة الدراسات السابقة وجد أن نسبة الإصابة بالتوحد عالمياً تقدر من ٧:٥٪ في كل عشرة آلاف مولود (في: سهير محمود أمين، ٢٠٠٢).

ويعد القصور في المهارات الاجتماعية من الموضوعات الهامة المؤثرة على سلوك الطفل، ويزداد هذا الأمر أهمية لدى الطفل الذاتوي لتأخره في اكتساب الخبرات الحسية بشكل غير متناسق مع المثيرات البيئية، مما يؤدي لمزيد من العزلة الاجتماعية لديه، وهذا ما أشار إليه كل من "محمد صالح الأمام وفؤاد عيد الجوالده" (٢٠١١، ٢٣) إلى أن العزلة الاجتماعية هي صفة لدى أطفال اضطراب التوحد حيث أنهم يعزلون أنفسهم حتى ولو كانوا في مكان مليئ بالناس مقارنة بالأطفال العاديين.

كما تعد مهارات الحياة اليومية مهارات مهمة لا بد أن يتعلمها الطفل التوحدي، لأنها مهارات اجتماعية تساعده على أن يكون قادراً على المشاركة في الأنشطة اليومية، كما تزيد من استقلاليته واعتماده على جملة من الإجراءات السلوكية الإيجابية، والبعد عن الشعور بالاغتراب الاجتماعي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم تزويد أطفال تلك الفئة بخبرة عملية يتم فيها تعلم المهارات الاجتماعية من خلال تتابع روتيني مع التركيز على تبديل السلوكيات غير المقبولة والسلبية والتي تعتبر سلوكيات شائعة بالنسبة للمصابين بالذاتوية.

وقد ظهرت العديد من المحاولات والتدخلات الإرشادية المقدمة للأطفال الذاتويين والتي انشقت عن فلسفات مختلفة وتشمل هذه المحاولات العديد من التدخلات السلوكية والتدخلات النمائية والتدخلات السلوكية المعرفية. وتتفق كل من "فوزيه الجلامدة ونجوي حسين" (٢٠١٥) أن تعبير الأطفال الذاتويين عن مشاعرهم وانفعالاتهم من المشكلات الرئيسية، إذ أن الفهم الكامل للمفاهيم المعنوية مثل المشاعر والأحاسيس أو حتي الألم أو التعبير عنه يعد صعب للغاية وكنتيجه حتمية لتلك الاضطرابات، إذا لم يتم تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال لتطوير المهارات الاجتماعية والانفعالية التي تتلائم معهم لمساعدتهم في التعبير عن مشكلاتهم الانفعالية، وحالتهم النفسية في المراحل اللاحقة من الحياة. ويعتبر العامل الرئيسي الذي يكمن خلف العديد من مشكلات هؤلاء الأطفال هو عدم قدرتهم علي السيطرة علي انفعالاتهم وعدم القدرة على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، مما يعوق قدرتهم علي إدارة انفعالاتهم حسب الموقف. ويرى "إبراهيم عبد الله الزريقات" (٢٠٠٤، ١٦٨) أن هناك أهمية لتنمية المهارات الانفعالية والاجتماعية في حياة الطفل الذاتوي حيث تساعده في النمو والتفاعل السليم، لذلك تعد الذاتوية من أشد الإعاقات التي تبدأ من ميلاد الطفل، وتستمر معه حتي مماته ولا ينجو منها أو تتحسن أوضاعه إلا بنسبة لا تتعدى (٢٠٪-٣٠٪) ويقتصر ذلك علي الحالات الخفيفة التي تعاني من الذاتوية دون أي إعاقة أخرى (Lederman, 2005:24). وتؤكد

قائمة المحتويات

منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار (World Health Organization, 2017:3) شخص في العالم لديهم شكل من أشكال الإعاقة، وهذا يمثل قرابة (١٥٪) من سكان العالم، ويوجد ما بين (١١٠-١٩٠) مليون شخص لديهم صعوبات كبيرة للغاية في العمل، مما يشير إلى تزايد أعداد المعاقين في العالم بشكل ملحوظ وكبير خاصة في الأونة الأخيرة من عصرنا الحديث، كما برز هنا الاهتمام الكبير بفئات المعاقين علي كافة المستويات، كما أن (٨٠٪) من المعوقين معظمهم من بلدان العالم الثالث والبلدان النامية (حسام الدين جابر السيد، ٢٠١٨)، وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (٢٠١٩) إحصاءات تشير إلى نسب الأشخاص ذوي الإعاقات بالدول العربية وأن أكبر نسبة من ذوي الإعاقة في المغرب ٥,١٪، تليها السودان ٤,٨٪، وتراوح النسبة بين (٢-٣٪) في كل من مصر والبحرين وفلسطين واليمن، وبلغت النسبة أقل من ٢٪ في باقي الدول. وتقدر نسبة انتشار التوحد بمعدل واحد لكل ١١٠ طفل (Barnard, 2002:11)، وترتفع نسبة الإصابة بين الذكور بمقدار ٤:١ عند الإناث (في: خالد المهدي، ٢٠٠٨، ١٠)، وهو منتشر في جميع بلدان العالم وأسبابه غير معروفة بوجه قطعي، ولا يوجد شفاء تام منه، وهو باق مع الطفل مدى الحياة (رندا الخطيب، ٢٠٠٩، ١٣؛ جابى كيفوركين، ٢٠١٠، ٦).

والتوحد هو: أحد أهم الإعاقات النمائية (Pervasive Development Disorder) ويتميز بضعف حاد في التواصل والمهارات الاجتماعية والسلوكيات التكيفية، وتظهر علاماته قبل سن الثالثة، ومعظم الأطفال التوحديين يسجلون درجات أقل من المتوسط في اختبارات الذكاء، ويظهرون صعوبات في التخطيط والقدرة اللفظية وتعميم الاستجابات، إلا أن هؤلاء الأطفال قد يفوقون الأطفال العاديين في بعض المهارات مثل تصميم المكعبات، كما يمتلكون ذاكرة ممتازة وأحياناً يظهرون قدرات فائقة في الموسيقى والرسم (أحمد السيد سليمان، ٢٠١٠، ١٢).

ويندرج التوحد تحت ما يسمى بالاضطرابات الارتقائية أو اضطراب طيف التوحد Autism Spectrum Disorder والتي تشمل خمسة اضطرابات، إضافة إلى التوحد، منها: الاسبرجر، واضطراب الطفولة التحولي، والاضطراب الارتقائي غير المحدد، وقبل إصدار التشخيص الإحصائي الخامس كان اضطراب "ريت" يندرج معهم تحت هذه المظلة الشاملة، ولكن بعد اكتشاف الجين المسبب لهذا المرض مؤخراً، خرج من نطاق اضطرابات طيف التوحد. واضطراب طيف التوحد يتضمن إعاقة نوعية في التفاعل الاجتماعي والتواصل، بالإضافة إلى ظهور أنماط سلوكية نمطية ومتكررة ومحدودية في الاهتمامات والنشاطات. كما أنه من الاضطرابات النمائية التي انتشرت في العقود الأخيرة، مع غياب الأسباب التي تؤدي لهذا الاضطراب، لكن الجهود العالمية تبحث عن الأسباب من أجل رفع هذا التحدي عن كاهل الآباء والأطفال أنفسهم (محمد موسى، ٢٠٠٧، ٢٣؛ وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ٩).

وتُعد التوحدية بمثابة متلازمة أو جملة أعراض لها بعض المظاهر الإكلينيكية، منها اضطراب الانتباه والإدراك، وضعف في القدرة على الاختلاط بالواقع، وضعف في العلاقات الاجتماعية، واللغة، والسلوك الحركي، كما يتميز بجملة أعراض تمثل ثلاثة اضطرابات سلوكية وهي: اضطرابات عامة في التفاعل الاجتماعي، اضطرابات في النشاط التخيلي والقدرة على التواصل، انغلاق على الذات وضعف الانتباه المتواصل للأحداث الخارجية (حسنى حلواني، ١٩٩٦).

وبعد فئة أطفال التوحد Autism في مقدمة تلك الفئات الخاصة التي تحتاج إلى رعاية وتدريب وتأهيل يؤدي إلى زيادة كفاءة من يعانون منها، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتقويم سلوكهم من أجل التمهيدي، لعودتهم مرة أخرى للتفاعل مع أقرانهم العاديين والانصهار في بوتقة المجتمع، وإذا كانت فئة المعاقين عقلياً قد نالت قسطاً معقولاً من البحث والدراسة، فإن فئة التوحديين لم تنل حظها في هذا الإطار، وذلك على مستوى مصر والوطن العربي على الأقل، حتى إننا نادرًا ما نجد مركزاً متخصصاً لتلك الفئة من الأطفال، وغالبًا ما يتم إلحاقهم مع أقرانهم المعاقين عقلياً بمدارس التربية الفكرية (عادل عبدالله محمد، ٢٠٠٨، ١٢١).

قائمة المحتويات

كما يعتبر التوحد شكل من أشكال الاضطرابات السلوكية التي يحوطها الكثير من الغموض سواء في أسباب الإصابة بهذا الاضطراب أو أساليب تشخيصه أو طرق علاجه. وتعانى العيادات النفسية المصرية من قصور واضح في أساليب تشخيص هذا الاضطراب، حيث أنهم قد يشخصوا الأطفال على أنهم مصابون بالتخلف العقلي، رغم أن دليل التشخيص الإحصائي الثالث المعدل DSM III-R لا يدرج التوحد تحت تصنيف التخلف العقلي ولكنه يصنفه ضمن الاضطرابات السلوكية، ومن ثم فهناك فروق واضحة بين التخلف العقلي والتوحدية (عمر بن الخطاب خليل، ١٩٩٤: ٦٣-٦٤).

ومنذ فترة طويلة أدى عدم الاتفاق على تعريف هذا الاضطراب، وتحديد أسبابه، وعدم وجود معايير تشخيصية محددة وصريحة إلى جعل عملية التشخيص صعبة إلى حد كبير، مع ذلك فإن التطورات التي تحققت خلال العشرين سنة الأخيرة، قد زادت من فهمنا للتوحد، وقادت إلى مزيد من الاتفاق بين المتخصصين، وهذأت من خوف الناس إزاء عملية التشخيص، ومع أن أسباب الاضطراب مازالت غير معروفة بالتحديد إلا أن معظم المتخصصين يتفقون على أن اضطراب التوحد يتضمن مجموعة من الاضطرابات السلوكية المحددة بوضوح (محمد عبد الرحمن ومنى خليفة، ٢٠٠٤، ٩٠).

مفهوم التوحد: Autism

يعود مصطلح التوحدية إلى أصل كلمة إغريقية (يونانية) تعني أوتوس (Autous) وتعني النفس أو الذات، ولم يتفق العالم العربي بعد علي تعريف موحد لهذا المصطلح حتى الآن، فبعض الباحثين يستخدم لفظ الذاتوية كتعريب لهذا المصطلح (محمد محمد عوده، ٢٠١٥، ٢٩).

وهو قصور أو توقف في نمو الإدراك الحسي واللغة وبالتالي في نمو القدرة علي التواصل والنمو المعرفي والاجتماعي، ويصاحب ذلك نزعة انطوائية وانغلاق علي الذات مع جمود عاطفي ويصبح كأن جهازه العصبي قد توقف تماما عن العمل، كما لو كانت توقفت حواسه عن إرسال أو استقبال أية مثيرات خارجية أو التعبير عن عواطفه وأحاسيسه وأصبح الطفل منغلقا علي ذاته في عالمه الخاص (يوسف القريوتي، عبد العزيز السرطاوي، جميل الصمادي، ٢٠٠٢).

وتعرف الجمعية الأمريكية الذاتوية "بأنها إعاقة في النمو تتصف بكونها مزمنة وشديدة وهي تظهر في السنوات الثلاث الأولى من العمر وهو محصلة لاضطراب عصبي يؤثر سلباً علي وظائف الدماغ (مني الحديدي وجمال الخطيب، ٢٠١٨: ٢٨٤).

وبالرغم من أن مصطلح "التوحد" هو الأكثر انتشارا واستخداما، فلا يعني ذلك أنه الأكثر دقة في التعبير عن مضمون هذه الإعاقة، حيث يري "محمود حموده" أن إطلاق اسم التوحد على الأوتيزم ليس صائبا وذلك لسببين: أولهما: أن الترجمة لكلمة Autism ليست التوحد، ولكنها الذاتوية لأنها أصلا مشتقة من auto بمعنى ذاتي، وثانيهما: أن كلمة توحد هي ترجمة Identification وهي حيلة دفاعية وضعها "فرويد" في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، ثم جاء اكتشاف "ليوكانر" للحالات الذاتوية في عام ١٩٤٣م، أي بعد أن كانت كلمة توحد قد أعطيت للحيلة الدفاعية المذكورة، فلا يصح إعطاؤها لكلمة أوتيزم كترجمة لها، ويؤكد "إبراهيم محمود" صحة رأي "حموده" إلا أنه يميل إلى استخدام كلمة التوحد بدلا من كلمة الذاتوية كترجمة للفظة الإنجليزية Autism، ذلك أن كلمة التوحد يسهل تناولها واستخدامها من قبل الأطباء والمتخصصين وكذلك الآباء والأمهات وجميع المعنيين بهذه الإعاقة (في: إبراهيم محمود بدر، ٢٠٠٤، ١٩-٢١).

قائمة المحتويات

وهناك العديد من التعريفات التي حاولت وصف هذا الاضطراب، حيث أشارت معظمها إلى المظاهر السلوكية لدى أطفال التوحد، فقد تم وصفهم بالانعزال، والانسحاب، والنمو غير السوي، وعدم النجاح في إقامة علاقات مع الآخرين (مصطفى نوري، محمد صالح، ٢٠٠٦، ٣٦٣).

ويعرف القانون الأمريكي لتعليم الأفراد المعاقين Individuals With Disabilities Education on Act التوحد بأنه "إعاقة تطويرية تظهر بشكل ملحوظ على التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي"، وتظهر هذه الأعراض بشكل ملحوظ قبل سن الثالثة من العمر، بالإضافة إلى انشغال الطفل بالنشاطات المتكررة والحركات النمطية، ومقاومته للتغيير البيئي أو مقاومته للتغيير والروتين اليومي، إضافة إلى الاستجابات غير الاعتيادية أو الطبيعية للخبرات الحسية (في: إبراهيم الزريقات، ٢٠٠٤، ٢٢)، كما جاء تعريف الجمعية الأمريكية للتوحد American Society of Autism مطابقا للتعريف المقترح من قبل "ريتفو وفريمان Ritvo & Freeman" والذي يشير إلى أن الذاتية تحدث قبل ثلاثين شهرا ويتضمن اضطرابا في النمو، والاستجابات الحسية للمثيرات، والكلام واللغة، والقدرات المعرفية، وتعلق غير عادي في الناس والأحداث والأشياء (في: محمد محمد عوده، ٢٠١٥، ٣١-٣٢).

وتعرف الجمعية الأمريكية للتوحد Autism Society of America (ASA) التوحد بأنه: نوع من الاضطرابات التطورية، التي تظهر خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وتكون نتيجة لاضطرابات نيورولوجية (عصبية) تؤثر على وظائف المخ، وبالتالي تؤثر على مختلف نواحي النمو، فيجعل الاتصال الاجتماعي صعب ويجعل عندهم صعوبة في الاتصال سواء كان لفظيا أم غير لفظي، وهؤلاء الأطفال يستجيبون دائما إلى الأشياء أكثر من الاستجابة إلى الأشخاص، ويضطرب هؤلاء الأطفال من أي تغيير يحدث في بيئتهم، ودائما يكررون حركات جسمانية أو مقاطع من الكلمات بطريقة آلية متكررة (في: مصطفى نوري، محمد صالح، ٢٠٠٦، ٣٦٣).

ويعرفه عادل عبدالله (٢٠٠٣، ٤٦) بأنه "وجود خلل في التفاعلات الاجتماعية، والتواصل، واللغة، واللعب التخيلي، وذلك قبل أن يصل الطفل إلى سن الثالثة، إلى جانب السلوكيات النمطية، ووجود قصور أو خلل في الاهتمامات والأنشطة". ويعرفه الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية (American Psychiatric Association, 2013) بأنه "حالة من القصور المزمن في النمو الإرتقائي للطفل، يتميز بانحراف وتأخر في نمو الوظائف الأساسية المرتبطة بنمو المهارات الاجتماعية واللغوية، وتشمل: الإنتباه، والإدراك الحسي، والنمو الحركي، وتبدأ هذه الأعراض في مرحلة الطفولة المبكرة ما بين ٣٠:٤٢ شهرا من العمر".

كما عرفه عدد من الباحثين بأنه "أحد الاضطرابات النمائية الذي يتصف بضعف في العلاقات الاجتماعية، والتواصل، والأداء اللغوي، والالتزام بمجموعة من السلوكيات والأهداف، كما يختلف الأطفال المصابون بالذاتوية من حيث شدة الأعراض، وطرق التعبير في مواقف الحياة" (Dawson, 2008, 137; Barnard, 2002, 56-58). وهو أحد الاضطرابات التطورية المنتشرة والتي تظل متزامنة مع الطفل مدى الحياة وتؤثر بشكل كبير على مهارات التفاعل الاجتماعي، والسبب الرئيسي في هذا الاضطراب عوامل وراثية قوية واضطرابات عصبية حيوية وأوصت العديد من الدراسات بالاهتمام بالأطفال عند ظهور هذا الاضطراب والتشخيص الدقيق والتدخل المبكر لأهميته في العلاج (Dyches, 2010).

ويعرف "مورين أرونز - تيسا جيتنس (Morin-Teesa, 2008, 7) مرض التوحد Autism بكونه: عبارة عن اضطراب في القدرة المعرفية مصحوب ببعض الاضطرابات في الناحية النفسية والحيوية، مما يجعل له عظيم الأثر على جميع نواحي تطور الجانب الاجتماعي للفرد.

قائمة المحتويات

ويعرفه "محمد عدنان" أنه: عجز يعيق تطوير المهارات الاجتماعية، والتواصل اللفظي، واللعب التخيلي والإبداعي، وهو نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ، مسببة مشكلات في المهارات الاجتماعية، تتمثل في: عدم القدرة على الارتباط وخلق علاقات مع الأفراد، وعدم القدرة على اللعب، واستخدام وقت الفراغ، وعدم القدرة على التصور البناء، والملاءمة التخيلية" (في: أحمد فهمي السحيمي، ٢٠١١، ٢٥).

وتعرفه "آن نرفانا Anne Narfarina" بأنه "اضطراب في مركب السلوك العصبي المعروف بالخلل في التفاعلات الاجتماعية المتبادلة والخلل في الاتصال، وكذلك وجود أنواع في السلوكيات النمطية والاهتمام بالنشاطات المتكررة الدائمة" (في: مروة جمعة، ٢٠١٢، ٢١-٢٢).

ويتضح مما سبق ارتباط التوحد بالاضطراب في التواصل اللغوي بصفة خاصة، والتواصل الاجتماعي بصفة عامة (سيد أحمد، ٢٠١٣، ٢١٨).

النظريات المفسرة لاضطراب الذاتوية(التوحد):-

- النظرية النفسية Psychological Theory:

قامت النظرية النفسية على الاعتقاد السائد فيها بأن عدم دراية الوالدين وإهمالهم وعدم العناية بتربية الأبناء يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة باضطراب التوحد، ومن المؤيدين لهذا التفسير العالم "برونو بيتلهم"، حيث كان يقوم بنقل الأطفال ذوي اضطراب التوحد للعيش مع عائلات بديلة كأسلوب للعلاج، وحيث كان ذلك يبعث بالارتياح على أباء وأمهات الأطفال المصابين باضطراب التوحد(أسامة فاروق مصطفى والسيد كامل الشربيني، ٢٠١٦، ٥٩).

- نظرية العقل: Mind Theory

يؤكد "بارون كوهين وآخرون" (Baron Cohen, et al., 1985: 39) أن هناك سبب في الاعتقاد بأن الأطفال ذوي اضطراب التوحد يفتقرون إلى نظرية العقل، وقد تم اختيار هذه الفرضية باستخدام نموذج دمية في اللعب وتم التجانس بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وهي مجموعة من أطفال اضطراب الداون ومجموعة من أطفال اضطراب التوحد في العمر، وقد أظهرت مجموعة أطفال اضطراب التوحد فشلاً في اختبار الاعتقاد رغم أن لديهم عمر عقلي أعلى من المجموعة الضابطة، ويحدد هذا النموذج الآلية التي يكمن وراءها عنصراً حاسماً في نمو المهارات الاجتماعية، والقدرة على تصور الحالات الذهنية وفهم المعاني، والقدرة على تشكيل "تمثيلات من الدرجة الثانية وظهور اللعب الظاهري" (في: عبير السيد أحمد، ٢٠١٨، ٢٥٩).

- نظرية حجم المخ:

توصلت بعض هذه الدراسات إلى أن حجم المخ لدى التوحديين أكبر من أقرانهم غير المصابين بالمرض. كذلك فإن هناك مناطق في مخ الطفل التوحدي تعمل بصورة جيدة، وأخرى يوجد فيها خلل ما، والقائمون على تلك النظريات يرون أن التدخل المبكر من خلال البرامج الخاصة المصممة للأطفال التوحديين، من الممكن أن يؤدي إلى تنشيط المناطق التي يوجد فيها خلل، وإعادة تشكيل وظيفتها بصورة تقترب من الصواب، وذلك اعتماداً على مرونة المخ، وقدرته على التشكيل وفق الخبرات والتجارب المختلفة (منال القاضي، ٢٠٠٩، ١١).

قائمة المحتويات

- نظرية الذات: Self Theory

يرى "محمد صالح الامام وفؤاد عيد الجوالدة" (٢٠١١: ١٩٤) أن ذوى اضطراب التوحد لديهم قصور فى عدم القدرة على معالجة المعلومات المتعلقة بالانفعالات، والمعلومات المتعلقة بالآخرين فى نفس اللحظة، كما لو أن الاقتراب بالآخر يسبب غياب الذات، وتستمر المعلومات فى التراكم، ولكن كما لو أنها تراكمت ليس من قبل الذات ولكن من قبل حاسوب خالى من الذات، وهى تنقسم إلى نقص الوعى الجسدى، والمعالجة الأحادية والتي تتسبب فى مشكلات تتعلق بالآخرين، ووجود الآخر سبب غياب الذات.

ويرى "محمد على كامل" (٢٠٠٥) أن الأطفال ذوى طيف التوحد غالبًا ما يعانون من ضعف فى مستوى مهاراتهم الاجتماعية؛ حيث تكون درجاتهم فى الغالب منخفضة على مقاييس المهارات، وهذا يؤدي-بجانب عوامل أخرى- إلى حدوث العديد من المشكلات التي تتعلق بالاتصال والتواصل والاستقلال، كما أنها قد تؤدي فى الوقت ذاته إلى حدوث بعض اضطرابات السلوك، كالعدوان والعناد وفرط النشاط والتدمير وإيذاء الذات، والذي قد ينتج جزئيًا عن حالة الاندفاعية التي يتسم بها هؤلاء الأطفال، وهذا يزيد بطبيعة الحال من احتمالات توقع الفشل في التفاعل الاجتماعي والشعور بالاغتراب الاجتماعي.

أعراض اضطراب التوحد:

هناك العديد من الأعراض التي تميز الطفل التوحدي هي:

- يجذب الطفل التوحدي فى العادة إلى نشاط واحد أو نشاطات محدودة بصورة مكثفة.
- قد يتمسك بطقوس بعينها ويكررها.
- قد يهتم بأجزاء محددة من الأشياء أكثر من اهتمامه بالشيء نفسه.
- قد يقوم بحركات مكررة غير مبررة مثل رفرفة اليدين (منال القاضى، ٢٠٠٩، ٢١).

- خصائص الأطفال التوحديين:

يحدد المركز الطبي بمدينة "ديترويت" الأمريكية Detroit Medical Center عددًا من السمات التي تميز الأطفال التوحديين وذلك فى المجالات الآتية:

- ١- العلاقات الاجتماعية: قد يفشل الطفل التوحدي فى التفاعل مع القائمين على رعايته، وتكوين صداقات، كما أنه لا تبدو عليه السعادة أبدًا، وتقل استجابته للإشارات الاجتماعية كالتواصل بالعين أو الابتسام مثلاً.
- ٢- السلوكيات: يحدث سلوك متكرر من جانب الطفل، مثلاً: أن يستمر فى نقل دمية من إحدى يديه إلى اليد الأخرى، أو يمشي فى أرجاء الحجرة يتحسس الحوائط، كما يفتقر بشكل واضح إلى الوعى بالأمان، وتنتابه نوبات غضب وبكاء مستمرة دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك.
- ٣- التواصل: يلحظ على الطفل أن لغته تنمو ببطء أو لا تنمو على الإطلاق، كما أنه يستخدم الكلمات دون أن يكون لها معنى، وغالبًا ما يقوم بتكرار غير ذي معنى لكلمات أو عبارات ينطق بها شخص آخر، وفي أغلب الأحيان يستخدم الإشارات بدلاً من الكلمات.
- ٤- العمليات الحسية والإدراكية: قد يبدو الطفل التوحدي وكأنه أصم، حتى وإن كانت قدرته على السمع عادية، وإذا ما تمت مضايقته قد يلجأ إلى الضوضاء الشديدة، وقد يضع أصابعه فى أذنيه أو يغطيها عند سماع أصوات معينة، وغالبًا ما يجذب إلى الموسيقى، كما قد تتأثر حواسه للمثيرات المختلفة إلى درجة أقل أو أكبر بكثير من أقرانه وهو ما يعد بمثابة ردود فعل غير عادية للإحساسات المادية.

قائمة المحتويات

٥- اللعب: يتسم الطفل بنقص أو قصور في اللعب التلقائي أو التخيلي، كما لا يبدي أي مبادرات للعب التظاهري، ولا يقلد أفعال الآخرين (في: عادل عبدالله محمد، ٢٠٠٨، ٢٦٢: ٢٦٤).

كما أوضحت نتائج العديد من البحوث والدراسات أن الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد يتصرفون بالآتي: قصور في المهارات الاجتماعية مثل: المشاركة، التعاون، حسن الاستماع أو الإنصات، ردود فعل غير مناسبة للمواقف التي يتواجدون فيها، بالإضافة إلى العزلة، وعدم الاهتمام بالآخرين، حيث أظهرت دراسة آمي إثيريبي (Etherby, Amy, 1984, 2) وجود قصور لدى الأطفال التوحديين في وظائف الاتصال الاجتماعي عن الأطفال العاديين، كما أكدت دراسة أونيل روبرت (Robert, O'Neill, 1987, 11) وجود قصور في التفاعلات البيئية للأطفال التوحديين مقارنة بالأطفال العاديين، وتوصلت دراسة بورك جاكوب (Jacob Burack, 1994, 3) إلى أن الانتباه البصري منخفض لدى هؤلاء الأطفال، ووجود عجز في الانتباه لديهم، وجاءت نتائج دراسة لوف ستيفن (Love Steven, 1994, 8) أن هناك انخفاض في مستوى إدراك التعبيرات العاطفية لديهم، كما أكدت دراسة كوني شويانج (Connie Shu-Ya Won, Wong, 2006) أن الأطفال التوحديين لم يشتركوا في اللعب معظم الوقت، كما أن سلوكيات الانتباه المشترك لديهم كانت أقل.

خصائص السلوك الاجتماعي لدى الأطفال ذوي طيف التوحد:

يختلف الأطفال التوحديون في درجة تأثرهم بإعاقة التوحد، وبالتالي مدى تطورهم مع مرور الوقت، ولكن "ليوكانر Leo Kanner" وصف تسع خصائص مشتركة بينهم هي:

- ١- انعزالية توحدية مفرطة (Extreme Autistic Aloneness).
- ٢- تأخر وانحراف في اللغة.
- ٣- المصاداة (Echolalia).
- ٤- ذاكرة قوية ومقدرة على الحفظ.
- ٥- حساسية مفرطة إزاء المؤثرات الخارجية.
- ٦- الرفض الشديد للتغيير وتنوع محدود للنشاط العفوي والتلقائي.
- ٧- قدرات إدراكية فائقة.
- ٨- مظهر جسدي طبيعي.
- ٩- عائلات تتميز بمستويات مرتفعة من الذكاء (في: وفاء علي الشامي، ٢٠٠٤، ٢٦: ٢٩).

وللأطفال ذو طيف التوحد خصائص انفعالية واجتماعية فهم أكثر عرضه للضغوط والقلق والخوف، وغالبا ما تكون ردود أفعالهم للبيئة والمواقف البيئية قوية، إلا أنهم يجدون صعوبة كبيرة في تنظيم انفعالاتهم عندما تتم إثارتهم، وغالبا ما تكون ردود أفعالهم ذاتية بدرجة كبيرة، خاصة في المواقف الجديدة، إلى جانب صعوبة التنظيم الذاتي لردود الأفعال (عادل عبدالله، ٢٠١٤، ١٤٣).

ولكن أبرز خصائص وأعراض التوحد هو: السلبيية في السلوك الاجتماعي، ويعتبر هو مفتاح تحديد خاصية التوحد، ويمكن تصنيف المشكلات الاجتماعية إلى ثلاث فئات: المنعزل اجتماعيا، وغير المبالي اجتماعيا، والأخرق اجتماعيا (محمد عدنان عليوات، ٢٠٠٧، ١٠١).

وغني عن البيان أن الأطفال التوحديين يعانون كما يشبر عادل عبد الله (٢٠٠٢، ٢٠٠٤) من قصور واضح في معدل نموهم المعرفي، وفي قدراتهم المعرفية المختلفة. كما أنهم من جانب آخر يعانون من قصور واضح في مجالات أخرى تعد بمثابة ثوابت أساسية يمكن أن نعرف هذا الاضطراب من خلالها هي القصور الاجتماعي،

قائمة المحتويات

والقصور في التواصل، والاهتمامات والميول والسلوكيات المقيدة والتكرارية والتي يمكن أن نعرض لها على النحو التالي :

١- قصور في نموهم الاجتماعي :

يتمثل هذا القصور في وجود صعوبات ومشكلات اجتماعية عديدة من جانبهم فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي عامة لدرجة تجعله يمثل في أساسه مشكلة اجتماعية . وتعتبر الصعوبات التي تواجههم في هذا الجانب كثيرة ومتعددة منها ما يلي:

- ١ - صعوبة إقامة العلاقات الاجتماعية المتبادلة .
- ٢ - قصور الانتباه المشترك من جانبهم .
- ٣ - عدم قدرتهم على التعاطف مع الآخرين .
- ٤ - صعوبة فهم القواعد الاجتماعية من جانبهم .
- ٥ - عجزهم عن الارتباط بالأقران .
- ٦ - عدم قدرتهم على التواصل البصري .
- ٧ - عدم قدرتهم على فهم تعبيرات الوجه .

٢- قصور في التواصل مع الآخرين :

يعاني هؤلاء الأطفال أيضاً من قصور في التواصل سواء لفظياً أو غير لفظي حيث أن هناك ٥٠ % منهم على الأقل لا تنمو اللغة لديهم على الإطلاق، وبالتالي لا يكون بمقدورهم استخدام اللغة في الحديث أو استخدامها للتواصل، أما النسبة الباقية فإنها تعاني من قصور واضح في نمو اللغة لديهم حيث يتأخر ذلك النمو بشكل ملحوظ، ولا يكون لديهم سوى بعض الكلمات القليلة، ومع ذلك لا يكون بإمكانهم استخدامها في سياق لغوي صحيح كي تدل على معناها الذي نعرفه نحن، أي أنهم لا يستخدمونها بشكل صحيح، كذلك فهم يعانون من اضطرابات عديدة ومختلفة في النطق. ومن ناحية أخرى فإن لغتهم التعبيرية expressive تتسم بالتكرار، والترديد المرضي للكلام echolalia ، والنطق النمطي لتلك الكلمات التي يعرفونها، وعدم القدرة على إجراء محادثات متبادلة مع الآخرين أي عدم القدرة على إقامة حوار أو محادثة معهم، وإبدال الضمائر، كما أن نغمة الصوت وإيقاعه من جانبهم يكونا غير عاديين، هذا بخلاف الاستخدام الشاذ أو غير العادي للإيماءات . ومن ناحية أخرى فإن لغتهم الداخلية Internal language أي قدرتهم على التظاهر أو اللعب التخيلي تمثل جانب قصور آخر لديهم. أما قدرتهم على الفهم والاستيعاب من جانب آخر فتكون محدودة جداً، كما أنهم يكونوا غير قادرين على فهم وإدراك المفاهيم المجردة .

٣- اهتمامات وميول وسلوكيات مقيدة وتكرارية :

فيما يتعلق باهتماماتهم وسلوكياتهم المقيدة والتكرارية فهي تتضح في أمثلة عديدة من بينها أن أنماط لعبهم تكون تكرارية ونمطية، وأنهم يقومون بجمع أشياء معينة غالباً ما تكون غير ذات قيمة أو جدوى لهم، ويضعونها في صف . كذلك فمن أهم الأمور التي تميزهم التعلق بأشياء غير عادية والانجذاب إليها، والانشغال الشديد بموضوعات أو أمور معينة، ومقاومة أي تغيير يمكن أن يطرأ على بيئتهم المحيطة حتى وإن كان مثل هذا التغيير بسيطاً، والإصرار على التمسك بروتين صارم في أداء الأشياء إلى جانب القيام بحركات نمطية معينة .

وجدير بالذكر أن التدخلات المختلفة وخاصة التدخلات الطبية أو الغذائية التي تتعلق بتحديد نظام غذائي معين يكون أثرها محدوداً، أما التدخلات الأخرى والتي تكون سلوكية في الغالب كما يرى عادل عبد الله (٢٠٠٢)

قائمة المحتويات

حتى مع استخدام المثيرات البصرية التي تسير وفق الاتجاهات الحديثة في هذا الصدد وفي مقدمتها جداول النشاط المصورة فإن نتائجها تتوقف على مستوى ذكاء الطفل وترتبط به في علاقة إيجابية . ولكن برامج التدخل المبكر Earlyintervention تسهم في الحد بدرجة كبيرة من تلك المشكلات المتباينة التي يعاني الطفل منها فتعكس آثارها على الأسرة أيضاً حيث أن عدم التعامل بفاعلية مع تلك المشكلات يقلب حياة الأسرة رأساً على عقب، ويجعلها لا تطاق، كما أن النجاح في التعامل معها من خلال تلك البرامج ييسر التفاعل بين أعضاء الأسرة، ويساعدهم في التغلب على تلك المشكلات التي يسببها الطفل . فالأطفال التوحديين يتسمون بعدم قدرتهم على فهم أن للآخرين وجهات نظرهم التي قد تختلف عما لديهم هم أنفسهم، وأن لهم خططهم وأفكارهم ومشاعرهم التي تتباين كثيراً عما يكون لديهم، إضافة إلى عدم قدرتهم على التنبؤ بما يمكن أن يفعلوه في مختلف المواقف الاجتماعية (Gillson, 2000).

وطفل التوحد ليس شرطاً أن يتصف بكل تلك السلوكيات السابقة، بل يكتسب بعضها، فكل طفل توحدي يختلف عن الآخر، وذلك حسب درجة التوحد لديه هل هو بسيط أم متوسط أم شديد، فهناك عوامل متعددة مسببة لاضطراب التوحد، وهذا يفسر التعدد الكبير لأعراض هذا الاضطراب من حيث الاختلاف بين الحالات المصابة وبين الأعراض المسجلة لكل منها؛ مما يجعل كل طفل توحدي حالة متميزة متفردة قائمة بذاتها تستدعي تشخيصاً فردياً كأساس لابد منه لتدخل علاجي ناجح (إبراهيم محمود بدر، ٢٠٠٤، ٥٢).

ويقترض "روبرت Robert" أن هناك شكلان مميزان للتوحد، يتصف الشكل الأول بوجود تلف ثنائي الجانب بالمخ، والذي يمنع الحفاظ والإبقاء على التركيب الأساسي الدلالي للغة والمهارات الاجتماعية والنشاط المنظم الهادف، ومثل هؤلاء الأطفال لا يستطيعون بناء تركيب للمعنى اللغوي، أما الشكل الثاني وهو الأكثر شيوعاً فلا يرتبط بتلف في المخ أو بأي أعراض عصبية أو محددات بيولوجية، بل هو مرتبط بالأمراض النفسية والوجدانية والأسرية، ويعتبر شكلاً من أشكال الاضطراب والخلل الوجداني (في: أحمد السيد سليمان، ٢٠١٠، ١٤-١٥).

ويتميز الأطفال ذوي طيف التوحد ببعض الخصائص السلوكية، والتي تمثل انحرافاً عن معايير السلوك السوي لأقرانهم العاديين ممن هم في مثل سنهم، مثل عدم قابليتهم للتعلم، وعدم قدرتهم على التعامل مع الآخرين؛ سواء كان ذلك في المدرسة أم خارجها، كما تظهر عليهم أعراض اضطرابات السلوك، وتختلف حدتها من طفل لآخر، ويتفق معظم المدرسين على ملاحظتها هي: توقع الفشل، عادات تعليمية خاطئة، انخفاض واضح في مستوى الإنجاز، والدافعية، غرابة السلوك وعدم اتساقه، قصور الانتباه، الافتقار إلى التركيز، تقلب حاد في المزاج، ضعف التأزر الحركي، ضعف في مستويات أو معدلات النشاط أو السلوك الاجتماعي (سليمان عبدالواحد، ٢٠١٠، ٢٠٧-٢٠٨).

أسباب التوحد:



على الرغم من عدم القدرة حتى الآن على تحديد سبب معين يعد هو المسؤول عن اضطراب التوحد فإن هناك بعض الآراء تذهب إلى وجود ارتباط له بإصابة الأم الحامل ببعض الأمراض كالحصبة الألمانية Rubella أو الحصبة العادية Measles أو النكاف Mumps ، وهناك من الباحثين من يربطه أيضاً باضطراب في جين معين كما هو الحال بالنسبة للفينيل كيتونوريا Phenylketonuria PKU ، وهناك من يربطه كذلك بشذوذ كروموسومي معين مثل كروموزوم X الهش Fragile X . ومع ذلك فإن صورة اضطراب التوحد في تلك الحالة تظل لانمطية Atypical ورغم كل هذا هناك رأي قوي يذهب إلى ربط مثل هذا الاضطراب بالتصلب الدرني Tuberculous Sclerosis . وإلى جانب ذلك فإن دراسات التوائم تؤكد أن هناك سبباً جينياً لهذا الاضطراب حيث أنه قد تكرر في حالة التوائم المتشابهة بنسبة ٩٢ ٪ في مقابل ١٠ ٪ فقط للتوائم غير المتشابهة. وعلى الرغم من ذلك فليس هناك رأي يمكننا أن نتمسك به وندعي أنه هو المسؤول الأول أو الأساسي لهذا الاضطراب . وبذلك يتضح جلياً تضارب الآراء حول هذه الأمور خاصة وأن هناك رأياً قوياً آخر يذهب إلى أن هناك شيئاً ما خطأ قد وقع بالفعل بين الحمل والولادة وأدى إلى حدوث تغيير في كيمياء المخ وذلك على الرغم من عدم القدرة على تحديد ذلك الأمر .

وقد يرى البعض أسباباً أخرى تتمثل في:

- شخصية الأم الباردة التي لا تتفاعل مع طفلها وتتكلم معه- انفصام الشخصية عند الأم أو الأب .
- المشاكل النفسية والطلاق في المنزل - إمكانية حدوث التوحد بين التوأمين بنسبة تصل إلى ٥٠٪.
- الالتهاب الفيروسي الذي يصيب الأم الحامل مثل الحصبة الألمانية وتضخم الخلايا الفيروسية والتهاب الدماغ الفيروسي.
- حالات وأمراض أثناء الولادة: مثل نقص الأوكسجين أو التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين أو إصابة الأم بالنزيف أثناء الولادة.
- درجة الحرارة العالية لأكثر من ٤١,٥ درجة مئوية للطفل وتؤثر على الدماغ وتؤدي إلى تلف خلايا المخ.
- العيوب الخلقية - تناول أدوية أثناء الحمل بدون أمر الطبيب-تلف خلايا المخ من أدوات الولادة.

قائمة المحتويات

- اضطرابات الكيمياء الحيوية للطفل فأن ارتفاع البروتين في خلايا بعض الأطفال التوحدين بنسبة تصل إلى ١٠٠٪.
- الدوبامين يزيد في المناطق التي تتحكم في الحركة الجسمية وكذلك epinephrine and non-epinephrine والتي تتركز في المناطق التي تتحكم في التنفس والذاكرة والانتباه والتي تلعب دورا في حدوث التوحد.

في حين قسم البعض الأسباب إلى:

-أسباب بيولوجية:

أثبتت البحوث والدراسات الطبية أن اضطراب التوحد يحدث لأسباب بيولوجية، ومن تلك الأسباب المحتملة هي: العوامل الجينية (الوراثية)، التهابات الفيروسية، المشاكل التي يمكن أن تصاحب فترة الحمل والولادة، وأحد هذه الأسباب يمكن أن يحدث تلفا في المخ يعتقد أن تنتج عنه الإصابة بالتوحد، إلا أن هذه الأسباب البيولوجية لا توجد عند كل طفل توحدي، مما يدل أن هناك عوامل بيولوجية أخرى لم يتم كشفها حتى الآن (نور الهدي محمد صبحي كابس، د.ت، ١٥-١٦).

-أسباب خاصة بظروف الحمل والولادة:

مثل إصابة الأم بالنزيف خصوصا بعد الأشهر الثلاثة الأولى، أو التعرض لأشعة إكس أثناء الحمل، وهناك بعض الفيروسات التي تعبر المشيمة وتؤثر على الطفل، والتي يعتقد أن لها أثرا في حدوث التوحد مثل: فيروس "الروبيلا Rubella"، كما ترجع بعض الدراسات حدوث التوحد إلى أسباب مناعية، وذلك بعبور أجسام مضادة Antibodies من الأم إلى الجنين، والتي تؤثر بصفة خاصة على الخلايا العصبية (منال القاضي، ٢٠٠٩، ١٠).

-أسباب بيئية:

"هناك عوامل بيئية ارتبطت بالتوحد، مثل: لقاح "MMR" والفيروسات، وبعض الأمراض المعدية، التعرض للمواد الكيماوية السامة، واضطرابات في العمليات الأيضية، حساسية من تناول الألبان والقمح، المضادات الحيوية الخاصة بعلاج التهابات الأذن، ونهاية: تختلف أسباب الإصابة بالتوحد من حالة إلى أخرى، فالفيروسات تسبب التوحد لبعض الأشخاص، ويسببه التعرض لكيمواويات سامة لدى نسبة قليلة منهم، وهناك بعض الحالات التي توارثت الاضطراب، بينما أصيب بعض الأشخاص بالتوحد نتيجة لتغير مفاجئ في الجينات، إلا أن جميع هذه الأسباب تنتج نمو غير طبيعي لوظائف المخ" (وفاء علي الشامي، ٢٠٠٤، ١٥٩-١٦٠).

نسبة انتشار اضطراب التوحد:

تشير إحصاءات عام ٢٠٠١م إلى أنه من بين كل (٥٠٠) حالة ولادة هناك حالة توحد، أما بالنسبة لمجموعة الطيف ككل فتشير الإحصاءات إلى وجود حالة من كل (٢٠٠) حالة ولادة (ل. خوان هيفلين، دونا فيورينو أليمو، ٢٠١١، ٦٨)، وفي العموم نسبة التوحد تختلف من دولة لأخرى، وذلك لعدم وضوح الأسباب، والأخطاء في التشخيص.

ويتفق كلا من "محمد عدنان عليوات" و"ياسر الفهد" على أن نسبة شيوع التوحد عالميا تقدر بنسبة (٤-٥) حالات توحد كلاسيكية في كل (١٠,٠٠٠) مولود، أما "رابية الحكيم" فتقدر في كتابها "دليل التعامل مع التوحد" أن نسبة التوحد هي (٧٥) حالة في كل (١٠,٠٠٠) إنسان، في حين تؤكد دراسات المعهد القومي الأمريكي للصحة العقلية علي أن نسبة التوحد هي (١-٢) من بين كل ألف نسمة (في: بشير شريف، ٢٠٠٤، ١٥).

ويرى إبراهيم محمود بدر (٢٠٠٤) في ضوء الإحصاءات الحديثة لنسبة انتشار اضطراب التوحد والتي أصبحت ١٥ ضعفا عما كانت عليه سابقا: أن الأمر ينذر بالخطر، مما يؤكد ضرورة القيام ببحوث مسحية في مصر والعالم العربي، لتحديد معدل انتشار الاضطراب واتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية للوقاية من الاضطراب

قائمة المحتويات

والتدخل المبكر والعلاج، "حيث يرتفع انتشار التوحد بنسبة (١٠-١٧٪) سنوياً، فقد أصبح التوحد مشكلة صحية وطنية طارئة.

ويؤكد المركز الطبي بمدينة "ديترويت" الأمريكية Detroit Medical Center (١٩٩٨) على أن هذا الاضطراب يصيب الطفل قبل أن يصل عمره إلى ثلاثين شهراً، البنين به قياساً بالبنات من ثلاث إلى أربع مرات، وهو اضطراب يستمر مدى الحياة. وتذهب الجمعية الأمريكية للتوحد Autism Society of America (١٩٩٩) إلى أن معدل الانتشار هذا قد جعل منه ثالث أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً، ومن ثم فإنه يعد أكثر شيوعاً من زملة أعراض داون، ويؤيد تقرير لقسم الخدمات الخاصة بذوي الاضطرابات النمائية بولاية كاليفورنيا California State Department Developmental Services (١٩٩٩) هذا الرأي، ويتضح أن عدد الأفراد التوحديين ينمو بشكل سريع للغاية، وذلك قياساً بأقرانهم ذوي الاضطرابات النمائية المختلفة. وتوضح التقديرات أن صافي معدل الزيادة السنوية في عدد الأفراد التوحديين قياساً بأقرانهم ذوي الاضطرابات الأخرى يصل إلى (٣٪) تقريباً (عادل عبدالله محمد، ٢٠٠٨، ٣٢٠-٣٢١).

المشاكل الرئيسية للأطفال المصابين بالتوحد:-

الأطفال التوحديين يعانون من مشاكل كبيرة في اللغة والتخاطب بالإضافة إلى المشاكل السلوكية مثل عدم مشاركة الأطفال الآخرين في اللعب، كما أنهم يفعلون ويغضبون بدون سبب واضح ولديهم صعوبات سلوكية في التعامل مع الآخرين تتركز في سلبيتهم في التعامل وهؤلاء الأطفال قد يكونون انطوائيين ساكنين وقد يكونوا ناشطين مخربين وتختلف درجة المشاكل السلوكية من الشديدة إلى الخفيفة فقد يكونوا مؤذيين لأنفسهم وللآخرين.

ولا يوجد علاج تام وشفافي ولا نستطيع إصلاح الخلل الدماغى ولكن يمكن تعديل السلوك والمشاكل اللغوية ليستطيع التوحدي العيش بسهولة مع الآخرين.

- يولد الطفل التوحدي سليماً وعند بلوغه الثانية أو الثالثة من العمر تبدأ التغيرات السلوكية والصمت التام أو الصراخ المستمر ونادراً ما تظهر بعد الولادة وهى:
- الرتابة وعدم اللعب وكل حركاته متكررة- الانعزال الاجتماعي ورفض التعامل مع الآخرين
- الخمول التام أو الحركة المستمرة بدون هدف- تجاهل الآخرين حتى تعتقد أنه أصم - تأخر الحواس
- الخوف الشديد أو عدم الخوف- ٣٠٪ من أطفال التوحد لديهم تخلف فكري اقل من ٥٠٪
- نسبة قليلة لديهم قدرات خاصة مثل عزف الموسيقى بعد سماعها لمرة واحدة أو رسم صورة رائعة أو حفظ قطعة طويلة بدون معرفة معناها أو حل مسألة حسابية معقدة بدون آلة حاسبة في حين لا يستطيع أن يحل مسألة حسابية بسيطة جداً أحياناً أخرى ويمكن أن يقوم بتعلم أصعب وأدق البرامج الخاصة بالكومبيوتر وقد يفسر البعض ذلك بقدرات خارقة - التوحد يمكن أن يحدث مع متلازمة داون.

المهارات الاجتماعية لدى أطفال طيف التوحد:

يعاني أطفال طيف التوحد من قصور في المهارات الاجتماعية؛ حيث إن ضعف التواصل الاجتماعي من الخصائص الأولية للتوحد؛ سواء التواصل البصري، أو التواصل بإقامة علاقات مع الأقران والأصدقاء، كما يعاني هؤلاء الأطفال من خلل في استخدام اللغة والكلام، وعدم القدرة على استخدام اللغة غير اللفظية (كلغة الجسد)، والتعبير الانفعالي عن المشاعر كالخزن والفرح والغضب (Johnny Matson, 2009, 129).

قائمة المحتويات

ولكن هناك أطفال طيف توحّد لديهم مهارات استثنائية في مجالات مثل الموسيقى، والذاكرة الخرافية، والرياضيات، والمهارات الحركية على سبيل المثال: بعضهم يمكن أن يحسب اليوم من الأسبوع لأي تاريخ معين، وآخرون يمكنهم أن يتذكروا ويغنون أغنية بشكل مشابه تماماً للأغنية الأصلية التي تم الاستماع إليها، وبالرغم من هذا فليس جميع الأطفال التوحّدين لديهم هذا النوع من المهارات (كوثر حسن عسليّة، ٢٠٠٦، ١١٩).

وبشكل عام فإن تشجيع التفاعل الاجتماعي وعلاقات الصداقة وتيسيرها لدى الأطفال التوحّدين قد يكون له تأثير جوهري في تحسين قدرتهم على الأداء الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك؛ فإنه يجب أن يوضع في الحسبان أنه ليست هناك إمكانية للتأكد من التأثير الحقيقي للعزلة الاجتماعية، أو صعوبة المهارات الاجتماعية على قدرة الطفل المستقبلية ليتم دمجها بنجاح في المجتمع، وما زال الاعتقاد الغالب بأنه من المهم التركيز على الدمج الاجتماعي بقدر المستطاع، حيث لا يقتصر الهدف على أن يتعلم الفرد المهارات الاجتماعية ولكن يجب جعل هذه السلوكيات وسائل في المخزون السلوكي لديه (روبرت كوجل، لن كوجل، ٢٠٠٣، ١٣٩).

ويرى "محمد كامل" أن الأفراد ذوي طيف التوحّد غالباً ما يعانون من ضعف في مستوى مهاراتهم الاجتماعية؛ حيث تكون درجاتهم في الغالب منخفضة على مقاييس المهارات، وهذا يؤدي -بجانب عوامل أخرى- إلى حدوث العديد من المشكلات التي تتعلق بالاتصال والتواصل والاستقلال، كما أنها قد تؤدي في الوقت ذاته إلى حدوث بعض اضطرابات السلوك، كالعدوان والعناد وفرط النشاط والتدمير وإيذاء الذات، والذي قد ينتج جزئياً عن حالة الاندفاعية التي يتسم بها هؤلاء الأفراد، وهذا يزيد بطبيعة الحال من احتمالات توقع الفشل في التفاعل الاجتماعي (في: عادل عبدالله محمد، ٢٠٠٨، ١٢٤).

فالأطفال ذوي طيف التوحّد يجدون صعوبات كبيرة في اكتساب المهارات الاجتماعية الأساسية الآتية:

- ١- صعوبة في فهم وترسيخ القوانين والعادات الاجتماعية عندهم.
- ٢- الميل إلى السلوكيات الوجدانية والانفرادية.
- ٣- عدم الاهتمام بمشاعر الآخرين.
- ٤- استجاباتهم تتسم بالغضب والانفعالات غير الملائمة مع زملائهم ومع المعلمين.
- ٥- ضعف واضح في الرغبة لتطوير العلاقات الاجتماعية.
- ٦- قلة الإقبال على التعلم والاندماج الاجتماعي (عطاب حميمي، ٢٠١٨، ٤١).

النتائج المترتبة على ضعف المهارات الاجتماعية لأطفال طيف التوحّد:

توصل "عادل عبدالله" إلى وجود علاقة ارتباطية دالة بين المهارات الاجتماعية والعدوانية والاندفاعية، أو النشاط الزائد بوجه عام، وأن نقص المهارات الاجتماعية يعد هو السبب الرئيس الذي تترتب عليه العديد من المشكلات السلوكية لدى كلتا الفئتين، كالغضب والعدوان والاندفاعية وتشتمت الانتباه؛ حيث إن نقص المهارات الاجتماعية يتباين مسبباتها يؤدي بهم إلى الانسحاب من التفاعلات الاجتماعية، وقد يلجأون إلى العدوان سواء على الذات، أو تحطيم ما يحيط بهم من أشياء وممتلكات، أو يصبحون كما كشفت دراسة "كونزا Konza" مصدر إزعاج للآخرين من خلال ما يسببونه من فوضى وعصيان ونشاط زائد وانسحاب اجتماعي (في: عادل عبدالله محمد، ٢٠٠٨، ١٥٣).

سادساً: صعوبات التعلم:

يعد موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات الحديثة في ميدان التربية الخاصة مقارنة مع فئات التربية الخاصة الأخرى، ففي السبعينات من القرن الماضي بدأ موضوع صعوبات التعلم بالظهور،

قائمة المحتويات

وعلى الرغم من هذه البداية المتأخرة، إلا أن هذا المجال قد نال من المهتمين والمختصين في مجال التربية الخاصة قدراً هائلاً من الاهتمام، ويعود السبب في ذلك وجود فئة من فئات التلاميذ غير العاديين التي لا تبدو عليها ظاهرياً أية حالة من حالات التربية الخاصة المعروفة كالإعاقة البصرية أو السمعية أو العقلية أو الحركية، ولكنها تعاني في الوقت نفسه من مشكلات التحصيل الأكاديمي، بالإضافة إلى مشكلات النشاط الزائد أو تشتت الانتباه، أو مشكلات في الدافعية، أو مشكلات في المهارات الاجتماعية (فاروق الروسان، ٢٠١٣، ٥٩).

وتعد صعوبات التعلم الأكاديمية من أكثر المشاكل التربوية التي يعاني منها التلاميذ، والتي تقف كحاجز أمام إنجازهم الدراسي، حيث أصبحت هذه المشكلة تؤرق الكثير من الآباء والأمهات، كون أطفالهم لا يستطيعون مجاراة أقرانهم فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

ويؤكد (Nidhi,K.,etal.,2015) على أن التخطيط التعليمي الفعال والتدخل المبكر للحد من صعوبات التعلم يعتمد بشكل كبير على فهم دقيق لمراحل نمو التلاميذ المختلفة، حيث هناك قلة في عدد الباحثين الذين اهتموا بدراسة الأداء الأكاديمي في الرياضيات، وخاصة للطلاب ذوي صعوبات التعلم. وأشارت نتائج دراسته إلى وجود فروق كبيرة بين التلاميذ العاديين والتلاميذ ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات، حيث تقدم التلاميذ العاديين بمعدل أعلى من أقرانهم الذين لديهم صعوبات في التعلم.

وأكدت العديد من الدراسات والبحوث (Catts,etal.,2002,P.45) أن ذوي صعوبات التعلم يعانون من بطء في معالجة المعلومات مما يؤدي معه إلى فقد للمعلومات المتدخلة خلال عملية المعالجة مما يترتب عليها صعوبة الفهم القرائي والتعبير الكتابي، وبطء في الاستجابات على المهمات اللغوية، كما أظهرت النتائج ضعفاً لغوياً أي ضعفاً في الحصيلة اللغوية والمفاهيم بسبب التجهيز والمعالجة للمعلومات (بطرس حافظ، ٢٠٠٨، ٢٥٧).

تعريف صعوبات التعلم Learning Disability:

في ضوء تعريف كل (Hallahan& Mercer,2002, P.67) وقاموس (APA, 2015, P.594) يمكن تعريف صعوبات التعلم بأنها "هم أولئك التلاميذ الذين يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية المتضمنة فهم اللغة أو استخدامها سواء أكانت شفوية أم كتابية، ويظهر هذا الاضطراب على شكل عجز عن الاستماع، أو الكلام، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو العمليات الرياضية، على نحو لا تشتمل فيه صعوبات التعلم المشكلات التعليمية التي تعود أساساً إلى إعاقة عقلية أو سمعية أو بصرية أو سلوكية أو الحركية أو الحرمان البيئي أو الاقتصادي أو الثقافي".

وتعرفه ليرنر "Learner" بأنه اضطراب ناتج عن أسباب فسيولوجية وظيفية لدى التلميذ، قد تكون ناتجة عن خلل وظيفي في الأعصاب والدماغ، ويؤثر الاضطراب على قدرات الفرد العقلية بحيث تؤثر على تحصيله الأكاديمي في مجال مهارات القراءة والكتابة والتهجئة والمهارات العددية" (في: خالد محمد أبو شعيرة وأحمد ثائر، ٢٠٠٩، ٢٧).

والتلاميذ ذوي صعوبات التعلم: Children with learning disabilities هم تلاميذ عاديون من حيث الذكاء ليس لديهم أي إعاقة جسدية أو تخلف عقلي ولكن لا يستطيعون الاستفادة من أنشطة وخبرات التعليم المتاحة لهم في الفصل الدراسي وخارجه، فهم لديهم صعوبات أكاديمية تحصيلية تجعلهم أقل من زملائهم في تحصيل مادة أو أكثر.

قائمة المحتويات

وهو اضطراب في العمليات العقلية، والنفسية التي تشمل الانتباه، والإدراك، وتكوين المفهوم، والتذكر، وحل المشكلة التي يظهر صداها في عدم القدرة على تعلم القراءة، والكتابة، والرياضيات، وما يترتب عليها في المدرسة الابتدائية، أو فيما بعدها من قصور في تعلم المواد الدراسية المختلفة (بطرس حافظ، ٢٠٠٦).

محكات تشخيص صعوبات التعلم:

هناك العديد من الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها تحديد الأطفال ذوي صعوبات التعلم وتمييزهم عن الأطفال العاديين وذوي الإعاقات الأخرى من خلال محكات أساسية (الظاهر، ٢٠١٠، ص ص ٢٦-٣١؛ عادل عبد الله، ٢٠١٠) هي:

١- **محك الاستبعاد:** عند تشخيص التلميذ من ذوي صعوبات التعلم علينا استبعاد إصابته بأي إعاقة من الإعاقات الأخرى مثل التخلف العقلي أو إعاقة سمعية أو بصرية أو الجسمية، أو الاضطرابات الانفعالية.

٢- **محك التباعد:** يقصد به تباعد المستوى التحصيلي للطالب في مادة عن المستوى المتوقع منه حسب حالته، أي التفاوت بين القدرات العقلية والمستوى التحصيلي للمتعلم.

٣- **محك التربية الخاصة:** ذوي صعوبات التعلم لا تصلح لهم طرق التدريس المتبعة مع التلاميذ العاديين مما يوجب إيجاد طرق خاصة في تشخيص وتدريب هذه الفئة. وفيه يتم توفير خدمات خاصة وطرق وأساليب تعلم وبرامج تصمم لمعالجة مشكلاتهم التحصيلية، ومعلمين متخصصين ومن أمثلة طرق التربية الخاصة استخدام الطريقة الحس حركية مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم.

٤- **محك العلامات النيرولوجية:** حيث يمكن الاستدلال على وجود الصعوبات التعليمية من خلال التلف العضوي البسيط في المخ والذي يمكن فحصه من خلال رسم المخ .

أنواع صعوبات التعلم:

تصنف صعوبات التعلم إلى نوعين رئيسين:

١- صعوبات تعلم نمائية: Developmental Learning Disabilities

تتمثل في العمليات المعرفية المتعلقة بالانتباه والإدراك، والذاكرة والتفكير واللغة وهذه العمليات تشكل أهم الأسس التي يقوم عليها النشاط العقلي المعرفي للفرد ومن ثم فإن أي اضطراب أو خلل يصيب واحدة أو أكثر من هذه العمليات يفرز بالضرورة العديد من الصعوبات الأكاديمية اللاحقة بالإضافة إلى صعوبات التفكير واللغة الشفهية (عادل عبد الله، ٢٠١٠).

٢- صعوبات التعلم الأكاديمية Academic Learning Disabilities: هي الصعوبات التي تتعلق بموضوعات الدراسة: وتشمل: صعوبات القراءة Dyslexia، وصعوبات الكتابة Dysgraphia، وصعوبات التهجئة، والتعبير الكتابي، وصعوبات الرياضيات Dyscalculia (الزيات، ٢٠٠٧، ص ص ٤٨-٧٠؛ عزيز، ٢٠٠٨؛ هالاهان وكوفمان، ٢٠٠٨، ص ٣٣٨). ويتضح مما سبق أن العلاقة بين صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم الأكاديمية هي علاقة سبب ونتيجة.

خصائص ذوي صعوبات التعلم:

- الخصائص المعرفية:-

يفتقر ذوي صعوبات التعلم إلى القدرة على تعميم الإستراتيجيات المتعلمة لحل المشكلات على مواقف أو مشكلات جديدة وأنهم يميلون إلى استخدام إستراتيجيات وأساليب عشوائية في كتاباتهم مع ضعف الاهتمام الواضح بما يكتبون. كما أشارت الدراسة إلى أن ٤٠٪ من استجابات الطلاب ذوي صعوبات التعلم مقابل ٦٪ من استجابات العاديين تعكس إجابات عشوائية لا علاقة لها بالمهام المطلوب الاستجابة عليها، كما كانت كتاباتهم مشوشة ومفككة تفتقر إلى الترابط والتنظيم والغرض والمعنى. واتفقت العديد من الدراسات على أن الطلاب ذوي صعوبات التعلم لديهم صعوبات في الكتابة وبصفة خاصة يفنقرون إلى القدرات النوعية الخاصة التي ترتبط بالكتابة كالذاكرة البصرية – والقدرة على الاسترجاع إلى جانب القدرة على إدراك العلاقات المكانية، كما أنهم يعانون من القصور الوظيفي في النظام المركزي لتجهيز ومعالجة المعلومات.

- الخصائص الوجدانية لصعوبات التعلم:

أشارت الدراسات والبحوث إلى أن اضطرابات الجهاز العصبي المركزي واضطراب بعض الوظائف النفسية العصبية لذوي صعوبات التعلم تترك بصماتها على النواحي الانفعالية الدافعية فيبدو الطفل مكتئباً ومحبطاً ويميل إلى الانسحاب من مواقف التنافس التحصيلي القائم على استخدام الكتابة والتعبير الكتابي، كما لوحظ على الطفل الغياب المتكرر في حصص التعبير والإملاء وتظهر عليهم علامات الميل إلى العدوان المستمر، كما يفنقر هؤلاء إلى القدرة على التأزر الحركي واستخدام اليد والأصابع وإدراك المسافات والعلاقات بين الحروف والرموز والكلمات.

- الخصائص العقلية للاضطرابات اللفظية:-

اللغمة هي النطق الخاطئ لبعض الحروف الساكنة التي يصعب استخدامها وبالتالي تصبح في مؤخرة الحروف التي يتعلمها الطفل بإتقان، وقد تكون ناتجة عن عيوب بالجهاز الصوتي أو لأسباب عاطفية (مغلاة الأم في رعاية الطفل أو رغبة الطفل في أن يظل صغيراً). وأحياناً يكون الطفل قادراً على نطق الأصوات البسيطة بصورة صعبة ولكنه ينطق بصورة سيئة بعض الكلمات: ويرجع هذا إما لاستعجاله الشديد أو عدم القدرة على التمييز والتحكم في إصدار الأصوات.

وفى حالات أخرى يكون التعبير الشفهي الذي يصدره الطفل طبيعياً ولكن في نهاية مرحلة الطفولة وفى مرحلة المدرسة الابتدائية يظل عند مستوى الكلمات المرتبة والجمال الناقصة وذلك ينجم عن القصور العقلي أو نتيجة لبطء النضج بوجه عام.

وهناك اضطراب لغوي معروف وهو التمتمة التي قد تظهر عند الطفل ٢-٣ سنوات وهي تصيب الذكور بصفة خاصة وأحياناً تختفي تلقائياً ولكن في حالات أخرى تستمر وتزداد خطواتها إذا لم تعالج بصورة ملائمة.

وتتسم لغة المتمتم بالتردد والتكرار بصورة واضحة وأحياناً يتسم بعدم القدرة الكاملة على نطق الكلمة. وهذا ينجم عن تغير في إيقاع الجهاز التنفسي والذي يحدث أثناء نطق الحروف وأحياناً يكون مصحوباً بظواهر أخرى مثل بعض التقلصات في العنق والأكتاف واحمرار الوجه. وإذا كانت اللغمة معروفة في كل العالم إلا أن أسبابها مجهولة إلى حد كبير.

قائمة المحتويات

-الخصائص الانفعالية للاضطرابات اللفظية:

اللغمة ترتبط بالجانب الانفعالي حيث أن الفرد المصاب بها يتعلم فقط مع أشخاص بذاتهم وفي مواقف محدودة وعندما يتحدث عن مشاكل بالغة الحساسية بالنسبة له.

والأطفال المضطربين كلامياً منهم من يتمتع بذكاء عام يفوق قدراتهم الشفوية وفي هذه الحالة يكون معدل التفكير أسرع لترجمة المضمون إلى ألفاظ لغوية عندئذ تصبح اللغة في بعض اللحظات معاقة ومتوقفة أحياناً لا يستطيع تكوين الجمل والكلمات الصحيحة مما يعوقه دراسياً.

واضطراب الجانب الانفعالي يهز الثقة بالنفس والمخاوف مما يؤدي بالضرر على الجهاز الصوتي.

سابعاً: فرط الحركة المصحوب بنقص الانتباه ADHD

يعد الانتباه من أهم العمليات العقلية التي تلعب دوراً هاماً في النمو المعرفي لدى الفرد، وبالرغم من أن الانتباه عملية عقلية نمائية، إلا أنه قد نجد عدم قدرة بعض الأطفال على تركيز انتباههم أو تنظيم نشاطهم الذهني نحو شيء بعينه لفترة، مع عدم استطاعتهم أن يتحرروا من العوامل الخارجية المشتتة لانتباههم، كما أنهم يتحركون حركات مفرطة دون هدف، واندفاعيون مما يوقعهم في أخطاء كثيرة.

وإن كانت اضطرابات الانتباه المصحوب بنشاط حركي زائد تمثل مشكلة بالنسبة للأطفال العاديين وللمحيطين بهم، فلنا حينئذ أن نتصور حجم معاناة الأطفال ومن يقوم برعايتهم، لذ تعد اضطرابات الانتباه المصحوب بنشاط حركي زائد بمثابة تحد كبير للآباء، حيث يقوم هؤلاء الأطفال المعاقين ذهنياً بسلوكيات لا تتلاءم مع البيئة التي يعيشون فيها، فيلجأ الوالدان إلى أساليب تربوية خاطئة للحد من هذه السلوكيات غير المرغوب فيها، ومن هنا تتبلور الحاجة إلى الإرشاد الأسري لزيادة التواصل والتفاعل الأسري ومواجهة الضغوط الناتجة عن كونهما أبوين لمثل هذا الطفل بالإضافة إلى تدريبهم على تنمية بعض مهارات الطفل الاجتماعية (Fee,1993,67; Ellison,2004,732).

ويعتبر اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو النشاط الزائد (ADHD) مشكلة تسبب للطفل العديد من المشكلات أولها صعوبات التعلم بالإضافة للمشكلات الصحية التي يسببها الطفل لنفسه نتيجة فرط الحركة المصحوب بالسلوك الاندفاعي، بالإضافة إلى قلة الانتباه، مما يجعله يضع نفسه في الكثير من المواقف الصعبة أو الخطرة دون تفكير.

وقد حظى اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد في الآونة الأخيرة باهتمام كبير من قبل الأخصائيين النفسيين والمربين والقائمين على العملية التعليمية والباحثين في مجال التربية وعلم النفس وطب الأطفال وغيرهم نتيجة للآثار السلبية التي تحدثها في الطفل على المستوى المعرفي والانفعالي والاجتماعي، وما تحدثه أيضاً من مشكلات لأسرته، إذ يصاب الوالدين بالإحباط والحرص نظراً لعدم قدرتهم على التعامل مع طفلهم بصورة سليمة، أو مساعدته على التحكم في سلوكه، لذلك يضطر الوالدين إلى الانسحاب مع طفلهم من المواقف الاجتماعية خشية التعرض للانتقاد.

كما يعد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من بين الاضطرابات النمائية الأكثر شيوعاً بين الأطفال والمراهقين، حيث بلغت نسبة انتشاره في مرحلة الطفولة بين (٣-٥٪) وفقاً لتقديرات الجمعية الأمريكية للاضطرابات العقلية (Valentine Anciaux, et al. P.13)، وقد تصل نسبة انتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية

قائمة المحتويات

إلى (٧٪) في الأعمار (٤-١٧) سنة الذين تم تشخيصهم كمضطربين (Brown, 2007). وفي جمهورية مصر العربية أظهرت نتائج الدراسات أن نسبة انتشار الاضطراب بين أطفال مدارس التعليم الأساسي تراوحت بين (٥,٧٪ - ٦,٢٪)، وينتشر في البلدان العربية بنسبة ٥-٢٠٪ لدى أطفال المدرسة الابتدائية من مختلف الطبقات الاجتماعية، وتعد نسبة انتشاره لدى الذكور ثلاثة أمثال انتشاره لدى الإناث (زكريا الشربيني، ١٩٩٤، ٢٠٢).

كما تعزى أسباب الإصابة باضطراب الانتباه وفرط الحركة إلى مجموعة غير متجانسة من العوامل تتراوح ما بين الوراثة، البيئة، والعوامل النورولوجية، الأمر الذي سهل تفسير العلاقة بين صعوبات التعلم و(ADHD) مروراً بوظيفة الذاكرة العاملة، وهذا ما ينعكس سلباً على خبرات الطفل أو يجعل استيعابه للمادة التعليمية صعباً.

مفهوم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:



يسميه البعض اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد، وقد يسمى اضطراب تشتت الانتباه مع فرط النشاط (كامبل وآخرون. Cambell, et al. ١٩٨٦؛ ستاين Stein، ١٩٩٥؛ ليلي كرم، ٢٠١١)، وقد يسمى اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، و(ADHD)، وقد يسمى اضطراب ضعف الانتباه المصاحب للنشاط الزائد (ربى على سلطان وآخر، ٢٠٠٨). وفي دراسات أخرى النشاط الزائد المصاحب بنقص الانتباه، نظراً لأن كل حالات فرط الحركة تكون مصحوبة بقصور الانتباه وليس كل من لديه قصور في الانتباه مصحوب بفرط الحركة، ومن ثم فقد تعددت الأسماء والاضطراب واحد.

ويعرف الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل (٢٠٠١) اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد بأنه "الصعوبة في التركيز وعجز في الاستمرار في المهمة، يصاحبه نشاط زائد". والذي يعرف بأنه نشاط حركي غير هادف لا يتناسب مع الموقف أو المهمة ويسبب الإزعاج للآخرين، حيث يتضمن المعيار التشخيصي لاضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد (ADHD) ما يلي:

- قصور في الانتباه (فشل الفرد في إنهاء المهمات والصعوبة في التركيز).
- الاندفاعية أو التهور (التصرف قبل التفكير في الأمر والصعوبة في تنظيم العمل).
- النشاط الزائد (الحركة المتواصلة) (الزارع، ٢٠٠٧، ١٥).

فهو باختصار عبارة عن سلوك متواصل من زيادة في الحركة ونقص في الانتباه مع وجود سلوك اندفاعي، بشكل لا يتناسب مع عمر الطفل (Le Cendreau, 2007, P.9).

كما يعتمد الكثير من الباحثين والمختصين على تعريف الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) في دراساتهم لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وهو نفسه التعريف الذي جاء في الطبعة الرابعة من الدليل

قائمة المحتويات

التشخيصي الإحصائي للاضطرابات العقلية، حيث صُنفت الأعراض إلى ثلاثة أنماط : هي اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد (ADHD) بزيادة في نقص الانتباه، اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد (ADHD) بزيادة في النشاط الحركي والاندفاعية، واضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد (ADHD) يجمع بين أعراض نقص الانتباه، الاندفاعية والنشاط الزائد (Wikipedia,2009).

ونظرا لاهتمام العلماء والباحثين بدراسة اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه كأحد اضطرابات الطفولة والتي تمتد إلى مرحلة الرشد، فقد تعددت التعريفات التي تناولته حيث ركز بعض الباحثين في تعريفهم على الأعراض المميزة له، في حين ركز آخرون على الأسباب، فبالنسبة للاتجاه الذي ركز على الأعراض فقد اتخذ من كثرة الحركة وزيادة النشاط معياراً للحكم على الطفل بأنه يعاني من هذا الاضطراب كتعريف "Ross" الذي يعرف هذا الاضطراب بأنه: ارتفاع مستوى النشاط عند الطفل عن المعيار السوي، وذلك من وجهة نظر الكبار الذين يعتبرون هذا النشاط مصدر قلق وإزعاج لهم (خالد محمد علي القاضي، ٢٠٠١، ٢٢). كما تعرف خولة أحمد يحي (٢٠٠٠، ١٧٩) الإفراط الحركي بأنه "نشاط جسمي وحركي حاد، وطويل المدى لدى الطفل، بحيث لا يستطيع التحكم بحركات جسمه، بل يقضي أغلب وقته في الحركة المستمرة، ويظهر هذا السلوك غالباً من سن الرابعة حتى سن ما بين ١٤-١٥ سنة. أما بالنسبة للاتجاه الذي ركز على الأسباب في تعريفهم لهذا الاضطراب فنجد البعض ركز على الأسباب البيولوجية أو المرضية، كتعريف بريور وسانسون (Prior & Sansoun, 1986) حيث يعرفان هذا الاضطراب على أنه: اضطراب يصيب الأطفال قبل سن السابعة، ممن يعانون من خلل في الجهاز العصبي المركزي. وتعريف كايل وويكس نيلسون (Kail & Wicks-Nelson, 1993) بأنه: اضطراب يطلق عليه متلازمة الطفل ذي النشاط الزائد وهو يصيب الأطفال ممن لديهم مخ معاب بيولوجيا، ويركز آخرون على الأسباب البيئية للاضطراب كتعريف وولكر وروبرتس (Walker & Roberts, 1992) لهذا الاضطراب على أنه "حالة من عدم الاستقرار الحركي المزمن، مع عدم وجود بداية واضحة لأعراضه، ولا يكون نتيجة لاضطرابات الجهاز العصبي المركزي أو ذهان الطفولة".

ويعرف نامار وآخرون (MC Namar, et al., 2000) الأطفال ذوي اضطراب ADHD على أنهم "أولئك الأطفال الذين يزدون على الأقل بمقدار انحراف معياري واحد عن متوسط الأطفال العاديين، على أحد المقاييس التي تقيس الأعراض الأساسية لهذا الاضطراب ولا يكون هذا مصحوباً بمؤشرات واضحة لاضطراب الجهاز العصبي المركزي أو ذهان الطفولة".

وتعرف منظمة الصحة العالمية (WHO) ضعف الانتباه المصحوب بفرط النشاط على أنه "مزيج من النشاط الزائد والسلوك غير المكيف، مع نقص الانتباه والعوز إلى التدخل بإصرار في المواضيع والسيطرة على المواقف" (حاتم الجعافرة، ٢٠٠٧، ١٠).

ويعرف زكور محمد مفيدة وعبد الفتاح أبي ميلود (٢٠١٥) صعوبات الانتباه بأن درجة الانتباه والتركيز قصيرة جداً، ويكون الأطفال غير قادرين على التنظيم، يظهرون كأنهم ليسوا مهتمين لما حولهم، يجدون صعوبة في بدء وأكمال ما يقومون به من نشاط، خصوصاً ما يظهر أنه ممل أو متكرر أو فيه تحدي أو تفكير، كأنهم لا يسمعون عندما يتحدث معهم ولا ينفذون الأوامر المطلوبة منهم، يفقدون أغراضهم، وينسون أين وضعوا حاجياتهم (كتبهم وأقلامهم) مثلاً. أما فرط النشاط فهو فرط الحركة وزيادة النشاط علامة مميزة حيث يرى الطفل يتلوى، يتأمل، لا يستطيع البقاء في مكانه أو على مقعده نراه يجري في كل مكان، يتسلى كل شيء، كثير الحركة لا يهدأ، يتكلم بلا هدف، كما يجد صعوبة في التأقلم واللعب مع الأطفال الآخرين.

وعرفته أمانى عبد المقصود (٢٠١٦) بأنه "صعوبة فى التركيز والانتباه وعجز عن الاستمرار فى أداء عمل ما مصحوب بنشاط حركى زائد وغير هادف لا يتناسب مع الموقف ويسبب الإزعاج للآخرين".

واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder هو المصطلح الحالى الذى اعتمدته الجمعية الأمريكية للطب النفسى فى إصدارها الخامس لوصف الأطفال والمراهقين والبالغين الذين يظهرون أنماطاً سلوكية تتصف بضعف فى الانتباه Inattention وفرط فى النشاط Hyperactivity والاندفاع Impulsivity (American Psychiatric Association, 2013). وهو نوع من الاضطرابات التى تصيب الأطفال وتكون واضحة لديهم فى عمر الحضانة والسنوات الأولى من التعليم الأساسى، وتظهر فى تصرفاتهم حيث يكون من الصعب على هؤلاء الأطفال السيطرة على سلوكهم وانتباههم (Russell, A.,Barkley, 1996, P.1).

ومما سبق يتضح أن مصطلح اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو ما يعرف اختصاراً بـ ADHD يركز على وصف الحالات التى تعاني من وجود مشاكل فى الانتباه والتحكم فى الدوافع بالإضافة إلى فرط الحركة، وقد تم استخدام مصطلح اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD كمصطلح جامع يشير إلى ثلاث مجموعات فرعية من المرضى، على وجه التحديد:

- ١- من يعانون بشكل رئيسي من مشاكل فى الانتباه
- ٢- من يعانون بشكل رئيسي من مشاكل فرط الحركة/ردود الفعل المبالغة والفجائية
- ٣- من يعانون بشكل رئيسي من مشاكل الانتباه وفرط الحركة/ردود الفعل المبالغة والفجائية فى ذات الوقت.

وأوضحت دراسة "لاهي" و"بيلهام" إلى أن نقص الانتباه وفرط النشاط الحركي عرضان متلازمان لاضطراب واحد، وليساً نمطين منفصلين (السيد سيد أحمد، ١٩٩٩، ٣؛ عصام نور، ٢٠٠٢، ١١٩؛ فاطمة الزهراء حاج صابري، ٢٠١٤). وعليه فإن مصطلح "اضطراب الانتباه" يكون للدلالة على "قلة الانتباه وفرط الحركة" وهذا ما أكدته "رابطة علم النفس الأمريكية" على مصطلح "فرط النشاط" حيث أطلقت على هذا الأخير "اضطراب الانتباه".

وقد صنف تعريفات اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وفقاً لعدة اتجاهات أو مجالات منها:

أولاً: التعريف الطبي:

يعرف الأطباء اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة على أنه اضطراب جيني المصدر ينتقل بالوراثة في الكثير من الحالات، وينتج عنه عدم التوازن الكيميائي أو عجز في الوصلات العصبية الموصلة لجزء من المخ والمسئولة عن الخواص الكيميائية التي تساعد المخ على تنظيم السلوك (Zametkon, 1990). كما تعرفه مجموعة من الأطباء متخصصة في قصور الانتباه والاضطرابات العقلية، (Professional Group for attention and Related Disorder (PGARD), 1990) على أنه "اضطراب عصبي حيوي يؤدي إلى عملية قصور حاد تؤثر على الأطفال بنسبة ٥٪ من تلاميذ المدارس" (مشيرة عبد الحميد أحمد اليوسفي، ٢٠٠٥، ١٧). بينما يعرفه تشرنومازوف (Chernomazova, 1996) على أنه "نتيجة قصور في وظائف المخ التي يصعب قياسها بالاختبارات النفسية". وأخيراً يعرفه المعهد القومي للصحة النفسية (National Institute of Health) (٢٠٠٠) على أنه "اضطراب في المراكز العصبية التي تسبب مشاكل في وظائف المخ، مثل: التفكير والتعلم والذاكرة والسلوك" (فى: مشيرة عبد الحميد أحمد اليوسفي، ٢٠٠٥، ١٧).

ثانياً: التعريف السلوكي :

عرف باركلي (Barkley,1990) في نظريته عن اضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط على أنه "اضطراب في صنع الاستجابة للوظائف التنفيذية قد يؤدي إلى قصور في تنظيم الذات، وعجز في القدرة على تنظيم السلوك تجاه الأهداف الحاضرة والمستقبلية مع عدم ملائمة السلوك". واتفق جولدستين Goldstein مع باركلي في أن الأطفال من ذوي نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط يعانون من مشاكل متعلقة بالوظيفة التنفيذية أثناء التعلم قد تكون السبب في إعاقة نموهم الأكاديمي وتجعلهم يعانون من صعوبة العمليات اللفظية المتصلة باللغة (في: مشيرة عبد الحميد اليوسفي، ٢٠٠٥، ١٨). بينما عرفه تشرنامازوفا (Chernomozova,1996) على أنه "اضطراب نتيجة النشاط الحركي البدني والنشاط العقلي للطفل، عندما يكون في حالة هياج أو ثورة للانتصار على أي شيء ممنوع عنه".

ثالثاً: التعريف حسب الدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية :

أشار الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات العقلية American psychiatric Association DSM4 (١٩٩٤) إلى الأعراض الرئيسية التي يتم على أساسها تشخيص اضطراب الانتباه، والتي يجب أن تظهر على الطفل قبل التشخيص بستة أشهر متتالية وتتمثل هذه الأعراض في: نقص القدرة على الانتباه، النشاط الحركي المفرط، والإندفاع.

أما في الطبعة الرابعة المعدلة للدليل التشخيصي والإحصائي الرابع (DSM IV-TR) التي صدرت عام (٢٠٠٠) فقد تم التأكيد على أن السمة الرئيسية للاضطراب تتضمن ثلاثة أنماط سلوكية هي:

١- اضطراب تشتت الانتباه/النشاط الزائد: نمط مشترك يشتمل على الأعراض التشخيصية للبعدين تشتت الانتباه والنشاط الزائد.

٢- اضطراب تشتت الانتباه/النشاط الزائد: نمط يسود فيه تشتت الانتباه، ويشتمل على أكثر الأعراض التشخيصية كتشتت الانتباه مع بعض أعراض النشاط الزائد.

٣- اضطراب تشتت الانتباه/النشاط الزائد: نمط يسود فيه النشاط الزائد، ويشتمل على أكثر الأعراض التشخيصية للنشاط الزائد مع بعض أعراض تشتت الانتباه (إيلي كريم المرسومي، ٢٠١١، ٣٧).

وفي الدليل التشخيصي الخامس DSM-V للجمعية الأمريكية للدراسات النفسية تم التمييز بين ثلاث أنواع لاضطرابات الانتباه هي:

١- اضطراب الانتباه مع فرط النشاط: نوع يوجد لدى الأطفال ستة أعراض أو أكثر لعدم القدرة على الانتباه مع مصاحبتها لستة أعراض أو أكثر من فرط النشاط مع وجود الاندفاعية، ويوجد هذا النوع من الاضطراب لدى الأطفال والمراهقين.

٢- اضطراب الانتباه بدون فرط النشاط: نوع من الاضطراب يوجد لدى الأطفال ستة أعراض أو أكثر لعدم القدرة على الانتباه في حين يوجد أعراض قليلة لا تدل على النشاط المفرط (ابتسام حامد السطيحة، ٢٠٠١، ٢٢).

٣- اضطراب تسود فيه الحركة المفرطة: هو عبارة عن هيمنة الحركة المفرطة وظهوره بشكل أكثر من سلوك عدم الانتباه.

ويجب أن نفرق بين الطفل الشقي المتحرك والطفل الذي لديه فرط حركة، فالطفل الشقي المتحرك يتحرك حركة مقصودة وهو طفل ذكي وليس لديه فرط حركة فالحركة نتيجة للنشاط Activity ونسبة ذكائه IQ أما الطفل

الذى لديه فرط حركة فهو يأتى بحركات غير مقصودة ودون هدف محدد وعشوائية نتيجة قصور ما فى بعض وظائف المخ، وهذه الحركات مصاحبة لفقدان أو قصور فى الانتباه.

- الآثار السلبية لتشتت الانتباه المصحوب بفرط الحركة:

١- تأثير نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط على التحصيل الدراسي:

تظهر لدى بعض التلاميذ في المراحل الدراسية المختلفة سلوكيات مزعجة تؤثر على سير العمل في الفصل الدراسي، ويفسرها المعلمون غالبا على أنها تصرفات غير لائقة من تلميذ لا يشعر بالمسؤولية أو بعبارة أخرى تلميذ مشاغب كمقاطعة التلميذ لعمل المعلم وعدم إتمام واجباته أو حتى التحديق في أشياء ليست مرتبطة بالدرس.

ويشير وينر (Wenar,1994) إلى أن التلاميذ ذوي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يسجلون أداء يقل عن أداء الأطفال العاديين بمعدل ٧-١٥ درجة على اختبارات الذكاء المقننة، ويفسر ذلك، بأنه ربما يعود إلى أن خصائص هؤلاء التلاميذ تعوق أداءهم الجيد على اختبارات الذكاء منها مثل: قصر فترة الانتباه، وتوقع الفشل. ويرى رايسر وبوير (Risser&Bower,1993) في دراسة لهما أن التلاميذ ذوي تشتت الانتباه مع فرط النشاط يتميزون بمتوسطات درجات أعلى من متوسطات التلاميذ العاديين على مقاييس العجز المعرفي.

وتظهر مشكلات نقص الانتباه غالبا في مرحلة التعليم حيث يكون التلميذ عرضة لمهام دراسية متعددة تتطلب انتباهه لفترة طويلة من الوقت، وتستدعي قيامه بجهود معينة لإتمام تلك المهام. فالتلاميذ ذوي نقص الانتباه مع فرط النشاط يواجهون صعوبة في معظم المهام التي تتطلب نجاحا أكاديميا لبدء أو إتمام المهام، والقيام بالتحويل من مهمة إلى أخرى، وكذلك التعامل مع الآخرين واتباع التعليمات، وإنجاز أعمال دقيقة أو تتطلب عملا منظما وأداء مهام تتطلب أكثر من خطوة.

ففي المرحلة الابتدائية تزايد مسؤولية التلاميذ المضطربين لتوجيه الانتباه داخل الفصل الدراسي أو حتى للمهام التي توكل لهم، فالتلميذ ذو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عادة ما تنقصه القدرة على الضبط الذاتي فيكثر صراخه داخل الحجرة الدراسية وقد يدعم المعلم تلك الأفعال السلبية مما يضعف لديه القدرة على الضبط الذاتي (خالد محمد علي القاضي، ٢٠٠١، ٩٦).

أما في المرحلة الإعدادية عندما يتحول التلاميذ إلى مرحلة المراهقة فإنهم ينزعون إلى الاستقرار نسبيا وتدرجيا (حاتم الجعافرة، ٢٠٠٧، ٤١) وفي المقابل قد يصبحون قلقين، ودائما يبحثون عن شيء ما، ويحبون الضجيج مما يسبب لديه مشكلات تعليمية.

٢- تأثير نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط على الحياة النفسية:

أ - عدم الاتزان الانفعالي:

من الأعراض الثانوية لتلاميذ ذوي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أنهم يتميزون بعدم الثبات الانفعالي، حيث أن هؤلاء التلاميذ كثيرون البكاء لا يتحملون أي نقد، وكثيرا ما يتلزم هذا الاضطراب مع الاضطرابات الانفعالية خاصة القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة.

كما يشير وهالن (Whalen,1989) إلى أن ذوي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يفقدون أعصابهم عندما لا تلبى طلباتهم، ويتخيلون أنهم يستطيعون أن يهزموا أي شيء من المحيط بهم وكثيرا ما يكشف الفحص النفسي عن وجود اكتئاب نفسي، وإحساس بالنقص لأنهم يرون أنفسهم كتلاميذ سيئين وغير محبوبين وينظر إليهم على أنهم صانعوا مشاكل (محمود عبد الرحمان حمودة، ١٩٩٨، ١٥٧).

قائمة المحتويات

ب - انخفاض مفهوم الذات:

تشير نتائج دراسة جنزيلز وسيلرز (Ganzelez&Sellers,2002) إلى أن التلاميذ المصابين بهذا الاضطراب يعانون من تدني مفهوم الذات، ويبدوا عليهم الشعور السلبي تجاه أنفسهم. وتشير دراسة إيمان ابراهيم عز (٢٠٠١) أن هؤلاء التلاميذ لديهم ضعف في تقدير الذات، وكانوا أكثر استياء من مظهرهم الجسدي وأكثر تعاسة مقارنة بأقرانهم العاديين، كما أن لديهم مفهوما منخفضا للذات الأكاديمية. ويفسر هوزا وآخرون (Hoza,et al.,2002) انخفاض مفهوم الذات بأنه رد فعل للفشل المستمر والمتكرر في كل من البيت والمدرسة، والذي يؤدي إلى ضعف في الدافع، ومستوى الطموح للتلميذ. كما يؤكد في هذا السياق باركلي (Barkley,1990) إلى أن تقدير الذات المنخفض لدى هؤلاء التلاميذ المضطربين يرجع إلى التغذية الراجعة السالبة المستمرة التي يحصل عليها هؤلاء التلاميذ أثناء تفاعلهم مع الآخرين، وعدم تقبلهم اجتماعيا.

٣-تأثير اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط على الحياة الاجتماعية:

أ - العلاقة بالآخرين وتكوين الأصدقاء:

يذكر هينتشو وهلينتش (Hinchow&Helinch,1995) أن التلاميذ ذوي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يعانون من صعوبات في تكوين صداقات مع الآخرين وخاصة أقرانهم، كما أنهم يعانون في الاحتفاظ بالعلاقات التي تربطهم بأصدقائهم.

ويشير لورجز (Lorgs,1993) إلى أن هؤلاء التلاميذ لديهم نقص في عملية تأسيس روابط الصداقة، ولديهم مشكلات تتعلق بعملية التكيف والتطبيع الاجتماعي. ويرجع سبب ضعف علاقة التلميذ بالآخرين إلى الاندفاعية القوية، ونشاطه عديم الغرض، وضعف تركيزه وضعف قدرته على تحمل الإحباط وضعف احترام الذات لديه، وقد يعود كذلك إلى أن هؤلاء المتعلمين غير قادرين على التعبير عن شعورهم ورغباتهم وآرائهم بصورة مناسبة.

ب - المهارات الاجتماعية:

شيرستايين (Stein,1995) إلى أن التلاميذ من ذوي الاضطراب يعانون من عجز في المهارات الاجتماعية، حيث أن طبيعة خصائصهم تحول دون أدائهم للسلوك الماهر اجتماعيا، كما أنهم يكونون أقل تعاونا مع الآخرين، وأقل اندماجا، ويستجيبون كما لو كانوا لا يسمعون الآخرين، ومن هنا تصبح ضعف المهارات الاجتماعية سمة مميزة لاضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط، إضافة إلى انتشار السلوك العدواني لفظيا أو بدنيا حينما يتعرضون للإحباط، أو حينما يتم إيدائهم انفعاليا من الآخرين، ولا يهتمون بأثر سلوكهم العدواني. كما يؤكد كامبل وآخرون (Cambell,et al.,1986) إلى أن (٨٨ %) من التلاميذ الذين شخّصوا على أنهم عدوانيون كانوا يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عند الكبار:

هناك تأثيرات لاضطراب نقص الانتباه عند العديد من الكبار وله أعراض إحباط واسعة الاختلاف قد تعوق كل شيء في علاقاته المهنية. ومع زيادة المسؤوليات في متابعة المهنة والأسرة والأشغال والمهام المنزلية التي تتطلب من الفرد زيادة قدرته على التنظيم والتركيز وضبط الانفعال والتي من الممكن أن تمثل تحديات في هذه الحالة فإن المصاب بهذا الاضطراب يستحيل عليه أداء هذه المهام، حيث أن هذا الاضطراب يؤثر على كل مراحل التفكير.

وقد يساهم هذا الاضطراب في إحداث مشاكل صحية تشمل تناول الطعام الإجباري وإساءة استخدام العقاقير، والقلق والتوتر المزمن وتدني احترام الذات ونسيان تناول الأدوية.

قائمة المحتويات

كما يساهم في إحداث مشاكل مهنية في العمل وصعوبات مالية، حيث يعاني الكبار المصابين بالاضطراب من شعور قوى بعدم الإنجاز ومشكلة الاحتفاظ بوظيفة واتباع قواعد الشركات والالتزام بروتين العمل اليومي، ومشاكل في التعاملات المالية. كما توجد مشاكل في العلاقات، حيث تسبب ضغط في العمل والعلاقات العاطفية والأسرية، والشعور بعدم القدرة على السيطرة على مجريات الأمور.

وغالبا ما يبدو اضطراب نقص الانتباه عند الكبار أقل صعوبة من الأطفال، ومن الأعراض الشائعة: -صعوبة التركيز والاستمرار فيه: حيث غالبا يكون لدى الكبار صعوبة في الاحتفاظ بالتركيز والمواظبة اليومية للمهام العادية.

-الفوضى وكثرة النسيان: تشمل ضعف المهارات التنظيمية ويغلب عليه طابع الفوضى (في المنزل، المكتب، السيارة) -الميل إلى التأجيل- خلل في بداية ونهاية الخطة- فقد أو ضياع الأشياء باستمرار (مفاتيح، محفظة، تليفون، مستندات، فواتير)- التأخير المزمن- تكرار نسيان المواعيد والالتزامات.

-الاندفاع: خلل في التصرفات والاستجابات والتعليقات، وربما يتصرف الفرد قبل أن يفكر، والاندفاع في أداء المهام دون قراءة التعليمات، وعدم التحلي بالصبر، وشديد التهور في المواقف، ويجد الفرد نفسه في مواقف تنطوي على مخاطر، ومن مظاهره: تكرار مقاطعة الآخرين - ضعف السيطرة على النفس- التفوه المفاجئ بألفاظ غير مهذبة وغير مناسبة دون تفكير.

-الصعوبات النفسية: المعاناة من صعوبة التعامل مع مشاعرهم كالغضب والإحباط، وتتمثل هذه الأعراض في: الاحساس بتدني الانجازات-عدم التعامل بشكل جيد مع الإحباط-التوتر والارتباك- سرعة الغضب وتقلب المزاج- شدة الحساسية تجاه النقد- تدني احترام النفس والشعور بعدم الأمان.

-القلق: وتتمثل مظاهره في: الشعور بالقلق الداخلي والاثارة-الميل إلى المخاطرة-الشعور بالملل-التوتر المزمن.

لذا قد يلجأ الوالدان إلى أساليب تربوية خاطئة للحد من هذه السلوكيات غير المرغوب فيها، كاتباع الأساليب الوالدية التي تنسم بالرفض الصريح أو المقنع، والإهمال، والتحكم، واللامبالاه، والنذب وإحساس الطفل أنه غير مرغوب فيه، والحرمان العاطفي من الوالدين، والحماية الزائدة والتدليل (السيد على وفانقة محمد، ١٩٩٩: ٤٣)، والعقاب البدني أو النفسي (ضياء منير، ١٩٨٧: ٤١)، وزيادة التحكم الوالدي (Harvey, 2000, 49)، كما إنه أحيانا يفكر هؤلاء الآباء أن طفلهم هو المسئول الوحيد عن سوء سلوكه، وقد لا يدركون أن أسلوب الرعاية الوالدية الخاطيء الذي يتبعونه هو سبب زيادة اضطرابات الانتباه والحركة الزائدة لدى هذا الطفل (محمد السيد ومنى خليفه، ٢٠٠٣: ٧٤)، مما يعرض الأطفال لمزيد من المشكلات النفسية والاجتماعية التي يمتد أثرها للوالدين وخاصة إذا فشلوا في معرفة الطريقة الصحيحة في التعامل معها (راشد السهل، ١٩٩٥: ٥٩).

ثامناً: اضطرابات اللغة والتواصل:

تعد فئة الأطفال ذوي اضطرابات اللغة والتواصل هي من الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزايد الاهتمام بها في الفترات الأخيرة محلياً وعالمياً، فمن خلال الخطة الخمسية للتصدي لمشاكل الإعاقة في مصر أشارت الإحصاءات الحديثة إلى تزايد أعداد الأطفال ذوي الإعاقة، فكانت نسبة الإعاقة في مصر (١٩٩٦) تقريبا ٣،٤ % أي تبلغ ٢ مليون من ذوي الإعاقات المختلفة منهم ٧٣٪ من أصحاب الإعاقة الفكرية (البسيطة والمتوسطة والشديدة

قائمة المحتويات

(، أما تقديرات المعاقين فكريا بدرجة بسيطة فكانت النسبة ٢,٥ % عام ١٩٩٧ (المجلس القومي للطفولة والأمومة، ١٩٩٧)، وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠٠٢/٢٠٠٣م إلى أن عدد الأفراد المعاقين فكريا بمرحلتى التعليم الابتدائي والإعدادي تبلغ تقريبا ١٧,١١١ (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٠٣).

مفهوم اللغة والتواصل:

تعد اللغة وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي، والتعبير عن الذات وفهم الآخرين وهي وسيلة مهمة من وسائل التواصل العقلي، والمعرفي، والانفعالي، حيث تحقق التواصل بين الأفراد ومن خلالها يتناقلون المشاعر والأحاسيس. كما تتيح اللغة للإنسان التعبير عن أفكاره ومشاعره وآماله وآلامه، وهذه نعمة أختص الله بها الإنسان من بين سائر الكائنات (سعيد كمال، ٢٠١٨، ١١).

وتعرف اللغة بأنها "نظام من الرموز التي يتفق عليه في ثقافة معينة، أو جنس معين، أو بين أفراد فئة معينة، ويتسم هذا النظام بالتنظيم والضبط طبقاً لقواعد محددة، ومن ثم فإن اللغة تعد إحدى وسائل التواصل بين أفراد المجتمع" (العزیز الشخص، ٢٠١٣، ٢٢).

وهي نظام يستخدمه مجموعة من الأفراد لإعطاء معنى للأصوات والكلمات، والإشارات، أو أية رموز أخرى ليتمكنوا من التواصل مع الآخرين. ويعرفها بعض اللغويين بأنها "نظام من الأصوات المنطوقة له قواعد تحكم مستوياته المختلفة، الصوتية والصرفية والنحوية وتعمل في انسجام ظاهر مترابط، وهي وسيلة يعبر بها الفرد عن أفكاره ومشاعره وانفعالاته وعواطفه" (أسامه فاروق، ٢٠١٤، ٦٤).

وجمع "ابن جني" بين تعريف اللغة وبين وظائفها بقوله "إن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" وهو في تعريفه هذا يشير إلى أن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل وهو تعريف جامع، بحيث يتضمن العناصر الأساسية للغة في كونها: نظام من الأصوات المنطوقة- يستخدمها مجتمع من بني الإنسان- تستخدم للتفاهم والتعبير عن المشاعر والأفكار (ميساء أحمد و فرات قاضم، ٢٠١٥، ١٦).

ويعد التواصل "علاقة ديناميكية متبادلة، ولكي تحدث هذه العلاقة بين أكثر من شخص يجب أن تشمل على قدرة الأشخاص على الفهم واستخدام اللغة اللفظية والإيماءات واللغة المصاحبة أو ما يسبق اللغة وكذلك القدرة على تحديد الموضوع في المحيط الاجتماعي أو السياق الاجتماعي. ولكي تستمر المحادثة بفاعلية يجب أن يكون لدى الشخص قدرة معرفية للاحتفاظ بذاكرة قصيرة المدى وربط الكلام بالموقف الاجتماعي والتواصل الغرضي، فالمعرفة تسهل للطفل أيضا القدرة على فهم اللغة المجردة مثل الدعابة والمعنى غير الحرفي (Ruth Huubner, 2001, 276).

كما تعد عمليات التواصل جوهر الحياة واستمرار الحياة الاجتماعية وتطورها من خلال عملية التواصل والتي تعد حجر الزاوية في بناء الجماعات المختلفة ووسيلة للتفاهم بين الأفراد بعضهم البعض فكما أن الغذاء والهواء ضروريان لحفظ بقاء الكائن الحي فالتواصل لا يقل عنها ضرورة بالنسبة لاستمرار وبقاء الحياة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات (عبد الستار سلامة، ٢٠٠٩، ٥٥).

تعريف اضطرابات اللغة والتواصل:

تعرف الاضطرابات اللغوية إجرائيًا بأنها "الاضطرابات اللغوية التي يعاني منها الأطفال، ومتمثلة في اضطراب اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية (إيهاب الببلاوي، ٢٠٠٦، ٣٥).

-اضطراب اللغة الاستقبالية:

هي "عدم القدرة على فهم اللغة وتشمل المهارات اللغوية المستقبلية فهم اللغة المنطوقة والرد عليها والكلمات المكتوبة، ومع ذلك فإن اللغة الاستقبالية لا تتعامل فقط مع مهارات المفردات، ولكنها تتعامل أيضًا مع فهم الإيماءات وتفسير الفرق بين الأسئلة والبيانات والتعليمات وفهم بعض المفاهيم النحوية بدقة" (المرجع السابق، ٣٥).

-اضطراب اللغة التعبيرية:

هي "عدم القدرة على التواصل، وهي القدرة على التعبير عن الأفكار والرغبات والاحتياجات، وتحديد وتمييز الكائنات في البيئة، وتجميع الكلمات معًا لتشكيل جملة، ووصف الأحداث والإجراءات، والإجابة على الأسئلة، وتقديم أمثلة على مهارات اللغة التعبيرية، سواء باستخدام اللغة بشكل مناسب أو دمج تعبيرات الوجه والإيماءات، بالإضافة إلى الكتابة(نفس المرجع السابق، ٣٨).

-تصنيف اضطرابات اللغة والتواصل:

تعددت وتنوعت المفاهيم الخاصة باضطرابات التواصل وفقاً لتعدد المداخل والأطر النظرية في هذا الميدان من ناحية ووفقاً لتنوع الأعراض وشدة وتوقيت ظهور الاضطراب من ناحية أخرى.

ويقصد باضطرابات اللغة تلك الاضطرابات المتعلقة باللغة نفسها من حيث زمن ظهورها أو تأخيرها أو سوء تراكيبها من حيث معناها وقواعدها، أو صعوبة قرائتها وكتابتها(أديب عبد الله، وإيمان طه، ٢٠١٥، ٧).

ويمكن تصنيف التواصل إلى نوعين رئيسيين هما: التواصل اللفظي، والتواصل غير اللفظي، حيث ينحصر التواصل اللفظي في تلك الألفاظ التي ينطق بها الفرد مخاطبًا غيره من الأشخاص، بينما يتسع التواصل غير اللفظي ليشمل العديد من الوسائل نذكر منها تعبيرات الوجه والإيماءات بأنواعها، ووضع الذراعين، والرجلين، ووضع الجذع، وطريقة الجلسة ... إلخ. فمعظم النظريات تقسم التواصل إلى تواصل لفظي وتجعل فيه الوظيفة الأساسية وتواصل غير لفظي وتجعل منه الوظيفة الثانوية(هشام الخولي، ٢٠١٠، ٤١). وقد ذكر كارلسون وآخرون (Carlsson,etal.,2006,374) أن اللغة هي الأداة الرئيسية لعملية التواصل اللفظي وغير اللفظي، وهي التي تُثري الحياة الاجتماعية، فمن دونها ينعدم التواصل وبالتالي تنعدم النواحي الاجتماعية في الحياة".

وتعرف هلا السعيد (٢٠١٤، ٤١) اضطرابات التواصل على أنها "اضطراب ملحوظ في اللغة أو الصوت أو الطلاقة الكلامية أو التأخر اللغوي أو في عدم تطور اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية، الأمر الذي يجعل الطفل بحاجة إلى برامج علاجية أو تربوية خاصة".

وذكر عبدالعزيز إبراهيم (٢٠١٣) الأنماط المختلفة لاضطرابات اللغة والتواصل: وتشمل اضطراب اللغة الاستقبالية: ويتضمن عدم القدرة على فهم الكلام المسموع أو ترميزه، واضطراب اللغة التعبيرية: وتعرف بصعوبات في القدرة على إنتاج الكلام، واضطراب اللغة الاستقبالية- التعبيرية المختلط: وهو خليط بين اضطراب اللغة الاستقبالية والتعبيرية، وهي عبارة عن التأخر النمائي للغة: وصعوبات في القدرة على فهم اللغة وإنتاج الكلام. ويمكن تصنيف اضطرابات اللغة والكلام بأكثر من طريقة ومن بين هذه الطرق:

قائمة المحتويات

- ١- اضطرابات في النطق ونظام الصوت: من أبرز مظاهرها الأخطاء في إنتاج أصوات اللغة.
 - ٢- اضطرابات في الطلاقة اللغوية: من أبرز مظاهرها التأتأة ويتم تقويم هذا الاضطرابات في معظم الأحيان بالملاحظة.
 - ٣- اضطرابات في إنتاج الأصوات: يكون الاضطراب في نوع الصوت ومن أمثله وصف الصوت بالأجش أو اللهث، أو المتقطع أو الأخبب.
 - ٤- اضطرابات اللغة: تظهر عندما تختلف لغة الطفل من حيث صيغها، ودلالاتها، واستعمالاتها في السياق الاجتماعي على غير ما هو متوقع بالنسبة لعمر الطفل والثقافة التي ينشأ فيها (سعيد كمال، ٢٠١٨، ٤٥-٤٦).
- في حين يصنف فكري متولى لطيف (٢٠١٥، ١٥٠) اضطرابات النطق والكلام إلى:
- ١- اضطرابات اللغة الاستقبالية وتشمل: عيوب في الاستخدام رفيع المستوى للغة- العيوب التركيبية- دلالات الألفاظ- عيوب النظام الصوتي- عيوب النظام المورفولوجي.
 - ٢- اضطرابات اللغة التعبيرية وتشمل: الخنف، اللدغة: الرائية، والسينية، والأمامية خلفية- الحبسة الكلامية- التلعثم، والحذف، والإضافة، والإبدال، والتحريف.

مشكلات اللغة والتواصل لدي تلاميذ المدرسة الابتدائية:

يعد نقص مهارات التواصل من الملامح الأساسية لدي تلاميذ المدرسة الابتدائية ومن أهم الأعراض المميزة والمؤشرات المهمة في تشخيصها، ولذا يبدو واضحاً أن المشكلة لدي هذه الفئة هي مشكلة التواصل اللفظي وغير اللفظي (محمد سيد موسي، ٢٠٠٧، ١٨)، حيث يتسع مدي مشكلات التواصل اللفظي لديهم اتساعاً كبيراً، فهناك فئة تعاني من مشكلات لغوية الأمر الذي يترتب عليه عدم استخدام أصحاب هذه الفئة من تلاميذ المدرسة الابتدائية للغة المنطوقة ومن هذه المشكلات ما يلي:

١- **اللغة قبل التواصل:** توجد مشكلات ترتبط بالاستخدامات التربوية للغة لدي تلاميذ المدرسة الابتدائية، ويعتمد الاستخدام التربوي للغة علي افتراض وجوب تدريب الطفل علي التواصل في مرحلة ما قبل المدرسة فإن الطفل يكتسب اللغة أولاً ثم يتعلم بعد ذلك كيفية استخدامها في أغراض التواصل في مرحلة ما قبل المدرسة (ريتا جوردن، ستيوارت بيول، ٢٠٠٧، ١٠٤).

٢- **مشكلات النطق:** يعرف النطق بأنه وسيلة الاتصال الكلامي التي تستخدم الرموز اللغوية التي من خلالها يستطيع الطفل النطق والتعبير وتعليم تلاميذ المدرسة الابتدائية عملية اخراج الاصوات ونطق الكلمات، وتكوين الجمل الكلامية وذلك وفقاً لقدرتهم الفردية حيث أن القدرة علي التواصل لا تقتصر علي إخراج الأصوات أو تكوين جمل مستقيمة نحوية بل تشمل القدرة علي توصيل المعاني والأفكار عن طريق الحوار في إطار اجتماعي، وهذا الدور ضئيل في عملية التواصل (أحمد سليم، ٢٠٠٦، ١٢١-١٢٢). كما يتسم تلاميذ المدرسة الابتدائية بالبطء في تنمية اللغة المنطوقة، لذا فنحن في حاجة إلى تشجيع استخدام وسائل جديدة للتواصل بحيث لا يصل التلاميذ إلى حالة من الإحباط والإحساس بالملل، حيث أن الوسائل البديلة لا تأخذ مكان اللغة المنطوقة ولكنها تكملها حيث تحتاج إلى تشجيع دائم (Michael, 2004, P5).

٣- **فهم واستخدام اللغة:** غالباً ما يستخدم تلاميذ المدرسة الابتدائية اللغة في إطار ضيق من حيث الموضوعات وبصفة أساسية في طلب الاحتياجات الخاصة بهم والكلام المتكرر عن اهتماماتهم الخاصة وبهذه الصورة تكون اللغة غير مفيدة بمعنى أنها لا تبني علي ما يقوله الآخرون (سايمون كوهين، باتريك بولتون، ٢٠٠٠، ١٠٢).

قائمة المحتويات

٤- قلب الضمائر: يجد تلاميذ المدرسة الابتدائية صعوبة كبيرة في فهم الطريقة التي يستخدمون بها الضمائر (أنا- أنت) بشكل صحيح، فيقومون بالتوظيف الخاطئ، والخلط في استخدام الضمائر (Richard, 2005, 25).

ولهذا فإن الإطار اللغوي والتنظيم مظهران من مظاهر الاضطرابات لدى الطفل ومن الأشياء التي تواجهه بشكل واضح، كالحديث في الهاتف وذلك لعدم استطاعته فهم طريقة الحديث المختلفة من الآخرين (عبير فاروق، ٢٠٠٥، ٤٥-٤٦).

ويفسر كثير من العاملين في هذا المجال صعوبات التخاطب التي يواجهها الأطفال بالتأخر اللغوي، أي أن الطفل مقارناً مع أقرانه لا يكتسب اللغة في نفس الجدول الزمني المتعارف عليه (الجدول الزمني الدوري التطوري لنمو اللغة)، ففي السنة الأولى يفهم التعليمات البسيطة- يقول: ثلاث مفردات تعبيرية بجانب كلمة ماما وكلمة بابا، يربط الكلمات بالأشياء مثل: عندما يسمع سيارة فيشير إلى جراج السيارة، يعرف أسماء الأشخاص والأشياء. وما بين السنة الأولى والثانية: يفهم معنى كلمة (لا)- يستخدم من ١٠ إلى ٢٠ مفرد أغلبها أسماء - يستخدم جمل قصيرة مكونة من كلمتين - يقلد أصوات الحيوانات المألوفة - يشير إلى أعضاء جسمه ويتعرف عليها. وما بين السنة الثانية والثالثة: يدخل في حوار مع نفسه أو مع لعبته- يسأل عن الأشياء باستخدام ماذا أو أين- يستخدم جمل نفي (لا أريد)- تصل حصيلته المفرداتية إلى ٤٥٠ كلمة- يستخدم ضمير المتكلم (أنا) بدلاً من أن يذكر اسمه- يستطيع أن يركب ٣- ٤ ألوان مع نظائره - يعرف معنى كبير وصغير. ما بين السنة الثالثة والرابعة : يستطيع أن يسرد قصة - يستخدم جمل طويلة مكونة من ٤ إلى ٥ كلمات- تصل مفرداته اللغوية إلى ١٠٠٠ كلمة - يعرف اسمه واسم الحي الذي يعيش فيه . وما بين السنة الرابعة والخامسة : يستخدم جمل طويلة مكونة من ٥ أو ٤ كلمات - يستخدم الفعل الماضي استخدام صحيح - تصل مفرداته اللغوية إلى ١٥٠٠ كلمة - يفرق بين شكل المثلث والدائرة والمربع - يتحدث بمفردات فيها نوع من التخيل (Imagination) (أنا أتمنى). وما بين السنة الخامسة والسادسة : يستخدم جمل طويلة مكونة من ٦ إلى ٥ كلمات- تصل مفرداته اللغوية إلى ٢٠٠٠ كلمة- يتحدث عن وظائف الأشياء (أنت تأكل بالملقعة) - يعرف الأشياء مصنوعة من ماذا - يعرف العلاقات المكانية (فوق - تحت - بعيد - قريب) يعرف عنوان - يعرف العملة المحلية - يعرف معكوسات الكلمات - يعد ١٠ أشياء - يميز بين يده اليمنى ويده اليسرى - يستخدم كل أنواع الجمل البسيطة والمركبة.

إن عملية التخاطب عملية معقدة يشترك فيها المرسل والمستقبل ولكي تتم يجب توفر الآتي: القدرة السمعية - القدرة العضلية - القدرة العصبية- القدرة العقلية - القدرة التنفسية - قوة اندفاع هواء الزفير.

مثال: إذا أراد شخص أن ينطق صوت (ب) فهناك سلسلة من العمليات المعقدة تتم في جزء ضئيل جداً من الثانية الواحدة وبشكل آلي فائق السرعة والدقة، ففي البداية تستدعي الدماغ الصورة الصوتية لصوت (ب) ثم يصدر أمراً للجهاز العصبي المركزي لنطق صوت (ب)، ثم يقوم الجهاز العصبي المركزي بتوصيل الأمر إلى الجهاز العصبي الطرفي، ثم يقوم الجهاز العصبي الطرفي بتوصيل الأمر عن طريق الأعصاب المسؤولة عن عضلات الشفاه لكي تتحرك وتنقبض، في ذات الوقت يصدر الأمر وبنفس التسلسل السابق إلى عضلات الجهاز التنفسي لكي تقوم بإخراج الهواء من الرئتين إلى القصبة الهوائية، ومن ثم إلى الحنجرة فتتهتز الأحبال الصوتية نتيجة لاندفاع الهواء من خلالها، وينتج عن ذلك صوت يتم تشكيله داخل تجويف الفم، ثم يصل الهواء إلى الشفاه المنقبضة فتنتفح ويحدث ما يشبه الانفجار (ب).

أنشطة تدريبية

- س ١- عرف كل من: الإعاقة الحركية-الصمم- الإعاقة البصرية- الإعاقة السمعية -اضطرابات التواصل-الإعاقة العقلية - قرط الحركة ونقص الانتباه؟
- س ٢- قارن بين أسباب الإعاقة السمعية؟
- س ٣- وضح مشكلات المعاقين سمعياً؟
- س ٤- وضح أنواع كف البصر-أنواع صعوبات التعلم؟
- س ٥- وضح خصائص المعاقين عقلياً؟
- س ٦- وضح تصنيف اضطرابات اللغة والتواصل ؟

روابط إلكترونية

روابط إلكترونية للاستفادة منها:

<https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9>

<https://www.almayadeen.net/news/health/845478>

<almrsal.com/post/876819>

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/Booklet%20%20-%20Arabic_0.pdf

https://mobiforu.com/index.php?r=viewNew&t=696JJ&preid=169&preType=2&clickid=M7210416879230255223&partner_id=1314&utm_content=fdc2c69a9caf9c919596a191959ca58fbbcd9cbbfbc8c818586b1838281b5a7babab98ebe8c8db3838081eae6eae1e9f8f9e9fbb2ecefbbef1e3ef97a595ad84878e828acca48c80ce1d4d3e4d7cefbf8f9989e908e97f3f0c0f6c6c7c3fccbffff6cfccdc2c3f7f0f7f6f4f3e3eee8e0ebe7eaece6e4d7

رابط الاختبار التفاعلي:

[https://docs.google.com/forms/d/1u9D-ESL92A6cJl93Rt6Le2ibv9vdv-DQBMVAmj_G2ZBU/edit?](https://docs.google.com/forms/d/1u9D-ESL92A6cJl93Rt6Le2ibv9vdv-DQBMVAmj_G2ZBU/edit?hl=ar)

hl =ar

قائمة المحتويات

الفصل الثالث

الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

- تمهيد.
- الاحتياجات التربوية للنمو النفسي والاجتماعي لدى المعاقين سمعياً.
- الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال المعاقين عقلياً.
- حقوق المرأة المعاقة ذهنياً.
- الحاجات الأساسية لأسر الأطفال المعاقين عقلياً.
- دور الأسرة فى إشباع حاجات الأبناء المعاقين ذهنياً.
- الضغوط النفسية التي يتعرض لها آباء واسر الأطفال المعاقين ذهنياً.
- دور الوالدين في ارتقاء وتحسين مستوى التوافق النفسي لأبنائهم المعاقين عقلياً.
- الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع والدي المعاق.
- جودة الحياة الأسرية واضطرابات اللغة والتواصل.
- أنشطة تدريبية.

مخرجات التعلم المستهدفة

في نهاية الفصل يصبح الطالب قادرًا على أن:

- يحدد الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال المعاقين عقلياً.
- يحدد الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال المعاقين سمعياً.
- يقارن بين حقوق المرأة المعاقة وغير المعاقة.
- أن يفهم الحاجات الأساسية لأسر الأطفال المعاقين عقلياً.
- أن يستنتج الضغوط النفسية التي يتعرض لها أسر الأطفال المعاقين .
- أن يتفهم دور الأسرة في إشباع حاجات الأبناء المعاقين.
- أن يتدرب على الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع والدي المعاق.

الفصل الثالث

الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

تمهيد:

إن الطفل له حاجاته الأساسية التي يرغب في إشباعها، ويعمل على ذلك بالأساليب والطرق المناسبة له والتي تتفق مع قدراته وإمكانياته، كما أن له حاجاته الخاصة به والتي تظهر لديه بسبب الإعاقة والظروف التي مر بها. ومن هذه الاحتياجات:

- **احتياجات جسدية:** حيث يكون المعاق بحاجة إلى الأجهزة التي تساعد على استعادته لياقته الجسدية وتعويضه عن ما فقده بسبب الإعاقة التي حدثت له.
 - **احتياجات إرشادية:** لكي يتقبل المعاق إعاقته ويستطيع العيش بسلام مع نفسه فهو بحاجة إلى الإرشاد من قبل الأخصائيين الذين يساعدونه على التكيف وتنمية شخصيته بصورة صحيحة مع الآخرين.
 - **احتياجات التعليمية:** المعاق كغيره من الأفراد في المجتمع بحاجة إلى تعليم، لذا يجب أن يتوفر التعليم المتكافئ لمن هم في سن التعليم.
 - **احتياجات تدريبية:** يمكن حدوث ذلك عن طريق توفير فرص التأهيل في مؤسسات خاصة، وتدريبه على ما يناسب قدراته وإمكانياته ووضع الإعاقة التي يعاني منها .
 - **احتياجات مهنية:** فالطفل المعاق بحاجة إلى التوجيه المهني المبكر والاستمرار فيه حتى ينتهي من العملية التأهيلية.
 - **احتياجات اجتماعية:** تتمثل في تقوية علاقة المعاق بالمجتمع الذي يعيش فيه، وتعديل نظرة المجتمع إليه حتى يكون بالإمكان توفير فرض الاحتكاك والتفاعل المتكافئ مع الآخرين من حوله، والعمل على دمج مع المجتمع وتتمثل الاحتياجات الاجتماعية في الجوانب الآتية:
 - **تدعيمية:** في مجال العمل الذي يقوم به.
 - **ثقافية:** إن الفرد بحاجة إلى توفير الأدوات والوسائل الثقافية ومجالات المعرفة الأساسية والضرورية المتعددة.
 - **الحماية:** الطفل المعاق بحاجة إلى توفير الحماية له في بعض المواقف أو المجالات المختلفة.
- ولما كان للمعاق حاجاته التي يجب إشباعها كغيره من بين جنسه فقد أصدرت مجموعة من التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في شأنه نصت موادها على أن يحيا المعاق حياة طبيعية مثله مثل باقي سائر البشر من حوله.
- **الاحتياجات التربوية للنمو النفسي والاجتماعي لدى المعاقين سمعياً:**
أكد عبد السلام زهران (٢٠٠٨) وفتحي عبد الرحيم (١٩٩٨) على الاحتياجات التربوية للنمو النفسي والاجتماعي لدى المعاقين سمعياً والتي من أهمها:-
إحاطة المعاق سمعياً بجو من العلاقة الدافئة والتقبل مما يقوى ثقته بنفسه وبالآخرين.

قائمة المحتويات

العمل على أن يتقبل المعاق إعاقته وان يمتصها في إدراكه الذاتي وأن يعمل وينتج ويعيش في ظلها كحقيقة واقعية.

إشعاره بالاحترام والحب والحنان والأمن حتى ينتزع من نفسه أحاسيس الخوف والقلق .
الاهتمام بالأنشطة التعليمية والاجتماعية التي تسهم في حل المشكلات التي تواجهه.
الشعور بالتقبل ممن حوله في الأسرة والمدرسة والمجتمع لتحقيق توازنه الانفعالي.
عدم التدخل المتعسف في اختيار المجال المهني الذي سيكسب به عيشه.
تعويدته على تحمل المسؤولية وإتاحة الفرصة له لممارستها حتى يتعلم كيف يخدم نفسه ويخدم بيته.
تشجيعه على تكوين علاقات جديدة مع جماعة الرفقاء.
تعويدته على الاستقلال العاطفي وتكوين قيم سلوكية تتفق مع عالمه المتطور الذي يعيش في إطاره.

-الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال المعاقين عقلياً:-

تعتبر الحاجات النفسية للطفل المعاق عقلياً ضرورية، فإذا ما توافرت وسائل الإشباع لهذه الاحتياجات قد تساهم في تحسين توافقه النفسي، وإذا لم تتوافر له وسائل الإشباع فقد تؤدي إلى ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها تؤدي به إلى الإحباط وانعدام الثقة سواء في نفسه أو في الآخرين المحيطين به، كما أن احتياجاته كثيرة ومتنوعة ويعتمد علي الأسرة في تلبية هذه الاحتياجات والتي يمكن إيجازها فيما يلي:-

١- الحاجة إلى الأمن النفسى: شعور الطفل بالأمن يعنى شعوره بأن هناك من يهتم به ويحميه، ويحتاج الأطفال المعاقين عقلياً إلى أن يكونوا موضع عطف وحب من والديهم ومن مدرسيهم ومن سائر المحيطين بهم.
ويتحقق الأمن النفسى للمعاق عقلياً إذا عاش في مناخ أسرى متماسك يمدّه بالثقة فى نفسه التى تساعد على تكوين علاقات سوية مع غيره من المحيطين به (أمل معوض الهجرسى، ٢٠٠٢: ١٨٩).

٢- الحاجة إلى التقبل من الآخرين: حاجة الطفل المعاق إلى التقبل ينمىها ويدعمها شعوره بأنه محبوب ومرغوب فيه من قبل الكبار والمحيطين به، ويهددها شعوره بأنه منبوذ ومضهد أو غير مرغوب فيه، ويعمل إشباع هذه الحاجة على نمو علاقة الطفل بالآخرين وتطورها، وعدم إشباعها يؤدي إلى فقدان الأمن والاستقرار النفسى والاجتماعى. ويجمع علماء النفس على أن حرمان الطفل من الحب والتقبل يصنع فيه القسوة ويدفعه إلى الانحراف عن السلوك العادى، وكلما شعر بأن الآخرين يتقبلونه ويحبونه شعر بالرضا عن نفسه وبالأمن والسعادة مما ينعكس على استقراره النفسى، وعلى النقيض فإن الحرمان من الحب والتقبل يصيبه بالقلق والتوتر والعناد وغيره من ألوان الاضطراب النفسى مما يشعره بالتعاسة والحزن والانطواء أو العدوان الزائد (فى: مريم ثابت، ٢٠١٠، ٦٥).

٣- الحاجة إلى التقدير: ترتبط هذه الحاجة بالحاجة إلى الحب والعطف والتقبل من الآخرين، فالطفل فى حاجة إلى أن يشعر بالتقدير والتقبل من الآخرين لما يفعله من أعمال معينة. ويتضح ذلك فى الدور الذى تلعبه عملية التنشئة الاجتماعية للطفل وتربيته فى إشباع حاجة التقدير للحاجة إلى التقدير فلا تهتم الأسرة أو المعلمة أو المدرسة بمساعدة هؤلاء الأطفال على أداء بعض الأعمال البسيطة التى تشعره بقيمته بالنسبة لنفسه وللآخرين، فالطفل المعاق عقلياً يحتاج إلى أن يحوز إعجاب الآخرين سواء من أفراد الأسرة أو من الأقران. ولذا يجب تشجيع الطفل المعاق على أدائه لأعمال يقوم بها، وينظر له بعين الاعتبار وبارتباطه بحاجته إلى النجاح والتقدير.

٤- الحاجة إلى تدريب حواسه واستثمارها لاكتساب الخبرات والمعارف التي حالت الإعاقة العقلية دون إكسابها لذلك فهو يحتاج إلي التدريب المستمر لاستغلال حواسه حتي ينمو بصورة جيدة .

٥-يحتاج الطفل إلى التدريب على المهارات الاستقلالية لديه حتي يتمكن من الاعتماد على نفسه لتلبية احتياجاته الأساسية مثل: الأكل- الشرب- اللبس- الحفاظ على النظافة والمظهر الخارجى.

٦-يحتاج الطفل المعاق عقليا إلى "تكوين علاقات اجتماعية سليمة مع المحيطين به فيتعرف على (أبيه- وإخوته- جيرانه- اقاربه)، حتى يستطيع الاندماج والتوافق معهم ويتفاعل معهم بصورة جيدة ولا يكون هامشيا" وعالة عليهم ومن خلال حاجاته إلى التفاعل معهم يمكن له التدريب والتعلم على الكثير من السلوكيات الاجتماعية المرغوبة.

٧-يحتاج الطفل إلي التدريب المستمر على مختلف المهارات المعرفية المختلفة.

٨- يحتاج الطفل إلى تنمية اللغة حيث يجب على الأم أن تدربه على إصدار الأصوات وتقليدها إلى جانب زيادة حصيلته اللغوية من خلال التعرف على أسماء كل المحيطين به.

٩- الطفل المعاق عقليا"يكون دائما لديه الرغبة في تحقيق قدر معقول من النجاح فى التغلب على الصعوبات، فعلى الأسرة أن تجنبه قدر المستطاع المواقف الصعبة التى قد لا تتناسب مع قدراته واهتماماته (أشرف العوضى، ٢٠٠١، ٨٣) .

ويرى البعض أن الطفل المعاق عقليا لديه العديد من الاحتياجات النفسية والاجتماعية منها: الحاجة إلى العلاقة الطبيعية بالأسرة، وأداء الأسرة لمهامها الطبيعية (رسمى عبد الملك، ١٩٩٤ ، ٢٥)، والحاجة إلى الأمن والإشراف (محمد الهابط، ١٩٨٥ : ١٩)، والحاجة الى تعديل مفهوم الذات والشعور بالكفاءة (كمال إبراهيم مرسى، ١٩٩٦، ٢٨٩)، الحاجة الى تقبل الآخرين (أمل معوض الهجرسى، ٢٠٠٢، ١٩٠)، الحاجة إلى تكوين علاقات صداقة، حيث يعتبر عنصرا هاما فى حياة الطفل المعاق (Steven,R.,1994:383).

-حقوق المرأة المعاقة ذهنياً:

- يجب توعية الرأي العام بوضع المرأة المعاقة واحتياجاتها والعمل على تصحيح الاتجاهات السلبية حول قدراتها وإبراز ما تتمتع به من إمكانيات تجعلها مساوية للآخرين وذلك من خلال الآتي :
١. تثقيف وتوعية المرأة المعوقة لتمكينها من الحياة الطبيعية طبقا لقدراتها.
 ٢. توعية الأسرة والمجتمع باحتياجات المرأة المعوقة.
 ٣. ضمان المساواة في تقديم الخدمات والرعاية للمرأة المعوقة .
 ٤. تدريب المرأة المعوقة وتأهيلها مهنيا بما يتفق وإمكاناتها وقدراتها وميولها وتوفير فرص العمل المناسب لها.
 ٥. توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة المعاقة.

-الحاجات الأساسية لأسر الأطفال المعاقين عقلياً:-

هناك طرق كثيرة يستطيع المجتمع من خلالها تقديم المساعدة للمعاق وعائلته، حيث يوجد مؤسسات تستطيع الاهتمام بالأطفال الأكثر تخلفاً ومتعددي الإعاقة، وذلك بالرغم من أن الأفضل فيحالات كثيرة أن يبقى الطفل المعاق في بيئته مع عائلته لكن توجد حالات يتطلب فيها وضع الطفل في إحدى المؤسسات المختصة في التعامل

مع مثل هذه الحالات الخاصة التي من الصعب على العائلة التعامل معها، وذلك لأن وضع البيت صعب والطفل الذى يعاني من عدة إعاقات يحتاج إلى وقت ومهارة أكثر مما تستطيع العائلة توفيره.

إن أسر الأطفال المعاقين عقليا يواجهون العديد من التحديات أكثر بكثير من أسر الأطفال العاديين خاصة عندما يكون الطفل لديه أكثر من إعاقة. كما أن وجود طفل معاق ينطوى على توتر بدرجة عالية وأزمات أسرية كبرى، بالإضافة إلى إجهاد الوالدين والضيق النفسي لأولياء أمور الأطفال المعاقين فى الأوساط الاجتماعية المختلفة. ومن ثم فإن أسر الأطفال المعاقين لديهم احتياجات خاصة (Abdulhade,H.&Radi,M.,2012)، فهم في حاجة إلى المعلومات والدعم والخدمات الإرشادية والتدريبية وغيرها.

ويعرف بيلي وبلاسكو (Bailey&Blasco,1990) الحاجة الأسرية بأنها الرغبة فى الحصول على الخدمات أو الأهداف التى ينبغى تحقيقها من وجهة نظر الأسرة (فى: أشرف العوضي، ٢٠٠١: ٢١٥). ويمكن الإشارة إلى الحاجات الرئيسية لأسر الأطفال المعاقين عقليا" كالتالى:-

أ- الحاجة للمعلومات:-

يعد الحصول على المعلومات من الحاجات الملحة بالنسبة للوالدين، كما أن على أن حاجة الوالدين لفهم تأخر الطفل مطلب عام، كما أنهما بحاجة لمعرفة ما يجب أن يتوقعاه في المستقبل، وهما بحاجة أيضا لمعلومات تتعلق باحتياجات الطفل وكيفية مساعدته ضمن نطاق روتين الحياة اليومية، وتعتمد طبيعة الحاجة للمعلومات على نوع الإعاقة وشدها (Carver,V.,1992:127;Zaidman,A.&Jamies,J.,2007; Fetton,E.&Mearns,J.,2012).

ب- الحاجة للدعم:-

تشير الدراسات إلى أن آباء الأطفال المعاقين عقليا" يلجأون إلى الأخصائيين طلباً للمساعدة والتوجيه عندما يكونوا تحت وطأة الضغوط الخاصة بعدم القدرة على التعايش مع أطفالهم المعاقين عقليا أو تختلف الأسر في استجابتها للمساعدة التى تعرض عليها، لذا فمن المهم مناقشة الوالدين بخصوص نوعية المساعدة التى تلبى احتياجاتهم مع الاعتراف دائماً بأن حاجاتهما قابلة للتغير بتغير الظروف (Rasck,H.,1996,597;James,H.,etal.,2010;Fetton,E.&Mearns, J., 2012).

وترى روزكام وآخر (Roskam,Isabell,et al.,2006) أنه يجب مساندة الوالدين من خلال تقديم خدمات الدعم الانفعالي، والعملية، وتدريبهم على مهارات الوالدية ومساعدتهم فى التعامل مع التحديات التى تؤثر سلبا على قدرتهم على أن يصبحوا آباء على مستوى جيد بما فيه الكفاية.

ج- الحاجات الاجتماعية:-

قد تفقد ولادة الطفل المعاق عقليا الوالدين للانسحاب والعزلة الاجتماعية التي قد تستمر لسنوات، ومن ثم يمكن أن يصبح أكثر عرضه للأخطار الاجتماعية من خلال آراء واتجاهات الآخرين السلبية وعدم دعوتهم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة والمناسبات الرسمية، وبالتالي قد يشعر الوالدان بالإجهاد لعدم حصولهما إلا على قدر ضئيل من المساعدة من قبل الآخرين، ولذلك فإنه من الضروري مساعدة الوالدين في التفاعل الاجتماعي وتوفير مساندة متكاملة من المجتمع لهما (Kirk,S.,et al.,1997,197; Zaidman, A. & Jamieson,2007;Lee,etal., 2008).

د- الحاجة إلى الخدمات المجتمعية:-

من المعروف أن تصورات الوالدين لإحتياجاتهم قد لا تتفق مع تصورات المهنيين لها، ولذلك يجب أن تعد مراكز لتوفير الخدمات لهم وذلك بدراسة الاحتياجات بعناية، بالإضافة إلي التقييم الدوري لمستوى هذه الخدمات (Kirk.S.,et.al.,1997, 197; Fetton,E.& Mearns,J.,2012).

هـ - الحاجات المالية:-

إن العناية الطبية من العمليات الجراحية والأدوات الخاصة، بالإضافة إلى الرعاية اليومية للطفل المعاق عقلياً تشكل جميعها عبئاً مالياً على الوالدين، و بالتالي فهما أكثر تعرضاً للمشكلات الاقتصادية كلما بذلا مجهوداً لسداد تكلفة الخدمات اللازمة للطفل المعاق عقلياً" (حمدي أمين، ٢٠٠٦: ٤٧؛ فيتون وميرنس Fetton, E.& Mearns,J., ٢٠١٢).

و- الحاجات المرتبطة بوظيفة الأسرة:-

يحتاج الوالدين إلى إدراك الأنشطة المرتبطة بوظيفة الأسرة وحل المشاكل وتحديد الأدوار، بالإضافة إلى إيجاد أنظمة للدعم الداخلي للأسرة وإيجاد أنشطة ترفيهية (Culpin,M.,1999,86;Fetton,E.& Mearns,J.,2012). ويذكر سميث (١٩٧١، ٢١٦-٢٢٤) أن الاحتياجات والرغبات للمعاق عقلياً البالغ ٩ سنوات هي نفس احتياجات معظم البالغين الآخرين، ومن هذه الاحتياجات الحاجة إلى النوم- الطعام- الملابس- الحماية - الدفء، ومن الاحتياجات الحيوية التي غالباً ما تهمل الحاجة للحب والتقبل والمرح، وهناك أيضاً احتياجات أخرى مثل حرية الاكتشاف وإشباع حب الاستطلاع وتعلم أشياء هامة وجديدة وشيقة، وإشباع الممارسات الدينية وخلق شيء ما ولا تقل تلك الاحتياجات أهمية للمعاق عن العادي ويحتاج المعاق البالغ بجانب الاحتياجات الأساسية إلى أمن مادي و إرشاد أثناء أوقات حرجة معينة في حياته ويجب أن يتم ذلك من خلال برامج معتمدة لكي تعد المعاق عقلياً البالغ بطريقة تسمح له بالنمو نحو الاستقلالية.

ويشير ميتلر وماكوناش (١٩٩٠) إلى أهمية الاحتياجات الجنسية لدى المعاق عقلياً البالغ، ومن المحتمل أن تكون المشاكل الجنسية الناجمة عن المعاق عقلياً مساوية لنفس المشاكل الجنسية الناجمة عن بعض الشباب العادي، ولكن نحن نتعامل مع المعاق عقلياً بحذر لإشباع هذه الاحتياجات نظراً لظروفه الخاصة.

قائمة المحتويات

- دور الأسرة فى إشباع حاجات الأبناء المعاقين ذهنياً:-

إن إصابة أحد أفراد الأسرة بإعاقة مهما كان نوعها ودرجتها فإنها ترتب على كاهل الأسرة أعباء إضافية تقل أو تكثر وفقاً لمعايير معقده بدءاً بطبيعة الإعاقة مروراً بقدرات سائر أعضاء الأسرة المحيطة وصولاً إلى درجة استيعاب العائلة الكبيرة ومجتمعها المحيط.

وتعد الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى، وتعتبر الطفولة أحد المعالم الأساسية التي تقوم عليها هذه المؤسسة وأهمها العلاقة التي تجمع بين الأم وطفلها، فالأم هي الموضوع الذي يتبنى الطفل من خلاله تصورات حول ذاته وعالمه الخارجى لما توفره له من تواصل بصري وارتباط عاطفي إيجابي يشعره بالأمان (أمنية بزيو، ٢٠١٩)، وعند وجود طفل معاق عقلياً فى الأسرة، ينشأ عنه نوع من الضغوط النفسية التي تؤثر على أفرادها، ولعل الأم أكثر الأفراد تأثراً بإعاقة طفلها باعتبارها الشخص الأكثر اتصالاً به، مما يجعلها تعاني من التوتر النفسى الذى يمتد بالتفكير حول مستقبله، فتبرز لديها مشاعر الخوف والقلق حول مصيره، والخوف من مواجهة المواقف المستقبلية، وعدم القدرة على تلبية كل المتطلبات التي تفرضها تبعات الإعاقة فالطفل المعاق عقلياً له خصائص تختلف عن غيره من الأطفال العاديين نظراً لإمكاناته المحدودة فهو يعاني من قصور فى السلوك وانخفاض فى مستوى الذكاء العام تجعله غير قادر على تحقيق توقعات والديه إلى جانب متطلبات العناية والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم (خديجة مسعود، ٢٠١٥؛ نور الهدى حمداوى، ٢٠١٩)، وتشير الأدبيات إلى أن أسر الأطفال المعاقين عقلياً يعانون من معدل مرتفع من الضغوط الوالدية وخصوصاً فى علاقتهم بطفلهم المعاق وأخوته العاديين مما يؤثر على أخوته نتيجة التعلق الزائد والاهتمام والرعاية من الأسرة وخصوصاً الأم بالطفل المعاق، كما يتأثر التوافق الزوجى بين الأب والأم نتيجة لزيادة الضغوط والمتطلبات التي يحتاجها الطفل المعاق (Gerstein, Crnic, Blacher&Baker, 2009؛ أسامة فاروق وسيد كامل، ٢٠١١)، ويعد الأطفال المعاقين عقلياً وبالأخص الطفل المصاب بمتلازمة داون نجدهم من الأطفال الأكثر حساسية وفى احتياج دائم للرعاية والتأهيل، كما أنهم يتميزون عن غيرهم من الأطفال المعاقين بالكثير من الأمور من أهمها تعدد الإعاقات والأمراض والمشاكل الصحية التي قد يعانون منها والتي من أبرزها التخلف العقلى وهو ما قد يتسبب فى ضغوط حياتية على الأسرة بصفة عامة والأم بصفة خاصة (بدرة ميموني، ٢٠٠٥؛ محمد مصباح، ٢٠١٠)، ويعد قلق المستقبل أحد أنواع القلق التي تشكل خطورة على حياة الفرد والتي تمثل خوفه من المجهول، وينجم عنها خبرات ماضية وحاضرة تشعره بعدم الأمن، وتوقع الخطر والذي يوتر بالطبع على حالته النفسية وتشعره بعدم الاستقرار، مما يؤدي فى النهاية للشعور باليأس، ولذلك يعد قدرة الفرد وتحمله للأعباء جزءاً هاماً فى إدراكهم وتحمل الضغوط سواء بشكل سلبي أو إيجابي (دعاء شلهوب، ٢٠١٥؛ سمية سراج، ٢٠١٩)، ويزيد من هذه الضغوط وجود طفل معاق فى الأسرة حيث تواجه الأسرة والأم بوجه خاص تحديات وضغوط نفسية وعبء يؤثر على حياتها بصفة عامة وخصوصاً أم متلازمة داون، وهذا ما أشار إليه (Rossi, et al.) عن تعرض الآباء والأمهات لضغوط نفسية عند ميلاد طفل معاق (حركياً أو ذهنياً) وأكثر هذه الضغوط هي مشاعر القلق والشعور بالذنب والرفض والانسحاب

قائمة المحتويات

(في: حسن عبد المعطى، ٢٠٠٩)، لذلك فهي في احتياج دائم للشعور بالمرونة النفسية لأنها أساس الشخصية السوية، فالشخص القادر على الاستجابة للمواقف المتباينة هو شخص مرن يستطيع التوافق النفسي الجيد مع ظروف الحياة السيئة ومواقف الحياة الضاغطة التي يواجهها الفرد، فالشخص المرن لديه استراتيجيات تكيف جيدة تثير انفعالات إيجابية بشكل ملموس، مثل التفاوض والسلوك الموجه نحو الهدف (Ong, et al., 2006). ومن ثم تعرف المرونة النفسية على أنها قدرة الفرد على التكيف والبقاء مع المواقف الصعبة (طاهر عمار، ٢٠٢١)، وبذلك فالأم التي تتمتع بمرونة نفسية لديها القدرة على تحمل أعباء الحياة، كما أنها في احتياج للشعور بالأمن النفسي (صافية أبو بكر، ٢٠٢١).

وتؤثر البيئة المنزلية والمدرسة على نمو الذكاء والإصابة بالتأخر العقلي حيث يكون للاستقرار في الحياة العائلية أثراً في نمو الذكاء خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وفي مرحلة الحضانة والمرحلة الابتدائية. فالأسرة والمدرسة يقومان بعملية التنشئة الاجتماعية والغرس الثقافي لإعداد الطفل للحياة الاجتماعية وتحديد الدور الذي يقوم به. ويكون للحالة الصحية أثراً واضحاً في التحصيل الدراسي وتكرار الغياب هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية ودور التغذية. ويكون لكل هذه العوامل أثراً واضح قد يكون مباشراً في حدوث التأخر العقلي خاصة لفئة المتأخرين عقلياً المورون.

وقد أوضحت البحوث الميدانية في مصر أسباب الإعاقة الذهنية والتي يمكن تلخيصها في الإهمال في علاج الأمراض، الإصابة بالحمى بأنواعها والمعروفة محلياً (ارتفاع درجة الحرارة) – كثرة الأمراض منذ الميلاد وتعاطى الكثير من الأدوية. كذلك كثرة تعاطى الأدوية أثناء الحمل، أو استخدام الأدوية التي انتهت صلاحيتها هذا إلى جانب الفارق الزمني بين حدوث الإعاقة واكتشافها يعد من العوامل المباشرة في حدوث الإعاقة، فكلما كان الفارق الزمني قصيراً كلما كان لذلك أثره في الحد من الإعاقة وسرعة مواجهتها أو التعامل معها.

وتلعب الأم دوراً إيجابياً وسلبياً في نفس الوقت في حدوث الإعاقة عامة والإعاقة الذهنية خاصة، إذ تعتبر علاقة الأم بالطفل المعاق من أهم العلاقات فهي تمثل أهم الشخصيات التي يرتبط بها، فهي تقدم له المساعدة والحب والحنان وفي نفس الوقت قد تكون العامل الأساسي في حدوث الإعاقة وذلك لنقص المعرفة لديها، وعدم الوعي بخطورة المرض والعواقب المترتبة عليه، مثل تلوث المياه، وعدم النظافة، وكثرة الذباب، تؤدي إلى حدوث أمراض الإسهال، ويؤدي التهاب اللوز واحتقانها إلى الإصابة بالحمى الروماتيزمية وإهمال علاجها يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، كما يؤدي الانسحاب من المجتمع والعزلة على اعتبار أن الإعاقة تعد وصمة للأسرة، وعدم التفكير في مستقبل الطفل للاعتقاد السائد بأن الطفل المعاق يرزقه الله ويتولى أمره لذلك لا بد أن يترك أمره إلى الله.

وتعد الأمية الثقافية من العوامل الهامة في حدوث الإعاقة الذهنية فغالبية الحالات قد حدثت نتيجة العوامل البيئية المكتسبة بعد الميلاد. لذلك لابد من التركيز على محو الأمية الثقافية خاصة لدى الأم فالنمو العقلي يتأثر بالبيئة الاجتماعية التي يتربى فيها الطفل.

وللطفل المعاق ذهنياً مجموعة من الحاجات النفسية والاجتماعية إلي جوار الحاجات البيولوجية، كما أن له مجموعة من الحاجات الصحية التي يجب أن تشبع داخل الأسرة وعدم إشباعها أو اضطراب أشكال الإشباع نتيجة للاتجاهات السلبية للأسرة أو موقفها النفسي والاجتماعي من الطفل يؤدي إلي تعرض الطفل لعدد من المشكلات، ولعل أكثر الحاجات التي يحتاجها الطفل المعوق داخل الأسرة هي الحاجة إلي الحب والفهم.

إن إشباع هذه الحاجات النفسية والاجتماعية في الوقت المناسب لها، ينتج طفلاً متزناً سليماً قادراً على الاستفادة من عمليات التدريب المختلفة التي يتعلمها سواء في المدرسة أو المنزل .

***الضغوط النفسية التي يتعرض لها آباء وأسر الأطفال المعاقين ذهنياً وافتقارهم لكيفية إدارتها: -**

يحيا والدا الطفل غير العادي بصورة عامة والمعاق ذهنياً تحت ضغوط متعددة وجميعها مرتبطة بالاحتياجات الخاصة لهذا الطفل، وبالقلق على مستقبله وحياته القادمة، مما يزيد من حدة تلك الضغوط على والدي الطفل واعتماديته عليهما، وما يفرضه وجوده عليهما من أعباء سواء داخل المنزل أو خارجه .

ومن بين أهم الضغوط التي يعيش تحت وطأتها آباء وأسر الأطفال المعاقين ذهنياً ما يلي:

- ١- قلة المعلومات بشأن طبيعة المشكلة وأسبابها وكيفية التعامل معها، والتفكير المستمر في البحث عن حلول لها.
- ٢- عدم المعرفة بمصادر الخدمات المتاحة، وبرامج الرعاية العلاجية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية المتوافرة.
- ٣- التوتر والقلق والانشغال إلي حد خوف الزائد على مستقبل الطفل.
- ٤- المشكلات السلوكية والصحية لدى الطفل المعاق ذهنياً مما يستلزم اليقظة والانتباه المستمرين من الوالدين والأخوة.

٥- ضغوط مادية تتمثل في زيادة الأعباء المالية نتيجة ما تستلزمه رعاية الطفل من تكلفة اقتصادية، وما قد يترتب على ذلك من استنزاف معظم موارد الأسرة .

٦- شكوك الوالدين في جدوى تعليم الطفل وتدريبه لاسيما بالنسبة لحالات الإعاقة الذهنية الشديدة والحادة.

٧- الشعور المرير بالحرج والحساسية وعدم الارتياح في المواقف والمناسبات الاجتماعية نتيجة التباعد الملحوظ بين مستوى أداء الطفل المعاق ذهنياً وأداء أقرانه العاديين، إضافة إلي الانطباعات السلبية عن حالته لدى الأصدقاء والمعارف، مما يدفع الوالدين إلي تجنب الطفل مثل هذه المواقف والمناسبات فيزداد شعوره بالوحدة والعزلة والإحباط .

٨- صرف معظم وقت الوالدين في رعاية الطفل وشعورهما بالإرهاق لما تتطلبه حالته من اهتمام مستمر.

٩- ضالة الوقت المتاح لرعاية الأبناء، وقلة فرص الشعور بالاستمتاع، وممارسة النشاطات الترويحية وإسباغ الاهتمامات والميول الشخصية سواء لدى الوالدين أم بقية الأبناء.

وتشكل هذه الضغوط عبئاً ثقيلاً على كاهل الوالدين والأسرة كما تلقى بظلال كثيفة على المناخ الأسرى، وهو ما يستلزم الإرشاد النفسي للوالدين وأعضاء الأسرة لمساعدة جميع الأطراف على معايشة هذه الضغوط والصمود أمامها، والتعامل معها بصورة إيجابية.

- دور الوالدين في ارتقاء وتحسين مستوى التوافق النفسي لأبنائهم المعاقين عقلياً:



١- دور الوالدين وأهميته في تنمية الطفل المعاق عقلياً (القابل للتعلم)، ووصوله لأعلى مستوى من التوافق النفسي.

حيث تعتبر الأسرة هي الخلية الرئيسية في المجتمع وعليها عبء التنشئة الاجتماعية ولذلك لا يمكن إغفال دور الأسرة في مساعدة أبنائها، وستظل الأسرة هي المسؤولة عن القيام بهذا الدور مهما شاركتها في ذلك بعض المؤسسات الأخرى في المجتمع.

وتربية الأطفال مسؤولية كبيرة مهمة صعبة وشاقة، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأطفال العاديين فهو أكثر صعوبة وأكثر مشقة بالنسبة للأطفال المعاقين عقلياً، وذلك لأن أسرة الطفل المعاق عقلياً تواجه مشكلات وتتصدى لتحديات خاصة إضافة إلى تلك التي تواجهها الأسر جميعاً، فالأعاقة العقلية غالباً ما تتطوى على صعوبات ومشكلات مادية ونفسية وطبية واجتماعية وتربوية (Stone, F., 1990: 196).

٢- ردود فعل الوالدين النفسية تجاه طفلهم المعاق عقلياً:

يحدث الطفل المعاق عقلياً لدى والديه ردود فعل قد تعوق التواصل والتفاعل بين الوالدين وبينه، وبين الوالدين والمجتمع بشكل عام، ويذكر "جوردان" Jordan (١٩٩١: ٣٠) أن هناك توقعات يحتفظ بها الوالدان خاصة بأطفالهما حديثي الولادة فإذا ما حدث ذلك تكون النتيجة مفزعة لهما، وغالباً ما تشير هذه النتيجة مشاعر يمتزج فيها الخوف بالألم، وخيبة الأمل بالشعور بالذنب، والارتباك والعجز والقصور.

ويلخص "عادل عز الدين الأشول" (١٩٩٣: ٢٧-٢٨) أهم ردود الفعل الشائعة لدى الوالدين تتمثل فيما يلي:

قائمة المحتويات

- القلق، الشعور بالذنب والإحباط، واليأس، والعجز عن مواجهته الموقف.
- التشكك في التشخيص.
- الاعتراف بإعاقة الطفل.
- التبصر بمشكلة الطفل وقبول إعاقته والسعي إلى تعليمه وتأهيله.

وعلى الرغم من أن ردود الفعل تتباين من حيث شدتهما ومدتها والمراحل التي تظهر بها، إلا أن الوالدين يمكن أن يمروا بها ويصبحون أكثر توافقاً مع أنفسهما ومع أطفالهما وأيضاً مع المجتمع، ولا يتم ذلك إلا بتفهم مشاعر الوالدين وتدعيمهما، مع توضيح أسباب إعاقة طفلهما، وإتاحة الفرصة لهما للتعرف على الخدمات المتاحة أو البرامج المناسبة لطفلهما، بالإضافة إلى توضيح أهمية الدور الذي يقوم به بمشاركتهم في تنمية وتدريب طفلهما، ومدى تأثير هذه المساندة الفعالة على كل من الطفل والوالدين (ألفت محمود نجيب، ٢٠٠٠: ٣٥-٣٦؛ جيمس وآخرون. James,etal, ٢٠١٠؛ فيتون وميرنس Fetton & Mearns, ٢٠١٢).

وكلما شارك الوالدان في جعل الطفل يعيش في بيئة أكثر طبيعية، وأكثر توافقاً يعود بنتائج إيجابية على الطفل في توافقه مع أسرته ومجتمعه، كلما أصبح الوالدان أقل شعوراً بالذنب.

٣- مشاركة الوالدين في تربية الطفل المعاق عقلياً:

إن الطفل جزء لا يتجزأ من أسرته، ولا يمكن فصلهما أثناء التعامل مع أحدهما، لذلك فهناك أهمية لمشاركة الوالدين في تربية وتنمية طفلهما المعاق عقلياً والأدوار التي يتخذها الوالدان للمشاركة (ألفت محمود نجيب، ٢٠٠٠، ٣٦؛ شيلي وآخرون. Selly,etal, ٢٠٠٨؛ ديفز وآخرون. Davis,etal, ٢٠٠٩).

وبذلك فإن إشراك الوالدين في تربية أطفالهما، إنما هو واجب اجتماعي ومطلب تشريعي، وبخاصة في حالة الأطفال الذين يعانون من الإعاقة، فالتشريعات التربوية تنص على ضرورة مشاركة الوالدين في تربية أطفالهما ذوي الحاجات الخاصة، وحاجات الطفل المعاق ووالديه تضيف أهمية متزايدة على دور الوالدين في تربية الطفل (جمال محمد الخطيب، ١٩٩٣، ١٦٤).

ويؤكد "فاروق محمد صادق" (١٩٩٧، ١٨) على الوالدين مسئولية تجاه طفلهما المعاق عقلياً في تحمل المسئولية والرعاية، فكلنا راع وكل راع مسئول عن رعيته، فالطفل مسئولية الوالدين قبل أن تكون مسئولية أي فرد آخر، وبذلك فإن إرشاد الوالدين ومساندتهما يمكن تبريره على إنه الدور الأساسي والهام في حياة الطفل المعاق عقلياً للارتقاء به، ووصوله للتوافق النفسي.

ويتفق "كمال إبراهيم مرسى" (١٩٩٦، ٣٠١-٣٠٣) مع ما سبق من تأكيده على مسئولية الوالدين في رعاية طفلهما المعاق عقلياً أكثر من مسئوليتهم في رعاية الطفل العادي، وذلك لأن الطفل المعاق يحتاج إلى رعاية نفسية وتربوية، مما يجعل رعايته في الاسرة عملية مجهدة ومكلفة خاصة بالنسبة للأُم لأن لها الدور الأكبر في العناية بالطفل، ومساعدته على الاستفادة من مؤسسات المجتمع، والتعاون مع المدارس ومراكز التأهيل والتدريب في رعاية الطفل المعاق عقلياً.

قائمة المحتويات

ولا يوجد تشابه بين أسر المعاقين عقليا، فكل أسرة لها خصائصها الفريدة وتتمتع بمواطن قوة محددة وقد تعاني من مواطن ضعف معينة، ولهذا السبب نجد ان الدراسات العلمية التي بحثت في هذا الموضوع انتهت إلى ثلاث قضايا أساسية وهي:-

أ- أن الإعاقة العقلية قد تفرض على الوالدين تغيرات معينة مهمة في مجرى حياتهما وهي تقود إلى شعور بالحزن الذي يختفي أحيانا" ولكن قد يعود فيظهر مجددا".

ب- إن الإعاقة العقلية شيء غير متوقع فكل أب وأم في الدنيا ينتظرون طفلاً عاديا "بل قل مثاليا"، ولذلك فليس غريبا أن تمثل هذه الحالة صفة للأمال لدى الوالدين.

ج- لما كانت حالة الإعاقة العقلية تشكل أزمة حقيقية فإنها تحدث رودود فعل نفسية قد تكون شديدة (حمدي أمين، ٢٠٠٦: ٤٣-٤٤).

***الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع والدي المعاق:-**

- أن يظهر المرشد النفسي التعاطف والتفهم لحالة الوالدين النفسية مع الشرح الوافي لحالة الطفل ودرجة تأخره العقلي.
- أن يوضح للوالدين أن حالة المعاق عقليا" يمكن التغلب عليها بتنمية جوانب القوة لدى الطفل لإعادة توافقه مع المجتمع.
- أن يركز على بعض التوجيهات العامة التي تساعد على قبول الواقع والتعامل معه مع الاستعانة بالمفاهيم الدينية عن القضاء والقدر.
- أن يوضح للوالدين الاسباب المختلفة للإعاقة العقلية، وتوجيههم للخدمات التي تتناسب مع حال طفلهم المعاق، بدلا من الإحساس بالذنب الذي لا يفيد بل يقلل من قدرة الوالدين على معرفة أساليب التأهيل الصحيحة (يوسف عبد الحميد، ٢٠٠٤: ٣٨١).

-جودة الحياة الأسرية واضطرابات اللغة والتواصل:

تلعب الأسرة دور بالغ الأهمية في عمليات نمو السلوك الاجتماعي والقدرة على التواصل، فالوالدين بالنسبة لطفلها هما مفتاح الحياة، إذ منهما يستمد العطف والحنان والدفع والأمان، وتؤثر نوعية العلاقات المتبادلة بين الطفل وأسرته على ثقة الطفل بنفسه أو تحط من قدره لذاته، أن التشجيع والعطف والالتزان في العلاقات الأسرية يجعل شخصية الطفل تنمو نموا سليما (أمني عبدالمقصود، سميرة شند، ٢٠١٠).

ومن حيث تأثير أبعاد جودة الحياة الأسرية على نمو المهارات اللغوية فقد توصلت دراسة "برنشتين" في هذا المجال إلى أن أنماط التواصل اللفظي في بعض أسر الطبقات المتدنية ثقافيا في بريطانيا ووصفها بأنها نمط ضيق ذو اتجاه واحد لا يشجع على تبادل الحديث والحوار ويعتمد على إصدار الأوامر للطفل دون إعطائه الفرصة للتساؤل أو حتى تقديم مبرر للأمر الذي يصدر إليه من سلطة أعلى متمثلة في الأب والأم (هدى محمود الناشف، ٢٠٠٧، ٤٨).

ويؤثر المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في نمو أو ضعف اللغة لدى التلاميذ، كما أن أطفال المؤسسات والملاجئ أقل محصولاً من الناحية اللغوية مقارنة مع التلاميذ الذين يربون في أسرهم بسبب قلة خبراتهم واتصالهم مع الآخرين وإهمالهم أحياناً (فاروق الروسان، ٢٠٠٠، ١٤).

وقد أجرى جوردون وآخرون (Gordon, et al, 2003) دراسة استهدفت التعرف على دور أولياء الأمور من خلال مهاراتهم في نمو القدرة على الاتصال بالكلام لأطفالهم وبلغت عينة البحث (٥٠) طفل من الذين يعانون من اضطرابات التواصل وعائلاتهم من الآباء والأمهات، وتوصلت الدراسة إلى أن الآباء يختلفون في تفاعلهم مع أطفالهم، كما أن تفاعلات الآباء مع أطفالهم تختلف عن الأمهات في حديث الطفل الموجه.

وقد نشأ مفهوم جودة الحياة الأسرية (FQOL) من فكرة أن العائلات تشكل الأساس الرئيسي لوظيفة واستقرار المجتمعات المعاصرة (Brown & Brown, 2003). ووفقاً لنظرية النظام الأسري، يرتبط كل فرد من أفراد الأسرة ببعضه البعض وببيئتهم لتشكيل منظومة كلية، لذلك فإن أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقات يغير نظام الأسرة وكيفية التفاعل مع المجتمع (Bertelli, Bianco, Rossi, Scuticchio & Brown, 2011).

ويعتبر الأطفال الذين لديهم قصور في السمع والكلام لديهم مستويات منخفضة في جودة الحياة، كما ينخفض مستوى جودة الحياة الأسرية للوالدين الذين لديهم أطفال ضعاف السمع والكلام (Haukedal, et al., 2018). كما تتأثر جودة الحياة الأسرية بصعوبات الكلام أو اللغة لدى الأطفال، حيث تتأثر مخاوف الوالدين المتعلقة بالكلام/ اللغة واكتئاب الأمهات بجودة الحياة الأسرية لدى الأبناء ذوي صعوبات النطق والتواصل (Feeney, et al., 2016). ويعاني آباء الأطفال الذين يعانون من ضعف في الكلام والسمع في سن ما قبل المدرسة من HRQOL أقل من آباء الأطفال الأصحاء في نفس العمر، وتتأثر أمهات الأطفال ضعاف السمع بشكل خاص مما يدل على تأثير سلبي في جميع المجالات الصحية تقريباً.

كما تتأثر جودة الحياة الأسرية للوالدين الذين لديهم أطفال يعانون من اضطرابات في اللغة والتواصل، حيث تتأثر عملية التفاعل بين الوالدين والطفل مما ينعكس سلباً على التفاعل الاجتماعي للطفل ومهارات التواصل ومن ثم جودة حياته الأسرية (Aras, I., et al., 2014).

كما أوضحت دراسة سهى عدنان جمول (٢٠١٤) وجود علاقة ارتباطية بين جودة الحياة الأسرية وتحسن مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

أنشطة تدريبية

- س ١- وضح الاحتياجات التربوية للنمو النفسي والاجتماعي لدى المعاقين سمعياً والمعاقين بصرياً؟
- س ٢- الحاجات الأساسية لأسر الأطفال المعاقين عقلياً. ناقش هذه العبارة؟
- س ٣- للأسرة دور في إشباع حاجات الأبناء المعاقين ذهنياً. ناقش هذه العبارة؟
- س ٤- يتعرض والدي المعاقين لكم من الضغوط النفسية. ناقش هذه العبارة؟

روابط إلكترونية

روابط إلكترونية يمكن الاستعانة بها:

<https://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/DisabilityAndSociety/SpecialNeedsDemands.htm>

<https://www.moh.gov.sa/awarenessplatform/VariousTopics/Pages/Disability.aspx>

[/https://altibbi.com](https://altibbi.com)

<https://islamonline.net/archive>

الفصل الرابع

ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية المستدامة (برامج التدخل)

الأهداف التربوية والتأهيلية لبرامج الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم.

- التدريب على المهارات الاجتماعية كطريقة علاجية.
 - مهارة إدارة الذات.
 - استراتيجية اللعب وأهميته.
 - اللعب والطفل التوحدي.
 - ملامح البرامج الإرشادية والتأهيلية لأسر الأطفال المعاقين عقليا.
 - كيفية التعامل مع الطفولة المعاقة ذهنياً.
 - التأهيل النفسي للمعاقين.
 - أهداف برامج التأهيل النفسي.
 - طرق تعليم الأطفال.
 - المحافظة على نفسية الطفل ذوي الإعاقة.
 - دور الأسرة في تعديل الاتجاه نحو الابن وأساليب معاملته.
 - تعامل الأسرة مع أخوة الطفل المعاق.
 - تفاعل الأسرة مع المجتمع المحيط وأسرة الأطفال المعاقين.
 - تعاون الأسرة مع الفنيين المعنيين بحالة الابن المعاق
- #### التدخل المبكر

- مفهوم التدخل المبكر.
- أهمية التدخل المبكر.
- طرق التدخل المبكر.
- ١ - البرامج الوقائية في الطفولة المبكرة. 2 - البرامج الإنمائية في الطفولة المبكرة.
- المهارات الاجتماعية.
- أهم برامج تنمية المهارات الاجتماعية.
- علاج التوحد.
- برامج التدخل.
- العلاج بالفن في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أساليب تعليميه جديده لذوي الاحتياجات الخاصة .

مخرجات التعلم المستهدفة

في نهاية الفصل يصبح الطالب قادرًا على أن:

- يذكر طرق الاكتشاف المبكر للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يتعرف على طرق رعاية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يشرح برامج تنمية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يعدد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وخصائص كل فئة.
- يستنتج أهمية الاكتشاف المبكر للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يناقش طرق الرعاية المقدمة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يختار البرامج التربوية المناسبة بتنمية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاص.
- يحلل إجراءات ومتطلبات الدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يطبق البرامج التي تساعد على تنمية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يستخدم الأنشطة المناسبة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يقيم طرق تشخيص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يعمل في فريق لاختيار البرامج المناسبة لتنمية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يتواصل بفاعلية مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء تطبيق الاختبارات النفسية عليهم.
- يستخدم الحاسب الآلي لتطبيق الأنشطة العملية التي تنمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفصل الرابع

نوي الاحتياجات الخاصة والتنمية المستدامة

(برامج التدخل)

المبادئ الأساسية في إرشاد المعاقين بشكل عام :

- ١-المعاق له جميع متطلبات الفرد العادي بالإضافة إلى متطلبات الإعاقة .
- ٢-يحتاج المعاق إلى التدريب على المهارات الأساسية للتوافق مع الآخرين .
- ٣-يحتاج المعاق إلى التشجيع المستمر للاعتماد على نفسه وتحقيق الاستقلالية
- ٤-يحتاج المعاق إلى التركيز على مواطن القوة لديه .
- ٥-يحتاج المعاق إلى تقديم المساعدة له وقت الحاجة إليها فقط .

المبادئ الأساسية في إرشاد أسرة المعاق:

- ١-مشكلة المعاق هي مشكلة الأسرة كلها .
- ٢-يجب الاستفادة من فهم الأسرة للشخص المعاق وتشجيعهم على التعاون .
- ٣-يجب مساعدة الوالدين على التخلص من الأزمة النفسية التي يعانيان منها بسبب وجود هذا المعاق .
- ٤-يجب إيضاح معنى الإعاقة للأسرة وتحديد درجة هذه الإعاقة لابنهم وضرورة التوافق معها والتعاون في تقديم الخدمات لهذا الفرد.

الخدمات الإرشادية:

أ-الإرشاد العلاجي :

- ١-دراسة شخصية الفرد المعاق عقلياً .
- ٢-دراسة المشكلات النفسية المرتبطة بالإعاقة .

ب-الإرشاد التربوي :

- ١-توفير فرص التعليم لهذه الفئة واختيار المناهج المناسبة لهم .
- ٢-تنمية الاستفادة من الحواس الموجودة لدى الفرد المعاق.
- ٣-تنمية الاعتماد على النفس بقدر الإمكان .

ج-الإرشاد المهني :

الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل المهني حسب الحالة.

د-الإرشاد الأسري :

يبدأ منذ مجيء الطفل المعاق ومنها :
تقبل الحالة – تعديل اتجاهات الأسرة نحو المعاق- تجنب أساليب الرعاية الوالدية الخاطئة مثل: الحماية الزائدة –
تخليص الوالدين من مشاعر الذنب بخصوص إعاقة طفلها .

*الأهداف التربوية والتأهيلية لبرامج الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم:

إن الأغراض التربوية لأي برنامج تختلف من برنامج لآخر وذلك تبعا للفئة الموجه لها البرنامج، وبالتالي فإن أهداف البرامج الموجهة إلى الأطفال المعاقين عقليا هي مساعدتهم على الاستفادة مما لديهم من طاقات محدودة، ونحن لا نتوقع أن نساعد الطفل المعاق على أن يصبح طفلا عاديا ولكن على الأقل يمكننا أن نوصله إلى مستوى من الكفاية الشخصية والاجتماعية بالشكل الذي يستطيع فيه أن يشق طريقه مع العاديين معتمدا على نفسه إلى حد ما، لذلك كان من الضروري أن تدور الخبرات التربوية حول هذه الأغراض، وهكذا فإن أي برنامج لتدريب وتأهيل المعاقين عقليا يجب أن يوجه نحو تحقيق الأهداف الآتية:

أ- مجال التنمية والتوافق الشخصي:

- إن النمو والتوافق الشخصي يعني كل ما يعزز شعور الطفل بقيمته الذاتية واستقلاله ووجوده الشخصي ويمكنه من التوجيه الذاتي والاعتماد على نفسه بقدر استطاعته وذلك عن طريق الآتي:
- 1- تعلم وممارسة المهارات الاستقلالية الأساسية واللازمة للعناية بالذات والاعتماد على النفس في الملبس والمأكل وقضاء الحاجة والنظافة الشخصية واتقاء الأخطار وتجنب الحوادث.
 - 2- اكتساب المهارات الحركية ومساعدة الطفل على التحكم والتأزر الحسي الحركي، وتحسن قدرته على الانتباه والتركيز والتمييز الحسي.
 - 3- اكتساب وممارسة بعض مهارات النمو اللغوي ومساعدته على إدراك المعاني والمفاهيم اللغوية.
 - 4- تنمية المهارات اللغوية لدى الطفل وقدرته على التطبيق والكلام وتشجيعه على الاتصال اللفظي والتفاهم مع الآخرين.
 - 5- اكتساب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة مهارات الحياة اليومية كإدراك الوقت والزمن ومهارات التنقل واستخدام المواصلات والتعامل بالنقود والأرقام والاتصال بالآخرين واستخدام مسميات الأشياء والتمييز بينهما.
 - 6- تعلم العادات الصحية السليمة وممارستها لتمكينه من الحفاظ على صحته.
 - 7- تدعيم الصحة النفسية للطفل من خلال مساعدته على ضبط انفعالاته وتقبل ذاته والثقة بنفسه، وإظهار الانفعالات المناسبة.
 - 8- تنمية قدرته البصرية والسمعية والحركية والعضلية وإكسابه بعضا من المهارات اللازمة لشغل وقت الفراغ.

ب- مجال التنمية والتوافق الاجتماعي:

- يعني تأهيل المعاق للحياة الاجتماعية وممارسة الدور الاجتماعي وذلك عن طريق:
- 1- تنمية مهاراته الاجتماعية ومقومات السلوك الاجتماعي، كاحترام العادات والتقاليد وآداب الحديث والسلوك والتعاون ومراعاة مشاعر الآخرين والحفاظ على ملكية الآخرين والملكية العامة وتحمل المسؤولية إزاء تصرفاته وأفعاله.
 - 2- توسيع نطاق خبراته الاجتماعية وتشجيعه على تكوين علاقات اجتماعية طيبة ومثمرة مع الآخرين وذلك بتهيئة المواقف الاجتماعية المناسبة والمتكررة للاندماج مع الآخرين ومشاركتهم الأنشطة المختلفة والتفاعل الإيجابي معهم.
 - 3- تشجيع الطفل على التكيف مع مختلف المواقف والظروف التي يواجهها وحسن التصرف فيها.
 - 4- علاج الاضطرابات السلوكية ومظاهر السلوك المضاد للمجتمع لدى المعاقين عقليا كالعنصرية والميل إلى إيذاء الآخرين والانسحاب والعادات غير المقبولة أو الشاذة.

قائمة المحتويات

٥- تنمية مهارات السلوك الاجتماعي كتحمل الآخرين والتعاون والمساندة وتبادل الأخذ والعطاء والمشاركة الاجتماعية.

ج- مجال التنمية المهنية:

يعد تأهيل المعاقين للحياة العملية ومساعدتهم على تحقيق استقلاليتهم واكتفائهم الذاتي من الناحية الاقتصادية بشكل جزئي أو كلي وطبقا لما تسمح به استعداداتهم من أهم الغايات التي تسعى البرامج التربوية والتأهيلية إلى تحقيقها وذلك عن طريق الآتي:

- ١- الكشف عن استعداداتهم المهنية وتعريفهم بأسماء المهن والوظائف والأدوات المستخدمة في كل منها.
- ٢- التدريب على عمل ما أو مهنة مناسبة تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، وتنمية مهارات الأداء اللازم لها.
- ٣- إكسابهم العادات والاتجاهات المهنية الملائمة، والسلوك المهني المقبول ومهارات الحفاظ على المهنة.
- ٤- السعي لدى الجهات المختصة لتوفير فرص العمل والتشغيل (خولة يحيى وماجدة عبيد، ٢٠٠٥، ١٤٩-١٥٢).

وهناك طرق وأساليب للتدخل تقسم إلى ثلاثة تصنيفات عامة: الطرق المبنية على العلاقة، الطرق المبنية على المهارة، الطرق المبنية على علم وظائف الأعضاء، وإنشاء العلاقات يقود إلى تطور المهارات وإلى تحسن في أعراض اضطرابات طيف التوحد، أما طريقة التدخل المبنية على المهارات فتشير إلى أن الأطفال المعاقين يعانون من قصور يمكن تحسينه من خلال اكتساب المهارات التي تعتبر ضرورية للتفاعل والتواصل والمشاركة، وقد حظيت هذه الطريقة بكم كبير من الدراسات التي تدعم فاعليتها بالنسبة للأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، وعملت على تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للطلبة ذوي اضطرابات طيف التوحد بشكل عام، أما الطرق المبنية على وظائف الأعضاء فتعمل على تطوير أداء الحواس والأعصاب لتحسين السلوك والعلاقات، واقترح بعض المؤيدين استخدام هذا المنحى لعلاج أعراض اضطرابات طيف التوحد (ASDS) أملا في تعديل آلية استقبال ومعالجة النظام العصبي للمعلومات، فإن تصحيح القصور البيولوجي والعصبي يؤدي إلى تراجع أعراض اضطرابات طيف التوحد، وبالتالي فإن الفرد يستطيع أن يطور العلاقات وأن يتعلم المهارات (ل. خوان هيفلين، دونا فيورينو أليمو، ٢٠١١، ١٤١: ١٤٣).

-التدريب على المهارات الاجتماعية كطريقة علاجية:

ترتبط العديد من الاضطرابات النفسية والسلوكية والتربوية بالقصور في المهارات الاجتماعية، فقد أثبتت الدراسات النفسية أن القصور في المهارات الاجتماعية مرتبط بالعديد من الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والخجل والخوف والانسحاب. وكذلك العديد من الاضطرابات السلوكية مثل: النشاط الحركي الزائد ونقص الانتباه والعدوان والمشكلات السلوكية داخل المدرسة، وترتبط بالعديد من المشكلات التربوية، مثل: صعوبات التعلم والتأخر الدراسي، ويلحظ القصور في المهارات الاجتماعية لدى الذين يعانون من مشكلات في القدرات العقلية، مثل: التخلف العقلي، ويوجد قصور في المهارات الاجتماعية لدى ذوي الاضطرابات النمائية، مثل: اضطراب التوحد (سعد رياض، ٢٠١٠، ١١٧).

قائمة المحتويات

وانخفاض مستوى المهارات الاجتماعية قد يفسر ذلك الإخفاق الذي يعانيه الطفل في مواقف التفاعل الاجتماعي، والذي يتمثل في عدم استثمار الفرص المتاحة لإقامة علاقات مع الآخرين، ويضاف إلى ذلك أن ذوي المهارات الاجتماعية المنخفضة لديهم صعوبة في فهم وتفسير سلوك ومقاصد الآخرين على نحو يستدعي ردود أفعال قد تؤثر سلباً على العلاقة معهم، ومن المتفق عليه أن المهارات الاجتماعية من المحددات الرئيسة لنجاح الفرد أو فشله في المواقف الاجتماعية المتنوعة (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١١١-١١٢).

وذكرت كل من: ل. خوان هيفلين، دونا فيورينو آليمو (٢٠١١، ٣٧٩) أن التدريس المباشر للمهارات الاجتماعية يمكنه أن يكون فعالاً في تعزيز اكتساب المهارات الضرورية للتفاعل مع الآخرين، كما أن النمذجة والممارسة والتلقين والتحصير والتعزيز أظهرت بعض الفاعلية الواضحة في تدريس المهارات الاجتماعية من خلال استخدام الاستراتيجيات البصرية لتلقين حدوث السلوك، وتدريب الطلبة على التسجيل الذاتي للسلوكيات قد يؤدي إلى تعزيز الاستمرارية في إظهار السلوك وتعميمه.

ولما كانت الإعاقة الذهنية تمثل مشكلة يعاني منها الطفل وعائلته من حيث كونها مرض أصاب الطفل فيحد من قدرته، وطاقاته كعضو في المجتمع له دور وعلاقات ومسؤوليات نحو نفسه، ونحو المجتمع الذي يعيش فيه فإن التنمية المستدامة للطفل المعاق كمورد من الموارد البشرية تركز الاهتمام على تنمية ما لديه من قدرات. ويتم ذلك عن طريق التدريب الاجتماعي لإعادة إدماجه في المجتمع لأخذ مكانه في البناء الاجتماعي الذي يتضمن الجماعات الاجتماعية التي ينتظم فيها الأفراد في علاقات اجتماعية محددة.

ويتضمن البناء الاجتماعي أنماط مختلفة من الجماعات مثل:

جماعة السن، النوع، الجيرة، المدرسة، اللعب، وينتمي الأطفال إلى هذه الجماعات وفقاً لقدراتهم على أداء دورهم حسب نوع الإعاقة الذهنية.

ويكون للتدريب الاجتماعي أثر هام في تنمية قدرات المعاقين وذلك بالانتماء، حيث أن الانتماء يحولهم إلى مواطنين مساويين لغيرهم، ويحولهم من العزلة إلى المشاركة في الأنشطة المجتمعية المناسبة لقدراتهم فالفرد الذي يزداد نشاطه الاجتماعي ويشارك في حياة الجماعة لا يؤثر في وجوده الاجتماعي أن يكون معاقاً. وتحتاج رعاية المعاقين إلى تضافر جهود المتخصصين في مختلف المجالات الاجتماعية، النفسية، الطبية، والمهنية.

ويركز التدريب الاجتماعي على:

- ١- المظهر العام للطفل المعاق
- ٢- التدريب على بعض الممارسات للحفاظ على المظهر العام
- ٣- التدريب داخل مؤسسات الرعاية أو الرعاية المنزلية على بعض الممارسات اليومية لاكتساب عادات اجتماعية.
- ٤- إعداد برنامج مدرسي خاص يتناسب وظروف الطفل المعاق ودرجة الإعاقة.
- ٥- إعداد برنامج مهني داخل مؤسسات الرعاية وخارجها يمكن الطفل المعاق من الاعتماد على نفسه لكسب عيشه.
- ٦- تكوين جماعات نشاط لإلحاق الطفل بها والمشاركة في مختلف الأنشطة وفقاً لنوع الإعاقة وقدرات الطفل.

قائمة المحتويات

٧- ربط الطفل بالعالم الخارجي للقضاء على العزلة والعودة إلى البيئة الطبيعية والاجتماعية.

٨- كما وضع برنامج للتدريب الاجتماعي لفئة المتأخرين عقلياً من فئة المورون Faille Minded ممن تتراوح أعمارهم بين ١٢ - ١٦ سنة داخل مؤسسات الرعاية وخارج مؤسسات الرعاية، حيث أشتمل البرنامج على:- برنامج دراسي، برنامج مهني، برامج النشاط الاجتماعي والرياضي، الارتباط بالعالم الخارجي، الانتماءات الاجتماعية، والإعداد للعودة إلى البيئة الاجتماعية الطبيعية. وأثبت البرنامج فعاليته في تدريب الأطفال على المهارات اللازمة التي من شأنها جعلهم أفراد عاملين ومنتجين في المجتمع، وقادرين على إعالة أنفسهم دون الاعتماد على الآخرين.

ويقوم التفاعل الاجتماعي بتزويد الطفل بخبرات تعليمية تساعد على تعلم المهارات الاجتماعية وتعلم المهارات اللغوية والحركية وطرق التعبير عن المشاعر والعواطف وتعرفه بالقيم الأخلاقية. ويلعب هذا التفاعل دوراً كبيراً في عملية النمو الاجتماعي لدى كل من الأطفال العاديين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فمن منا لا يحتاج إلى تواصل وتفاعل اجتماعي مهما اختلف مستواه التعليمي أو الاجتماعي أو حتى قدراته العقلية والجسدية والنفسية؟ وكأي فرد من أفراد المجتمع يحتاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتفاعل الاجتماعي والذي يكسبهم ثقة وأمان.

فالطفل المعاق لا يحتاج لشفقة بقدر ما يحتاج لعطف وحنان وتفهم لإعاquته ودرجة هذه الإعاقة. والقاعدة الأهم والأعم في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة هي التعامل الفردي (أي أن تعامله باستقلالية وتشعره باهتمام وانتباه). حيث أن إحساس الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة بنفسه يأتي من خلال معاملتك له. وللتواصل الاجتماعي فنون لا تقتصر على طبقة معينة من الناس. فهناك أيضاً فن التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد يصادف أن تلتقي بهذه الفئة في مكان عام أو في الطرقات أو حتى تكون مستضيفاً لهم في بيتك. فما هي أصول التعامل مع الأطفال في المواقف والمناسبات الاجتماعية؟

- أولاً: ما يتوجب عمله عند لقائك أو استقبالك لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة:
- ١- حاول أن تبادر بالتعارف وخاصة إذا كان الطفل يستجيب للمس الجسدي بحيث تعانقه بدفء أو بمد يديك على كتفه والربت عليه لطمأننته وإكسابه شعوراً بالأمن.
 - ٢- إسأل الطفل عن أسمه بنبرة هادئة محافظاً على ابتسامتك. فإن كان لا يعرف أسمه انتظر الرد من المرافق له. وبعد أن تعرف أسمه حبيه بأسمه بصوت هادئ (أهلاً يا محمد. إزى حالك؟)
 - ٣- إن كان لديك أطفال أطلب منهم أن يبادروا بالتحية والترحيب كما فعلت وذلك لكسر الخوف والغربة في نفس المعاق (إذابة الثلج). كما أنه عليك تشجيع الأطفال الموجودين على اللعب معه كي لا يضجر الطفل.
 - ٤- إن الصوت والكلمات المستخدمة جزء لا يتجزأ من عملية التواصل فنبرة الصوت الهادئة وسرعة الكلام البطيئة من شأنها أن تزرع الأمن والثقة وتزيد من تفاعل الطفل ذو الاحتياجات الخاصة.
 - ٥- لا تنسى التواصل الجسدي مع هذه الفئة فانحناء الجسم للأمام والذي يرافقه التواصل البصري يعبر عن الاهتمام ويوحى للطفل بأن ما يقوله مهم مما يدعم ويعزز مشاركة الطفل في عملية التواصل.
 - ٦- قد يسيء هؤلاء الأطفال تفسير المواقف الاجتماعية وقد يستجيبون لها بطريقة غير ملائمة حيث يكون النمو الاجتماعي لتلك الفئة ضعيفاً ويظهر ذلك في المواقف الاجتماعية، فعلى من يتعامل معهم أن يحاول تفهم ذلك وتداركه بجذبهم للمشاركة وخاصة إن كانوا يحاولون التتحي والانسحاب، فهم بحاجة ماسة للتشجيع على الدمج.

قائمة المحتويات

٧- من المهم مكافأة وتعزيز هؤلاء الأطفال لتشجيع التواصل والاتصال لديهم.

ثانياً: عند محاولة الحديث والمشاركة مع هذه الفئات في المواقف الاجتماعية المختلفة، وعند محاولة الطفل التعبير عن ذاته يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

١- استمع له:

إذا أتاك طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة محدثاً فعليك الاستماع إليه وعدم استعجاله بالكلام. فقد يتأفف البعض ويحاول الاستعجال بحجة عدم فهمهم لما يقوله الطفل. فمما لا تترك في هذه الحال إعطاء الطفل فرصة للتعبير عما يجول في خاطره والتنفيس عما في داخله حتى لو كان بالأصوات. فعندما يتواصل الطفل ذو الاحتياجات الخاصة مع أي فرد كان فهو يحاول جاهداً أن يقول لك ما يشعر به، بل ولربما يريد أن يعبر لك عن مدى سعادته. لذلك علينا محاولة فهم ما يقول ومساعدته في التعبير عن نفسه حتى لو استدعى الأمر الاستعانة بمن يساعدك على فهم أقواله في ذاك الموقف.

٢- أشعره باهتمامك فيما يقول.

أعط الطفل اهتمامك وأصغ إليه حتى لو لم تفهم كل ما يخبرك به. وإياك أن تشعره باللامبالاة فيما يقول أو أنك غير مكترث. فإن حسن استماعك للطفل وعدم مقاطعتك لتعبيراته تشجعه على تطوير مهارة التعبير عن الذات والإنتاج اللفظي.

٣- تعديل السلوك.

إن أخطأ الطفل ذو الاحتياجات الخاصة إياك وأن تعاقبه بقسوة جارحة ولا أن تفرط في تدليله بتجاوزك لأخطائه. فالقسوة الجارحة ستنبعها نظرات ضيق وشعور بالحزن والانتقاص من قدره وخاصة إذا حدث هذا أمام الناس. كما يجب عدم تجاوز الأخطاء إن صدرت في مواقف معينة، بل كأى طفل سوي علينا تعديل سلوكه بالعقاب إن أخطأ وتعزيزه بالثواب إن أصاب. ولا يكون العقاب أمام جمع من الناس إلا عقاباً لفظياً لا يجرح. فالهدف من العقاب تنبيهه بالسلوك الخاطئ وعدم تقبله. وبذلك يتنبه الطفل لأخطائه فيتجنبها ويشعر بالمتابعة المستمرة والتي من شأنها تعويد الطفل على السيطرة على أخطائه وتجنبها. ومن جهة أخرى إن أخطأ الطفل فلا يجب أن نحل مشاكله بعزله عن العالم لإراحة نفسه، بل علينا أن ندفعه للتواصل الاجتماعي ودمجه مع الآخرين. فإن من أهم الجوانب التي يجب أن نركز عليها ونأخذها بمحمل الجد هي الجوانب الاجتماعية والتواصلية للطفل المعاق.

ومن هنا يجب أن نتذكر دوماً أن طفلنا يحتاج لعطفنا واهتمامنا، والعطف والاهتمام لا يعني أبداً الإفراط في تدليله والتجاوز عن أخطائه، بل اهتمامنا ينعكس في تنشئتنا له وتقويته للاندماج في المجتمع وهذه أبسط حقوقه. ومن ثم علينا جاهدين أن نجنب أبنائنا المعاقين الانسحاب اجتماعياً لأن حاجاتهم النفسية بنفس المستوى من الأهمية لحاجات الأفراد الآخرين. ويجب أن نراعي أنه من أقل حقوق الطفل ذو الاحتياجات الخاصة هو السماح له بالتفاعلات الروتينية لإعطائه الفرصة للشعور بالأمن والثقة. وهذا كله يعتمد على من يتعامل مع الأطفال.

-مهارة إدارة الذات:

تعد استراتيجية إدارة الذات أحد المداخل العلاجية والتربوية الحديثة التي تستخدم في مجال علم النفس والصحة النفسية فهي تحسن الجوانب الإيجابية للتلميذ وتعمل على خفض الجوانب السلبية التي تعوق قدراته، ويعد التلاميذ المعاقين بحاجة إلى الخدمات الداعمة لمساعدتهم للوصول إلى أقصى مدى تسمح به قدراتهم، وتجعل التلاميذ المعاقين أكثر كفاءة وانضباطاً في الصف الدراسي (Nonnomacher,2008:4).

قائمة المحتويات

ويرى إمبرجتس (Embregts, Petri, J.C.M., 2003) أن الأطفال من ذوى صعوبات تعلم القراءة فى مرحلة الطفولة هم الأشد احتياجاً للمساعدة، للوصول إلى مستويات أعلى فى الأنشطة الوظيفية والاجتماعية والتعليمية والترفيهية، وإكساب الطفل المهارات والسلوكيات المناسبة والتي من خلالها يعتمد على نفسه، وبالتالي يقل اعتماده على الآخرين. وتقوم مهارة إدارة الذات على تعليم الأطفال ذوى صعوبات التعلم تلك السلوكيات التي تساعد على التعامل مع البيئة التي يعيشون فيها، فالقراءة أداة للتواصل والترابط بين أفراد المجتمع، ومضاعفة للخبرة الإنسانية، كما أنها وسيلة من وسائل التعبير عن المشاعر والانفعالات، والتذوق، ونقل التراث من جيل إلى آخر بالإضافة إلى أنها من أهم عوامل النمو العقلي والانفعالي للفرد، ولذلك تعد أحد أهم المهارات التي يمتلكها الفرد فى المجتمع الحديث.

ويعانى الأطفال ذوى صعوبات تعلم القراءة من العديد الاضطرابات النفسية كالقلق، التوتر، والاضطرابات السلوكية كالاندفاعية والسلوك العدواني (إيناس مصطفى، ٢٠١٥). لذا تعد إدارة الذات أحد الأساليب المفيدة والناجحة فى مساعدة الأفراد ذوى الاضطرابات والأفراد ذوو صعوبات التعلم بشكل عام (Embregts, 2003:288).

استراتيجية اللعب وأهميته:

أكدت العديد من الدراسات على أن اللعب يعد أنسب الوسائل التي تتبع فى إرشاد الأطفال بصفة عامة والأطفال المعاقين بصفة خاصة، للمساعدة فى حل المشكلات والتغلب على الاضطرابات السلوكية والانفعالية والاجتماعية، وتنمية الاتجاهات نحو الذات ونحو المجتمع (عيسى عبد الله الجابر، ١٩٨٩؛ غادة ناجى، ١٩٩٤؛ نادية رشدى، ١٩٩٥؛ خالد عبد الرازق، ٢٠٠١). مما يوضح أهمية وجود برامج لتحسين مهارات التفاعل الاجتماعى لهم بما يساهم ويتناسب مع حاجاتهم وقدراتهم من خلال تصميم العديد من الأنشطة والمهارات التي تعتمد على اللعب.

مفهوم اللعب:

تعددت مفاهيم اللعب وتنوعت، ويعرف اللعب لغوياً بأنه "العب" أى عمل عملاً لا يجدى عليه نفعا (ضد: جد) (المعجم الوسيط، ١٩٨٥). ويعرف فى قاموس جود (Good, 1975) بأنه "نشاط موجه أو حر يؤديه الأطفال للمتعة والتسلية".

كما يعرف اللعب بأنه "النمو المرجو الذي يدعمه الاهتمام، حب المعرفة، التقليد، وهى العوامل التي تحفز الصغير على المعرفة والفهم والتكيف مع المجتمع، وبهذا يكتسب الدراية والخبرة، وهو كذلك الأمر الذي يلزم المجتمع بأن يكون متجاوباً مع الطفل ومتفهماً له (كوتونى برنارد، ١٩٩١، ١١).

وتعرفه شيلا جوسى (Jowsey, S., 1992) بأنه "البيئة الطبيعية لنمو وتطور مختلف المهارات ولتعلم التفاعل مع الآخرين" (ص ١).

قائمة المحتويات

ويعرف أسعد نصيف (١٩٩٧) اللعب الجماعى بأنه "شبكة من التفاعلات التى تتم فى إطار جماعى بين مجموعة من الأفراد وفق تنظيم محدد" (ص٦).

وتعرفه كامليا عبد الفتاح (١٩٩٨) بأنه "لغة الطفل الرمزية للتعبير عن الذات حيث يمكن القول بأن اللعب هو "حديث الطفل واللعب هو كلماته" (ص٥٣).

ويمكن القول أنه من الصعب إيجاد تعريف شامل واضح ومحدد للعب، وذلك لاختلاف الأطر المرجعية للباحثين وتوجهاتهم النظرية -فمنهم من يرى أن اللعب إشباع للحاجات (هدى قناوى، ١٩٩٥)؛ ومنهم من يرى أنه بغرض الاستمتاع فقط ودون دافع (Good، ١٩٧٥؛ أحمد بلقيس وآخر، ١٩٨٧). ومنهم أيضاً من يرى بأنه لغة الطفل للتعبير عن الذات مؤكدين على أهمية تنمية المهارات اللغوية من خلال اللعب، فى حين أكد آخرون على أهمية الجانب الوجدانى الذى يماثل فى أهميته الجانب اللغوى للعب (شيليا جوسى، Jowsey, S، ١٩٩٦؛ عبد الرحمن وشيخة الدبستى، ١٩٩٧؛ كامليا عبد الفتاح، ١٩٩٨). كما أن منهم من يراه على أنه بيئة طبيعية لتعلم التفاعل الاجتماعى وتنمية المهارات الاجتماعية للطفل (Winnicotte، ١٩٨٨؛ Jowsey, S، ١٩٩٢؛ أسعد نصيف، ١٩٩٧). ومع ذلك يمكن الوصول إلى تعريف للعب يستند إلى الآراء النظرية المختلفة فى هذا الجانب وهو أن اللعب:-

- أ- مجموعة من الأنشطة الموجهة وغير الموجهة التى يمارسها الأطفال من أجل تحقيق المتعة والتسلية .
- ب- اللعب ضرورة بيولوجية لبناء شخصية الطفل ووسيلة للتعبير عن حاجاته ومشكلاته.
- ج- عن طريق أنشطة اللعب يكتسب الطفل مجموعة من المهارات والخبرات والمعارف بالبيئة المحيطة بهم وتنمية العلاقات الاجتماعية فيما بينهم.

ويشير أيزنبرج (Isenberg, 1982) إلى أنه إلى جانب أن اللعب نشاط ومتعة للطفل فهو أيضاً طريق الطفل ليكتشف ذاته والعالم المحيط به، فأتناء اللعب يتعلم الطفل الوعى بذاته ويكتسب مهارات مثل الاتصال بالآخرين والتفكير المنظم القائم على أساس وجود مشكلة تتطلب الحل، كذلك يتطلب الاتصال بالآخرين نمواً لغوياً وحصيلية لغوية تزداد أثناء لعب الطفل بمفرده أو بأدوات لعبه أو مع رفاقه.

ويرى العديد من الباحثين أن اللعب يساهم فى نمو وتطور العلاقات الاجتماعية كوظيفة أساسية، حيث أن الاستمتاع باللعب يجعل الطفل يميل إلى خلق اتصال بينه وبين الآخرين لإمداده بالمثيرات الجسمية، والانفعالية، بل أن ما يحدث من تحسن وتطور فى السلوك الاجتماعى للأطفال يكون نتيجة اللعب، حيث أنها تتحول إلى أنشطة تتطلب تدريباً على ضبط الذات، وهناك من يؤكد على أن إعداد الأطفال ليكونوا قادرين على اللعب فى حد ذاته يتضمن نمواً فى الاتجاهات الاجتماعية الإيجابية، ويعتبر خروج الطفل من مركزه حول ذاته مرهوناً بتطور العلاقات الاجتماعية، حيث يكون اللعب التعاونى والجماعى بمثابة تنازل الطفل عن رغباته الملحة والفورية فى سبيل أن يستمر اللعب الذى هو عليه (Erikson, E. ، ١٩٥٠؛ Bruner, J. ، ١٩٧٢؛ Vygotsky, L. ، ١٩٨٣؛ Jowsy, S. ، ١٩٩٢؛ تينا بروس، ١٩٩٢؛ سلوى عبد الباقي، ١٩٩٢؛ سهير كامل أحمد، ١٩٩٣).

قائمة المحتويات

- اللعب والطفل التوحدي:

من الثابت أن اللعب يُكسب أطفال التوحد قيمة بارزة في نموهم الاجتماعي بل يمنحهم بالإضافة إلى ذلك الثقة بالنفس ويمُدّهم بعمليات التواصل الاجتماعي SocialCommunication مع الآخرين سواء كان ذلك في محيط الأسرة، أو المدرسة، أو في بيئة اللعب، فذلك المحيط هو الذي يكتسب الطفل المُصاب بمرض التوحد من خلاله الاستقلال الذاتي.

وتُشكل مجموعة الألعاب والأنشطة الرياضية الحركية والجسمية جميعها فائدة كبيرة في إزالة ظاهرة الانطواء والإحجام التي تميزه عن الأطفال العاديين فإذا حرصنا على ذلك من خلال ما وفرناه من ألعاب هادفة فنكون قد حققنا لهنوعاً من التوافق الاجتماعي مع أسرته ومع أقرانه من أفراد مدرسته.

وحرص الأسرة على مشاركة طفلهم المُصاب بالتوحد واختلاطه مع الأخوة الآخرين في نفس المنزل ومشاركتهم اللعب أمر جيد يُماثل تماماً حرص الأسرة المدرسية على مشاركة التوحدي مع أقرانه الطبيعيين في الألعاب التي يُمارسونها ومُجمل هذه النشاطات الرياضية والألعاب المُستهدفة تُساعد هؤلاء الأطفال على التفاعل مع الآخرين وتعكس النتائج المُستهدفة من علاجهم مستقبلاً.

وهناك مجموعة من النقاط الرئيسية من الأفضل للأسرة التعرف عليها قبل البدء في عمليات اللعب هي:
أولاً: التعرف على قدرات وميول الطفل التوحدي حتى نستطيع أن نهياً له اللعبة الهادفة التي يستطيع من خلالها أن يمارس نشاطه الاجتماعي باللعب بعيداً عن التوتر والصعوبات التي تعرقل عملية العلاج باللعب. وأفضل مثال على ذلك الأسرة التي تعرف طبيعة شخصية طفلهم المصاب بالتوحد ومدى تأثيره ببعض المثيرات التي تُثيره فتراعي فيه هذه الأمور عند اختيار اللعبة الهادفة وتوازن بيئة اللعب في العلاج.

ثانياً: عدم إغفال الإعاقة الجسدية إذ أن هناك بعض الأسر التي تغفل الإعاقة الجسدية والضعف أثناء التعامل مع اللعبة ولا تنتبه لأثرها في نفسه أو في تفكير الطفل التوحدي، وهذه كلها أمور مهمة لا بد من مراعاتها لأن هناك من لديه إعاقات سمعية أو بصرية أو لمسية، ولهذا يجب مراعاة هذه الظواهر المُعيقة وخاصة لدى التوحديين لأن جميع هذه الملاحظات الدقيقة التي يغفل عنها بعض أولياء أمور الأطفال التوحديين يجب أن تؤخذ جيداً بعين الاعتبار، لأن ظروفهم الصحية لا تساعدهم على التواصل والتفاعل اللعبي مع الآخرين بحكم الاضطراب العصبي الموجود في كياناتهم فيؤدي إلى انعكاسات سلبية وحركات عشوائية غير مفهومة الدلالة أو المغزى.

ثالثاً: ضرورة استقرار العوامل الإيجابية، حيث يجب أن تستقر العوامل الإيجابية والمُعززات المساعدة أثناء اللعب لصالح التوحديين، لأن هذا الأمر سوف يجنبهم الدوافع السلبية في الألعاب، وخاصة أثناء غضبهم وتوترهم وقلقهم من الألعاب التي قد تكون محط تقييم وعلاج جسدي واجتماعي ونفسي لهم، فمثلاً هناك ألعاب ذات آثار خاصة، مثل تمارين رياضية خاصة للعضلات الرخوة في الأصابع أو في اليدين أو الرجلين وهذه الألعاب خاصة بتلك العضلات مثل عملية قذف الكرة أو الضغط على المُعجنات الطينية أو لعبة شد الحبل

قائمة المحتويات

أو الفك والتركيب وهذه الألعاب لها تمارين رياضية ذات أثر محدود، يستهدف من ورائها تقويم عيب بدني أو الحد من إعاقة جسدية خاصة بالطفل المصاب بالتوحد، أو تخفيف قصور نمائي يعاني منه .

ملاح البرامج الإرشادية والتأهيلية لأسر الأطفال المعاقين عقليا:-

قديمًا كان هدف برامج التدخل لذوى الإعاقات العقلية هو الاهتمام بالأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة بعيداً عن العائلة والسياق البيئى. وعلى مدى العقدين الماضيين تغير هذا الاتجاه وبدأ الاهتمام بأسر المعاقين عقليا من خلال تطوير أساليب الدعم لهم وتحسين نوعية الحياة لديهم، لما لذلك من أهمية قد تنعكس على أطفالهم المعاقين عقليا (Samuel,R.,et al.,2011). وفيما يلى بعض ملاح البرامج الإرشادية والتأهيلية لأسر الأطفال المعاقين عقليا:-

- ضرورة إشتراك الوالدين في برامج إرشاد وتأهيل المعاقين عقليا" حتى نضمن تعاونهم مع الأخصائيين والمعالجين .
 - العمل على إشتراك الوالدين فى عمليات الإرشاد والتأهيل للطفل المعاق عقليا إبتداء" من تزويدهم بالمعلومات الضرورية عن حالة الطفل وأسبابها وأعراضها وأشكال الرعاية التى تقدم للطفل فى هذه الحالة وكيفية تقديمها .
 - العمل على تغيير مفاهيم الوالدين عن الإعاقة العقلية .
 - توضيح مسئولية الوالدين فى خلق مناخ يسوده مشاعر الحب والمودة وحسن المعاملة .
 - تدريب الوالدين على كيفية مساعدة أبنائهم المعاقين عقليا .
 - حث الوالدين الذين يشاركون فى البرامج التأهيلية على ضرورة تعاونهم مع الأخصائيين لإنجاز البرنامج.
 - تعليم الوالدين كيف يقوموا بتقييم تقدم الطفل وتحسن سلوكه (علاء الدين كفاي، ٢٠٠٥: ٣٧٤- ٣٧٨) .
- وفيما يلى عرض لبرامج الرعاية الخاصة للأطفال المعاقين عقليا:-

١ - برامج الرعاية الطبية:-

- نظرا لتقدم البحوث العلمية فى المجال الطبي فقد تم التوصل إلى إمكانية القضاء على بعض أساليب الإعاقة العقلية بعد الولادة إذا ما تم التدخل المبكر بما يحقق نتائج ملحوظة كالتالى:-
- حالات الإعاقة العقلية الناتجة عن التمثيل الغذائي لحمض Pku الفينيل كيتون يوريا، فإذا تم اكتشافه مبكرا" يتم وضع نظام غذائي خاص للطفل حتى بلوغه السادسة من عمره، وبالتالي يتم علاجه.
- حالات RH التى تظهر نتيجة اختلاف دم الأم عن دم الجنين، ويمكن حقن الطفل خلال ٧٢ ساعة بعد الولادة لمنع تكوين الأجسام المضادة (نور الدين إبراهيم، ٢٠٠٢: ١٠٩).

٢ - برامج الرعاية البدنية:-

- هي برامج تقي الطفل المعاق عقليا" من الترهل الجسمي وذلك على يد متخصصين لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم البدنية (مجدى عرفه، ٢٠٠١: ٢١١).

٣ - برامج الرعاية النفسية:-

- تهتم برامج العلاج النفسي بمساعدة الطفل المعاق عقليا" للتخلص من مشاعر الخوف تجاه أسرته والبيئة المحيطة به، وزيادة ثقته بنفسه عن طريق الأنشطة العقلية المعرفية والحركية التي يستخدم فيها قدراته ومهاراته بنجاح، ومساعدته على التخلص من نزعاته العدوانية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، والعمل مع أسرة الطفل المعاق عقليا ومساعدتها على تقبله وتدريبه، وتقديم الدعم النفسي المناسب لأسرة الطفل المعاق عقليا" من أجل تفعيل قدرتها على القيام بمسؤولياتها تجاه طفلهم المعاق عقليا" (Graz,V.,et al.,2002: 49-52).

قائمة المحتويات

٤- برامج الرعاية الاجتماعية:-

تتيح برامج الرعاية الاجتماعية الفرص لعلاج الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها المعاق عقلياً، كالشعور بالحرمان والانطواء على النفس وفقدان القدرة على تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين، كما تهدف أيضاً "إلى تدريب المعاقين عقلياً" على حب وأحترام العمل، وكذلك يهدف إلى تدريبهم على الانتفاع بوقت الفراغ فيما يفيدهم من خلال برامج الأنشطة الترفيهية مثل: الحفلات، والرحلات والمسابقات التي يشارك فيها الطفل المعاق عقلياً" مما يساعد في تحسين توافقه النفسي (عرفات زيدان، ٢٠٠٣: ٢٦١).

٥- برامج التربية الخاصة للمعاقين عقلياً:-

تركز برامج التربية الخاصة للأطفال المعاقين عقلياً على مساعدتهم لتحسين الاداء العقلي وتحسين قدراتهم وتنمية مهاراتهم المعرفية والاجتماعية، وكذلك تنمية مهاراتهم الحركية، ومهارات التواصل اللازمة للاعتماد على النفس، وكذلك تدعيم أشكال السلوك الإيجابي، ومحاولة علاج السلوك غير المرغوب فيه، ويؤكد الأخصائيون الذين يعملون مع الأطفال المعاقين عقلياً "على أن نجاح البرامج يحتاج إلى الأخصائيين المهنيين في كافة التخصصات الطبية والنفسية، والاجتماعية والمعلمون وأخصائيون العلاج الطبيعي والآباء والامهات وغيرهم (شاهين عبد الستار، ٢٠٠٥: ٢٩٢).

كيفية التعامل مع الطفولة المعاقة ذهنياً:

تختلف طريقة التعامل مع الطفولة المعوقة حسب نوع كل إعاقة من الإعاقات، فالعامل مع الطفل الكفيف يختلف عن التعامل مع الطفل الأصم أو الطفل المعاق ذهنياً أو الطفل فاقد أحد الأطراف.

ومن أهم طرق التعامل مع الشخص المصاب بإعاقة واحدة ألا تعامله كأنه عاجز في نواحي أخرى، لا تظهر الشفقة، عامل الأطفال المعاقين بصورة طبيعية قدر الإمكان، بما في ذلك ردعهم عند إساءة التصرف، أنهم في حاجة إلي تعلم أصول اللياقة والأدب تماماً كالأطفال الآخرين.

التأهيل النفسي للمعاقين: Psychological Rehabilitation

تلعب الظروف النفسية للفرد المعاق وأسرته دوراً بارزاً وحيوياً في تحويل حالة العجز إلى تقبل حالة العجز والتكيف معها والعمل على الاستفادة من أنشطة وبرامج التأهيل اللازمة. ولا بد من التذكير من أن الآثار النفسية التي تتركها حالة العجز على حياة الفرد وعلى حياة أفراد أسرته غالباً ما تكون من الدرجة العميقة التي تحتاج إلى جهود كبيرة في العمل للتخفيف من المشاعر والضغط النفسية التي يمكن أن تنشأ عن حالة العجز.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع نرى أن العديد من الدراسات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي قد اهتمت بدراسة الآثار والضغط النفسية الناجمة عن حالة العجز والإعاقة سواء على الفرد المعاق نفسه أو على أسرة الفرد المعاق.

كما أن الآثار الناجمة عن ولادة طفل معاق في الأسرة، غالباً ما تتعرض الأسرة لضغوط نفسية شديدة تؤثر على كيانها كنظام اجتماعي من جهة وتؤثر على أفرادها من جهة ثانية.

قائمة المحتويات

إن من أهم مظاهر الضغوط النفسية التي يتعرض لها أفراد الأسرة هي الشعور بالخل أو الدونية أو الذنب، إنكار الإعاقة، الحماية الزائدة أو رفض الطفل المعاق وإخفائه عن الأنظار أو الانعزال عن الحياة الاجتماعية وعدم المشاركة في مظاهرها.

كذلك فإن حالة العجز أو الإعاقة تؤثر على الفرد المعاق نفسه فهي تؤثر على فهمه وتقديره لنفسه وإمكانياته وتجعله يعيش في حالة من القلق والتوتر والخوف من المستقبل، كما قد تؤثر في نظرته للحياة وثقته بالآخرين.

أهداف برامج التأهيل النفسي:

أ- أهداف موجهة نحو الفرد المعاق وتشمل التالية:

- ١- مساعدة الفرد المعاق على تحقيق أقصى درجة من التوافق الشخصي، ذلك من خلال تقبله لذاته وظروفه وواقعه، وفهمه لخصائصه النفسية ومعرفة إمكاناته المتبقية وتطوير اتجاهات إيجابية عن ذاته، ومساعدته على مواجهة ما يعترضه من معوقات والتغلب عليها.
- ٢- مساعدة الفرد المعاق على تحقيق أقصى ما يمكن من التوافق الاجتماعي والمهني: وذلك من خلال مساعدته في تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين والخروج من العزلة الاجتماعية والاندماج في الحياة العامة للمجتمع، وكذلك مساعدته على الاختيار المهني السليم الذي يتناسب مع حالته وميوله واستعداداته.
- ٣- العمل على تعديل بعض العادات السلوكية الخاطئة التي قد تنشأ عن الإعاقة.

ب- أهداف موجهة نحو أسرة الفرد المعاق:

- ١- مساعدة الأسرة على فهم وتقدير وتقبل حالة الإعاقة، وذلك من خلال تزويدها بالمعلومات الضرورية عن حالة الإعاقة ومتطلباتها وتعديل اتجاهاتها نحو إعاقة طفلها.
- ٢- مساعدة الأسرة على مواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ عن حالة الإعاقة والتخفيف من آثارها.
- ٣- مساعدة الأسرة للوصول إلى قرار سليم واختيار مجال التأهيل المناسب لطفلهم المعاق.
- ٤- مساعدة الأسرة على بناء توقعات إيجابية وموضوعية عن قدرات وإمكانات طفلها المعاق.
- ١- تدريب الأسرة إرشادها على أساليب رعاية وتدريب الطفل المعاق.

طرق تعليم الأطفال:

- طريقة سبيتز:

يرى "سبيتز" أن الطفل المعاق عقلياً يعاني من ضعف في استقبال المعلومات، لذا يجب علينا كمربين ومعلمين لهذا الطفل أن نعمل على تنظيم المعلومات المقدمة للطفل المعاق بطريقة بسيطة تمكنه من استقبال المعلومات بطريقة سهلة ومناسبة له ولقدراته ويكون وفقاً لما يلي:

- ١- تنبيه الطفل للمهمة المراد تعليمه إياها: مثلاً في جانب خدمة الذات (لبس الملابس) انظر سوف نتعلم اليوم كيف نلبس ويهيئه للمهمة بتوفير المناخ الملائم لتنفيذ المهمة، وقد يعرض عليه بعض الأسئلة: من ألبسك لبسك اليوم أو ملابس جميله ورائعة حتى نعلم في ذهنه المفردة والمهمة.
- ٢- انتباه الطفل للمهمة المراد تعلمها: يجب أن تكون الوسيلة التعليمية في المهمة أكثر تشويقاً وجذباً حتى نلفت انتباه الطفل للمهمة المراد تعليمه، وكذلك أسلوب المعلم مهم أيضاً.

قائمة المحتويات

٣- **استقبال المعلومات:** استقبال المعلومات السمعية والبصرية بطريقة سهلة، وعدم تكثيف المعلومات حتى لا يفقد الطفل القدرة على التركيز بل معلومة سريعة وبسيطة، ثم التدرج من السهل للصعب. واقترح "سبيتز" أنه يجب أن تطبق هذه الخطوات بطريقة جيدة ومنظمة وخاصة مع الأطفال المعاقين عقلياً لاسيما وأنهم يعانون من ضعف في استقبال المعلومات، واقترح هذه الطريقة لاستقبال المعلومات من خلال: تصنيف الأشياء وتقديمها للأطفال على شكل مجموعات متشابهة أو متجانسة من خلال الطرق الآتية:

- التشابه في الشكل الخارجي واللون.

- التشابه في الوظيفة بين المثيرات.

- التشابه بين المثيرات.

٤- **حفظ المعلومات:** أي نكرر السؤال على الطفل حتى بعد الانتهاء من المهمة. كي يحفظ الطفل المعلومة أو المهمة التعليمية التي تلقاها مع تكرار هذه المعلومة خلال اليوم وغدا وبقية أيام الأسبوع حتى نستطيع أن ننمي قدرات الذاكرة قصيرة المدى.

٥- **استدعاء المعلومات:** يجب أن نسأل الطفل بعد إنهاء المهمة في نفس اليوم لاستدعاء المعلومات التي تعلمها وفي الغد أيضاً حتى نتأكد من فهمه ومعرفته للمعلومة.

٦- **استدعاء المعلومات عند الضرورة:** يمكن للمعلم أن يستعيد المهمة التعليمية للتأكد من مدى احتفاظ الطفل بها وقد يكون ذلك لفترات زمنية متباعدة.

المحافظة على نفسية الطفل ذوي الإعاقة

كيف نحافظ على نفسية الطفل المعاق:

- لا بد أولاً من تقبل الطفل واحترامه والاعتراف بإعاقته، وعدم الخجل من انتمائه للأسرة والتعامل معه بصبر.

- اكتشاف نقاط القوة لديه وحاول تنميتها وعدم التعامل معه على أنه عاجز كلياً.

- امتدح نجاح الطفل مهما كان صغيراً .

- استخدم أنواع التشجيع المختلفة خاصة التي عن طريق اللمس مثل: التربييت على الكتف.

- لا تسرف في التدليل ولا تبخل بالثناء عليه .

- تجنب الاستهزاء به أو إظهار التذمر منه أو معاملته بقسوة وإهماله .

- اسمح له بالمحاولة وأعطيه الفرصة للاعتماد على نفسه وتنمية الاستقلالية الذاتية لديه بما يتناسب مع قدراته.

- لا تواجهه بعجزه وأعطيه جرعات من الأمل .

- تجنب الحديث عن حالته أمام الآخرين .

- كن صريحاً في التعامل معه وافتح معه الحوار وعرفه أن الإعاقة ليست نهاية الحياة وقص عليه قصص الناجحين من المعاقين.

- لا تفرط في معاملة الطفل دوناً عن باقي أخوته؟

قائمة المحتويات

- التزم مع أفراد الأسرة سياسة موحدة في التعامل معه .
- لا تفرط في تدليله ولا إهماله .
- كفله ببعض الأعمال في حدود إمكانياته وعوده تحمل المسؤولية مثله مثل باقي أفراد أسرته .
- شجعه على اللعب مع أخوته بالألعاب التي تناسبه .
- عوده الاعتماد على نفسه في القيام باحتياجاته الأساسية مثل الأكل واللبس وغيرها .

دور الأسرة في تعديل الاتجاه نحو الابن وأساليب معاملته:

- قد يستطيع الابن المعاق عقليا الاستمتاع والشعور بالرضا والوصول إلي أقصى ما تمكنه قدراته إذا ما اتبعت الأسرة الآتي:
- ١- إذا لم تحط من قيمة عمله البسيط بل تشجعه وتعتبره انجازا يستحق الفخر.
 - ٢- إذا وضعت له أهداف يمكنه تحقيقها والوصول إليها.
 - ٣- إذا عاونته في خطوات التدريب وتعلم المهارات التي يستطيع أداءها أكثر من تلك التي يعجز عنها.
 - ٤- إذا حرصت على تكرار وتكرار المعلومة والخبرة التي ترغب في تعليمه إياها بأكثر من أسلوب وطريقه وباستخدام وسائل معينة تنبه أكثر من حاسة لديه وذلك بلا ملل أو ضجر.
 - ٥- إذا أتيحت له الفرصة للمحاولة مهما تكرر الفشل فمن الأفضل أن يحاول حتى ولو فشل من ألا يحاول علي الإطلاق.
 - ٦- إذا أعطته حبا وحنانا صادقا بالرغم مما يعانيه من نواحي قصور وبصرف النظر عن مقدار ما حرم منه فإنه في المقام الأول طفل قبل أي اعتبار آخر كما أنه لازال يحتفظ بالكثير من القدرات التي يمكننا صقلها وتدريبه عليها.
 - ٧- إذا عاملته كما تحب أن يعامله أفراد المجتمع، فاتجاهاتنا وأسلوب معاملتنا لطفلنا المعاق عقليا هما اللذان يشكلان اتجاهات وأسلوب تعامل أفراد المجتمع معه .

-تعامل الأسرة مع أخوة الطفل المعاق:

لا يقل دور أخوة وأخوات الطفل المعاق عقليا بحال من الأحوال عن دور الوالدين، بل يعد دورهم أساسيا وحيويا ومكملا لدور الوالدين وتبرز أهميته من كون الأخوة يميلون بصفة عامة إلى إتباع اتجاهات الوالدين نحو الابن المعاق عقليا كما يمكن لهم إذا أحسن توظيفهم أن يكونوا خير معلم وموجه ومرشد وصديق لأخيه المعاق. فالأمر ليس مجرد وجود حالة طفل معاق عقليا في الأسرة بقدر مدى المسؤولية التي تلقى على أفراد الأسرة، وخاصة الإخوة والإناث منهم على وجه الخصوص نتيجة لوجود هذا الأخ المعاق.

فعندما يتوقع الوالدان من الإخوة والأخوات أكثر مما تتحمل طاقتهم أثناء تعاملهم مع أخيه المعاق ينشأ صراع نفسي عنيف وإحباط وتوتر في حياة الأسرة يحول حياتها إلى عذاب، هذا وقد يؤدي الاهتمام الزائد من الوالدين بالابن المعاق إلى إهمال إخوته مما يخلق جوا من التوتر والاستياء داخل الأسرة.

قائمة المحتويات

-دور الأسرة في تنمية العلاقة بين المعاق وإخوته:

يجب على الأسرة أن :

- ١-مساعدة أخوة المعاق على فهم حالته والفروق الفردية بين البشر وذلك على قدر استيعابهم .
- ٢-تبصير أخوة المعاق بالأساليب السوية والمناسبة لمساعدة أخوهم وفق ظروف الإعاقة.
- ٣-تشجيعهم على عدم الخجل من أخيه المعاق عقليا، حيث لا يوجد ما نخجل منه فأى فرد في أية أسرة معرض أن يكون مكانه إذا شاء الخالق عز وجل.
- ٤-عدم المبالغة والإسراف في حماية ومساعدة الابن المعاق على حساب أخوته.
- ٥-تراعى البعد عن التعبير اللفظي عن استيائهم أو ضجرهم من أخيه المعاق أمام الآخرين عامة والأخ المعاق خاصة.
- ٦-تحرص على أن لا ينعكس وجود الأخ المعاق عقليا سلبا على حق أخوته في الاستمتاع بحياتهم وطفولتهم

تفاعل الأسرة مع المجتمع المحيط وأسر الأطفال المعاقين:

تتمثل أهمية أفراد المجتمع المحيط وأسر الأطفال المعاقين الآخرين في كونهم المجتمع الذي يتفاعل معه الطفل المعاق والذي يعد بحق الأسرة الممتدة لهذا الطفل بما تمثله الأسرة من توجيه ورعاية وإشراف وعطف، وهم من يعد الطفل المعاق لكي يستطيع التعامل والعيش معهم في حالة وفاة الوالدين والأخوة أو فقد إشرافهم ورعايتهم بأي شكل من الأشكال.

ولذلك فإنكار الطفل المعاق وحجبه عن المجتمع يسهم في تدعيم رفض المجتمع له ويوسع الفجوة بينهم، لذلك فمن الأفضل أن يخرج الابن المعاق إلى الشارع والمطعم والمتنزهات وأن ندمجه داخل المجتمع ونبقيه مع أقرانه (عاديين-معاقين) أطول وقت ممكن، بل ومن الأفضل أن لا نبخل بجهد أو وسيلة لإحضار الأطفال الآخرين إلى منزله وإذا استلزم الأمر تقديم بعض المدعمات والحوافز لجذبهم وذلك حتى يتعرفوا على قدرات وإمكانات الطفل المعاق عقليا وانه رغم ما يعانيه من بعض القصور إلا أنه قادر على أن يشاركهم الكثير من الأنشطة وأن له من الإمكانيات والقدرات ما يفوق توقعاتهم، وتأتى أهمية هذه الخطوة في كون هؤلاء الأطفال هم المجتمع المستقبلي لهذا الطفل والذي يعد للتعامل معه .

والتفاعل مع أسر الأطفال المعاقين والالتقاء بهم يتيح للأسرة:

- ١-حرية التعبير عن النفس والتنفيس عن المشاعر والانفعالات.
- ٢-توفير نماذج للاستفادة من خبرات الآخرين بما يمثلونه من مواقف حياتيه حقيقية.
- ٣-مشاركة الغير ممن يلاقون الصعوبات نفسها وربما أكثر حملا .
- ٤-استئثار المشاعر والانفعالات والعواطف الايجابية تجاه الابن المعاق مما ينعكس ايجابيا في العلاقات المتبادلة بين أفراد الأسرة .

دور أسرة الطفل المعاق في التفاعل مع المجتمع:

على الأسرة الحرص على:

- ١-التحدث أمام الآخرين بصراحة عن مشاعرهم الأبوية نحو ابنهم المعاق عقليا وإمكاناته وإعاقته وما يمكنه عمله وما لا يمكنه أدائه كي يقف المتعاملون معه على قدراته الحقيقية.
- ٢-معاملة الابن المعاق كما يحبون أن يعامله أفراد المجتمع حيث أن طريقة وأسلوب معاملة الأسرة له هي التي تحدد أسلوب تعامل الآخرين معه.
- ٣-تشجيع الابن المعاق عقليا على عرض مواهبه وهواياته وقدراته على الآخرين مما يساهم في تنمية ثقته بنفسه ويعدل من اتجاهات الآخرين نحوه.

تعاون الأسرة مع الفنيين المعنيين بحالة الابن المعاق:

يعد التعاون بين أولياء الأمور مع فريق الفنيين المعنيين (طبيب- أخصائي نفسي- أخصائي اجتماعي- معلم تربوي-أخصائي تخاطب-أخصائي علاج طبيعي....الخ. أحد المقومات الأساسية لنجاح أي برنامج يهدف إلى الأخذ بيد الابن المعاق، فالأسرة بمفردها عاجزة عن تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الابن، كما أن فريق العمل الفني يذهب جهده أدراج الرياح إذا لم يجد الدعم والمساندة والمتابعة مع الأسرة، ومن هنا كانت أهمية التعاون بينهما وذلك من خلال الحرص على:

- ١-التحدث عن ابنهم المعاق ومشاعرهم نحوه بكل صراحة ووضوح وصدق وكذلك التحدث عن إمكاناته الحقيقية ودرجة إعاقته وجوانب قوته وقصوره مما يساعد على التقييم الواقعي ووضع الخطة العلاجية الفردية المناسبة.
- ٢-المشاركة بقدر المستطاع في الخطة العلاجية الفردية وتحديد الأهداف القريبة والبعيدة المدى ومتابعة سير الخطة العلاجية الفردية أول بأول.
- ٣-تقبل تعليمات وتوجيهات المختصين كل في تخصصه وتوفير الظروف والخدمات اللازمة والميسرة لتنفيذ الخطة العلاجية الفردية
- ٤-الاستفسار عن كل ما يهمهم بلا خجل.
- ٥-العناية الطبية والمتابعة الدورية للابن المعاق عقليا، فقد يعاني من مشكلات لا تساعد قدراته عن التعبير عنها .

التدخل المبكر

مفهوم التدخل المبكر:-

هو نظام تربوي وعلاجي ووقائي يقدم للأطفال الصغار من عمر الميلاد وحتى ٦ سنوات ممن لديهم احتياجات خاصة ويعتبر التدخل المبكر من أهم أنظمة دعم الأسر.

أهمية التدخل المبكر:-

يعطى فرصة كبيرة للوقاية من تطور مشكلاته لأن معدل نمو المخ لاسيما في الأشهر الثلاثة الأولى يكون سريعاً حيث يصل النمو في حجم الدماغ إلى نصف مخ البالغ عند مرحلة ٦ اشهر من عمر الطفل وهنا تكمن أهمية التدخل المبكر كما أن التدخل يساعد الأسرة على تخطي مجموعة كبيرة من المشاكل التي سيتعرضون لها لوجود طفل معاق فيها.

طرق التدخل المبكر:-

- التركيز على ارتباط الجانب الحركي بالجانب الإدراكي.
 - تدريب العضلات الدقيقة في اليد نظراً لارتباط قبضة اليد الوثيق بإدراك الطفل وتطور مراكز كثيرة في المخ .
 - عدم منع الطفل من التعرف على جسمه بحرية من خلال تفحصها بالفم -مص اليد والإصبع.
 - الضغط على عضلات اليد لتحريكها ذاتياً.
 - تمارين المرونة للعضلات والمفاصل.
- وبعد التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقات العقلية والذي يحدث في الفترة من العام الأول وحتى السادس من عمر الطفل على درجة كبيرة من الأهمية حيث يعود بالفائدة على الطفل ويساعده دون شك في تحقيق قدر معقول من التواصل مع الآخرين المحيطين به، كما يساعده على التفاعل معهم . ويمكن أن نقوم بتصنيف برامج التدخل المبكر التي يتم تقديمها لهؤلاء الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى ما يلي:
- برامج تهدف إلى الوقاية من الإعاقة: يتم تقديمها لأولئك الأطفال الذين يعدون في خطر يعرضهم للتخلف العقلي البسيط.
 - برامج تعمل في سبيل تنمية أولئك الأطفال الذين تم تصنيفهم بالفعل على أنهم معاقون: يتم تقديمها للأطفال ذوي مستويات التخلف العقلي الأكثر شدة.
- وبشكل عام يجب أن نعمل على تحقيق أهداف معينة خلال البرنامج بما يضمن اشتراك الطفل في العديد من الأنشطة المختلفة، ومن أهمها ما يلي:
- ١- التشخيص المبكر لهؤلاء الأطفال، والتعرف عليهم، وتحديدهم من خلال تقييم شامل لهم.
 - ٢- تزويد الأسرة بما يجب أن تقدمه للطفل، ومساعدتها في تنفيذ خطة معينة في هذا الصدد، والاشتراك معها في تحديد الأنشطة المناسبة .
 - ٣- إعداد المعلمين المؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على تحقيق معدل معقول من النمو .

قائمة المحتويات

٤- تحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة أو المعلم في هذا الإطار، والسير معاً وفقاً لخطة محددة في سبيل تحقيق مصلحة الطفل.

وإذا كانت برامج التدخل المبكر تتنوع بصورة عامة لتشمل تلك البرامج التي تتركز حول الطفل، والبرامج التي تتركز حول الأسرة، وبرامج التدخل المجتمعية فإن البرامج التي أشرنا إليها سلفاً تندرج تحت النوع الأول من هذه البرامج، وإن كان جانباً منها يخضع للنوع الثاني. كذلك فإن التدخل المبكر يتطلب أن يتم إجراء تقييم شامل للطفل يتم من خلاله التعرف على اهتماماته، وما يميل إليه، ويفضله، كما يتم أيضاً التعرف على قدراته العقلية، وقدرته على التواصل، وتقييم الوسائل التعليمية المستخدمة، وتحديد حاجات الطفل. ويتم بناءً على ذلك تحديد استراتيجيات التعلم المناسبة، وتحديد الخطة التربوية الفردية لكل طفل، واستراتيجيات التواصل، والأنشطة والألعاب اللازمة للتفاعل. كذلك فإن التدخل المبكر يتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة التي تعمل على الحد من الآثار السلبية للإعاقة فلا تتحول بالتالي إلى عجز دائم، كما تعمل على توفير الرعاية المطلوبة، والخدمات العلاجية اللازمة التي تساعد الطفل على النمو والتعلم حال استفادته منها. وحتى تأتي مثل هذه العملية بثمارها المرجوة ينبغي أن تتضمن عدداً من العناصر كما يلي:

- ١- أن تبدأ بعملية تقييم للأسرة والظروف الأسرية المختلفة.
- ٢- دراسة الخصائص المختلفة للبيئة الأسرية للطفل وما يمكن أن تتيحه من فرص متنوعة للنمو أمامه.
- ٣- التعرف على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية بين الطفل ووالديه.
- ٤- دراسة الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأسرة وما يمكن أن يكون له من انعكاسات على تعلمه، وما يسهم به في ذلك.
- ٥- التعرف على المستوى التعليمي والثقافي للأسرة.
- ٦- التعرف على تلك الضغوط الناتجة عن الإعاقة وتحديدتها والتعامل معها.
- ٧- التعرف على ردود أفعال الأسرة تجاه مثل هذه الضغوط.
- ٨- تحديد مستوى الكفاءة الوالدية في التعامل مع مختلف الضغوط التي تواجههم، ومن بينها الضغوط الناتجة عن الإعاقة.

والتدخل المبكر لا يقتصر على التربية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة لدعم نمو الأطفال المتأخرين والأطفال المعرضين لخطر الإعاقة والأطفال المعاقين ولكن يشمل أيضاً على خدمات الكشف، والتشخيص المبكر والخدمات المساعدة مثل العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي الخاص بعلاج اضطرابات التخاطب والنطق والكلام والإرشاد والدعم والتدريب الأسري وبالفعل لن يكون هناك فائدة من عملية التدخل المبكر للطفل إذا لم تكون الأسرة هي العنصر الأساسي في عملية التأهيل فنحن نعلم أنه في السنوات الأولى من عمر الطفل يكون لصيقاً ومعتمداً على والديه بدرجة كبيرة وخاصة الأم وبالتالي هم الأقرب والأسرع والأكثر فاعلية لهذه العملية التأهيلية لقدرات الطفل من جميع النواحي وفي جميع المجالات المرتبطة بحاجات طفلهم الفردية ومن

قائمة المحتويات

ناحية أخرى نجد أن عملية التدخل المبكر هي عملية مهمة جداً في تأهيل الطفل المعاق ذهنياً لعملية النطق والكلام لأن الطفل في هذه المرحلة يكون قابل لعملية التشكيل وإعادة البناء أكثر من مرحلة عمرية أخرى كما أن نمو خلايا الدماغ في هذه المرحلة تسير في سرعة تفوق المراحل العمرية التالية إلي أن تتوقف عند عمر ١٨ عام ثم يبدأ تطوير هذه القدرات بعد العام الـ ١٨ عن طريق تكثيف الخبرات والتجارب لدى الفرد، لذلك لابد من السرعة في عملية التدخل المبكر لاستثارة بيئة الطفل من جميع النواحي.

وينبغي أن تركز برامج التدخل المبكر التي يتم تقديمها لهؤلاء الأطفال على تنمية وتطوير مهاراتهم المختلفة كالمهارات الاجتماعية على سبيل المثال، ومهارات الحياة اليومية كي نساعدهم على التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، وعلى أن يأتوا بالسلوكيات الاستقلالية. وبذلك نلاحظ أن برامج التدخل المبكر التي تكون موجهة نحو الطفل تهدف إلى تحقيق أحد هدفين يتمثل أولهما في التواصل، في حين يتمثل الثاني في التعلم. أما البرامج الأخرى التي تكون موجهة نحو الوالدين والأسرة فتهدف إلى تعليم الوالدين وأعضاء الأسرة كيفية التغلب على تلك الصعاب والمشاكل التي يمكن أن تحول دون تحقيق أطفالهم للتواصل أو التعلم، وهو الأمر الذي تنطوي عليه البرامج المجتمعية أيضاً، ولكن يزداد عليه في تلك الحالة العمل على دمج هؤلاء الأطفال مع غيرهم سواء من المعاقين أو العاديين.

١- البرامج الوقائية في الطفولة المبكرة:

ترتبط برامج التدخل المبكر من هذا النوع والتي يتم تقديمها للرضع والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة الذين يعتبرون في خطر يعرضهم للإعاقة وتهدف إلى الوقاية من الإعاقة بتناول الظروف البيئية التي يمكن أن تؤدي إليها، ولذلك فإن أسرهم تشترك معهم في تلك البرامج أيضاً. ويتم في الغالب تقديم هذه البرامج للأطفال الذين ينحدرون من بيئات منخفضة الدخل مما يجعلهم معرضين للعديد من النتائج السلبية من بينها التخلف العقلي وهو الأمر الذي يمكن أن يحد من حدوثه. وكثيراً ما يتم تحديد المشاركين في البرنامج قبل مولدهم وذلك ممن يعيش آبائهم في بيئات فقيرة. وتتضمن مثل هذه البرامج خبرات تعمل على تعزيز النمو الحركي، والعقلي، واللغوي، والاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما تتلقى أسرهم عدداً من الخدمات الاجتماعية والطبية.

٢- البرامج الإنمائية في الطفولة المبكرة:

يتم تقديم هذه البرامج للرضع والأطفال بمرحلة ما قبل المدرسة الذين يتم تحديدهم على أنهم معاقون عقلياً بهدف مساعدتهم على تحقيق مستوى معرفي مرتفع بقدر الإمكان. وتؤكد هذه البرامج بشدة على النمو اللغوي والنمو الإدراكي. ونظراً لأن أولئك الأطفال غالباً ما يعانون من إعاقات متعددة فإن هناك متخصصين آخرين كأخصائيي اللغة والتخاطب، والأخصائيين الرياضيين يشاركون في تلك البرامج التي يتم تقديمها لهم. وإلى جانب ذلك فإن العديد من البرامج الجيدة تتضمن فرصاً للمشاركة الوالدية حيث يمكن للوالدين من خلال مشاركتهم في تلك البرامج مع أطفالهم، وما يؤدونه خلالها من ممارسات مختلفة معهم القيام بتعزيز بعض المهارات التي يحاول

قائمة المحتويات

المعلمون إكسابها لهم إذ يقوم آباء هؤلاء الأطفال بالتعلم من أولئك الأخصائيين الذين يتعاملون مع أطفالهم تلك الطرق والأساليب المناسبة للتعامل واللعب معهم، وإرضاعهم أو إطعامهم.

المهارات الاجتماعية: Social Skills

تعتبر المهارات الاجتماعية "سلوكيات ملحوظة يمكن قياسها، يستخدمها الفرد أثناء تفاعله مع الآخرين، وهي سلوك وليست سمة، وهذه السلوكيات إذا اجتمعت لدى الفرد أصبحت تعبر عن سمة عليا وهي الكفاءة الاجتماعية، وأن الكفاءة الاجتماعية مجموعة من المهارات تكوّن في مجملها السمة الكلية وهي الكفاءة الاجتماعية" (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١٠٧). وهي جزء من الكفاءة الكلية للشخصية، فإذا ما أضفنا إليها المهارات الأكاديمية، والمهارات الجسمية، والنفسية أصبحت لدينا شخصية متكاملة (سعد رياض، ٢٠١٠، ١٢).

ويعتبر التفاعل الاجتماعي هو أساس بناء الشخصية الاجتماعية للفرد وتشكيلها ونموها، والوسيلة الأساسية للتعلم والتوافق، وأداة تنظيم المجتمعات والتجمعات الإنسانية وانتقال حضارتها من جيل إلى جيل، فالتفاعل الاجتماعي: هو عملية تأثير متبادل بين الفرد والآخرين إزاء موقف ما على المستوى العقلي المعرفي أو الانفعالي، ويترجم هذا التأثير إلى سلوك، وقد يكون التفاعل لفظيا كما في الحوار والمناقشات، وإعطاء التعليمات، والمديح والثناء، والنقد والهزاء -أو غير لفظي كما في حركات الجسم وإيماءاته، وتعبيرات الوجه، والانتباه والإنصات أثناء المحادثة- وقد يكون لفظيا وغير لفظيا معا (أسماء السرسى، أماني عبد المقصود، د.ت، ٩-١٠).

وتتضمن المهارات الاجتماعية العناصر الآتية:

- ١- **مهارات تأكيد الذات:** تتعلق بمهارات التعبير عن المشاعر والآراء والدفاع عن الحقوق وتحديد الهوية وحمايتها ومواجهة ضغوط الآخرين.
- ٢- **مهارات وجدانية:** تسهم في تيسير إقامة علاقات وثيقة وودية مع الآخرين، وإدارة التفاعل معهم مما يساعد علي الاقتراب منهم، والتقرب إليهم ليصبح الشخص أكثر قبولا، ومن المهارات الرئيسة التعاطف، والمشاركة الوجدانية.
- ٣- **المهارات الاتصالية:** تنقسم إلي: مهارات الإرسال والتي تعبر عن قدرة الفرد علي توصيل المعلومات التي يرغب في نقلها للآخرين لفظيا أو غير لفظي، ومهارات الاستقبال والتي تعني مهارة الفرد في الانتباه، وتلقي الرسائل والإشارات اللفظية وغير اللفظية من الآخرين وإدراكها وفهم مغزاها، وبالطبع طفل التوحد لديه قصور في ذلك.
- ٤- **مهارات الضبط والمرونة الاجتماعية والانفعالية:** تشير إلي قدرة الفرد على التحكم بصورة مرنة في سلوكه اللفظي وغير اللفظي الانفعالي، خاصة في مواقف التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، فالمرونة الاجتماعية يجب أن توجه بمعرفة الفرد بالسلوك الاجتماعي الملائم واختيار التوقيت المناسب (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١٠٩).

وينبغي أن تكون برامج مهارات التواصل جزءا من جدول أنشطة المعالجة، وتعتبر مهارات التواصل ومهارات التفاعل الاجتماعي ضرورية لكي يصبح الفرد مشاركا في المجتمع وحتى يكون عضوا إيجابيا في المجتمع؛ وهناك العديد من المهارات المطلوبة مثل استثمار أوقات الفراغ وتبادل التحية، وغيرها من المهارات، ومن بين التدخلات

قائمة المحتويات

الخاصة بتعليم السلوكيات الاجتماعية برامج تتضمن اللعب مع أشخاص آخرين مع تبادل التأثيرات والعواطف بين الطرفين، ويمكن تعلم المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل بشكل أفضل في شكل مجموعات وقد استخدم "ميسبور ووليامز Mesibor, Williams" تبادل الأدوار، اللعب، تقديم نماذج من خلال القرناء لتنمية مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التعرف علي عواطف الآخرين والتجاوب مع الآخرين، ويعتبر تعليم مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي ذا أهمية كبيرة خاصة التواصل بالعين وتحية الآخرين والاستجابة لتحيتهم(في:أحمد السيد سليمان، ٢٠١٠، ٧٨-٧٩).

ويؤكد "عبدالفتاح غزال" في دراسته على ضرورة وجود برامج لتعديل سلوك الأطفال التوحديين وإكسابهم المهارات وتخفيف حدة أعراض التوحد لديهم، وتنمية المهارات داخل البرامج التدريبية تسمح لهم بالتفاعل مع المجتمع والقيام بالاشتراك في الأنشطة الحياتية، كما يؤكد "كونور Connor" على أن برامج التدخل المبكر المركزة يمكن أن تكون فعالة جدا خاصة إذا كانت واضحة البنية ومخططة لتعميم المهارات المتعلمة (في: محمد محمد عوده، ٢٠١٥، ١٨).

وقد نجح العديد من الباحثين في تنمية مهارات التواصل لدى التوحديين باستخدام بعض التقنيات حيث استخدم "ميرادج وآخرون Merriage, et al." الألعاب الترفيهية، تدريبات التمثيل، لعب الأدوار لتنمية مهارات التواصل البصري والتفاعل الاجتماعي(Greenway, C., 2000, 479).

ولأن الأطفال ذوي طيف التوحد يفتقدون إلي لبنات بناء المهارات الاجتماعية فهم نادرا ما يقيمون أية علاقات مع أقرانهم من أعمارهم وكذلك يفتقرون إلي قدرات اللغة، وقد يشاركون بقدرة أقل علي التقليد، فقد يكون لهم القليل من الأصدقاء أو لا يكون لديهم أصدقاء، ولكن تكون تلك العلاقات دائرة حول اهتمامات الطفل الخاصة به، ولا تدوم تلك العلاقات لخلل التماسك المركزي لديهم وعدم قدرتهم علي فهم الحب بطريقة عامة، فهم مثلا يركزون علي جزء صغير من الصورة دون الصورة بشكل عام(Briskman J, Happe F., (2001, 309-316).

ويستخدم مصطلح المهارات الاجتماعية في مجال الإعاقة العقلية، للإشارة إلى قدرة الفرد على أداء المهام الحياتية اليومية، وقدرته على الاستقلال والاعتماد على الذات في البيئة المحيطة، بالإضافة إلي تكوين علاقات اجتماعية مع أقرانه في المرحلة العمرية نفسها ومع الوالدين والأفراد الأكبر سنا، والذين يمثلون سلطة بالنسبة له (فيوليت فؤاد، ٢٠٠٥، ٤٢).

كما تشير دراسات التدخل العلاجي، التي تستهدف تحسين العلاقات الاجتماعية بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والعاديين، أنه يتعذر دمج الأطفال ذوي الحاجة الاجتماعية ما لم يتم بذل جهود مخصصة لهذا الغرض، وقد تم تعزيز المهارات الاجتماعية بنجاح في البيئات الدمجية، إضافة إلى ذلك فقد نجحت زيادة مهارات التواصل كوسيلة لزيادة التفاعل الاجتماعي، وتحسين الكفاية الاجتماعية للطفل ذي الحاجة الخاصة، وكذلك في تعزيز الصداقات بين الطفل التوحدي والقرين العادي (روبرت كوجل، لن كوجل، ٢٠٠٣، ٢٤٨).

قائمة المحتويات

طرق اكتساب المهارة:

- ١- **الطريقة الكلية:** تستهدف تقديم المهارة ككل للمتعلم في تمرين واحد وعمل تطبيقي شامل، ويحدث هذا عندما يكون إجراءات المهارة بسيطة غير مركبة أوسبق تقديم بعض أجزائها في مهارة أخرى، وأحياناً تقدم هذه الطريقة عندما يراد أن توضح الروابط بين العمليات المكونة للمهارة أمام المتعلم.
 - ٢- **الطريقة الجزئية:** تقدم المهارة للمتعلم علي صورة سلسلة من الإجراءات، ويتاح له التدريب على كل جزء على حده في صورة متسلسلة حتى يتم إنجاز العمل المطلوب ويصل المتعلم إلي المستوى المقبول من السرعة المطلوبة.
 - ٣- **الطريقة التجميعية:** يتم التدريب على كل جزء بصورة متصلة حتى يصل المتعلم إلى المستويات المطلوبة من سرعة ودقة الأداء، وبعد ذلك يتم تجميع المهارة والتدريب عليها ككل.
- وتختلف الكفاءة النسبية لهذه الطرق باختلاف المهارة حيث تتناسب الطريقة الجزئية في التدريب علي المهارات المعقدة لأنها تسمح بوقت متغير لكل جزء تبعاً لدرجة صعوبته، في حين تسمح الطريقة الكلية بالتدريب علي المهارات البسيطة، أما الطريقة الثالثة فهي تتناسب مع المهارات المركبة.

أهمية التقييم وتنمية المهارات:

أولى العلماء جل اهتمامهم لفئة الطفل التوحيدي، وتكاد تجمع الدراسات على أهمية التقييم كمدخل لرسم استراتيجيات علاجية فيري "بنتو وروجرز" أنه إذا كان الغرض من التشخيص هو تحديد وجود التوحد، فالتقييم هو عملية تحديد نقاط الضعف والقوة، واحتياجات الفرد؛ حيث تستخدم هذه المعلومات في وضع وتطوير البرامج العلاجية والتعليمية، وأيضاً في مناقشة فاعليتها (محمد محمد عوده، ٢٠١٥، ١٦).

وكذلك بالنسبة للبرامج الخاصة بتنمية المهارات المختلفة للطفل التوحيدي يؤكد "عبد الفتاح غزال" في دراسته على ضرورة وجود برامج لتعديل سلوك الأطفال التوحيدين وإكسابهم المهارات وتخفيف حدة أعراض التوحد لديهم، وتساعد البرامج التدريبية علي خفض السلوكيات غير الملائمة للتوحيدين، وتنمية مهاراتهم بصورة تسمح لهم بالتفاعل مع المجتمع والقيام بالاشتراك في الأنشطة الحياتية (في: محمد محمد عوده، ٢٠١٥، ١٦-١٧).

الألعاب التي تنمي المهارات الاجتماعية للطفل:

أحياناً يتم تجاهل مهارات الطفل الاجتماعية ورغبة الطفل في اللعب، وحبه إلى الانتقال من لعبة إلى أخرى، رغم أن ممارسته للعب من أهم العوامل لتعلم اللغة، والاكتساب المبكر لمهارة التواصل، باختيار الألعاب المناسبة، ويمكن للآباء أن يتعلموا كيف يثيرون انتباه الطفل، وإدراكه السمعي واللغوي.

ومن الألعاب التي تساعد على تنمية المهارات الاجتماعية للطفل الألعاب التي تعتمد على تبادل الأدوار أو التمثيل، حيث يمكن أن يأخذ كل من الطفل والاب والأم دوراً يمثلته كأنهم في موقف حقيقي مثل الطبيب والمريض،

قائمة المحتويات

أو المدرس والتلميذ، وقراءة الكتب المصورة مع طفلك أيضاً من العوامل التي تنمي مهارته الاجتماعية (سعد رياض، ٢٠١٠، ٤٥).

ومن المهارات التي يمكن أن تفيد الطفل التوحدي هي:

-مهارة التركيز والانتباه:

هي إحدى المهارات التي يحتاجها أطفال طيف التوحد بشدة، ويحتاج إلى مجهود كبير لتنميتها.

-مهارة المشاركة والتعاون: Participation:

هي إحدى المهارات الاجتماعية التي يمكن إكسابها للفرد، ويتم فيها اندماج الفرد واشتراكه مع الآخرين في اللعب والعمل والأنشطة والحديث والمشاعر، ويتم ذلك في جو من التفاهم والاتفاق دون إزعاج أو مضايقة للآخرين (ولاء محمد حسن، ٢٠١٠، ٥١).

-مهارة إدراك السلامة والأمان:

نظراً لأن إحساس هؤلاء الأطفال بالخطر ضعيف للغاية، فإنه يجب تعليمهم الاستجابة السريعة لأوامر النهي: توقف . لا . بس إلخ.

-مهارة حسن الاستماع أو الإنصات:

الطفل ذو طيف التوحد في حاجة لأن يتعلم مهارة الاستماع، ويتم ذلك عن طريق البدء بالتواصل بتلاقي النظر، ثم إعطاء الأمر، ثم التوجيه وتمثيل كيفية أدائه مع الاهتمام بالتعبيرات والإيماءات المدعمة (محمد إبراهيم عبد الحميد، ٢٠٠٣، ١٠: ١٢).

-مهارة التعبير عن الرأي:

عندما يتعلمها الطفل ويستطيع أن يعبر عن نفسه، يساعد ذلك على تنمية مهاراته وبالتالي تحسين توافقه النفسي.

-أسلوب المحاكاة:

يري "فيليب وشوارتز، Phillip, S. & Schwartz, I." أن استخدام المحاكاة من العوامل التي تساعد على إحداث تغييرات إيجابية في المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل (في: أحمد السيد سليمان، ٢٠١٠، ١١٦). وهناك أربعة طرق مميزة لتحسين مستوى النمو الاجتماعي لدى الأطفال التوحديين هي:

١- التدريس المباشر للسلوكيات الاجتماعية ذات العلاقة، والتي تعتمد على التحكم الظاهري بالمهارات المحللة المهمة؛ لتشجيع وزيادة عدد مرات وتكرار السلوك الاجتماعي، ويعتبر هذا الإجراء من أكثر الإجراءات فاعلية وتدخلا.

٢- تلقين السوابق أو توسط المدرس للفاعلات الاجتماعية، والشكل المعتاد لهذا الأسلوب هو تقديم مثير تلقيني للبدء بتصريف ما بواسطة المدرس، متبوعاً بالتعزيز (انتباه أو ثناء) للطفل التوحدي لمشاركته الناجحة في تفاعل إيجابي مع قريبه أو زميله.

٣- ابتداء القرين أو الرفيق ويشتمل هذا الإجراء على تدريس الأقران المقتردين اجتماعياً لبدء التفاعلات مع الأفراد الذين لديهم اضطراب التوحد.

٤- تدريس القرين، والبرنامج الذي يعتمد على هذا الأسلوب لا يقتصر فقط على تنظيم عملية التفاعل بين التلاميذ القادرين اجتماعياً وأقرانهم الذين لديهم اضطراب التوحد، وإنما أيضاً يوفر فرصاً إضافية، لتنمية المهارة للأطفال التوحديين (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١١٨-١١٩).

قائمة المحتويات

ويضع أحمد السيد سليمان (٢٠١٠، ١٢٧-١٢٨) عناصر مهمة يجب مراعاتها عند التدريب على المهارات الاجتماعية والتواصل منها:

تكرار السلوك المستهدف.

التعلم الموجه للقواعد الاجتماعية.

استبعاد المعززات بصورة تدريجية وبمرور الوقت.

التفسير اللفظي للمهارات الاجتماعية.

التدريب على المهارات الاجتماعية في الأماكن الطبيعية.

التدريب على لعب الأدوار للسلوكيات المستهدفة.

سهولة إمكانية استخدام المهارات.

التنسيق بين البيئة المدرسية والبيئة المنزلية.

فالتدريب على المهارات الاجتماعية اليومية والأنشطة المرتبطة بها تؤدي إلى تكامل شخصية الطفل ونموه، ويرفع من مستوى تقديره لذاته، ويؤثر على صحته النفسية؛ مما يكسب الطفل سمات شخصية إيجابية والثقة بالنفس والاستقلالية، في حين أن القصور في المهارات الاجتماعية وضعف القدرة على التفاعل الاجتماعي الإيجابي يؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والإحباط والخجل (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١١٤).

صعوبة التدريب علي المهارات الاجتماعية وأهميتها في ذات الوقت:

ثبت بشكل قاطع أن التدخل المبكر يفيد ويثمر بشكل إيجابي Positive مع أطفال التوحد، وعلى الرغم من الاختلاف بين برامج رياض الأطفال إلا أنها تشترك جميعها في التركيز علي أهمية التدخل التربوي الملائم والمكثف في سن مبكرة من حياة الطفل، ويستجيب أطفال التوحد لبرامج التربية الخاصة ذات التنظيم الجيد، والتي تصمم لتلبية الحاجات الفردية Individual Needs وتتضمن التدخل الذي يهتم بعلاج المشكلات التواصلية، وتنمية المهارات الاجتماعية وعلاج الضعف الحسي، وتعديل السلوك، على أن يتم ذلك من خلال متدربين ومعلمين من أصحاب الكفاءة والدراية، ومن أساسيات التدخل المبكر تدريب أطفال التوحد على مهارات الحياة اليومية في سن مبكرة، مثل تعلم عبور الشارع، أو التسوق بدرجة بسيطة، إضافة إلى تنمية المهارات ذات الصلة بجوانب: التواصل البصري، تحسن في عادات النوم، الانتباه، التحدث، استخدام الكلمات (كوثر حسن عسلي، ٢٠٠٦، ١٧٧: ١٧٩).

كما تعد المهارات الاجتماعية التحدي الأساسي للنجاح في تعلم وتدريب الأطفال المصابين بالتوحد، لأن العديد من الأطفال ذوي التوحد يعانون من نقصٍ حادٍ في التواصل اللغوي في حوارهم مع الآخرين. لذلك يلجأ الأخصائي المعني بالتدريب، وتعليم الأطفال التوحديين إلى استخدام مجموعة من الاستراتيجيات والفنيات، لإكسابهم المهارات الاجتماعية، والقدرة على التواصل الاجتماعي منها: (النمذجة-النمذجة بالصورة وبالفديو- المحادثة الاجتماعية- القصص الاجتماعية- تبادل الكروت- لعب الأدوار- اللعب التخيلي والرمزي وغيرها).

قائمة المحتويات

كما تشير البحوث والدراسات الحديثة للتدريب إلى أن اكتساب وتعلم المهارات الاجتماعية لأطفال التوحد يتضمن تكتيك تدريب الطفل على مهارات حل المشكلات، ومن خلال استخدام هذه الاستراتيجية تتم استثارة الطفل للمحادثة الاجتماعية والانتباه، وطلب المساعدة من الآخرين، والتواصل البصري، وهذا يُمكن الطفل من تعميم استخدام المهارات في المسارات الطبيعية للمهارات، التي تعلمها واكتسبها بالتدريب، ليطبق تلك المهارات في أنشطة الحياة الاعتيادية (Johnny Matson, 2009, 129).

ويذكر وليد خليفة وآخرون (٢٠١٣، ١١٣) أن هناك مشكلات أساسية في تدريب التوحيدين على المهارات الاجتماعية، تلك المتعلقة بالتعميم والاستمرارية، فيرون أن أكثر الدراسات تعتمد علي النتائج المرتبطة بموقف التدريب، حيث يجب أن يظهر تأثير التدخل علي الأداء خارج سياق التدريب الفوري، لذا، يجب علي الباحثين أن لا يضعوا بعين اعتبارهم أن التوحيدين يستطيعون كسب أي مهارة خاصة بسهولة ويسر، فأطفال التوحد يحتاجون إلى رعاية وعناية خاصة؛ ليزيدوا من كفاءة المهارات الاجتماعية، فيجب أن نركز بشكل أساسي علي تجزئة وتحليل المهارات الخاصة إلى عناصر بسيطة وسهلة، حتى يسهل تعلمها وتكرارها وتدعيمها، واستمرار التدعيم الاجتماعي والمادي في بيئة التوحيدي؛ حتى يستمر في تأدية السلوك المناسب.

ويشمل مفهوم التدريب على المهارات الاجتماعية عدداً واسعاً من الإجراءات والأساليب، التي تهدف إلى مساعدة الأطفال والبالغين التوحيدين على التفاعل الاجتماعي، ولأن كل موقف اجتماعي يختلف عما سواه؛ فإن ذلك يجعل من عملية التدريب على المهارات الاجتماعية أمراً شاقاً على المعلمين والمعالجين السلوكيين، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية وضرورة التدريب على المهارات الاجتماعية باعتبار أن المشاكل التي يواجهها التوحيديون في هذا الجانب واضحة، وتفوق في شدتها الجوانب السلوكية الأخرى وبالتالي؛ فإن محاولة معالجتها لا بد أن تمثل جزءاً أساسياً من البرامج التربوية والتدريبية (نورالهدى محمد صبحي كابس، د.ت، ٦٣).

ومن الأساليب المستخدمة في التدريب على هذه المهارات أسلوب تمثيل الأدوار، واستخدام كاميرا الفيديو لتصوير المواقف وعرضها، إضافة إلى التدريب العملي في المواقف الحقيقية، وبشكل عام يمكن القول إن التدريب على المهارات الاجتماعية أمر ممكن إلى حد ما، على الرغم مما يلاحظه بعض المعلمين أو المدربين من صعوبة لدى بعض التوحيدين تحول بينهم وبين القدرة علي تعميم المهارات الاجتماعية، التي تدربوا عليها على مواقف أخرى مماثلة أو نسيانها، وفي بعض الأحيان يبدو السلوك الاجتماعي للطفل التوحيدي غريباً من وجهة نظر المحيطين به، لأنه تم تعلمه بطريقة نمطية ولم يكتسب بطريقة تلقائية طبيعية.

ولابد من الإشارة كذلك إلى أن هناك بعض جوانب المهارات الاجتماعية التي يصعب تدريسها أو التدريب عليها، مثل الإحساس بمشاعر الآخرين وأفكارهم أو إظهار التعاطف مع الغير (نورالهدى محمد صبحي كابس، د.ت، ٦٣-٦٤).

وقد توصل عادل عبدالله (٢٠٠٢) في دراسته إلى أن تدريب الأطفال التوحيدين على المهارات الاجتماعية من شأنه أن يزيد وعيهم الاجتماعي وخبراتهم الاجتماعية ويزيد بالتالي من تفاعلاتهم ويجنبهم الدخول في العديد من

قائمة المحتويات

المشكلات التي من شأنها أن تعوق التفاعل الاجتماعي، وتؤكد سهير محمود (٢٠١٠، ٢٥٧) أن المشكلات السلوكية تظهر على الأطفال بسبب القصور في مهارات التواصل الاجتماعي، وأن هناك دراسات أثبتت فاعلية الإرشاد السلوكي والبرامج العلاجية في تحسين المهارات اللغوية والتفاعل الاجتماعي بين أطفال الروضة. ويتوقف تدريب الطفل وتعليمه لاكتساب المهارات الاجتماعية على عوامل متعددة منها: ما هو خاص بالطفل المتعلم، مثل: مراحل النمو، وخصائصه الشخصية، ومنها ما هو خاص بالمجتمع والبيئة التي يعيش فيها الطفل مثل: ثقافة المجتمع وأولوية القيم التي يريد غرسها في أفراد، وعاداته وتقاليده (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١١٤).

وأكدت بعض الدراسات على أهمية استخدام مجموعة من الرفاق في تحسين التفاعلات الاجتماعية لدى الطفل التوحدي منها دراسة "كارسيون Carrison" وذلك على عينة مكونة من ٣ أطفال توحديين تتراوح أعمارهم بين (٦-٧) سنوات مع مجموعة من الأطفال العاديين حيث تم تدريبهم على لعب الدور والتغذية المرتدة، وذلك بهدف تشجيع وإثارة التفاعل الاجتماعي المطلوب، وأسفرت النتائج عن تحسن واضح في تحسين العلاقات الاجتماعية بين هؤلاء الأطفال التوحديين، وتحسن في مستوى اللغة ونقص السلوك الفوضوي، كما أثبتت دراسة Pierce & Schreibmam ذلك أيضا (في: سهير محمود، ٢٠١٠، ٢٩٩-٣٠٠).

قياس المهارات الاجتماعية للأطفال التوحديين:

ناقش كثير من الباحثين في دراساتهم عجز المهارات الاجتماعية عند أطفال التوحد، وذهبوا إلى أن الأطفال التوحديين يفتقدون المهارات الاجتماعية، والبعض الآخر يذهب إلى أن المخزون المهاري لدى هؤلاء الأطفال فيه نضوب، وهم يعانون من مشكلة في تلك المهارات، ومن هنا جاء الاهتمام في إيجاد أدوات لقياس المهارات الاجتماعية وأشهر هذه الأدوات:

- ١- **قوائم الملاحظة المقتنة:** للصعوبات في التفاعلات الشخصية، كمؤشر لنقص المهارات الاجتماعية مثل: العجز عن توكيد الذات والخضوع، ويتكون من (١٢٧) بندا تقيس العوامل الآتية: التوكيد الاجتماعي، الدفاع عن الحقوق، التوجيه والتعبير عن المشاعر الإيجابية والسلبية، تقدير الذات، التعاطف.
- ٢- **مقاييس السلوك الاجتماعي والمهارات الاجتماعية:** من هذه المقاييس مقاييس السلوك التكيفي، ومقياس "فاينلاند" للنضج الاجتماعي، ومقاييس تقدير المهارات الاجتماعية.

معايير فاعلية البرامج الموجهة للطفل المصاب بالتوحد:

- كي تكون البرامج الموجهة للطفل المصاب بالتوحد فعالة يجب مراعاة المعايير التالية:
- ١- احتواء البرنامج على أهداف وأدوات وأنشطة مناسبة للأطفال سواء أكان التدريب فرديا أم جماعيا، مما يؤكد على محاولة التعرف على كل طفل وتحليل مواطن القوة والضعف عنده.
 - ٢- ترتيب جدول زمني روتيني لأنشطة الصف، يجعل الطفل يتقاضي الشعور بالارتباك وترتيب البيئة الصفية وتنظيمها على شكل أركان تساعد على تنفيذ البرامج ويبعد الطفل عن المشتتات.

قائمة المحتويات

- ٣- إتاحة الفرصة للتفاعل الاجتماعي في الغرفة الصفية مع الآخرين، وذلك بتنظيم الغرفة الصفية (منطقة العمل الجماعي).
- ٤- تقديم التعليمات بشكل واضح وقاطع يزيد من فاعلية البرامج.
- ٥- استخدام المدرب لمواد تعليمية متنوعة، وذلك لاستثارة أكثر من قناة حسية واحدة للحصول على تعليم مناسب للمهارة المراد تعلمها، يساعد البرامج الموجهة ويزيد من فاعليتها.
- ٦- تعميم الخبرات التعليمية التي قدمت في الفصل، بحيث يتم تطبيقها في أكثر من مكان مختلف، ومع أشخاص مختلفين وأوقات مختلفة باستخدام تعليمات متنوعة.
- ٧- استخدام أساليب تدخل واضحة ومحددة لاستثارة دافعية الأطفال (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١١٧-١١٨).

أهم برامج تنمية المهارات الاجتماعية:

- ١- برنامج ما كجنس، وجولدستاين (McGinnis, Gold Stein, 1984) يهدف إلى تحقيق مستوى مناسب من المهارات الاجتماعية في مجالات بداية المهارات الاجتماعية، والمهارات المرتبطة بالمدرسة، ومهارات تكوين الصداقات، التعامل مع المشاعر، وبدائل العدوان، والتعامل مع الضغوط، والأساليب المستخدمة في تحقيق هذه الأهداف: النمذجة، لعب الأدوار، التغذية الراجعة، التدريب الانتقالي.
- ٢- برنامج ولكر وزملانه (Walker, et al., 1983) يهدف إلى تحقيق مستوى مناسب من المهارات الاجتماعية في مجالات: التدريب على مهارة الاستماع والاستجابة للأوامر واتباع قواعد الفصل، مهارات التفاعل الأساسية مثل: الاتصال بالعين، انتظار الدور، مهارة التوافق، مثل: استخدام الكلمات المناسبة للموقف، مهارة إقامة الصداقات، مهارة التوافق والاستجابة لأفعال الآخرين، والأساليب المستخدمة في تحقيق هذه الأهداف: التعليمات المباشرة، النمذجة.
- ٣- برنامج ويلز (Wells, 1987) ويهدف إلى تدريب الأطفال بهدف النجاح في المدرسة، ومع النفس ومع الآخرين، وتدريبهم لتغيير سلوكهم المشكل في مجالات: تنمية مهارات التفاعل المناسب مع المعلمة، تكوين نظرة إيجابية إلى المدرسة، إتباع قواعد الفصل، الالتزام بالمواعيد والتعليمات، اكتساب القدرة على التحكم في النفس والتفاعل مع الأقران، تكوين الصداقات والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والأساليب المستخدمة في تحقيق هذه الأهداف: التعليمات المباشرة، النمذجة، التدريب الانتقالي.
- ٤- برنامج مانكس (Mannix, 1985) ويعتمد على القصص المصورة، ويتضمن دروس في بعض المهارات الاجتماعية، مثل: التدريب على إتقان العمل، والتدريب على التعامل مع الإحباط.
- ٥- برنامج جولي وزملاؤه (Golly, et al., 1998) ويهدف إلي تحسين سلوك الطفل وتكيفه الاجتماعي، والأساليب المستخدمة لتحقيق ذلك: التعليمات المباشرة، أساليب التدعيم بالنقط، ونلاحظ أن أهداف هذه البرامج تشترك في هدف واحد، وهو تحسين سلوك الأطفال، وإكسابهم المهارات الاجتماعية، وتعتمد على الأساليب نفسها في تنفيذ الأهداف، مع الاختلاف البسيط في المجالات التي تركز عليها (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ١١٩: ١٢١).

علاج التوحد:

برغم البحوث التي أجريت على التوحد، فإن العلم لم يصل بعد إلى تحديد دقيق للعوامل المسببة للاضطراب، ومن الطبيعي ألا يحدث تطور كبير في أساليب وبرامج التدخل العلاجي أو الوقاية من الاضطراب، بالإضافة إلى صعوبات التشخيص، وكذلك مشكلة تعدد الإعاقات التي كثيراً ما تصاحب الاضطراب.

ويرى إبراهيم محمود بدر (٢٠٠٤، ٦٣-٦٤) أن أهداف برامج علاج وتأهيل أطفال التوحد مهما تنوعت تنحصر في الأهداف المهمة الآتية:

- زيادة نمو الطفل في محاوره المختلفة وخاصة الأكثر تضرراً منها.
- الاهتمام بوجه خاص بنمو مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين.
- الاهتمام بالنمو اللغوي، وزيادة حصيلة الطفل من المفردات اللغوية المرتبطة بالمواقف الحياتية والدفاعية مع الآخرين.
- كف أو تخفيف السلوكيات النمطية والشاذة التي تعرقل التواصل مع الآخرين وتعلم الطفل.
- تعليم المهارات الأكاديمية والمهنية من أجل الإعداد التربوي والمهني.
- تعليم مهارات رعاية الذات خاصة لأطفال التوحد الذين يعانون من تخلف عقلي شديد بالإضافة إلى التوحد.
- مساعدة الوالدين والأسرة على تعلم طرق التواصل مع الطفل، والمشاركة في علاجه أثناء وجوده معهم في المنزل، وكذلك تقديم المساعدة والدعم والإرشاد لهم.

علاج التوحد في مصر والعالم العربي:

شهدت الساحة العربية مؤخراً زيادة في عدد ونوعية الخدمات الموجهة للتوحد، ويرى إبراهيم محمود بدر (٢٠٠٤، ١٠٣-١٠٤) أن فئة الأطفال التوحدين لم تتل حظها من الاهتمام والرعاية في مصر والعالم العربي، مقارنة بالفئات الخاصة الأخرى، ويرجع ذلك للأسباب الآتية:

- ١- صعوبة تشخيص حالات التوحد من جهة، ولمعاناة (٧٠٪) على الأقل من أطفال التوحد من تخلف عقلي كذلك، فإن كثيراً من أطفال التوحد يتم تشخيصهم من جانب الأطباء أو المختصين في مراكز الإعاقة الذهنية على أن هؤلاء الأطفال من المتخلفين عقلياً، وفي أحسن الأحوال يتم تأهيلهم في مدارس التربية الفكرية.
- ٢- يوجد في المنطقة العربية عموماً نقص شديد في الكوادر الطبية والتربوية والنفسية المؤهلة والمدرّبة للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال.
- ٣- نقص الوعي العام بأعراض إعاقة التوحد، خاصة من جانب الأمهات والآباء والتفسير الخاطئ لهذه الأعراض، ويترتب على ذلك عدم اكتشاف اضطراب التوحد منذ البداية، وبالتالي عدم التدخل العلاجي والتأهيلي المبكر، مما يعني مزيداً من تدهور النمو بسبب الآثار السلبية الناجمة عن تفاقم الإعاقة.
- ٤- توجد بعض مراكز العلاج التي تقدم عوناً لأطفال التوحد، ولكن دون وجود برنامج تعليمي فردي خاص لكل طفل توحدي، يساعده على نمو قدراته المعطلة بالكشف عن مشكلاته واحتياجاته، من خلال عمليات القياس والتقييم القائمة على أسس علمية موضوعية.
- ٥- إذا استطاعت أسرة لديها طفل توحدي أن تأخذه إلى إحدى العيادات الخاصة أو المراكز الطبية الخاصة، فإنها لن تستطيع مهما كان دخلها أن تواصل علاج طفلها بسبب ارتفاع نفقات هذا العلاج منذ اللحظة الأولى، مما يزيد من إحباط الأسرة واستسلامها للأمر الواقع دون تقديم أي إعداد أو تأهيل للطفل المصاب.

قائمة المحتويات

وقد قام كل من روجر مندوزا وتشري هيل (Mendoza & Hill,2010,12) بدراسة عن العبء الاقتصادي الملقى على عاتق أسر التوحيدين في مصر وقسمت الدراسة الأحياء المختلفة للقاهرة الكبرى إلى ثلاث مناطق (حضرية وشبه حضرية وريفية) وخلصت الدراسة إلى أن نسبة (٨٣,٣٪ : ٩١,٣٪) من التوحيدين يعيشون في بيوتهم تحت رعاية أسرهم وذلك لبعد المسافة بين بيوتهم وأقرب مركز متخصص للعلاج، وعدم القدرة على تحمل أعباء العلاج في تلك المراكز.

ويصنف إبراهيم محمود بدر (٢٠٠٤، ٨٢-٨٣) علاج التوحد إلى نوعين من العلاج هما:

أولاً: العلاج التقليدي: ويشمل العلاج النفسي التحليلي والعلاج الطبي والعلاج السلوكي.

ثانياً: الاتجاهات الحديثة في علاج التوحد: وتشمل بدورها ثلاثة اتجاهات هي:

أ- العلاج السلوكي الحديث (تحليل السلوك التطبيقي): وهو بتعبير "أندرو بوندي BondyA وجه جديد لعلاج قديم، يقوم على تحليل السلوك العياني للطفل التوحيدي، ثم القيام بإجراء عملي لتعديل هذا السلوك في اتجاه زيادة النمو أو كف معوقات النمو.

ب- برامج التدخل العلاجي والتأهيلي: وتشمل البرامج العلاجية التعليمية المدرسية والمنزلية، بقصد التعامل مع حالات التوحد فردياً وجماعياً، من أجل تعليم الطفل وإعداده لمهنة مناسبة لقدراته ورعايته ذاتياً ومساندة أسرته وإشراكها في علاج الطفل.

ج- العلاجات الحديثة: تقوم أساساً على ممارسة الطفل لبعض الأنشطة المميزة مثل: اللعب والرسم والموسيقى...إلخ، بهدف زيادة جوانب النمو المتضررة بسبب الإصابة بالتوحد.

التدخل المبكر في علاج اضطراب التوحد:

يسهم التدخل المبكر في تطوير نمو الطفل التوحيدي، إضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لذوق الطفل من الأهل والقائمين على رعايته، مما يحقق أقصى إفادة للطفل، فقد أثبتت الدراسات والتجارب العلمية أن تطور الحالة وتحسنها، يكونان أفضل بكثير إذا كان الطفل يخضع لبرنامج تعليمي منظم بدرجة عالية ومكثفة من (٢-٣) سنوات، مما يتيح فرصة أكبر لتطور ونمو المخ عنده، واكتساب الخبرات والتفاعل مع المحيط الذي حوله، مما يؤدي إلى تنمية القدرات المعرفية والاجتماعية لديه، ومن ثم تأهيل الطفل لدخول المراحل الدراسية العادية، وأحياناً يؤهله لإيجاد مهنة ما مقارنة بالأطفال الذين لم تتح لهم فرصة التدخل المبكر.

والسبب أنه في السنوات الأولى من عمر الطفل تكون بعض المراكز العصبية والحسية في الجهاز العصبي لاتزال في طور التشكيل، بحيث يكون من السهل تعديلها وتطويرها، وكذلك الخبرة المبكرة لدى الأهل لها دور مهم من خلال اتباعهم منذ السنوات الأولى لعمر الطفل الأساليب العلمية التربوية السليمة للتعامل مع طفلهم، وبالتالي التقليل من السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك لما يتصف به الطفل في هذا العمر من المرونة النسبية، والقابلية للتغيير (إبراهيم محمود بدر، ٢٠٠٤، ٦٤-٦٥).

قائمة المحتويات

برامج التدخل:

إن برامج التدخل تحسن نوعية الحياة التي يحياها أطفال الفئات الخاصة، وتتيح لأفراد الأسرة فرصة التفاعل مع أطفالهم، وذلك من أجل تحقيق احتياجاتهم وحل مشكلاتهم (محمد إبراهيم عبد الحميد، ٢٠٠٣، ٧)، وكما يؤكد محمد عوده (٢٠١٥، ١٠) "أن التوحد حالة طويلة المدى، يمكن أن تتحسن مع الوقت من خلال التعليم المناسب، ويحتاج هؤلاء الأفراد إلى مجهود حتى يصلوا إلى مرحلة التكيف"، وهناك العديد والعديد من البرامج الخاصة بأطفال التوحد نذكر منها:

برنامج لوفاس LOVAAS:

مبتكر هذه الطريقة هو "لوفاس LOVAAS" أستاذ الطب النفسي في جامعة "لوس أنجلوس"، وهو قائم على النظرية السلوكية والاستجابة الشرطية في علم النفس، حيث يتم مكافأة الطفل على كل سلوك جيد، أو على عدم ارتكاب السلوك السيئ، كما يتم عقابه (كقول قف، أو عدم إعطائه شيئاً يحبه) على كل سلوك سيئ، وتعتمد طريقة "لوفاس" على استخدام الاستجابة الشرطية بشكل مكثف (وليد خليفة وآخرون، ٢٠١٣، ٥٠).

وكثير من الدراسات الحديثة قد أكدت أهمية برنامج "لوفاس" في تحسين مسار نمو ما يقرب من نصف عدد الأطفال الذين التحقوا بهذا البرنامج بحيث أمكنهم دخول المدرسة العادية مع أقرانهم العاديين ومواصلة دراستهم، ورغم أن هذا النجاح فإن انتقادات كثيرة وجهت إلى هذا البرنامج، لأنه يقوم على خضوع الطفل التوحد للتعليم والتدريب المكثف لمدة (٤٠) أربعين ساعة أسبوعياً لفترة زمنية لا تقل عن سنتين، ويحتاج هذا العمل الشاق إلى عدد من الأخصائيين بعدد الأطفال التوحديين الملتحقين بالبرنامج، كما يحتاج إلى تكلفة مالية عالية جداً لا يقدر عليها معظم آباء هؤلاء الأطفال، وربما كان الحل هو تطبيق أجزاء من هذا البرنامج، مع تدخل بعض العلاجات الحديثة المنتقاة لتناسب حالة الطفل التوحد وأسرتهم (إبراهيم محمود بدر، ٢٠٠٤، ١٤٩).

برنامج تيتش TEACCH:

برنامج تربوي للأطفال التوحديين ومن يعانون من مشكلات التواصل، وقد طوره "إيريك شوبلر Eric Shopler" عام ١٩٧٢ في جامعة "نورث كارولينا"، ويعتبر أول برنامج تربوي مختص بتعليم التوحديين، كما يعتبر برنامجاً معتمداً من جمعية التوحد الأمريكية، ويرتكز على تعليم مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية واللعب ومهارات الاعتماد على النفس والمهارات الإدراكية، ومهارات التكيف في المجتمع ومهارات حركية والمهارات الأكاديمية وله مميزات عديدة، فهو يعتمد على التنظيم لبيئة الطفل سواء كان في المنزل أو غيره من الأماكن، حيث أثبتت هذه الطريقة أنها تناسب الطفل التوحد وتناسب عالمه، ويقوم بعمل برامج تعليمية خاصة لكل طفل على حدة، حسب قدراته الاجتماعية والعقلية والعضلية واللغوية، ويدخل هذا البرنامج عالم الطفل التوحد ويستغل نقاط القوة فيه، مثل: اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وحب الروتين، كما أنه يعتبر برنامجاً متكاملًا من عمر (٣-١٨) سنة، بالإضافة إلى التدخل المبكر، ولهذا فالبينة التعليمية لهذا البرنامج بيئة تعليمية منظمة تقوم على

قائمة المحتويات

المعينات والدلائل البصرية، لكي يتمكن الطالب من التكيف مع البيئة، حيث تقوم هذه البيئة المنظمة على تكوين روتين محدد، وتنظيم المساحات، والجدول اليومية، وتنظيم العمل، والتعليم البصري (كوثر حسن عسليّة، ٢٠٠٦، ٢٢٣: ٢٢٥).

وفي عام ١٩٧٢م حصل هذا البرنامج على جائزة الطب النفسي الأمريكية، باعتباره أحد أهم البرامج الفعالة في تعليم وتعديل سلوك الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية المختلفة، فضلا عن إمكانية تطبيق مبادئه في المدارس العامة، ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم البرامج فعالية في التعامل مع الأطفال ذوي اضطراب التوحد؛ ولذلك يتم تطبيقه في العديد من المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقات على مستوى العالم (عادل عبدالله، ٢٠١٤، ٢٣-٢٤).

برنامج بيكس PECS:

يهدف إلى تعليم الطفل التواصل القصدي، وهو نظام التواصل من خلال تبادل الصور، لتعليم الأطفال الذين لا يمتلكون القدرة على استخدام اللغة المنطوقة، ونظرا لأنه يستخدم الصور -وهي تعتبر لغة عالمية نوعا ما- فسيكون بمقدور الطالب التواصل مع أي شخص وفي أي مكان، كما أنه لا يتطلب من الطفل أن يقلد لغة منطوقة أو تقليدا للحركات كما هو الحال في التدريب علي النطق ولغة الإشارة، ولا يتطلب المحافظة على التواصل البصري خلال عملية التبادل (ل. خوان هيفلين، دونا فيورينو أليمو، ٢٠١١، ٣٤٢).

ويذكر عادل عبدالله (٢٠١٤، ٤٦) أن تعليم الأطفال ذوي اضطراب التوحد التواصل من خلال الصور لا يعني مطلقا أنهم سيعتادون على تلك الصور، ولن يتطور الكلام لديهم، حيث أثبتت الدراسات التي تناولت برنامج "بيكس" في تعليم التواصل لهؤلاء الأطفال أن النسبة الكبرى منهم قد تمكنت من استخدام الكلام في التواصل، وهناك نسبة أقل قد استخدمت الكلام والصور معا في تواصلهم مع الآخرين، حيث تمثل الصورة خطوة على الطريق للنطق.

برنامج صن رايز Son-Rise:

هو أحد البرامج المنزلية الخاصة بتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد، وطور هذا البرنامج "باري كوفمان وسماريا كوفمان" عام ١٩٧٠، وهما والدا طفل توحدي، وقد أخبرهما الأطباء أن حالة ابنهما ميؤوس منها، ولكنهما لم ييأسا وقاما بتعليم ولدهما لمدة (١٢ ساعة) يوميا على مدار الأسبوع طوال السنة، وأظهرت النتائج تقدم وتحسن ملحوظ على طفلهما وأصبح يتكلم بطلاقة، وتقوم فلسفة البرنامج على تقليد حركات الطفل والدخول إلى عالمه الخاص، مما ينمي لديه الشعور بالحب والطمأنينة والثقة (محمد محمد عوده، ٢٠١٥، ٣٠).

وفكرة البرنامج ببساطة أن والدي الطفل التوحدي هما الطبيب الحقيقي له، وهما الحريصان على طفلهما، والمهتمان بكل ما هو جديد في محيط إعاقته ابنهما، فهما الوحيدان اللذان يستطيعان الجزم بأن طفلهما التوحدي قد أظهر تحسنا ملموسا أو واضحا، وليس غريبا أن يكتشف الأب أم الأم علاجا لحالة طفلهما المصاب بالتوحد (أحمد

قائمة المحتويات

سليم النجار، د.ت، ١١٠-١١١)، وقد بدأ استخدامه في منتصف السبعينيات وفي عام ١٩٨٣ بدأ اعتماده عالمياً وبشكل رسمي كأحد البرامج المطبقة بنجاح مع أطفال التوحد (www. T7di. Net).

وينصح "كوفمان" في البداية بتعلم الكلمات التي فيها حركات، فهي أول وأسهل ما يستجيب له الطفل، فعندما نعلمه كلمة "فوق" علي سبيل المثال نرفعه عالياً (إلى الأعلى) فالكلمة هنا تتبعها حركة ومتعة وتعطي دافعاً أكثر للطفل أن يحاول تقليدها؛ ليحصل على الحركة الممتعة (فهو بمثابة اللعب الحركي)، بعد ذلك نعلم الطفل أسماء لها حركة مثل: كورة... وهكذا، والأهم أنه عند كل محاولة تواصل من الطفل، مثل: نطق كلمة أو جزء منها، لابد أن تُقابل من الوالدين بفرح مثير للطفل وانفعال مبالغ فيه حتى يعطيه ذلك دافعاً أكثر للاستمرار والمحاولة (www.twahod voice. com).

ولأهمية الدور الذي تقوم به الأسرة ركز البرنامج على التدريب الجيد لهم؛ لأنهم سيقومون بتنفيذ الجانب الأكبر في البرنامج، ويؤكد ذلك "كوهن Cohn" ويشير إلى أن "العلاقات السائدة داخل الأسرة، يكون لها تأثيرها الواضح على علاقات الأبناء الاجتماعية خارج الأسرة؛ لأن تفاعل الطفل مع الوالدين يساعده في التعرف على كيفية استجابة الآخرين له واستجابته لهم (في: عايدة شعبان، ٢٠٠٥، ١٤٨).

العلاج بالفن في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة:

إن الفن في نظر الطفل نوع محبوب من أنواع اللعب، وشكل من أشكال التعبير عن النفس والترفيه عنها، كما يمكن أن نجد في الرسم والنحت والرقص والموسيقى، وبالذات في المسرح الذي استخدم في العلاج النفسي فيما سمي "السيكودراما" Psychodrama. لأن المسرح النفسي يجب أن يتسع للمعاقين وغير المعاقين، فهو ليس مجرد علاج وإنما هو فن أيضاً، أو هو علاج عن طريق الفن. فما هو مسرح الطفل؟ وما هي خصائصه؟

-السيكودراما Psychodrama:

السيكودراما تمثيلية تستخدم الأدوات التي تستخدم في فن المسرح ويستعان بها في العلاج النفسي فالسيكودراما فن من ناحية، وطب من ناحية أخرى. وبعض الباحثين يعتبرها شكلاً من أشكال المسرح كما فعل مورينو Morino. وهو أول من استخدم السيكودراما، والبعض الآخر يعتبرها شكلاً من أشكال الطب النفسي. والواقع أن العلاج النفسي كان هدفاً من أهداف المسرح منذ بدايات هذا الفن.

ويعرف "أحمد عكاشة" السيكودراما إلى أنها نوع من أنواع العلاج الجماعي يجتمع فيه عدد من المرضى من خمسة أفراد إلى خمسة عشر يلعبون الأدوار المسرحية، ويجب أن تكون السيكودراما تعبيراً صادقاً عن مشكلة خاصة أو مشكلة جماعية للمرضى. وأثناء تمثيلهم للأدوار التي يقومون بها يتذكرون ما حدث لهم ويقدمونه بالصورة التي تتطلبها عملية التنفيس الانفعالي، ويتخلصون من مخاوفهم وشعورهم بالنقص أمام الجمهور، فيحسون بالراحة والاندماج في المجتمع. ومعنى هذا أن الجمهور أو المشاهدين شرط جوهري في السيكودراما، لأنه يمثل المجتمع

قائمة المحتويات

الذى كانت تمثلها الجوقة أو الكورس فى المسرح اليونانى. ويرى "عبد الرحمن سليمان" أن الجمهور يمثل رأى العام بالنسبة للمريض، وتعكس استجاباته مدى قبول المجتمع أو رفضه لما يصدر عن البطل (المريض). وهناك من يرى أن المشاهدين يجب أن يكونوا من المرضى الذين يدركون حاجتهم للعلاج النفسى ولهذا يندمجون مع الممثلين الذين لا يعبرون عن أنفسهم فقط، وإنما يعبرون عن كل الموجودين فالقائم بالدور يخاطب الجمهور ويتحد به، والجمهور يرى نفسه فيمن يقوم بالدور وفى هذا الاندماج يتحقق التطهير المطلوب لدى الطرفين. والسيكودراما إذن شكل من أشكال المسرح، لكنه مسرح من نوع خاص يقدم لممثلين من نوع خاص وجمهور من نوع خاص أيضا. وهو إذن نشاط يتطلب قدرا كبيرا من الرهافة والاستعداد لتفهم لغة الأطفال الذين يقدمونه والأطفال الذين يقدم لهم، فضلا عن قدرة على الاستقرار والاستنتاج ولباقة فى التعامل وإدراك لنعوية الاحتياجات والمطالب.

من هذا المنطلق يجب أن يكون الفنيون المشاركون بالتوجيه والتدريب فى عروض السيكودراما على درجة عالية من الكفاءة من النواحي النفسية والفكرية والثقافية ليكونوا قادرين على اختراق عالم هؤلاء الأطفال والتوفيق بين احتياجاتهم وما يعتمل داخلهم.

-العلاج بالموسيقى : " Music therapy "

الموسيقى هي الفن الوحيد الذي تحسه الحيوانات وضعاف العقول، وذلك لأنها تحوى في ذاتها عاملا طبيعيا أشبه بالتيار الكهربائي يؤثر على الأعصاب بغض النظر عن مستوى التطور ودرجة الذكاء. والموسيقى لكونها أكثر الفنون تجديدا فهي من أوسع قنوات الاتصال المفتوحة على المعاقين ذهنياً بسبب افتقارهم للقدرة الاتصالية، فتعمل الموسيقى على توصيل الأحاسيس.

العلاج بالرقص الإيقاعي:

إن الأطفال مهئون لاستقبال الموسيقى فهي تخلق الجو المناسب للتعبير والتواصل فالأطفال يستمتعون بالحركة المتمشية مع الإيقاع والآلات الإيقاعية ويستمتعون باستخدام أصواتهم كأدوات، بنفس القدر الذي يصنعون به الأصوات بأجزاء جسمهم الأخرى "كالتصفيق"، والدق بالأقدام، وأساليب الإيقاع الحركي المختلفة .

والإيقاع الحركي هو التقسيم الديناميكي الزمني للحركة أي التبادل الانسيابي بين الشد والارتخاء والانقباض والانبساط، لأنه يعكس درجة سريان القوة على مراحل زمنية وترى عنايات عبد الفتاح وتراجى عبد الرحمن (١٩٨٣) أن ثمة علاقة بين الإيقاع الحركي والإيقاع الموسيقي، فالإيقاع الموسيقي هو عبارة عن وسيلة على جانب كبير من الأهمية من خلاله يتم تنظيم وتعليم الإيقاع الحركي، هذا بالإضافة إلى أن تمرينات الإيقاع الحركي لداكروز تمكن الفرد من الإحساس، بالتعبير الموسيقي، وهي في مجملها تمثل هنا تكاملا وثيق الصلة بالحياة والحركة .

إن الإيقاع الحركي يعبر عن جميع عناصر الموسيقى بشكل يطابق محتوى المؤلف الموسيقى تماماً، فيصبح الجسم ، وكأنه آلة موسيقية، وهو ما يقوم بالربط بين القدرة الجسمية، والقدرة العقلية، والقدرة الانفعالية، تلك القوى التي يتوقف اتزان الانسان وتوافقه إلى حد كبير على مدى نموها وتقاربها.

-القصة الموسيقية الحركية:

هي عبارة عن أحداث متتالية تحوى مضمونا تربوياً أو علمياً تستخدم كل أنشطة الموسيقى وعناصرها، ويتم تنفيذ القصة عن طريق الحركة، وبذلك نجدها تضيف الحيوية والإثارة لجذب انتباه الطفل، وللقصة الموسيقية أهداف أخلاقية وتعليمية منها اكتساب قيم أخلاقية حميدة واكتساب أنماط سلوكية سوية تؤدي إلى التكامل والتفاعل الاجتماعي السليم وإثارة خيال الطفل وطموحه.

وقد استخدمت فاطمة محمد رمضان(٢٠٢٢) الرقص الايقاعي "التعبير الحركي" فى علاج التلاميذ من ذوى فرط الحركة ونقص الانتباه، وأثبت البرنامج فاعليته فى خفض النشاط الزائد وزيادة الانتباه.

دور الموسيقى فى علاج الإعاقات:

تشير "ماريا منتسورى" "إلى أهمية اللعب باعتباره وسيلة من وسائل التربية والتعليم كما يعتمد (أوراف Orff) فى أسلوب تربيته للأطفال موسيقياً على مبدأ التعليم عن طريق اللعب والذي يحول لعب الأطفال وغنائهم غير المنتظم إلى لعب وغناء منتظم، وهدفه من ذلك إثارة خيال الأطفال ، وتنمية الجوانب الخلاقة من أنفسهم مع استغلال الطاقة الحركية الطبيعية لديهم في سن مبكرة.

وبناء على ذلك فإن الاستعدادات الفطرية الأولى لدى الطفل، تأخذ شكل المشي أو الجري أو حتى القفز، وهى ما اصطلح على تسميته باللعب لهذا فان اللعب استعداد تلقائي من الطفل يقوم به للوصول إلى الإشباع اللازم لتنفيس الطاقة الكامنة فيه والتي لا يجد لها متنفسا غير الحركات العضلية .

ويشترك الإيقاع الحركي مع الألعاب الموسيقية في وجود عنصر الحركة في كليهما إلا أن الإيقاع يعتبر المادة الخام التي تغذى الأطفال، وتمدهم بالوسائل التي تعينها على تحقيق أهدافها، والألعاب الموسيقية أنواع منها: الألعاب الخاصة (التعبير الحركي)، والألعاب المعبرة (الأناشيد)، والألعاب ذات الأهداف التعليمية والألعاب المنظمة.

التذوق الموسيقي:-

إن التذوق والاستماع إلى الموسيقى أمر يسير إذا استهدفنا الاستمتاع بها كما نستمتع بقسط من دفء الشمس فى حين يصبح الاستماع شاقا حين نستهدف تفهم مغزاها الروحي لان الاستمتاع الواعي يتطلب دراية وجهدا كبيرا، وهذا أساس التذوق السليم.

قائمة المحتويات

ومن هنا فالتذوق نوعان هما:- تذوق سلبي، ويعني إثارة الناحية الجمالية دون معرفة الأسباب التي حركت هنا الإحساس بالجمال . وتذوق إيجابي، وهو في الواقع حكم عقلي وجمالي علي الأعمال الموسيقية لا يمكن الوصول إليه إلا بعد الأخذ بالمعلومات المناسبة للطفل، والتي تعينه للوصول لهذا النوع من التذوق .

الموسيقى وعلاقتها بالتوافق النفسي:-

أوضح هادلي أن العلاج المهني إجراء ضروري، خصوصاً لمرضي الأعصاب لإبقاء عقلم وجسمهم باستمرار في حالة نشاط ،حيث استخدم موريه Moreau العلاج بالموسيقى في القرن التاسع عشر والمقصود بالعلاج المهني هو استخدام أسلوب تنشيط الجسم والعقل الذي كان من أشكاله الإيقاع الحركي لعلاج النفس والروح. والعلاج بالموسيقى مر بثلاث مراحل:

-المرحلة الأولى:- ركزت علي دور الموسيقى دون الالتفات إلى دور المعالج.

-المرحلة الثانية:- ركزت على دور المعالج مع إهمال لدور الموسيقى من اجل تكوين علاقة ثنائية تبادلية مع المريض.

-المرحلة الثالثة:- هي تحقق التوازن المنشود فأصبح المعالج يستخدم قدراته للتركيز على العلاقة مع المريض، ثم يتحرك في الاتجاه المرغوب عن طريق الموسيقى وبالسرعة المناسبة. ثم بدأ استخدام الموسيقى بطريقة أكثر تخصصاً وظهرت مصطلحات جديدة مثل:

* العلاج بالفن Art Therapy

* العلاج الإبتكارى أو الخلاق Creative Therapy

* العلاج بالموسيقى Music Therapy

ومن هنا أصبح من الضروري إعداد منهج للمعالجين بالموسيقى، فكان هانس هوف Hans Hoff أول من وضع فكرة دراسة الموسيقى والطب معاً .

-العلاج بالموسيقى لبعض الأمراض النفسية:-

إن الموسيقى تقوم بدور كبير فى علاج الأمراض النفسية، فالموسيقى عنصر إنساني فريد تنساب نغماتها، وتغلغل إلى النفس والجسم، وهى فى حركتها وتأثيرها تفيد فى علاج قائمة كبيرة من الأمراض النفسية من بينها علاج المعاقين ذهنياً والمعوقين عضوياً والعاجزين عن التكيف مع الحياة.

ونوع الموسيقى المستخدم يجب أن يلائم شخصية المريض وظروف الحالة المرضية حتى يكون للموسيقى التأثير المطلوب.

والموسيقى التي تُختار لعلاج الطفل المضطرب انفعالياً لابد من اختيارها بحيث تلائم شخصيته فبعضها قد يكون مثيراً لمزيد من الاضطرابات، بينما البعض الآخر قد يؤدي إلى نتائج علاجية موجبة، وتحقق له مشاعر

قائمة المحتويات

الأمن، وتُخرجه من قوقعة التمرکز حول الذات، وتفتح له عالماً يُسقط عليه مشاعره بطريقة ملائمة، دون أن تحدث فيه صراعات جديدة، ومثل هذا الاختيار عمل شاق ودقيق وقد شغل الباحثون في مجال العلاج السلوكي بالموسيقى في السنوات الأخيرة، ومن أهم الأمراض النفسية التي يمكن أن تساهم الموسيقى في علاجها.

والعلاج بالموسيقى استخدمه العلماء لزمن طويل في معالجة المشكلات والاضطرابات السلوكية، حيث ثبت أن الموسيقى تفيد في حالات القلق والأرق وغياب التركيز الذهني والسلوك العدواني. وتعمل على تحسين صورة الذات وتزيد القدرة على استخدام الطاقة بشكل هادف فتقل السلوكيات غير المرغوبة، ويزيد التفاعل، وتحسن عملية الإستقبال السمعي والمهارات الحركية والتعبير الوجداني والقدرة على الإبداع والتخيل (سعاد عبد العزيز، ٢٠١٦، ص ٧).

-العلاج بالموسيقى لبعض الاضطرابات الانفعالية:-

يرى "Pettijohm" أن الاضطراب الانفعالي ينطبق على الشخص الذي يستجيب بدرجة مبالغ فيها لمثير انفعالي، لكونه عاجزاً عن إظهار تحكمات داخلية جيدة في عملية نموه ويجب أن يراعى عند وضع "البرنامج الموسيقي" لهذه الحالة فهم المعالج للأسباب المتصلة بالبيئة والوراثة، ومن خلال الفهم العميق للأسباب المختلفة يتم وضع البرنامج العلاجي الشامل، ويجدد "البرنامج الموسيقي" ليؤدي دوره العلاجي مع كافة الأساليب، كما يجب أن يكون المعالج على قدر من المرونة، ويلاحظ مدى فاعلية الموسيقى والتطورات التي تظهر على الحالة وإن يكون قادراً على الابتكار أو على الأقل يكون قادراً على تغيير أو تعديل ما يقدمه من الموسيقى لموسيقى أخرى، وذلك حسب ملاحظته لمدى الأثر الإيجابي أو السلبي لما يقدمه من موسيقى للحالة، والارتجال الموسيقي يلعب دوراً أساسياً، كما أن الموسيقى للطفل المضطرب انفعاليا توفر فرصاً كثيرة لتوصية السلوكيات غير المرغوبة إلى أنشطة مقبولة اجتماعياً فهنا تنشأ علاقة دافئة بين المريض والمعالج بسبب الاهتمامات المشتركة.

-العلاج بالموسيقى لبعض الاضطرابات السلوكية:-

يرى "جاستون" إلى أن للموسيقى تأثيراً إيجابياً على المضطربين سلوكياً من حيث اجتذابهم تجاه أنماط أفضل من السلوك. وينصح جاستون باستخدام الحركات الإيقاعية لدا لكروز، خلال أربع ساعات أسبوعياً ولمدة تسعة أسابيع حيث أن تجاربه مع أمثال هذه الحالات أحدثت تحسناً واضحاً في زمن رد الفعل البسيط عند هؤلاء الأطفال.

-استخدام الموسيقى في إحداث بعض التغيرات السلوكية لدى المعاقين ذهنياً:-

هناك عدة طرق للعلاج بالموسيقى نذكر منها: طريقة أورف Orff للعلاج بالموسيقى حيث أن أسلوبه في العلاج ينقسم إلى قسمين، القسم الأول/ العلاج الجماعي بالموسيقى، والقسم الثاني/ العلاج الفردي بالموسيقى، مع ملاحظة أن طريقة "أورف" في العلاج بالموسيقى تتوقف على حالة التخلف العقلي وهو يقسمهم إلى فئات كالتالي:

-فئة تعاني من فقد النشاط الزائد فيسمعهم.

-فئة تعاني من فقد السيطرة على الحركات، فيعالجها بالمثيرات الصوتية والعينية.

قائمة المحتويات

-فئة تعاني من النشاط الزائد فيسمعهم أصوات هادئة كغناء وترنيم المتألفات.

-فئة تعاني من عدم تمييز الأصداقاء فيعالجهم بتقديم أنشطة غنية في تنوعها مستخدماً الآلات ومتابعة الإيقاع بالتصفيق.

-فئة تعاني من تأخر الكلام: يكون العلاج بإثارة الطفل المتخلف عقلياً بآلات النقر كالطبلية الكبيرة، هذا إلى جانب استخدام مقاطع، ومطالبة الأطفال بإيجاد كلمات متشابهة، ثم تحول هذه الكلمات إلى مواقف علاجية مثل: (مرتفع - مظلم - فوق) .

-فئة ذات سلوك مشاغب: تنقسم إلى فريقين: الفريق الأول: يظهر الخجل ويرفض الكلام ويقاوم الاندماج فيعالجهم بإدماجهم في جماعة. والفريق الثاني: قليل التأمل، وقد يعالج علاجاً فردياً.

-فئة ذات سلوك عدواني: فيعالج هذه الفئة بخلطها بأطفال غير عدوانيين هذا النوع من العلاج مثالي إذا ما توافر للمعالج الوعي بما للموسيقى من طاقات علاجية، وفهم للمشكلات، ومعرفة كيفية استخدام الموسيقى، والأنشطة الموسيقية لتحقيق التغيرات السلوكية المرغوبة.

كما نشير إلى تجارب سميث (Smith,1962) حيث وجد أن الأنشطة الموسيقية تحدث أقصى مفعول لها في العلاج الجماعي مع المعاقين ذهنياً، وذلك أكثر مما لو استعملت أنشطة تشمل البصر، أو الشم أو اللمس.

وأفضل اختيار موسيقى للمعاق عقلياً هو اللحن والنص السهل مع مقدار معين من التكرار، وفي نفس الوقت يجب أن نتفق مع ميول المتخلف عقلياً، ومستواه الاجتماعي. ويمكن للمتخلف أن يساهم في خبرات موسيقية عديدة أهمها الإيقاع الحركي، الغناء، الاستماع، العزف الآلي البسيط.

ومما سبق يتضح العلاقة الوطيدة بين الموسيقى والتوافق النفسي. وأن ممارسة الأنشطة الموسيقية المختلفة تخلق ظروفاً ممتازة لتنمية الذوق والكشف عن القدرات والمواهب الخاصة لدى كل طفل، كما تعمل على دفع عملية التنمية المتوازنة لكل الأطفال.

دور الأنشطة التعبيرية الفنية فى علاج الإعاقات:

العلاج بالفن "الرسم" : " Art therapy "

إن التعبير الفني يتيح للأطفال طرقاً متعددة للتواصل المرئي، ودراسة الفنون واشتراك الأطفال في أنشطة الفنون، يُمكن الأطفال من تعلم أن أساليب التعبير عن المشاعر والأفكار هي من الأشياء المميزة للسلوك الإنساني، كما انه من المهم أن يتعلم الأطفال أن الخيال والأصالة هي مصادر متجددة تشكل التفكير الإنساني رفيع المستوى.

إن الاطفال الصغار يظهرون ميلاً طبيعياً نحو الفن إذا ما توافرت الفرص الفنية في بيئتهم، والفن مثل: اللغة- وسيلة اتصال، وسيلة للتعبير، وهو مرئي أكثر منه لفظي فهو يتضمن عناصر الخط والشكل واللون والملبس بدلا من الكلمات، ولأن الأطفال لديهم دافع فطري نحو التواصل فهم يعملون باستمرار على تنمية هذه الفطرة في كل المناسبات الممكنة، والاطفال الصغار إذا ما أعطوا خامات متنوعة، بالإضافة إلى الحرية والوقت الكافي لاكتشاف

كيف تعمل هذه الخامات ، فانهم سوف يعلمون أنفسهم مهارات الفنون التي يحتاجونها لكي يصلوا إلى ما يريدون أن ينقلوه.

وعلى هذا فإن أنشطة الفنون تنتمي أكثر إلى بيئة التعليم ذاتي التوجيه، فمعظم الأطفال بدءاً من سن الثالثة والرابعة حينما يقفون على الحامل الخاص بالرسم ويبدأون في عمل تخطيطاتهم، فإنهم يكتشفون الأدوات وإمكانيات الإستخدام، أكثر من كونهم يحاولون رسم صورة معينة وبإكتسابهم التحكم في هذه الأدوات فإنهم يبدأون في الإنتقال إلى مرحلة التحكم، وفيها يكررون اشكالا معينة "خطوط راسية ، دوائر" وتكرار ذلك يكون لإكتساب مزيد من التحكم . وفي النهاية يصل بعض الأطفال وليس كلهم إلى مرحلة المعانى Meaning Level ثم يبدأون في رسم الصور والأشكال المعروفة.

وتذكر "كاترين" إنه ليس هناك فاصل بين اللعب التجريبي أو الاستكشافى واللعب الابتكارى، فكل منهما ينبعث من الآخر، فالأطفال يحبون صنع الأشياء ولكنهم أولاً يجب أن يكتشفوا الخامات وكيفية إستخدامها . فالطفل الذى يترك وشأنه ليؤلف شعراً أو ليقود اللعب أو ليبتكر القصة أو يؤدي تمثيلية، هذا الطفل يبتكر شيئاً أيضاً، ولكننا عادة ما نقصد بكلمة اللعب الابتكارى الرسم والتلوين وعمل نماذج وصناعة الأشياء، وفي هذه الأنواع من اللعب يقوم الأطفال باختيار سلوك وخصائص الخامات المعطاة لهم بكل حواسهم، ويتركز اللعب الابتكارى فى :
-أن اكتشاف الخامات هو أول خطوة لصناعة الأشياء، والتناول اليدوي ذو قيمة في حد ذاته ، فالطفل يجب أن تتاح له فرصة اختيار الخامات بحواسه قبل أن يستغلها فى عمل شئ.
-متعة الإنجاز فى كل مرة يقوم فيها الطفل بصناعة شئ ما، وكل ذلك يزيد من شعوره بالثقة بذاته فى ثبات عالمه.
-من خلال صناعة الأشياء والتلوين، يمكننا أن نستشف ما يدور بأذهان الاطفال، ونتعرف على ما هو هام بالنسبة لهم، فالأطفال يعبرون بصورة أفضل من خلال أعمالهم.

ومما سبق يمكن تلخيص أهداف التعبير الفني فى:

-معاونة الطفل على العمل من خلال العديد من الخامات واكتشافها

-معاونة الطفل على تنمية الشعور بالقيمة والإنجاز .

-تنمية القدرة على العمل الجماعى، ومشاركة الآخرين .

-تنمية أساليب التعبير المرئية لدى الأطفال .

- استخدام الفن والرسم مع الأطفال المعاقين:-



تعد هذه الطريقة غير اللفظية ذات فائدة كبيرة مع الأطفال المعاقين فهي تعطيهم الفرصة للتعرف على قدراتهم، وتعطى لهم الفرصة للحصول على تقدير المعالج، أو الجماعة التي يعملون معها. ويتضح ذلك من خلال رسوم الأطفال المعاقين. حيث يعرض المؤلف بعض الرسوم التي رسمها الأطفال، فالمعاقين عقليا الذين يبلغون من العمر (١٠) سنوات يبدون كما لو كان عمرهم خمس سنوات، ولكنهم ليسوا مثل الأطفال الأسوياء في نفس العمر العقلي سواء في العقل أو الشخصية.

أساليب تعليمية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة:

من عوامل تحقيق الأهداف التعليمية اختيار أساليب تدريس مناسبة، وهي الكيفية التي تنظم بها المعلومات والمواقف والخبرات التربوية التي تقدم للطالب وتعرض عليه ليتحقق لديه أهداف الدرس.

ومن أهم أساليب التدريس: التوجيه اللفظي، الحوار والنقاش، المحاكاة، النمذجة، اللعب، التوجيه البدني، التمثيل، القصص، الخبرة المباشرة.

١- الحوار والنقاش:

تعتبر طريقة الحوار والنقاش أساس لمعظم طرق التدريس الحديثة، والتي تهتم بجوانب التواصل اللغوي بين المعلم والطالب. وتساعد هذه الطريقة على نمو المهارات اللغوية للطالب المعاق عقلياً. فعن طريقها يمكن للمعلم أن يتعرف على خبرات الطفل ومدى استيعابه للخبرات الجديدة، كما أنها تعتبر أداة للتفاعل الاجتماعي. فالمعلم الناجح هو الذي يتقن مهارة الحوار والنقاش مع طلابه وذلك لما لهذه المهارة من أهمية في توطيد التواصل مع الطلاب، مما يساعد على حل كثير من المشكلات اللغوية التي تعترض الطلاب المعاقين عقلياً كالتلعثم واللججة أو التأتأة. وذلك لأن الطالب هنا يناقش ويحاور بحرية مع المعلم ومع زملائه الآخرين.

٢- التوجيه اللفظي (الحث اللفظي):

تعتبر طريقة التوجيه اللفظي أحد الأساليب التدريسية المناسبة مع الطلاب المعاقين عقلياً وتحفز الطالب على القيام باستجابات مناسبة. وهو نوع من المساعدة المؤقتة تستخدم لمساعدة الطالب على إكمال المهمة المطلوبة، من خلال لفظ الكلمة أو الكلمات أو جزء منها بشكل يساعد الطالب على إعطاء الإجابة الصحيحة، وهذا الأسلوب يعتمد على الحث بالمعززات المناسبة.

قائمة المحتويات

٣- التمثيل (الدراما):

هي طريقة تتضمن قيام الطالب بتمثيل تلقائي عن طريق الانخراط في الموقف والتفاعل مع الآخرين وتقمص أدوارهم، وقد يكون التمثيل بواسطة طالبين اثنين أو أكثر بتوجيه من المعلم ، أما الطلاب الآخرون الذين لا يقومون بالتمثيل فإنهم يقومون بدور الملاحظين. وقد يكون التمثيل بتقمص أدوار لشخصيات اجتماعية مثل شخصية المعلم أو الأب أو الطبيب أو النجار ... وغيرها، أو قد تركز على اتجاهات إيجابية كالنظافة والنظام والعمل الجماعي ومساعدة الآخرين وحب الوالدين وطاعتهم وغيرها.

٤- طريقة المحاكاة والنمذجة (التقليد):

تسمى أحياناً أسلوب التعلم عن طريق التقليد وهي من الأساليب المعروفة منذ زمن بعيد في تعديل سلوك الأطفال المعاقين عقلياً، وخاصة الفئات العمرية المبكرة وفي المواقف المختلفة، ويتم هذا النوع عن طريق الملاحظة والتقليد من خلال ملاحظة الطفل للمعلمين أو الوالدين أو التلفزيون أو أي نموذج آخر. وتعتبر المحاكاة من طرق التدريس التي تعطي نموذجاً للطبيعية المعقدة للعلاقات سواء أكانت بشرية أم غير بشرية، والتي يعالجها المعلم عند مواجهته للطلاب في الفصل حيث يعمل على تقريب الأفكار المجردة إلى أذهان الطلاب ، حيث يقوم المعلم بنمذجة المهارة ويقدم توضيحاً عملياً لكيفية أداء المهمة من خلال عرض نماذج لكيفية أداء المهارة، ثم يطلب من الطالب تقليد النموذج وتأديته كما شاهده.

٥- التوجيه البدني:

في هذه الطريقة يقدم المعلم المساعدة للطلاب من خلال مسك يدي الطالب لمساعدته على تأدية المهمة المطلوبة، مثل أن يوجه الطالب يدياً لمسك القلم بطريقة صحيحة، أي يستخدم التوجيه اليدوي في توجيه الطالب خلال السلوك المستهدف دون أن يقوم المعلم بأداء هذا السلوك له.

٦- التعلم باللعب:

تعتبر طريقة التدريس باستخدام الألعاب من أبرز الطرق والاستراتيجيات التدريسية المناسبة لتعلم الطفل المعاق عقلياً، فمن خلالها يصبح للطفل دور ايجابي يتميز بكونه عنصر نشط وفعال داخل الصف لما يتسم به هذا الأسلوب التدريسي من التفاعل بين المعلم والمتعلمين خلال العملية التعليمية وذلك من خلال أنشطة وألعاب تعليمية تم إعدادها بطريقة عملية منظمة. وبإغراء المتعلم على التفاعل مع المواقف التعليمية بما تتضمنه من مواد تعليمية جيدة وأنشطة تربوية هادفة . فاللعب يساعد الطالب على أن يدرك العالم الذي يعيش فيه، ومن خلال اللعب يتعرف الطالب على الأشكال والألوان والأحجام والحروف والأعداد، ويقف على ما يميز الأشياء المحيطة به من خصائص وما يجمع بينها من علاقات . أيضاً يتعلم الطالب من خلال اللعب معنى بعض المفاهيم مثل أعلى وأسفل أو جاف ولين، وكبير وصغير. وتسهم خبرات اللعب في إنماء معارف الطالب عند بناء وترتيب الأشياء في مجموعات، فيتعلم كيف يصنف الأشياء ويدرك الوظيفة، ويعمل على الربط بين الشيء ووظيفته.

٧- الخبرة المباشرة:

يطلق على هذه الطريقة اسم طريقة المشروع، وهي إحدى طرق التدريس الحديثة والمتطورة، والتي تقوم على التفكير في المشروعات التي تثير اهتمامات الطلاب الشخصية، وأهداف المنهج. حيث تجسد مبدأ الممارسة داخل الصف وخارجه بهدف ربط الجانب النظري من المعرفة بالجانب العملي التطبيقي، فضلاً عن تنمية قدرات الطلاب المعاقين عقلياً الشخصية والاجتماعية. حيث يتفاعل الطالب مع الشيء المراد تعلمه كما يحدث في واقع الحياة، ويتم التعلم عن طريق الخبرة المباشرة الهادفة التي يحتاج الطالب فيها إلى عملية توجيه من المعلم حتى يستطيع أن يعبر عن إحساساته.

قائمة المحتويات

٨- القصص:

تعرف القصة على أنها طريقة تعليمية تقوم على العرض الحسي المعبر، الذي يتبعه المعلم مع طلابه لتعليمهم حقائق ومعلومات عن شخصية أو موقف أو ظاهرة أو حادثة معينة، بقلب لفظي أو تمثيلي أو قد تستخدم لتجسيد قيم أو مبادئ أو اتجاهات. إن هذه الطريقة تساعد في جذب انتباه الطلاب وإكسابهم خبرات ومعلومات وحقائق بطريقة شيقة وجذابة، ويحقق التعلم عن طريقها النجاح الذي يوصل إلى الأهداف ويسهم في تثبيت مواد التعليم في أذهان الطلاب ويبعد الملل والسأم اللذين قد تسببهما الطرق التي تسير على وتيرة واحدة، وتهيئ المتعة والفائدة في آنٍ واحد للطلاب. وهي عنصر تربوي هام له أهميته في المواقف التعليمية، فمن خلال القصة يكتسب الطفل المعاق عقلياً الكثير من المترادفات اللغوية سواءً عند سماعه للقصة أو عندما يقوم بروايتها، وهي تساعد في علاج الكثير من المشكلات التي يعاني منها، وتعمل على غرس السلوكيات الحميدة المرغوبة، وتنمي القدرة على الإصغاء الجيد والتمييز بين الأصوات.

روابط إلكترونية يمكن الاستفادة منها:

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF>

<https://www.webteb.com/child-health/diseases/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF>

<https://www.almasryalyoum.com/news/details/2508575>

<https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/efa34cb1-60d4-411e-bdac-15d78cc07fc2?t=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89--%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9>

<https://www.alwatan.com.sa/article/363570>

أنشطة تدريبية

- س ١- لبرامج الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم أهداف تربوية وتأهيلية ناقش هذه العبارة؟
- س ٢- يعد التدريب على المهارات طريقة علاجية. ناقش هذه العبارة؟
- س ٣- تعد مهارة إدارة الذات طريقة علاجية للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة. ناقش هذه العبارة؟
- س ٤- البرامج الإرشادية والتأهيلية لأسر الأطفال المعاقين عقليا تعتبر هامة. ناقش هذه العبارة؟
- س ٥- وضح كيفية التعامل مع الطفولة المعاقة ذهنياً؟
- س ٦- ما هى أهداف برامج التأهيل النفسى؟
- س ٧- للفن دور بالغ الأهمية فى علاج العديد من الاضطرابات النفسية والانفعالية والسلوكية. ناقش هذه العبارة؟

- رابط الاختبار التفاعلى:

https://docs.google.com/forms/d/15e_ZVcKHUe-ZheIKuemplpJh4GpmoUqOkSwIL8hXQs/edit?hl=ar

قائمة المحتويات

الفصل الخامس

التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية

- الدمج/التمكين.
- مفهوم التمكين الاجتماعي.
- تعريف الدمج .
- مبررات الدمج.
- أساليب الدمج.
- مزايا الدمج وسلبياته.
- دور جمعيات المجتمع المدني.
- العلاج الأسري لذوي الاحتياجات الخاصة.
- العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء الوالدين والأسرة.
- الإجراءات المتبعة لعلاج اضطرابات النطق والكلام .
- نصائح للأسرة التي لديها طفل يعاني من مشكلات في النطق.
- التربية الجنسية والتعامل الاجتماعي للمعاقين ذهنياً.
- دراسات وبحوث لذوي الاحتياجات الخاصة.
- أنشطة تدريبية.

مخرجات التعلم المستهدفة

في نهاية الفصل يصبح الطالب قادرًا على أن:

- أن يذكر مفهوم التمكين الاجتماعي.
- أن يقارن بين التمكين الاجتماعي والدمج.
- أن يقارن بين أساليب الدمج وسلبياته.
- أن يشرح دور جمعيات المجتمع المدني في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن يحدد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء الوالدين والأسرة.
- يتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين بفاعلية

الفصل الخامس

التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية

تكمّن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسيئات الاجتماعية المختلفة والمهيئة للإعاقة والتي تضع قيود وعقبات غير مبرره ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية. وتشير العديد من الأبحاث إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها، بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم .



وتفسر المداخل التقليدية الإعاقة بوصفها موضوعا طبييا، حيث تنحصر أي محاولة للتعامل مع أو التخلص من الصعوبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة علي ما يُعتقد أنه السبب في الإعاقة والمشكلات المرتبطة بها . وترتب علي ذلك أن هُمش واستبعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مسار الحياة الطبيعية مما أدى إلي فقدان أو محدودية مشاركتهم فيها نتيجة العقبات و الموانع Barriers الاجتماعية والبيئية التي تحول دون تفاعلهم مع المجتمع كالتحيز ضد الإعاقة والمعاقين والميل إلى الوصم والتمييط وبيروقراطية الإجراءات وتعذر وجود وسائل المواصلات المناسبة، كما أن مؤسسات التربية الخاصة تقوم علي فكرة العزل وبالتالي تفشل في تزويدهم بالمناهج التربوية العادية، مما يترتب عليه الاستبعاد من فعاليات الحياة الاجتماعية كما ذهب إلي ذلك تحليل "هنت" وأن السبب الأساسي في هذه المشكلات إنما يعزى إلي فشل المجتمع في التسامح مع / والتقبل للاختلافات والفروق بين المعاقين من المشاركة العادية في فعاليات وأنشطة وخبرات الحياة الاجتماعية اليومية. ومن ثم جاء مفهوم الدمج التربوي؛ لما ينطوي عليه من مضامين التكامل والاندماج بين أفراد المجتمع بصفة عامة.

قائمة المحتويات

وعرف بيرش (Birch, 1974) "الدمج" بأنه اتحاد التعليم الخاص مع التعليم العام بغرض تقديم خدمات متنوعة لجميع الأطفال حسب احتياجاتهم التربوية" (الموسى، ١٩٩٢م، ٩٢). ويشير قاموس التربية الخاصة إلى أن مفهوم الدمج يعني خدمة الأطفال المعاقين داخل البرنامج الدراسي العادي، مع توفير العاملين المتخصصين والخدمات المساندة بدلاً من وضع هؤلاء الأطفال في فصول خاصة مستقلة بهم (الفايز ١٩٩٧، ٣٨).

الدمج/التمكين Empowerment



إن قضية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع اندماجا كلياً هي قضية إنسانية تتعلق بالمجتمع ككل وتحتاج إلي كامل جهوده. ويعتبر مفهوم الدمج من المفاهيم التي أصبحت تشكل اهتمام لدى جميع العاملين والمنتمين في حقل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد التعليم من أهم أساليب التمكين إذ تعتمد عملية التعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة أساسية علي ما يعرف "بالخطة التربوية التعليمية" (Individual Educational Plan (IEP) ويقصد بها أن تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يعتمد علي أسلوب تفريد التعليم فكل طفل احتياجات تعليمية خاصة يفترض أن تقوم مناهج وطرق التعليم علي تلبيتها وذلك من خلال طرق التدريس الخاصة التي تعكس التنوع في المداخل المستخدمة لتحقيق أو تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة للتلاميذ غير العاديين في فصول التعليم سواء أكانت ضمن إطار ما يعرف بالتربية العادية أو التربية الخاصة.

وهناك خبرات ناجحة لم يتم الاستفادة منها كخبرات الأزهر الشريف في رعاية المكفوفين بجانب أقرانهم الأسوياء ودمجهم داخل المجتمع العادي والذي نادي به ديننا الحنيف.

ويشير "ألفرد أدلر" الذي تأثر بوجهة النظر الاجتماعية التي تنادي بأن العوامل الثقافية والعلاقات الاجتماعية السائدة في البيئة والعناصر المكونة لها هي المؤثر الأول علي السلوك، ولا يعني ذلك إنكار الدور الذي تلعبه العوامل الفطرية والقدرات الطبيعية والاستعدادات الجسمية، إلا أن ما يهمننا بالدرجة الأولى لتحقيق التمكين الاجتماعي هو التأكيد علي تأثير البيئة الاجتماعية والعوامل الثقافية علي الطريقة التي يستخدم بها الفرد قدراته واستعداداته.

مفهوم التمكين الاجتماعي:

يقصد به إكساب ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية إلي أقصى حد تؤهله لهم إمكانياتهم وقدراتهم إضافة إلي تغيير ثقافة المجتمع نحو المعاقين والإعاقة من ثقافة التهميش إلي ثقافة التمكين.

قائمة المحتويات

تعريف الدمج Mainstreaming

هو التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي على الأقل وهذا التعريف يرتبط بـ.

١- بوجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي.

٢- الاختلاط الاجتماعي المتكامل.

والدمج بمفهومه الحالي لا يعني فصل التلاميذ إلى فئتين: الأولى مكانها فصول التعليم الخاص، وأخرى لها أوضاع تعليمية وتربوية خاصة، ولكن يعني اندماجهم مع برامج الفصول العادية. ويستند الدمج إلى البرمجة الفردية فلا يدفع بجميع المعاقين إلى الفصول العادية بل لابد من المواءمة والتدرج، فقد يقتضي الدمج حضور بعض الحصص في مكان أو مدرسة أخرى (محمود، دت، ٨٢٢).

ويعني مفهوم الدمج، فيما يخص المعوقين، تعليمهم في المدارس العادية، مع أقرانهم العاديين، وإعدادهم للحياة في مجتمعهم مع العاديين. وبذلك هو عملية تهدف إلى تحقيق الدمج الاجتماعي والتعليمي للأطفال المعاقين، وتمكينهم من الالتحاق بالمدارس ورياض الأطفال، مما يوفر لهم بيئة تربوية أقرب ما تكون إلى البيئة الطبيعية.

والدمج كلمة لها معاني مختلفة حسب المستعملين لها، فهي تعني عند بعضهم وجود أطفال معوقين داخل فصول مدرسية عادية ويتابعون تعليمهم في ظروف الأسوياء نفسها، وتعني عند بعضهم الآخر وجود أطفال معاقين داخل فصول مدرسية عادية مع تحويل جزئي في وسائل وظروف التعليم مثل الاعتماد علي بعض طرائق التربية الخاصة مثل طريقة برايل والاستفادة من دعم تعليمي خارجي، وتعني عند فريق آخر من المهتمين بالتربية الخاصة استفادة المعوقين من بعض المواد المدرسية المدرجة ضمن الفصول العادية كالأشغال اليدوية والرسم مع مواصلة تعليمهم بمراكز التربية الخاصة، أما المعني الرابع للدمج فيعني وجود فصول للمعاقين داخل المدارس العادية لها مربوها المختصون ووسائلها المناسبة ولا يختلط المعوقون بالأسوياء إلا في فناء المدرسة أو في بعض المناسبات.

وهناك من يري أن الدمج يعني تمكين بعض فئات المعاقين من متابعة تعليمهم في الفصول العادية وما يترتب علي ذلك من إعداد التلميذ المعاق ولفروقه التعليمية وللمعلم من حيث برامج الإعداد والتأهيل ويجب أن لا يفهم من الدمج علي أنه مجرد حضور الطلاب المعاقين في الفصول المدرسية العادية، بل هو محاولة لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل أن يتطورا اجتماعيا وعقليا وشخصيا من خلال الاتصال والتفاعل مع أقرانهم العاديين، وهذا يتطلب إحداث تغيير في المدرسة والمناهج وطرائق التعليم المستخدمة في الصفوف وأنظمه التقويم، فالدمج ليس اختيارا بين كل شئ أو لا شئ لأنه يستند إلي فكرة أن تكون التربية أكثر مرونة، ولهذا السبب فإن التلاميذ الذين يعانون من أي صعوبات سوف يكونون قريبين من أقرانهم بالقدر الذي يستطيعون وبما يسمح لهم بالنمو والاندماج الاجتماعي. ومهما تعددت الآراء والاتجاهات تباينت وجهات النظر فإن الدمج كإستراتيجية جديدة في التربية الخاصة ينطلق من:

-التغيير الواضح في الاتجاهات الاجتماعية نحو الأطفال غير العاديين من السلبية إلي الإيجابية.

-توفير الفرصة الطبيعية للأطفال غير العاديين للنمو الاجتماعي والتربوي مع أقرانهم العاديين.

-إزالة الوصمة المرتبطة ببعض فئات التربية الخاصة، ويقصد بذلك الآثار السلبية الاجتماعية لدي بعض فئات التربية الخاصة وذويهم والمرتبطة بمصطلح مثل الإعاقة.

قائمة المحتويات

وقد ترتب علي ما سبق ظهور أفكار جديدة دفعت بحركة تربية ورعاية المعاقين إلي الاتجاه الإنساني وتنادي بالأخذ بمبدأ جعل المعاق طبيعياً أو سوياً Normalization وهو اتجاه اجتماعي يهدف إلي إتاحة الفرصة أمام المعاق للحياة مثل الأفراد العاديين و التعامل معهم علي نحو طبيعي وإعطائهم الفرص ومساواتهم في الحقوق وجعل الظروف المحيطة بهم عادية، ولكي يتم هذا الهدف استخدمت العديد من المصطلحات كمحطات أساسية في طريق تحقيقه، مثل مصطلح: التحرر من المؤسسات Deinstitutionations وبيئة تربوية أقل تقييداً least restrictive environment والتكامل التربوي invinromentEducational الدمج أو توحيد المجري التعليمي Mainstreaming ، والاحتواء أو المدرسة الشاملة inclusive school .

مبررات الدمج:

من المعلوم أن تعليم المعاقين عندما بدأ بشكل رسمي في جميع دول العالم كان يركز على برامج العزل والمدارس الداخلية، ثم عندما تبينت الآثار السلبية لعزل الأفراد ذوي الحاجات الخاصة - سواء على أنفسهم أو المجتمع - بدأ يتبلور اتجاه جديد نحو دمج المعاقين في المدارس العادية وهو ما يعرف بمرحلة "التكامل والاندماج" أي التكامل التام بين شرائح المجتمع المختلفة، وتهيئة الظروف التعليمية والنفسية والاجتماعية لتمكين الأفراد ذوي الحاجات الخاصة من الاندماج في المجتمع بعد معاناة تاريخية طويلة من العزلة (الموسى، ٣٢).

وتوجد عدة مبررات لدمج الطلاب المعاقين في المدارس العادية، ومنها:

- ١ - السلبات العديدة التي نتجت عن عزل المعاقين، ومنها:
 - أ- أن المدرسة الداخلية تعزل المعاق عن أسرته ومجتمعه وأقرانه العاديين وتسلبه الحب الطبيعي وهو حب والديه وإخوانه (سالم، ١٩٨٨، ١٠٣)
 - ب - الجمود والصرامة في المدرسة (عبدالرحيم وبثاي، ١٩٩٢، ٤٦).
 - ج - أن المدرسة الخاصة تحرم المعاق من ممارسة الحياة الطبيعية كما هي في الواقع (الطيب، ١٩٧٩، ٨٢).
 - د- إن إحساس المعاق بالعزلة الاجتماعية قد يؤدي به إلى الشعور بالانقباض وعدم الإحساس بالسعادة (صبحي، ١٩٧٩، ٥٩).
 - و- أن في المراكز الخاصة يتم التركيز عادة على جانب واحد فقط من جوانب شخصية الطفل المعاق، ألا وهو جانب الإعاقة، الأمر الذي ينجم عنه في الغالب إغفال الجوانب الإيجابية في شخصيته .
- ٢ - التكلفة المادية: حيث إن إنشاء مبان ضخمة مستقلة لكل إعاقة أكثر كلفة من إلحاق المعاقين بالمدارس العادية مع تأثيث غرفة المصادر وتزويدهم بالخدمات المساندة.
- ٣- أنه قد ترتب على عزل المعاق في مدرسة خاصة أن انسحب هذا الشعور على الأسرة فأصبحت بدورها تميل إلى عزل طفلها المعاق عن المجتمع وتنحيته عن أوجه الحياة الاجتماعية المختلفة، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة المعاقين في المجتمع حيث تبلغ نسبة الإعاقة الجسدية ٣٣٪ والإعاقة البصرية ٣٠٪ حسب إحصاءات المركز الوطني لأبحاث الإعاقة في المجتمع السعودي، مع ذلك فقلما نرى معاقاً في الأمكنة العامة أو المناسبات الاجتماعية (الموسى، ٣٢، ٣١).

أساليب الدمج:

هناك عدة آراء واتجاهات في دمج المعاقين في المدارس العادية تعتمد على نوع ودرجة الإعاقة وحاجة الطفل المعاق نفسه والإمكانات المادية والبشرية المتوفرة في البيئة. ويحدد النصاروي أربعة أشكال مختلفة للدمج هي (الفايز، ٤٣).

- وجود أطفال معاقين داخل فصول مدرسة عادية حيث يتابعون تعليمهم في ظروف العاديين نفسها.

قائمة المحتويات

- وجود أطفال معاقين داخل فصول مدرسة عادية مع الاستفادة من دعم تعليمي خارجي (غرفة المصادر، معلم متجول).

- وجود أطفال معاقين يستفيدون من بعض المواد الدراسية المدرجة ضمن الفصول العادية، كحصول التربية الفنية والاقتصاد المنزلي والرياضة، مع مواصلة بقية تعليمهم بمراكز التربية الخاصة.

- وجود فصول للمعاقين داخل المدرسة العادية لها معلموها المختصون ووسائلها المناسبة، ويتم الاختلاط بين المعاقين والعاديين في ساحة المدرسة أو في النشاطات اللامنهجية.

والصورة الحقيقية للدمج التي يتطلع إليها التربويون هي فيما أشار إليه الموسى من أن الدمج التربوي يمكن تحقيقه في أي مستوى من مستويات الدراسة من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية، حيث يعد معلم الفصل العادي مسؤولاً عن التلاميذ المعاقين؛ ولذا يقوم بتعديل طرائق التعليم والمحتوى المنهجي لتمكين جميع الأطفال من الانضمام إلى برامج عادية تكون على مستوى يتناسب مع قدرات كل طفل، ويغادر التلاميذ المعاقون الفصل الدراسي لمجموعة صغيرة أخرى لغرض تعليم فردي أو لتقويم فردي أو تسلم واستلام المواد التي يقوم بإعدادها مدرس التربية الخاصة، وهذا النوع من الدمج لا بد له من خدمات مساندة تشمل:- غرفة المصادر حيث تكون المصدر الرئيس للوفاء بالاحتياجات التعليمية الخاصة بالأطفال المعاقين.- برنامج المعلم المتجول حيث يقوم بالخدمات نفسها التي يقوم بها معلم خدمات غرفة المصادر.- برنامج المعلم المستشار، حيث يكون دوره استشارياً أكثر منه تعليمياً، ويقدم الاستشارة للمعلم أو الإدارة والطالب والأسرة.

مزايا الدمج وسلبياته:

من مزايا الدمج التربوي وإيجابياته (الموسى، ٣٩ - ٤٠، محمود، ٨١٢، كنمور، ١٩٨١، ١٦٦):

-تعتبر المدارس العادية هي البيئة الطبيعية التي يمكن للأطفال جميعاً أن ينموا فيها معاً على حد سواء.

- الدمج التربوي يتيح للأطفال المعاقين فرصة البقاء في منازلهم مع أسرهم طوال حياتهم الدراسية، الأمر الذي يمكنهم من أن يكونوا أعضاء عاملين في أسرهم وبيئاتهم الاجتماعية، وخصوصاً أن الحياة الأسرية على جانب كبير من الأهمية عاطفياً واجتماعياً واقتصادياً.

- أن الدمج التربوي يكسب المعاق المهارات الاجتماعية وحسن التصرف في المواقف المختلفة.

- أن احتكاك المعاقين بأقرانهم العاديين في سن مبكرة يسهم في تحسين اتجاهات كل منهم نحو الآخر.

- أن الدمج التربوي يعمل على إيجاد بيئة واقعية يتعرض فيها الأطفال المعاقون إلى خبرات متنوعة من شأنها أن تمكنهم من تكوين مفاهيم صحيحة واقعية عن العالم الذي يعيشون فيه.

- الدمج التربوي يعمل على الحيلولة دون ظهور وصمات العار التي عادة ما تصاحب الفصول الخاصة أو المعاهد الخاصة.

- أثبتت العديد من الدراسات أن التوافق النفسي والاجتماعي والتحصيل الدراسي يكون أفضل لدى الأطفال المدمجين من غيرهم والذين يدرسون في مدارس خاصة .

والدمج يحقق فوائد تنعكس إيجاباً، على الطالب المعاق، وأقرانه وأهله والمجتمع، فالطفل المعاق يكتسب الثقة بالنفس، وبقيمته بالحياة، ويدرك مدى قدراته في وقت مبكر ويشعر بانتمائه إلى أفراد مجتمعه، كما يكتسب مهارات جديدة، تمكنه من مواجهة صعوبات الحياة، ويمدّه بنمط سلوكي اجتماعي للتفاهم والتواصل وتخفيف الاعتماد المتزايد على الأم.

قائمة المحتويات

إن الدمج يؤدي إلى تغيير اتجاهات الطفل العادي نحو الطفل المعاق، ويكسبه شعور بأن زميله المعاق أخ له بالبشرية، وإنه عليه واجباً نحو مساعدته ومشاركته، بل والاستفادة من الأعمال التي يجيدها وربما يتفوق فيها على كثيراً من الأطفال العاديين.

ومن فوائد الدمج، أنه ينبه أفراد المجتمع إلى حق المعوق في إشعاره بأنه إنسان، وعلى المجتمع أن ينظر إليه على أنه فرد من أفرادهم، وإن الإعاقة ليست مبرراً لعزل الطفل عن أقرانه.

وبرنامج الدمج يشعر الأهل بعدم عزل الطفل المعاق عن المجتمع، كما أنهم يتعلمون طرقاً جديدة لتعليم الطفل، وعند ملاحظتهم لتطوره وتفاعله يصبح التفكير بطفلهم أكثر واقعية فتتحسن مشاعرهم تجاهه وتجاه أنفسهم.

وهناك عدة عوامل لنجاح عملية الدمج، منها عوامل طلابية وعوامل مدرسية وعوامل أسرية وعوامل مجتمعية.

وقد أثبتت الدراسات أن العوامل التي حظيت بالأهمية القصوى هي (الموسى، ٢٢، ٢٦):

- مرونة وتقبل معلم الفصل العادي للطفل المعاق.
- تقبل التلاميذ العاديين للطفل المعاق.- المهارات الاجتماعية للطفل المعاق.
- التحصيل الأكاديمي للطفل المعاق.- اتجاهات الأسرة الإيجابية وتقبلها للطفل المعاق.
- توفر المستلزمات البشرية والمادية المساندة للطفل المعاق. ومن بين هذه العوامل وجد أن مرونة معلم الفصل العادي تعتبر من الأمور الضرورية لإنجاح عملية دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية؛ ولذا فإن نجاح الدمج يعتمد إلى حد كبير على اختيار معلم الفصل العادي الذي يبدي رغبة أكيدة في التعامل مع هذه الفئة ويكون لديه روح التجديد وقبول التحدي.

إن عملية الدمج ليست سهلة، بل لها عدة متطلبات، لا بد من مواجهتها وتحقيق شروطها المتعددة، التي تتناول: قدرات الطفل المعاق وقابليته، واختيار هيئة تدريسية مناسبة، وبرنامج مدروس، وتقييم متواصل، وتهيئة للأقران، وأسرة المعاق.

ومن سلبيات الدمج أو من المصاعب التي تعترضه (ماهر محمود، ١٩٨٦م، ٣٠، الموسى، ٤٣):

- لا بد من وجود نظام مساند قوي متماسك حتى يمكن الوفاء باحتياجات التلاميذ المعاقين في المدارس العادية.
- يتطلب الدمج توفير عدد كبير من المدرسين الاختصاصيين والمرشدين النفسيين المتخصصين في مجال الإعاقة للتعامل مع أعداد قليلة متناثرة من المعاقين في المدارس العادية.
- أن الاتجاهات السلبية التي قد تبدر من معلم الفصل العادي أو من التلاميذ غير المعاقين قد تجعل عملية الدمج تجربة تعليمية سلبية بالنسبة إلى الأطفال المعاقين.

دور جمعيات المجتمع المدني:

يمكن لجمعيات تنمية المجتمع المحلي أن تساهم في توفير عناصر أساسية تكون دعامة لتعليم وتأهيل المعاق عقلياً حيث وجود القاعات والفصول الدراسية، الملاعب، المسرح وتمتلك جمعيات تنمية المجتمع المقومات ويمكن لها أن تحدث تكامل في عملية تقديم الخدمات من خلال:

- ١- توفير مقاعد دراسية داخل فصول التقوية بالجمعيات لاستيعاب المعاقين ذهنياً مع الفئة المتوسطة والبسيطة القابلة للتعليم والتدريب.
- ٢- وضع نسبة ٥٪ من عدد المشتركين بالرحلات التي تقوم بها الجمعية وتكون مجانية للمعاق وأسرتهم.
- ٣- تدريب وتأهيل المعاق ذهنياً على أعمال التريكو والطباعة داخل مقر الجمعية والورش المحمية.

قائمة المحتويات

٤- تشغيل نسبة لا بأس بها من المعاقين ذهنياً داخل مقر الجمعية.

بالإضافة إلى مراعاة بعض الأمور أثناء التعليم والتدريب أهمها:

١- المحبة والحنان تبني جسور الثقة:

بالحب والابتنسامة الجميلة بيننا وبين الطفل والتعاون يتم التعليم والتأهيل بروح عالية مهما كانت صعوبة الأداء للوصول إلى أقصى درجة الاعتماد على النفس.

٢- نموذج لتوضيح المهام المطلوبة :

طريقة سليمة لتعلم الطفل نموذج في أبسط صورة للفهم والإدراك وتكرار المحاولة لعدة مرات من خلال التقليد لمن حوله.

٣- التقليد :

تعليم المعاق عقليا القدرة على التقليد عن طريق النمذجة وقيام الطفل بها وتدعيمه للاستجابة.

٤- المحاولة والتدرج :

تدريب المعاق على المهارة والهدف المحدد عدة مرات عن طريق التقليد والتمثيل من السهل إلى الصعب وتحليل المهارة حتى يتقن الهدف.

٥- المساعدة :

مساعدة المعاق وتوجيهه أثناء أداء المهمة وتدعيمه للقيام به مرة أخرى والمساعدة ثلاثة وهي:-

- مساعدة كلية استخدام الأيدي لتحريك أطرافه للقيام بالفعل .

- مساعدة تعبيرية خاصة الذي ينتبه للغير على فهم الإيماءات .

- مساعدة لفظية وهي تعنى الكلمات.

٦- تقسيم النشاط إلى خطوات:

أ- التسلسل الأمامي: مثل تناول الطعام يبدو لنا سهل لكن بالنسبة للمعاق بالغة التعقيد فنعلمه على خطوات.

ب- التسلسل الخلفي: نبدأ بالخطوة الأخيرة مثلا بعد تناول الطعام نعلمه إعادة المعلقة إلى الطبق

٧- إيجاد دافع للتعلم :-

يحتاج تنمية الدافع إلى جهد كبير من الآباء والأخصائيين في الإرشاد والتوجيه

٨- الصبر:-

يجب على القائمين بالعمل التحلي بالصبر للبعد عن اليأس وعدم الشعور بالفشل فيبدأ الإحباط

٩- الانتباه والتركيز:-

المعاق عقليا ضعيف الانتباه والتركيز فيجب التركيز على المهم والبعد عن غير المهم.

- استعمال مثيرات لها أبعاد ثلاثة مثل (الصوت - الضوء - الحركة)

- تقديم المهام من السهل إلى الصعب

- تقديم التعزيز الإيجابي المناسب

- استخدام كل الوسائل التي سوف يتم شرحها.

- تنبيه المعاق للمهام المراد تعليمها

١٠- التعزيز والمكافأة بعد النجاح:-

قائمة المحتويات

- تعتبر المكافأة تعزيز للسلوك المرغوب فيه وهى نوعان مادي ملموس مثل الحلوى أو الهدايا ومعنوي مثل المدح أو الاحتضان وهناك نقاط مهمة للتدعيم وهى:
- التعزيز يكون خاص لكل طفل بمفرده.
 - يتم فى نهاية النشاط
 - يتم بعد النجاح فى النشاط
 - تحديد نوع وعدد مرات التدعيم المناسب لكل نشاط ولا يمكن تعلم المعاق خطوة ثانية إلا بعد تعلم الأولى
 - ١١- اختيار الوقت المناسب:-
 - اختيار الوقت المناسب مهم لتهيئة المعاق نفسيا للتدريب
 - ١٢- التعديل السلوكي :-
 - كل من المحيطين بالمعاق له دور فى تعديل السلوك.

ومن خلال هذا يمكن لجمعيات تنمية المجتمع أن تساهم في التكامل في عملية الرعاية وتكون دعامة أساسية في نجاح سياسة الدمج المجتمعي.

إن من أهم متطلبات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة هي توفير كافة أشكال المساندة الاجتماعية والخدمات الصحية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة لخفض مستويات الضغوط النفسية الواقعة علي هذه الأسر. وقد نبهت نتائج البحوث التربوية إلي أهمية المشاركة الكاملة للأسرة لما لها من آثار إيجابية وفعالة في تحقيق التوافق الاجتماعي والإنجاز والتحصيل التعليمي لهؤلاء الأطفال .

العلاج الأسري لذوي الاحتياجات الخاصة:

ما زال الجدل والنقاش مستمر حول أهمية مشاركة الأسر في تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والفوائد المتوقعة لهذه المشاركة. ولقد كانت مشاركة الأسرة في تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك برامج التدخل العلاجي والخدمات المخططة لهم محل اهتمام من الباحثين في مجال التربية الخاصة لعقود عديدة (Williams, Fox, Thousand & Fox, 1990; Hilton & Henderson, 1993; Spidel, 1995; Hilton, 1998)، وقد أكدت هذه الأبحاث على ضرورة إتاحة الفرصة للأسر لكي تلعب دوراً في كل جوانب تربية وتعليم التلاميذ ذوي الإعاقات، ولكن لكي يتم ذلك لابد من التعاون المباشر بين معلمى التلاميذ ذوي الإعاقات وأسرتهم. غير أنه غالباً ما يجد المعلمون صعوبة في القيام بذلك حيث تختلف أسر الأطفال ذوي الإعاقات في ردود أفعالهم عند تشخيص طفلهم على أنه ذو إعاقة، وكذلك في كيفية تعاملهم مع الضغوط الناتجة عن هذا التشخيص، وكذلك في احتياجاتهم الشخصية، وردود أفعالهم عند العمل مع المتخصصين ومقدمى خدمة الرعاية والدعم. وهذا التباين والاختلاف بين الأسر يجعل من كل أسرة وحدة فريدة في كيفية تعاملها مع المجتمع التربوي، كما أنه يزيد من صعوبة فهم المتخصصين لاحتياجات الأسر والعمل بفاعلية مع الوالدين. وعلى الرغم من ظهور بعض النماذج للعمل مع أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن هذه النماذج لا تشكل أداة متكاملة تساعد المتخصصين والوالدين على فهم الطبيعة متعددة الأبعاد Multidimensional nature لاحتياجات الأسرة.

وقد أشار (Meyer & Bailey, 1993; Hilton, 1998) إلى ضرورة تبني نظرة شمولية Comprehensive view للطفل ذي الإعاقة وأسرته مع الأخذ في الاعتبار كل من جوانب القوة والمعوقات الموجودة في محيط الأسرة.

وهذا المدخل يشجع على معرفة جوانب القوة للأسرة، ويحترم فرديتها Individuality ، وقدرات المسايرة والمواجهة Coping abilities.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء الوالدين والأسرة:

إن قيام أسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بأداء ناجح يعتبر أمر هام لإحراز تقدم فى حياة أطفالهم بوجه عام وفى مسار تربيتهم وتعليمهم. ويمكن الإشارة لهذا النجاح بما يسمى المواجهة Coping والتوافق Adjustment ، وقد حدد (McCubbin, 1983) ثلاثة أنماط للمواجهة الوالدية Parent coping والتي تنطبق على أسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهذه الأنماط هى: النمط الأول: الحفاظ على تكامل الأسرة Maintaining family integration ، التعاون Cooperation ، التفاؤل Optimism ، ويتمثل النمط الثانى فى بناء الدعم الاجتماعى والحفاظ عليه Social support ، تقدير الذات Self-esteem والاستقرار الفسيولوجى Physiological stability ، أما النمط الثالث فيركز على فهم الإعاقة أو العرض Syndrome. ويستطيع الوالدان تحقيق هذه الأهداف من خلال استخدام قدراتهم الشخصية وأنظمة الدعم.

ومدخل آخر لفهم أسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة يتمثل فى فحص استراتيجيات المواجهة Coping Strategies لدى الوالدين. وترتبط المواجهة ارتباطاً مباشراً بكيفية التعامل مع الضغوط Stress. وقد اهتم الباحثون ليس بكيفية التعامل مع الطفل ذى الإعاقة بل بكيفية تعامل الوالدين مع الضغوط المرتبطة بتشخيص طفلهم على أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك العيش معه. وقد اقترح (Lazarus, Folkman, 1984) خمسة أنواع لمصادر المواجهة Coping resources وهى: الشبكات الاجتماعية Social networks، مهارات حل المشكلات Problem-solving skills، المعتقدات العامة والخاصة General and specific beliefs، المصادر النفعية Utilitarian resources، بالإضافة إلى الجانب المعنوى والصحة والنشاط. وقد أشارت الأبحاث بعد ذلك إلى تفاعل وارتباط هذه الأنماط الخمس وأن الضغوط يجب وضعها فى نموذج متعدد الأبعاد Multidimensional model لفهم أسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن العوامل المؤثرة على أداء الأسرة:

١- القدرات الشخصية Personal strengths

تشير الأبحاث إلى أن هناك علاقة بين طرق مواجهة الوالدين للضغوط المرتبطة بوجود طفل ذى احتياجات خاصة داخل الأسرة وقدرات الوالدين على تقييم مصادر الضغوط وتعبئة جوانب القوة الشخصية لديهم؛ حيث تلعب القدرات الشخصية للوالدين دوراً رئيسياً فى نمو جوانب القوة داخل الأسرة. وقد أشار (Lambie & Daniels, 1993) Mohring إلى أن الصحة النفسية والقدرة على التفاعل مع العالم الخارجى يُعدان أمرين هامين لكى يبني الوالدان اتصالاً بأنظمة الدعم ويحتفظوا بهذا الاتصال بصورة دائمة. ويشير (Poetner, 1993) إلى أن مدخل تركيز المتخصصين ومقدمى الخدمة والرعاية على جوانب القوة داخل الأسرة يعتبر أمر ضرورى عند تقديم المساعدة وذلك فى مقابل المدخل القديم الذى كان متبعاً من قبل والذى يركز فقط على جوانب الضعف Weaknesses. وتصنف (Hilton, 1998) جوانب القوة الشخصية للأسرة إلى:

- البناء الأسرى والتفاعل Family structure and interaction
- الثقافة والعرقية Culture and ethnicity
- النمو الأسرى والتغير Family development and change
- الوظائف الأسرية Family functions

قائمة المحتويات

ويمكن النظر إلى جوانب القوة الشخصية على أنها المعرفة الداخلية والمهارات والخبرات، والاتجاهات والمعتقدات التي يدخل بها الفرد دوره الجديد كأب أو أم مسئول في أسرة لها احتياجاتها. ويمكن لكل جانب من جوانب القوة الشخصية السابق ذكرها أن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على عملية المواجهة Coping process الوالدية للضغوط المرتبطة بتشخيص طفل داخل الأسرة على أنه من ذوي الإعاقات النمائية. فعلى سبيل المثال قد تلعب القيم الدينية والثقافية دوراً في تقبل الأسرة لطفل ذي إعاقة نمائية داخل الأسرة حيث ينظرون إليه على أنه هبة من الله أو في المقابل عقاب نزل بالأسرة.

وقد اختلف الباحثون في تصنيفهم لجوانب القوة الشخصية التي تساعد الأسرة على المسابرة والمواجهة، فمنهم من رأى أنها تشمل الصحة الجسمية الجيدة Good physical health، مهارات حل المشكلات Problem - solving skills، الإدراك الإيجابي Positive perception (Garber, 1992) وهناك من رأى أنها تشمل: احترام الذات Self-respect، الحماية Protectiveness، التحمل Tolerance، الوجدان Affection، المرونة Flexibility، الأمل Hope، والكبرياء الأسري (Family pride Karpel, 1986).

ويذكر (Meyer & Bailey, 1993) أن المواجهة Coping مفهوم متعدد الأوجه Multifacted يختلف من أسرة لأخرى. وانطلاقاً من هذا التباين في عملية المواجهة من أسرة لأخرى وجد (Paul, Porter & Falk, 1993) أن الاستقرار الاقتصادي للأسرة Economic stability يسهم في تعزيز جوانب القوة الشخصية لها.

٢- أنظمة الدعم Support systems

عامل آخر يرتبط بقدرة الأسرة على مواجهة التحديات المرتبطة بتربية طفل ذي إعاقة نمائية هو قدرة الوالدين على بناء أنظمة الدعم والحفاظ عليها. ويعكس مستوى التوافق لدى الأسرة الدعم الذي تتلقاه من الأقارب وهيئات تقديم الخدمات والرعاية داخل المجتمع. وقد تكون القدرة على استخدام أنظمة الدعم محدودة بسبب ضعف القدرات الشخصية (على سبيل المثال ضعف مهارات الاتصال Poor communication skills، عدم الثقة في الغرباء Distrust of strangers)، ومع ذلك فإن استخدام المصادر المتاحة للدعم قد يعوض مثل هذه المعوقات. وتشير الأبحاث إلى وجود تباين بين الآباء والأمهات في احتياجاتهم للدعم حيث تظهر الأمهات في الغالب احتياجاً أكبر لأنظمة الدعم الرسمية وغير الرسمية، كما أن الدعم بوجه عام يُعد ضرورياً للأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقات نمائية، وأيضاً تبرز خدمات الراحة Respite care كأمراً هاماً لمثل هذه الأسر كي تستعيد نشاطها مرة أخرى (Beckman, 1991; Simeonsson & Simeonsson, 1993).

٣- المصادر الأسرية Family resources

يعتبر أفراد الأسرة مصدر رئيسي لقدرتها على المواجهة. فالوالدان والأخوة يلعبوا دوراً دائماً للأسرة التي لديها طفل ذي احتياجات خاصة. ويرى (Lambic & Daniels-Mohring, 1993) أن الأسرة ذات الوالد أو الوالدة فقط تؤدي إلى وجود أسرة بها بعض الخلل Dysfunctional family بعكس الأسرة الممتدة Extended family التي يتكاتف فيها الوالدان والأخوة والأقارب لدعم الأسرة ومواجهة التحديات المرتبطة بالطفل ذي الإعاقة. وقد يكون وجود طفل ذي إعاقة من الأمور التي تؤدي إلى تقوية الرباط بين أفراد الأسرة وقد يكون الأثر عكسياً (Smith, 1993; Hanline, 1991; Spidel, 1995) ويمثل الأعباء المادية، التعامل مع متخصصي الرعاية الطبية والتعليمية، فقدان التحكم في عملية اتخاذ القرارات Loss of control of decision making، المتطلبات الثقافية وتحدياتها، نقص الخدمات أو عدم الإبقاء باحتياجات الأسرة، مراحل الانتقال Transition periods، جوانب العجز في الطفل ذي الإعاقة، باقى أفراد الأسرة، تحديات ضخمة تواجهها أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

قائمة المحتويات

ونقص أنظمة الدعم للأسرة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الأسرية. ومن المصادر الرئيسية للضغوط الأسرية هي التفاعلات الحازمة بين الأسرة والمتخصصين في تقديم الرعاية Parent-professional interactions حيث أن المتخصصين ومقدمي الرعاية غالباً لا يهتمون بتأثير تدخلهم في محيط الأسرة ويركزون فقط على مجرد أداء خدمة التدخل العلاجي دون مراعاة لمحيط الأسرة وأفرادها، وهو الأمر الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى وجود مقاومة Resistence بل ورفض من جانب الأسرة لمقدمي الرعاية. كما أن نقص معرفة المتخصصين بظروف الأسرة وتركيزهم فقط على مجرد الحصول على المعلومات لأداء عملهم دون إظهار الاحترام والتقدير Appreciation لمشاعر الأسرة قد يزيد من الضغوط الوالدية.

وقد تؤدي هذه الضغوط إلى حدوث تغيرات في العلاقات الأسرية، وظهور بعض المشكلات الانفعالية للوالدين، وضعف التواصل بين أفراد الأسرة بل وحدث نوعاً من الصراع بين الأسرة ومقدمي خدمات الرعاية والتدخل العلاجي، بالإضافة إلى حدوث تغييرات في المعتقدات الأسرية وإحساس الأسر بفقدان القدرة والكفاءة في مواجهة التحديات مع فقدان تقدير الذات وقد يكون لمثل هذه الآثار تأثيراً سلبياً على الطفل ذي الإعاقة. وتري (Thomas,1993;Turnbull,1991) أن هناك عدداً من المتغيرات التي يجب الاعتناء بها عند محاولة فهم احتياجات الأسرة وتضم هذه المتغيرات المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة Socioeconomic status ، البناء الأسري Family structure ، الدعم الشخصي Personal support.

٤- مصادر المجتمع Community resources

بالإضافة إلى الدعم الموجود داخل الأسرة هناك بعض المصادر المجتمعية التي تقدم الدعم للأسرة. وتختلف هذه المصادر المجتمعية من بلد إلى آخر وإن كانت خدمات التربية الخاصة في العصر الحالي بدأت تأخذ الشكل العام ، ففي مصر على سبيل المثال بدأت بعض الجمعيات الأهلية تأخذ على عاتقها مسئولية تقديم الرعاية للأسر التي لديها احتياجات ضخمة مرتبطة بوجود طفل ذي إعاقة بين أفرادها. كما تسهم الحكومة من خلال مؤسسات الرعاية ومراكز الطفولة والأمومة في تقديم الخدمات لهذه الأسر.

وقد أشارت الأبحاث أن البرامج الرسمية لتقديم الخدمة والرعاية لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة هذه الأسر على التغلب على التحديات المرتبطة بذلك. (Simeonsson&Simeonsson, 1993).

٥- الضغوط Stress

على الرغم من مواجهة كل الأسر لقدر من الضغوط أثناء قيامها بعملية تربية أطفالها إلا أن الأبحاث قد أشارت إلى زيادة نسبة هذه الضغوط عند أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (Beckman, 1991; Meyer & Bailey, 1993) والضغوط نفسها لا تسبب الخلل في الأسرة وينبغي ألا ينظر إلى الأسرة على أنها تعاني من العجز Deficit بل يجب أن ننظر إلى هذه الضغوط على أنها شئ طبيعي في حياة أسر الأطفال ذوي الإعاقات، وأن استخدام الأسرة وضع الضغوط من عدد من المصادر المتنوعة منها ما يرتبط بالقدر الكبير من الوقت الذي يتم قضاؤه في الرعاية اليومية أو الإبقاء باحتياجات الرعاية الطبية، وكذلك زيادة المسؤوليات الوالدية، وزيادة.

٦- ردود الأفعال / الحزن Reactions / Grieving

يعتبر تشخيص طفل داخل الأسرة على أنه من ذوي الإعاقات النمائية حدث يسبب صدمة لأفراد الأسرة، كما أن هذا الحدث يكون له آثار مادية وانفعالية. وعلى الرغم من التباين الموجود بين الأسر إلا أن الدراسات البحثية قد أشارت إلى وجود أنماط متشابهة من ردود الفعل من جانب الآباء (Simeonsson & Simeonsson, 1993).

قائمة المحتويات

وتتمثل ردود الفعل هذه في وجود مشاعر الحزن Grieving وفقدان الطفل السليم Perfect child وقد أطلق على هذه المشاعر السليمة عرض الحزن المزمن Chronic sorrow syndrome. كما أشار (Jaffe, 1991) إلى أن هناك عدد من المشاعر التي يظهرها الوالدان منها الشعور بالذنب Feelings of guilt، الغضب، خيبة الأمل، الانسحاب، الحزن، والإنكار، وذلك في البداية ثم تتحول هذه المشاعر إلى الاكتئاب، العجز، التناقض والشعور بوجود حمل ثقيل على عاتقهم Burden، غير أن هذه المشاعر جميعها تتباين في شدتها من أسرة لأخرى بناءً على عجز الطفل وكذلك شدة مستوى إعاقته، وقد تؤدي شدة مستوى الإعاقة إلى زيادة قدر الضغوط التي تتعرض لها الأسرة.

وقد ركزت المحاولات الخدمية المبكرة في مجال التربية الخاصة على عملية الحزن Grieving process التي تتعرض لها الأسر. ويعتبر نموذج Kubler ross للعمل مع الأسرة من أجل القضاء على دائرة الحزن التي تعيش فيها الأسرة من أهم النماذج التي اقترحت مبكراً ويتكون من خمس مراحل بدءاً من الإنكار Denial التي تظهرها الأسرة ثم المرور بالغضب Anger، والتفاوض Bargaining، والاكتئاب Depression حتى يتم الوصول إلى القبول Acceptance. ويختلف الآباء في معدلات مرورهم بهذه الدائرة من المشاعر حيث يعودون في بعض الأحيان إلى مشاعر معينة أثناء زيادة فترة الضغوط وبالتالي لا يتم الوصول إلى حالة القبول الكامل. وينطلق هذا النموذج من أساس منطقي مؤداه أنه من الصعب تفسير حلقة مشاعر الحزن الوالدي من خلال استخدام نموذج مكون من مراحل خطية Linear-stages ذات بداية ونهاية.

ج- تأثير الضغوط Impact of stress

يمر آباء وأسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بنفس الضغوط التي تمر بها الأسر العادية، وعلاوة على ذلك فإن الضغوط المرتبطة بتربية طفل ذي إعاقة داخل الأسرة تزداد في قدرها بالإضافة إلى المتطلبات التي تفرضها هذه الظروف على الأسرة تجاه مقدمي الخدمي، وتوفير الرعاية للطفل، والصراع مع المتخصصين. والضغوط الناتجة عن مثل هذه البيئة تلعب دوراً محدداً في مرور الوالدين بمشاعر الأسى والحزن. وطبقاً للنموذج فإن الضغوط هي التي تسرع بوصول الفرد إلى مشاعر الحزن ويظهر هذا الأثر من خلال طريقتين، الأولى أن الضغوط يمكن أن تزيل العديد من آثار الدعم والفهم والتوافق. وفي هذه الحالة فإن الوالدين يرتدان إلى المشاعر السلبية مثل نقص التحكم، عدم الاستقرار الانفعالي، الخراب الانفعالي Emotional devastation وتعمر هذه المشاعر الوالدين والأسرة لفترة مؤقتة يعود بعدها الوالدان إلى حالة الاستقرار الانفعالي التي كانت قبل بداية الضغوط. وبمعنى آخر فإن أنظمة الدعم ومهارات المواجهة الشخصية يخفضان من تأثير الضغوط.

والجدير بالذكر أن هناك بعض المتخصصين أو بعض البيئات التي قد تسبب ضغوطاً غير عادية للوالدين وهو الأمر الذي قد يؤدي بالوالدين إلى التركيز على مجموعة معينة من المشاعر عند التعامل مع هذا الشخص أو عند الوجود في تلك البيئة. فعندما تبتعد مشاعر الوالدين عن المركز، فإن الحاجة لبعض الخطوات التي تتضمن البحث عن المساعدة والدعم تصبح أمر ضروري لعودة الوالدين إلى مجموعة المشاعر المركزية. وفي بعض الأحيان قد يختار الوالدان المكث في هذه الحالة لفترة من الوقت، وبالتدريج وبمرور الوقت وتوفر الدعم تقل الضغوط أو تختفي.

مسلمات النموذج متعدد الأبعاد :

يقوم النموذج على عدد من المسلمات هي:

- ١- أن الحزن ومشاعر الأسى هي عملية مستمرة Ongoing process.
 - ٢- أن حالة الحزن هي عملية طبيعية وظاهرة صحية لكل أسر الأطفال ذوى الإعاقات النمائية.
 - ٣- أن المدى الذى تؤثر هذه الحالة على حياة الأسر تختلف بناءً على العوامل الفردية التى تكون عناصر النموذج عند تطبيقه على كل أسرة على حده.
 - ٤- أن حالة الحزن ليست عملية استاتيكية Static process فالضغوط ، الوقت، المعرفة، وأنظمة الدعم والخدمات المتاحة تلعب دوراً فى إحداث تغيير فى تلك الحالة.
 - ٥- أنه تبعاً للطبيعة المستمرة وغير الثابتة لحالة الحزن ومشاعر الأسى التى تلم بالأسرة فإن أنواع التدخل العلاجى ينبغى أن تركز على احتياجات الوالدين فى كل أسرة على حده.
 - ٦- أن النموذج لا يعرف المواجهة أو حالة الحزن للأسرة بل إن ذلك يعتمد على التفاعل بين المتخصصين ومقدمى الدعم مع الوالدين وأفراد الأسرة.
- وفى النهاية ينبغى أن يعرف المتخصصون فى تقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة أن العمل تبعاً لهذا النموذج متعدد الأبعاد يغير من طبيعة أدوارهم والتى يجب أن تضم ما يلى:
- أ - تسهيل فهم الأسرة لحالة الحزن، والضغوط، وأنظمة الدعم وجوانب القوة الشخصية.
 - ب- مساعدة الوالدين وأفراد الأسرة على معرفة أن تفاعل الضغوط والأفعال الانفعالية فى حالة الحزن أمر طبيعى وظاهرة صحية.
 - ج- مساعدة الوالدين وأفراد الأسرة على إدراك أن حالة الحزن عملية مستمرة ومتغيرة.
 - د - تقوية الأسرة والوالدين على المواجهة والسلوك الاستقلالى.
 - هـ- تقديم التدريب للأسر حول مكونات النموذج.
 - و - تسهيل تفاعلات الوالدين مع أسر أخرى تمر بنفس الخبرات.
 - ز - تجنب أخذ أدوار تتعدى مسؤولياته كمقدم للخدمة والدعم (على سبيل المثال مرشد للأسرة أو معلم لأفرادها).
 - ح-مساعدة الأسر على فهم أن كل فرد فى الأسرة هو وحدة فريدة من الاحتياجات بناءً على جوانب القوة، وأنظمة الدعم وردود الفعل الانفعالى نحو الضغوط.
 - ط-معرفة أن التفاعل قد يكون أكثر فاعلية فى أوقات محددة بين حالة الأسرة.

الإجراءات المتبعة لعلاج اضطرابات النطق والكلام:

يقوم أخصائي تدريب النطق والكلام (أخصائي التخاطب) بعمل فحص شامل للطالب أو الطفل؛ يحدد من خلاله نقاط القوة والضعف لدى الطفل، مثل السمع - الكشف عن سلامة أعضاء الجهاز الكلامي، فهناك بعض الحالات والتي تتردد على وحدة التخاطب لدينا تحتاج إلى عمليات جراحية مثل شق اللسان، وعمليات تقويم الأسنان، وعمليات اللحمية، وعمليات الخنف، ثم يأتي بعد ذلك دور أخصائي التخاطب في تدريب الطفل على مخارج الحروف الصحيحة، وأيضاً لابد من معرفة معامل الذكاء وخاصة لدى الأطفال المعاقين ذهنياً، ومعرفة-أيضاً- هل يعاني الطفل من أعراض نفسية تتعلق بالكلام مثل الخجل، ثم يقوم أخصائي التخاطب بعد عمل التشخيص بعمل الخطة التدريبية والعلاجية اللازمة للطفل، ويتولى أخصائي التخاطب تدريب الحال- أو الطفل- وفقاً لما هو مخول له من صلاحيات، أما الأمور الطبية؛ فيقوم بشئونها ولي أمر الطالب مع الطبيب .

قائمة المحتويات

- أما بالنسبة للتدخل المبكر للأطفال المعاقين ذهنيًا في سن مبكرة لتأهيل الطفل لعملية النطق والكلام فيبدأ بـ :
- ١- تدريبات لأعضاء الجهاز الكلامي من تدريبات للسان والشفيتين والفكين، وتدرّبات للتنفس من نفخ وشفط باستخدام بعض الألعاب مثل : لعبة الصابون والصفارة الخ .
 - ٢-توظيف اللغة للأطفال ولو بالإشارة مثل توظيف أعضاء جسمه – المأكولات – المشروبات – مكونات الحجرة والمنزل الخ .
 - ٣-تقليد بعض أصوات الحيوانات والطيور .
 - ٤-نطق مخارج وأصوات الحروف الأبجدية .
 - ٥-نطق الكلمات والأشياء التي يراها ويستخدمها ويفضلها والمكونة من مقطعين أو ثلاثة .
 - ٦-تكوين الكلمات البسيطة من الحروف، وتكوين جمل لها معنى من كلمتين.

****نصائح للأسرة التي لديها طفل يعاني من مشكلات في النطق:**

- كرر الكلمات التي يقولها الطفل وتظهر له أنك تفهم ما يقوله.
- اعمل على زيادة مفردات الطفل اللغوية بكلمة أو كلمتين مثال: قال الطفل: عربية، فقل له: عربية بابا.
- انطق الكلمة بصورة صحيحة إذا ما أخطأ بها ابنك وطبعًا لا تطلب منه إعادتها ولا تقول له أنها خطأ؛ بل فقط أعد أنت ما قاله ابنك بصورة صحيحة، وطبعًا بزيادة كلمة أو كلمتين اثنتين معها.
- إذا قال الطفل كلام غير واضح، قل أنت ما يعنيه الطفل بطريقة مفهومة واضحة لا تتجاهل المحاولات التي يقوم بها الطفل من أجل التخاطب .
- علم الطفل الكلمات التي يحتاجها للتعبير عن شعوره ورغباته .
- اسأل الطفل أسئلة متعددة الخيارات، وذلك للحصول على إجابة منه مثال قل له: أتريد حليب أم عصير؟ هذا أوضح وأفضل من أن تقول له: هل تريد أن تشرب .
- استخدم المفارقة لإيضاح الاختلافات للطفل مثال: يقول لك: صير آه . قل له: عصير، بهذه الطريقة أنت لم تنتقد الطفل، ولكنك وضحت الفرق والصورة الصحيحة لنطق الكلمة.
- ركز على الأصوات التي ينطقها الطفل بصورة صحيحة، ولكنه يحذفها أو يستبدلها مثال: قال لك: تمك، يمكنك هنا أن تقول له مازحًا: س س س سمك، أحمد ياكل سمك، هنا أنت أتحت الفرصة له للنظر إلى فمك كي يرى الطريقة التي تنطق بها ذاك الحرف.

التربية الجنسية والتعامل الاجتماعي للمعاقين ذهنياً

المشاكل الجنسية للمعاقين ذهنياً :-

- المعاقين ذهنياً يمرون بمراحل البلوغ الجنسي ربما أبداً من غيرهم كما أن لهم في الغالب الاحتياجات نفسها.
- لا يميزون بين السلوك المقبول والسلوك الغير مقبول اجتماعياً.
- يتميزون بشكل عام بسهولة انقيادهم للآخرين وبالتالي فإن بعض الأفراد يستغلونهم لأغراض غير أخلاقية.

كيف نحمل أبنائنا من التحرش الجنسي ؟

- توعية الأبناء منذ الصغر - عدم السماح للأطفال بالنوم مع بعض في فراش واحد - مراقبتهم عند اللعب وخاصة عندما يختلون بأنفسهم
- لا يسمح لهم باللعب مع المراهقين والكبار - الحرص والجذر من الوالدين أثناء ممارسة العلاقة الجنسية
- بعض الأمهات تلاعب طفلها لأعضاء جنسه وهم صغار لكي تثير لديه الضحك وغرضها الدعابة ولا تدري أن هذه المداعبة ستجلب له المشاكل

كيف نشجعهم في حالة تعرضهم أن يخبرونا ؟

- يجب أن يحيطوا بالحب والحنان
- الابتعاد عن الخوف
- الأم تكون قريبة من بنتها والأب يكون قريب من ابنة

ما هي آثار التحرش الجنسي على نفسية الطفل ؟

- يتلذذ الطفل بهذا الموقف ويستمر على ذلك ويؤدي به إلى الانحراف.
- يشعر بالخوف .

- يشعر بالإهانة -

- يكون عدواني وانتقامي وقد يعتدي على الآخرين

- قد يكون انطوائي - يستمر في أحلام اليقظة.

- يصاب باضطرابات نفسية - يفقد الثقة بالنفس - يعاني من تأنيب ضمير - يعاني من أمراض جسدية - يصاب بالشذوذ.

نصائح للأهل أو القائمين بالرعاية :-

- لا تعود الطفل على الحزن الزائد

- الرقابة على برامج التلفزيون

- كيفية شغل أوقات الفراغ.

- تعويده منذ الصغر على ارتداء الملابس الفضفاضة وخاصة الملابس الداخلية

قائمة المحتويات

- تعويد الطفل أن ينام في حجرة أخرى بعيد عن أبويه.
- عدم السماح له بالذهاب إلى غرفة النوم إلا للنوم- تدريبه على حماية نفسه ولا يذهب مع شخص غريب إلى مكان معزول.

العناية بالأبناء جنسيا حسب السن:-

-الطفل الرضيع:

- الحرص على عورته ولا نتركه لأي شخص يغير له ملابسه الداخلية أو يحمّله- أن لا نعوده على تحسس أماكن العورات.
- لا نتركه في المنزل لوحده مع الخادم والأفضل أخذ الطفل معنا.
- إذا بلغ الطفل(ذكر/ أنثى) ٦ سنوات:-
- لا يخرج من المنزل لوحده في فترات الظهيرة أو المساء - يتم إفهامه ألا يحاول أحد أن يتحسس في أماكن عوراته، وهذه منطقة لا يطلع عليها أحد- إذا خلع ملابسه نتأكد من أن باب الحجرة مغلق- لا يخلع ملابسه أبدا خارج المنزل-لا ينام على بطنه.
- البدء في تعليم الاستئذان عند الدخول على الأم والأب في أوقات الظهيرة والمساء والفجر.
- لا تجله يخرج أبدا مع السائق أو الخادم لوحده- لا يلعب مع أبناء عمه أو أبناء خاله الأكبر منه سنا.
- تعويد الطفل لبس الملابس الداخلية الطويلة وتعليمها طريقة الجلوس السليمة- ألا تجلس ورجليها مفتوحة.
- لا يدخل أبدا غرفة السائق أو الخادم- تدريبه على تغيير محطات التلفزيون إذا ظهرت لقطات مخلة بالأداب حتى لو كان لوحده.
- بدأ التفرقة في النوم بينه وبين إخوته من الجنس المغاير ويفضل النوم في حجرة أخرى.

-إذا بلغت البنت ١٠ سنوات:

- تشرح لها والدتها معنى البلوغ والدورة الشهرية- تتحدث معها والدتها عن الاعتداء الجنسي .
- تشرح لها والدتها الأسباب الحقيقية وراء منعها الخروج مع السائق أو دخول غرفة العمال أو الطباخين لوحدها.
- عدم اللعب مع أولاد العم أو الخال بمفردها - عدم دخول أماكن يتواجد فيها العمال والخدم والطباخين.
- تربية البنت على الحياء- البدء في تدريبها الامتناع عن لبس الملابس القصيرة في المنزل وخارجه وتتعلّم بالاحتشام مع أخواتها ووالدها.
- ضرورة الابتعاد عن البنات اللاتي يكررن محاولة الالتصاق الجسدي ومسك اليدين أو الأحضان.

قائمة المحتويات

-إذا بلغ الولد ١٠ سنوات:

- يشرح له والده معنى البلوغ- يتحدث معه عن الاعتداء الجنسي-يوضح له أن يحتاط في اللعب مع زملائه وضرورة الانتباه للحركات التي تصدر منهم مثل: التقبيل- مسك اليد وتحسسها- وضع اليد في الشعر- الالتصاق الجسدي والأحضان- المديح لجمال الشكل والجسم - التربية على الحياء.

إذا ظهرت علامات البلوغ على الفتاة:

- تتحدث معها والدتها كيفية العناية بنفسها أثناء الدورة الشهرية.

دراسات وبحوث فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة

١-قامت مى محمد طعيمة وأمانى عبد المقصود وآخرين(٢٠١٨) بدراسة موضوعها "فاعلية برنامج تدريبي قائم علي المسرح في تنمية المهارات الاجتماعية وتحسين التوافق النفسي لدي الأطفال ذوي طيف التوحد، بهدف التعرف علي أثر برنامج تدريبي (قائم علي فنيات المسرح) لتنمية المهارات الاجتماعية وتحسين التوافق النفسي للأطفال ذوي طيف التوحد، وذلك من خلال التعرف علي مدي وجود فروق بين الأطفال الذين تعرضوا للبرنامج والأطفال الذين لم يتعرضوا للبرنامج علي مقياس المهارات الاجتماعية بأبعاده المختلفة ومقياس التوافق النفسي، وينتمي هذا البحث إلي الأبحاث التجريبية، وفي إطارها استخدم الباحثون المنهج التجريبي، واستخدموا في ذلك مقياسي المهارات الاجتماعية والتوافق النفسي لجمع البيانات المطلوبة، وطبقت أدوات البحث علي عينة مختارة من أطفال طيف التوحد قوامها (١٠) أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٣-٧ سنوات، وتوصلت نتائج هذا البحث إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي في المهارات الاجتماعية والتوافق النفسي في اتجاه القياس البعدي، كما كشفت النتائج أيضا أن المهارات الاجتماعية والتوافق النفسي جاءوا بدرجة أعلي لدي الأطفال الذين تعرضوا للبرنامج، بينما جاءت بدرجة أقل لدي الأطفال الذين لم يتعرضوا للبرنامج.

٢-قامت فاطمة محمد رمضان وأمانى عبد المقصود وآخرين(٢٠٢٢) بدراسة موضوعها " فاعلية برنامج قائم على التعبير الحركي لخفض اضطراب فرط الحركة وتحسين الانتباه لدى عينة من الأطفال بهدف تطويع التعبير الحركي لخفض اضطراب فرط الحركة وتحسين الانتباه لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، من خلال تصميم برنامج قائم على التعبير الحركي، وقد اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وذلك على عينة قوامها (١٦) طفلا وطفلة من الأطفال ذوي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية قوامها(٨) أطفال ٦ من الذكور و ٢ من الإناث والأخرى ضابطة قوامها (٨) أطفال ٦ من الذكور و ٢ من الإناث، ومستخدم أدوات تضمنت: مقياس فرط الحركة ونقص الانتباه ، والبرنامج

قائمة المحتويات

١ التعبير الحركي من إعداد الباحثة، واستغرق تطبيق البرنامج مدة زمنية قدرها شهران ونصف (١٠ أسابيع) بواقع ٤ جلسات أسبوعياً. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى لمقياس نقص الانتباه وفرط الحركة (الأبعاد والدرجة الكلية) لصالح أطفال المجموعة التجريبية، وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدى لمقياس نقص الانتباه وفرط الحركة (الأبعاد والدرجة الكلية) لصالح القياس البعدى، عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتبعية لمقياس نقص الانتباه وفرط الحركة (الأبعاد والدرجة الكلية)، وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والتبعية لمقياس نقص الانتباه وفرط الحركة (الأبعاد والدرجة الكلية) لصالح القياس التبعي، مما يوضح أن البرنامج فعال وله تأثير دام حتى بعد الانتهاء من تطبيقه بشهر.

٣-قامت إسراء عبد المقصود عبد الوهاب (٢٠٢٢). بدراسة موضوعها "فاعلية برنامج إرشادى قائم على استراتيجية إدارة الذات لتحسين جودة الحياة لدى عينة من الأطفال ذوى صعوبات تعلم القراءة"، بهدف إعداد برنامج إرشادى لتحسين جودة الحياة لدى الأطفال ذوى صعوبات تعلم القراءة، والكشف عن فعاليته من خلال استخدام استراتيجية إدارة الذات، وذلك على عينة قوامها (ن=٢٠) طفلاً وطفلة مقسمين الى مجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل منها (١٠) أطفال من الأطفال ذوى صعوبات تعلم القراءة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين (١٠-١٢) سنوات، مستخدمة أدوات تضمنت: استمارة بيانات أولية، مقياس إدارة الذات، مقياس جودة الحياة والبرنامج وجميعهم من إعداد الباحثة. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدى على مقياس إدارة الذات لصالح القياس البعدى، ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدى على مقياس جودة الحياة لصالح القياس البعدى، ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس إدارة الذات، ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس جودة الحياة.

٤-قامت إسراء عبد المقصود عبد الوهاب بدراسة موضوعها "فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات الاجتماعية وتخفيف الاغتراب الاجتماعى لدى الأطفال التوحديين، بهدف إعداد برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات الاجتماعية وتخفيف الاغتراب الاجتماعى لدى الأطفال التوحديين، والكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي ودوره فى تنمية المهارات الاجتماعية لديهم، وذلك على عينة قوامها (ن=١٠) أطفال (٥) ذكور، (٥) إناث من الأطفال التوحديين، ممن تتراوح أعمارهم ما بين (٥-٩) سنوات، وتم اختيارهم بطريقة قصدية، مستخدمة أدوات تضمنت: استمارة بيانات أولية (إعداد الباحثة)، مقياس المهارات الاجتماعية (إعداد: الباحثة)، ومقياس الاغتراب

قائمة المحتويات

الاجتماعى (إعداد: أمانى عبد المقصود عبد الوهاب، ٢٠١٦)، والبرنامج التدريبي (إعداد: الباحثة). وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس المهارات الاجتماعية لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الاغتراب الاجتماعى لصالح القياس البعدي، وعدم وجود فروق بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتبعي على مقياس المهارات الاجتماعية وكذلك على مقياس الاغتراب الاجتماعى.

٥- قامت ابتسام عبد الباسط وأمانى عبد المقصود وسماح حلمى يس (٢٠٢٢). بدراسة موضوعها "فاعلية إستراتيجية قائمة على التعليم المدمج فى تنمية التحصيل المعرفى لتصميم وتنفيذ الملابس الخارجية وأثرها على تحسين تقدير الذات لدى الطالبات الصم والبكم بالمرحلة الثانوية"، بهدف التعرف على فاعلية إستراتيجية قائمة على التعليم المدمج فى تنمية التحصيل المعرفى لتصميم وتنفيذ الملابس الخارجية وأثرها على تحسين تقدير الذات لدى الطالبات الصم والبكم بالمرحلة الثانوية، ويستخدم البحث المنهج التجريبي، حيث يتضمن المتغير المستقل وهو: إستراتيجية قائمة على التعليم المدمج، ومتغيرين تابعين هما التحصيل المعرفى وتقدير الذات، مستخدمين عينة قوامها (٢٣) طالبة من الطالبات الصم والبكم بالمرحلة الثانوية، وممن تتراوح أعمارهم الزمنية بين (١٦- ١٩) سنة فى الصف الثانى الثانوى بمدرسة الأمل للصم والبكم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومستخدمين أدوات تضمنت استبيان التعرف على خبرات الطالبات فى استخدام الحاسب والانترنت، اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لتصميم وتنفيذ (الجنولة)، مقياس تقدير الذات، واستبيان الاتجاه نحو التعليم المدمج بهدف قياس اتجاه الطالبات الصم والبكم نحو التعليم المدمج فى التدريس، وكانت من أهم النتائج التى توصل إليها البحث هى أنه توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطى درجات الطالبات فى القياسين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي لصالح القياس البعدي، كما توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطى درجات الطالبات فى القياسين القبلي والبعدي لمقياس تقدير الذات لصالح القياس البعدي.

قامت أمانى عبد المقصود وزينب علام (٢٠٢٢) بدراسة موضوعها "فاعلية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة الاجتماعية وخفض تشتت الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم، بهدف الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة الاجتماعية لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم، والكشف عن مدى استمرار فاعلية البرنامج التدريبي خلال فترة المتابعة في تحسين الكفاءة الاجتماعية لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم. على عينة مكونة من مكونة من ١٠ أطفال تم تقسيمهم الى مجموعتين ضابطة وتجريبية، ومستخدمين أدوات تضمنت: مقياس الكفاءة الاجتماعية لدى الاطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم، مقياس تشتت الانتباه فرط الحركة لدى الاطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم. والبرنامج التدريبي. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية، في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الكفاءة الاجتماعية

قائمة المحتويات

لصالح القياس البعدي، وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على الكفاءة الاجتماعية لصالح المجموعة التجريبية، عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية، في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية، في القياسين القبلي والبعدي على مقياس تشتت الانتباه وفرط الحركة، وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على تشتت الانتباه وفرط الحركة لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية، في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس تشتت الانتباه وفرط الحركة.

أنشطة تدريبية

س ١- وضح مزايا الدمج وسلبياته؟

س ٢- ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى أسر سوية. فكيف يمكن التعامل مع أسرهم؟

س ٣- وضح دور جمعيات المجتمع المدني فى التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة؟

س ٤- لماذا الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة؟

رابط الاختبار التفاعلى:

<https://docs.google.com/forms/d/1Im9xzk06w5r30rPtZpOGmponDIOAahsa9dSxzNFGiL8/edit?hl=ar>

قائمة المحتويات

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- ١- إبراهيم عباس الزهيري (٢٠٠٣). **تربية المعاقين والموهوبين ونظم تعليمهم** "إطار فلسفي وخبرات عالمية. القاهرة: دار الفكر العربي.
- ٢- إبراهيم عبد الله الزريقات (٢٠٠٤). **التوحد الخصائص والعلاج**. عمان: دار الفكر.
- ٣- اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية (١٩٩٤). **دراسات ومؤتمرات الاتحاد. الجيزة: مطبعة العمرانية.**
- ٤- أحمد السعيد يونس ومصري عبد الحميد حنورة (١٩٩٩). **رعاية الطفل المعوق طبيا ونفسيا واجتماعية**، ط٢. القاهرة: دار الفكر العربي.
- ٥- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (٢٠٢٠). **إحصاءات ذوى الإحتياجات الخاصة.**
- ٦- أسامة فاروق مصطفى والسيد كامل الشربيني (٢٠١٦). **سمات التوحد**. القاهرة: دار الميسرة للنشر والتوزيع.
- ٧- إلهامي عبد العزيز إمام وآخرون (٢٠٠١). **سيكولوجية ذوى الإحتياجات الخاصة**. القاهرة: جامعة المنيا.
- ٨- أماني عبد السلام (٢٠٠٥)، **فعالية برنامج التطبيق المقترح فى تحقيق عملية التواصل اللفظى لذوى الإعاقة السمعية بالمرحلة العمرية (٤-٦) أعوام**. رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم العلوم الأسرية، جامعة الخرطوم.
- ٩- أماني عبد المقصود وزينب علام (٢٠٢٢). **فعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة الاجتماعية وخفض تشتت الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم**. رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. جامعة الدول العربية.
- ١٠- أماني عبد المقصود عبد الوهاب، سماح حلمى يس، ابتسام عبد الباسط (٢٠٢٢). **فاعلية إستراتيجية قائمة على التعليم المدمج فى تنمية التحصيل المعرفى لتصميم وتنفيذ الملابس الخارجية واثرها على تحسين تقدير الذات لدى الطالبات الصم والبكم بالمرحلة الثانوية، المجلة العلمية لكلية التربية النوعية- جامعة المنوفية، الحادى والثلاثون، يوليو، ج ١.**
- ١١- أماني عبد المقصود عبد الوهاب (٢٠٢١). **فاعلية برنامج تدريبي لتحسين مهارات اللغة التعبيرية لدى الأطفال ذوى اضطراب المعالجة السمعية. المؤتمر العلمى الدولى الثامن لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية "دور كليات التربية النوعية فى تحسين بيئة سوق العمل فى ضوء رؤية مصر ٢٠٢٠-٢٠٣٠، بمدينة الأقصر فى الفترة من ٢١-٢٥ نوفمبر ٢٠٢١م، المجلة العلمية لكلية التربية النوعية-جامعة المنوفية، العدد الثامن والعشرون، نوفمبر.**
- ١٢- أماني عبد المقصود عبد الوهاب، محمود همام، مى محمد طعيمة (٢٠١٨). **فاعلية برنامج تدريبي قائم علي المسرح في تنمية المهارات الاجتماعية وتحسين التوافق النفسي لدي الأطفال ذوي طيف التوحد"، المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، العدد الرابع عشر، أبريل .**
- ١٣- أماني عبد المقصود عبد الوهاب، عبير عبد الله شعبان، إيمان حمدي عمار، سماح حلمى يس، مصطفى سلامة (٢٠١٧). **"فاعلية برنامج لتحسين مستوى جودة الحياة الأسرية للوالدين وتحسين التوافق النفسى لأبنائهم المعاقين عقليا القابلين للتعلم" مشروع بحثى تطبيقي تابع لجامعة المنوفية، بمجلة كلية التربية-جامعة المنوفية، العدد الأول، للسنة ٣٢.**

- ١٤- أماني عبد المقصود عبد الوهاب، عبير عبد الله شعبان، نوال سمير، زينب خالد محمد (٢٠١٧). برنامج مقترح قائم على العلاج بالفن (الخزف) لخفض قصور الانتباه وفرط الحركة لدى عينة من الأطفال"، **المجلة العلمية لكلية التربية النوعية**، العدد العاشر، ج ٢، إبريل كلية التربية النوعية- جامعة المنوفية (بحث مشترك).
- ١٥- إيمان فوزى (٢٠٠٦). **الحاجات النفسية وعلاقتها بالضغط لدى المراهق الاصم**، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الزقازيق.
- ١٦- إيهاب عبد العزيز الببلاوي، ومحمد أحمد خضير (٢٠١٠). **المعاقون بصرياً**. الرياض: دار الزهراء.
- ١٧- أبوجين مندل، مكاني فرنون (١٩٧٦). **إنهم ينمون في صمت- الطفل الأصم وأسرته**، ط٢، ترجمة عادل عز الدين الأشول. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- ١٨- بطرس حافظ بطرس (٢٠٠٨). **صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية**. رياض : دار الزهراء.
- ١٩- بطرس حافظ بطرس (٢٠٠٩). **سيكولوجية الدمج في الطفولة المبكرة**. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
- ٢٠- جمال الخطيب (١٩٩٨). **مقدمة في الإعاقة السمعية**. عمان: دار الفكر.
- ٢١- حامد عبد السلام زهران (١٩٩٨). **التوجيه والإرشاد النفسي**، ط٣. القاهرة: عالم الكتب.
- ٢٢- حسام الدين جابر السيد (٢٠١٨). **تحسين التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال التوحيدين باستخدام برنامج تدريبي للتواصل غير اللفظي**. **مجلة البحث العلمي في التربية**، العدد التاسع عشر، كلية البنات، جامعة عين شمس.
- ٢٣- حمدي شاكر محمود (٢٠٠٥). **مقدمة في التربية الخاصة**. جدة: دار الخريجي للنشر والتوزيع.
- ٢٤- حنان السيد حسنين (٢٠٢١) **الشعور بالضيق وعلاقته بضبط الذات لدى عينة من المراهقين المكفوفين**. **مجلة الدراسات العليا للطفولة**، جامعة عين شمس.
- ٢٥- حنان محمد شرشر (٢٠٠٦). **التنشئة الاجتماعية للمكفوفين وعلاقتها بالتوافق الشخصي والاجتماعي**. رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
- ٢٦- خالد عبد الرازق النجار (٢٠١١). **المكفوفون (رؤية حديثة)**. القاهرة: دار الغد الجديد.
- ٢٧- خالد محمد أبو شعيرة، أحمد ثائر (٢٠٠٩). **صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق**. عمان، الأردن: مكتبة المجتمع العربي للنشر.
- ٢٨- خولة أحمد يحيى (٢٠٢٠). **البرامج التربوية للأفراد ذوي الحاجات الخاصة**. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.
- ٢٩- رافت عوض السيد خطاب (٢٠١٤). **مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة**. القاهرة: مكتبة المتنبى.
- ٣٠- رشاد عبد العزيز موسى (١٩٩٢). **الفروق في بعض القدرات المعرفية بين عينة من الأطفال الصم وأخرى من عادى السمع**، **مجلة مركز معوقات الطفولة**، جامعة الأزهر، العدد الأول.
- ٣١- رمزية الغريب (١٩٨٢). **البناء النفسي للمعوق وتوافقه النفسي والاجتماعي**، ندوة الطفل المعوق. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب .
- ٣٢- زينب محمود شقير (٢٠١٤). **التدخل المبكر باستخدام برنامج إرشادي تدريبي أسرى من خلال الدمج الأسرى في تنمية مهارات اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية المنطوقة لدى الطفل التوحدي** (بحث منشور)، المؤتمر الدولي لخبراء الإعاقة والتأهيل الثاني- عنيزة.
- ٣٣- زينب محمود شقير (٢٠٠٢). **خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة (الدمج الشامل - التدخل المبكر - التأهيل المتكامل)**، **سلسلة سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين**، المجلد الثالث. القاهرة: النهضة المصرية.
- ٣٤- زينب محمود شقير (١٩٩٩). **سيكولوجية الفئات الخاصة والمعاقين**. القاهرة: النهضة المصرية.

- ٣٥- سعيد جابر المنوفي (١٩٩٠). إمكانية تدريس بعض مفاهيم المجموعات للتلاميذ المعاقين سمعياً باستخدام قراءة الشفاه والهجاء اليدوي، **مجلة العلوم التربوية والنفسية**، العدد الثاني، السنة السادسة.
- ٣٦- سليمان عبد الواحد يوسف (٢٠١٠). **سيكولوجية التوحد "الاوتيزم"**، الطفل الذاتوى بين الرعاية والتجنب. القاهرة: المكتبة العصرية.
- ٣٧- سهير محمود أمين (٢٠٠٢). فعالية برنامج تدريبي في تخفيف حدة الاضطرابات السلوكية لدى طفل التوحد- **مجلة كلية التربية**، المجلد الثامن، العدد الرابع، جامعة حلوان، ص ص ٩٥-٩٦.
- ٣٨- السيد عبد القادر شريف (٢٠١٤). **مدخل إلى التربية الخاصة**. القاهرة: دار الجوهرة للنشر والتوزيع.
- ٣٩- سيد محمد صبحي (٢٠٠٧). **رعاية وتأهيل الكفيف بحوث ودراسات**. القاهرة: **الدار المصرية اللبنانية**.
- ٤٠- شاعر قنديل (٢٠٠٠). **الإعاقة كظاهرة اجتماعية** بحوث مؤتمر نحو رعاية نفسية وتربوية أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة. كلية التربية، جامعة المنصورة، ٤-٥ إبريل، ص: ٣٨١-٤٢٨.
- ٤١- صفاء عبد العزيز سلطان (١٩٩٥). **تقويم منهج اللغة العربية للأطفال المعوقين سمعاً في ضوء مستويات الفهم اللغوي**، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق فرع بنها، كلية التربية.
- ٤٢- طارق عبد الرؤف عامر (٢٠١٥). **المهارات الحياتية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة**. القاهرة: دار الجوهرة للنشر والتوزيع.
- ٤٣- عادل عبد الله (٢٠١٠ أ). **صعوبات التعلم والتعليم العلاجي: قضايا ورؤى معاصرة**. الرياض: دار الزهراء.
- ٤٤- عادل عبد الله محمد (٢٠٠٨). **مقياس جيليام التشخيصى التوحدى**. القاهرة: دار الفكر العربى.
- ٤٥- عادل عبد الله محمد (٢٠٠٤). **الإعاقات العقلية، سلسلة ذوى الاحتياجات الخاصة، الجزء الثامن**. القاهرة: دار الرشاد.
- ٤٦- عادل عبد الله محمد (٢٠٠٢). **جداول النشاط المصورة للأطفال التوحديين وإمكانية استخدامها مع الأطفال المعاقين عقلياً**. القاهرة: دار الرشاد.
- ٤٧- عبد الرحمن سيد سليمان (٢٠٠١). **سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة، الجزء الأول - ذوى الحاجات الخاصة المفهوم والفئات**. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- ٤٨- عبد العزيز السيد الشخص (٢٠١٤). **مقياس الطفل التوحدى**، ط ٣. القاهرة: دار الرشاد.
- ٤٩- ----- (٢٠٠٦). **استمارة المستوى الاجتماعي والاقتصادي، الصورة الثالثة**. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- ٥٠- عبد السلام عبد الغفار ويوسف محمود الشيخ (١٩٨٥). **سيكولوجية الطفل غير العادي والتربية الخاصة**. القاهرة: دار النهضة العربية.
- ٥١- عبد السميع سيد احمد (١٩٨١). **ظاهرة الاغتراب بين طلاب الجامعة في مصر**، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية التربية.
- ٥٢- عبد المطلب أمين القريطي (١٩٩٦). **سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم**. القاهرة: دار الفكر العربى.
- ٥٣- عبد المطلب القريطي (٢٠٠٥). **سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة** القاهرة: الأمل للطباعة والنشر.
- ٥٤- عطية محمد سيد (١٩٩٠). **الاتجاهات نحو الإعاقة والتوافق النفسى لدى الطفل الأصم**، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، كلية التربية.
- ٥٥- على عبد النبي محمد حنفي (١٩٩٦). **دراسة مقارنة للتقبل الاجتماعي لدى المراهقين الصم وضعاف السمع والعاديين**، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق فرع بنها، كلية التربية.

- ٥٦- على محمود شعيب (١٩٩١). دراسة لمشاعر القلق والعصبية لدى الأمهات لأطفال معوقين وغير معوقين، المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري، الطفل المصري تحديات القرن العشرين ٢٧-٣٠ ابريل.
- ٥٧- عواطف محمد حسانين (١٩٨٥). الخصائص السيكولوجية والفسولوجية في علاقتها بالاستعداد للتعلم لدى المعوقين سمعياً- دراسة تجريبية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، كلية التربية بسوهاج.
- ٥٨- فاروق الروسان (٢٠١٣). سيكولوجية الأطفال غير العاديين، مقدمة في التربية الخاصة، ط٥. عمان. الأردن: دار الفكر العربي.
- ٥٩- فاتن فاروق عبد الفتاح موسى (١٩٩٤). علاقة الذكاء غير اللفظي بالتحصيل الدراسي لدى الصم والأسوياء، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، كلية التربية.
- ٦٠- فاروق الروسان (١٩٩٨). سيكولوجية الأطفال غير العاديين، الطبعة الثالثة. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٦١- فاروق الروسان (١٩٩٦). سيكولوجية الأطفال غير العاديين، مقدمة في التربية الخاصة، ط٢. عمان: دار الفكر.
- ٦٢- فتحي عبد الرحيم (١٩٩٠). سيكولوجية الأطفال غير العاديين، ط٤. الكويت: دار القلم.
- ٦٣- فتحي عبد الرحيم (١٩٨٣). سيكولوجية الإعاقة ورعاية المعوقين. الكويت: دار القلم.
- ٦٤- فتحي عبد الرحيم، وحليم بشاري (١٩٩٢). سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة، ط٣. الكويت: دار القلم.
- ٦٥- فيوليت فؤاد إبراهيم (٢٠٠٥). مدخل الى التربية الخاصة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٦٦- كمال إبراهيم مرسى (١٩٩٩): مرجع في علم التخلف العقلي، ط٢. القاهرة: دار النشر للجامعات.
- ٦٧- لطفي بركات احمد (١٩٨١). تربية المعوقين في الوطن العربي. الرياض: دار المريخ.
- ٦٨- ماجدة السيد عبيد (٢٠٠٩). وقفة مع الإعاقة السمعية. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
- ٦٩- ماجدة السيد عبيد (٢٠٠٠). السامعون بأعينهم -الإعاقة السمعية. عمان : دار صفاء.
- ٧٠- ----- (٢٠١٠). المشكلات التي تهدد أمن وسلامة الطلاب المعاقين سمعياً وبناء برنامج مقترح لتحسين فرص السلامة لهم، مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الانسانية)، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، جامعة إربد الأهلية. الاردن .
- ٧١- محمد إبراهيم عبد الحميد (١٩٩٩). تعليم الأنشطة والمهارات لدي الأطفال المعاقين عقلياً. القاهرة: دار الفكر العربي، ط١.
- ٧٢- محمد أحمد محمد على (٢٠٠٨).فاعلية برنامج تدريبي سلوكي لتحسين بعض مهارات التواصل غير اللفظي لدي عينة من الأطفال ذوي التوحد، رسالة ماجستير، كلية التربية-جامعة عين شمس.
- ٧٣- محمد السيد حلاوة (١٩٩٩). الرعاية الاجتماعية للطفل الأصم. الإسكندرية: المكتب العلمي للنشر.
- ٧٤- محمد صالح الامام وفؤاد عيد الجوالدة (٢٠١١). التوحد رؤية الأهل وأخصائيين. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- ٧٥- محمد عبد التواب (٢٠١٥). الصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: مكتبة المتنبي، الطبعة الأولى.
- ٧٦- محمد عبد المؤمن حسين (١٩٩٦). سيكولوجية غير العاديين وتربيتهم. القاهرة: دار الفكر العربي.
- ٧٧- محمد على عرابي (٢٠١٩). الوحدة النفسية والمساندة الاجتماعية المدركة لدى الطلاب المعاقين بصرياً، مجلة كلية التربية، العدد (٢٥)، جامعة بورسعيد.
- ٧٨- محمد محمد عوده (٢٠١٥). تشخيص وتنمية مهارات الطفل الذاتوى. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٧٩- منى الحيدى، جمال الخطيب (٢٠١٨). برنامج تدريبي للاطفال المعاقين. الأردن: دار الكر للنشر والتوزيع.

- ٨٠-مجدى فتحى غزال (٢٠٠٧). فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات الاجتماعية لدى عينة من الأطفال التوحدين- رسالة ماجستير- كلية الدراسات العليا، عمان، الجامعة الأردنية.
- ٨١-مختار حمزه (١٩٧٥). سيكولوجية المرضى وذوى العاهات، الطبعة الثالثة. القاهرة: مكتبة الخانجي.
- ٨٢-مصطفى فهمي (١٩٨٠). سيكولوجية الأطفال غير العاديين. القاهرة: مكتبة مصر.
- ٨٣-النشيمى الروبلى (٢٠١٩). اليقظة العقلية والمرونة والتدفق النفسي لدى الراشدين الطلابيين فى محافظة ظريف بالمملكة العربية السعودية. دراسة مقارنة بين المرشدين الجدد والقدامى، مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد السابع- المجلد الثالث.
- ٨٤-نجوى السيد (١٩٩٠). أهمية الاكتشاف المبكر للأطفال المعاقين، مجلة الاقتصاد المنزلي، العدد السادس، ديسمبر.
- ٨٥-هالاهان، دنيال و كوفمان، جيمس (٢٠٠٨). سيكولوجية الأطفال غير العاديين وتعليمهم، مقدمة في التربية الخاصة، ترجمة عادل محمد. عمان. الأردن: دار الفكر.
- ٨٦-وزارة التربية والتعليم (٢٠١٧). برنامج تدريب المعلمين للتعامل مع المعاقين سمعياً وضعاف السمع. برتوكول مع وزارة الاتصالات.
- ٨٧- وزارة التربية والتعليم (٢٠٠٩). فى شأن عدد الطلاب بالمدارس الابتدائية للصم وضعاف السمع (١).
- ٨٨-وزارة التربية والتعليم (٢٠٠٣). إحصاءات وملفات التربية الخاصة، إدارة التربية الخاصة. القاهرة .

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 89-American Pusiychiatric Assaciation (2013).Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thed).Arlintan.va:Authar.Abatement.J.&LE.D.D.(2011).Abatement oypyf I ntractable vocal sterecatypy using an avercarrection procccdurs. **Behaiuard Interventiaus**, 26.143-146.
- 90-American Psychiatric Association (1994). **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders**, 4th ED., DSM-IV, Washington, DC., American psychiatric press..
- 91- American Psychiatric Association (2015). APA Dictionary of Psychology, Second Edition, www.apa.org Assouline, S.; Nicpon, M. & Whiteman (2010): Cognitive and psychosocial characteristics of gifted students with written lauguage disability. **Gifted Child Quarterly**, 54(2), 102-115.
- 92-American Psychiatric Association(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5).Arlington,VA: **American Psychiatric Association**
- 93-Barkley, R. (1995). **Taking Change of ADHD: The Complete Authoritative Guide for Parents**, New York, Guilford press.
- 94-Brown,KW.Ryan,R.M&Creswell, J.D. (2007).Mindfulness theoretical foundations and evidence for its salutary effects. **Journal of Health**. 237-211, (4)18.
- 95-Carver,R.(1988)."Social factors in the development of the deaf child".**AEH/ AED**,VOL. 14(2),P.70-80.
- 96-Edmunds Cail,Roddo, Michael Fox Gene(1992).descriptions of deaf individuals personality structures:is it more than a coincidence that these description paralle those of the written **language of the deaf acehi/A ceds v.(18)N(2/3)**.
- 97-Eidik,T.V.(1994)."**Behavior Problems with deaf dutch bays**",mericon annols of the deaf, NOL.139,(4),pp.394-398.
- 98-Ellison, M (2004) .The Effect of Non –Verbal Redirection on Out of seat Behavior in a Subject Diagnosed as ADHD and MR , **Dissertation Abstracts International-B** Vol. 42, No. 3, p. 732.
- 99-Fee,V.,(1993): The Differential Validity of Hyperactivity/ Attention Deficits and Conduct Problems Among Mentally Retarded Children, **Journal of Abnormal Child Psychology**, Vol. 21, No. 1 p. 1-11.

- 100-Golos, B (2006). **Using instructional videos in American Sign as a language tool to facilitate the development of emergent literacy skills in deaf and hard of hearing preschool children**. Ph.D, of Colorado at Boulder.
- 101-Hallahan,D.P.& Mercer,C.D.(2002): **Learning Disabilities: Historical perspective**. In R. Bradley, L.Danielson, and D.P. Hallahan (Eds), Identification of learning disabilities: Research to practice (PP.1-67). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- 102-McLoughlin, J. & Lewis, R. (2008): **Assessing students with special needs**. Upper Saddle River: Merrill Prentice Hall.
- 103-Morethan,S.&Richard,L.(1980):"**The everyday needs of sick and handicapped children and their families**", Tovistocho publication. London, New York.
- 104-Nidhi,K.,Amanda,L.S.,Shanna,S.&Cengiz,Z.(2015). Longitudinal mathematics development of students with learning disabilities and students without disabilities: A comparison of linear,quadratic, and piecewise linear mixed effects models. **Journal of School Psychology**, April; 53(2), 105-120.
- 105-Richard Clautier et autre (2005). **Psychologie de l'enfant**.2 edition, Gaetan Morin editeur,Canada.